



1^{er} CONGRÈS

DE LA SOCIÉTÉ AFRICAINE
DE SANTÉ PUBLIQUE

GRAND-BASSAM, LES 15, 16 & 17 NOVEMBRE 2023



LIVRET DES RÉSUMÉS

THÈME

**SYSTÈME DE SANTÉ ET DÉFIS
SANITAIRES EN AFRIQUE**



1^{er} Congrès de la Société Africaine de Santé Publique

Grand-Bassam, les 15, 16 & 17 Novembre 2023

SYSTEME DE SANTE ET DEFIS SANITAIRES EN AFRIQUE

Livret des résumés

LIVRET DES RÉSUMÉS

COMMUNICATIONS ORALES

1^{er} Congrès de la société africaine de santé publique

[C002] Leçons apprises de la gestion d'une intoxication collective au Clostridium botulinum dans le district sanitaire Bouaké sud, décembre 2022 à janvier 2023

Kouassi Damus P.^{1,2}, Bamba Fatoumata³, Kouame Arsene D.^{1,2}, Coulibaly M'bégan², Kouame Edmond^{1,4}, Asse Vincent^{1,4}, Achi Vincent^{1,4}, Monemo Pacome^{1,4}, Kra Ouffoue^{1,4}, Aba Yapo T.^{1,4}, Diakite Aïssata^{5,6}, Benie Bi V.^{2,6}

- 1.UAO
- 2.INHP
- 3.DRS Gbèkè
- 4.CHU Bouaké
- 5.LNSP,
- 6.UFHB

Introduction : En décembre 2022 et janvier 2023, respectivement sont survenus deux épisodes de cas de décès communautaires, dans un contexte d'adoration de fétiche, dans le village Kpo-kahankro, district sanitaire Bouaké sud.

Méthode : Des investigations épidémiologiques ont été menées consistant à la détection de cas suspects, à leur prélèvement pour analyse, ainsi que le liquide du fétiche suspecté.

Résultats : Le premier épisode du phénomène a débuté le 02 décembre 2022, dans un contexte d'adoration de fétiche, de funérailles et de distribution de la vitamine A sur le lieu des funérailles. Ont été enregistrés 20 cas, dont 06 décès, d'une maladie marquée par des vomissements, la fièvre, la diarrhée et une adynamie chez des enfants de moins de 10 ans. Parmi ces cas, 18 malades sur 20 ont reçu la vitamine A (90%). Les enfants n'ont partagé aucun repas en commun. Une contamination de la vitamine A a donc été suspectée, mais l'analyse toxicologique et microbiologique de la vitamine A demandée n'a été réalisée. Le deuxième épisode a débuté le 19 janvier 2023, suite à une nouvelle adoration du fétiche, faisant 15 décès sur 57 malades. La distribution des cas révèle leur prédominance autour du fétiche ; 21/44 cas (47,7%). L'analyse microbiologique du contenu du fétiche a mis en évidence Clostridium botulinum. Le fétiche a donc été détruit et le phénomène s'est estompé. De nombreuses interférences lors de la gestion de ce phénomène ont mis en doute la source suspectée. Comme leçon apprise, il ne faut se fier qu'aux résultats des investigations épidémiologiques lors d'un phénomène de santé.

Conclusion : Seule l'investigation épidémiologique devrait guider la gestion de tout phénomène inhabituel.

Mots clés : Investigation, Intoxication, Clostridium botulinum, Bouaké, Côte d'Ivoire

[C007] Evolution des cas de syphilis chez la femme enceinte au Burkina Faso entre 2014 et 2020

Ouedraogo Smaïla¹, Yonli Bapougouni Philippe Christian², Romba Issa², Sarigda Maurice³, Ouedraogo Aïda¹, Meda Nicolas¹

1.Département de santé publique, UFR-SDS, Université Joseph Ki-Zerbo, Ouagadougou, Burkina Faso)

2.Secrétariat permanent du conseil national de lutte contre le VIH/sida et les infections sexuellement transmissibles, Ouagadougou, Burkina Faso)

3.Département de sociologie, UFR/SH, Université Thomas Sankara, Ouagadougou, Burkina Faso)

Introduction : La surveillance de la syphilis dans les sites sentinelles est une source d'information stratégique pour les décideurs du secteur de la santé. Nous avons analysé les données collectées dans les sites sentinelles de 2014 à 2020 pour déterminer la tendance de cette infection et identifier les facteurs qui influencent sa survenue chez les femmes âgées de 15 à 49 ans.

Méthode : Une étude transversale annuelle répétée a été conduite de 2014 à 2020 dans les sites sentinelles couvrant les 13 régions du Burkina Faso auprès des femmes enceintes âgées de 15 à 49 ans. Des données sociodémographiques, cliniques et biologiques ont été collectées à partir des registres de la séro-surveillance. Le diagnostic de la syphilis a été établi par les résultats du « Venereal Disease Research Laboratory » (VDRL) et du « Treponema pallidum Hemagglutinations Assay » (TPHA). Des prévalences globales et annuelles ont été estimées et les facteurs influençant la survenue de la syphilis ont été identifiés à l'aide d'une régression logistique.

Résultats : Au total 55 157 femmes enceintes ont été incluses. La prévalence globale de la syphilis était de 1,2 %. La prévalence de la syphilis est passée de 1,2% en 2014 à 1,8% en 2020 après une chute progressive entre 2016 et 2017 avec respectivement 0,7% et 0,6%. Résider en milieu rural était associé à l'infection à syphilis chez les femmes enceintes (OR = 1,83 ; IC 95% : [1,47-2,28] ; $p < 0,01$).

Conclusion : Pour renverser la tendance à la hausse de l'infection à la syphilis chez les femmes enceintes au Burkina Faso, les autorités sanitaires doivent mettre en place des stratégies appropriées (sensibilisation) de prévention et de contrôle ciblant les femmes vivant en milieu rural.

Mots clés : évolution – surveillance – syphilis - femmes enceintes - Burkina Faso

[C008] Augmentation de la demande en charge virale chez les PVVIH éligibles grâce à l'utilisation de DHIS2-Tracker : Expérience du projet EAWA Togo".

D'almeida Yema¹, Essopha Kokoloko¹

1.EAWA Togo

Introduction : La faible demande de TAV est due à la capacité des sites à identifier et à contacter les patients éligibles qui doivent faire un test de charge virale. L'outil numérique DHIS2_Tracker a permis au projet Ending AIDS in West Africa (#EAWA) au Togo d'améliorer la création de la demande.

Méthode : Le DHIS2_Tracker fournit des données en générant avec précision une liste de candidats éligibles pour la CV deux fois par année fiscale, ce qui permet d'évaluer la demande pour chaque semaine, chaque mois et chaque année. Grâce à l'utilisation des caractéristiques des dates d'éligibilité à la CV du DHIS2_Tracker pour chaque patient, de leurs coordonnées et des fiches de suivi de la CV qui résument les dates de prélèvement des échantillons de sang et les résultats des tests précédents.

Résultats : En novembre 2020, le projet Ending Aids in West Africa (#EAWA) du Togo ne comptait que 14 % de PVVIH sous traitement antirétroviral ayant subi un test de charge virale et, parmi les personnes testées, 82 % avaient une CV supprimée. Au début de l'année fiscale 22, le Togo comptait 44 926 patients séropositifs actifs. Les données du DHIS2_Tracker ont permis d'identifier 23 980 patients éligibles à la CV jusqu'au 31 mars 2023. Le statut d'éligibilité est recoupé avec les dates de renouvellement du traitement antirétroviral afin de combiner les rendez-vous. Environ 52 % des patients éligibles ont fait le test, tandis que 41 % des patients non encore éligibles l'ont fait 60 jours à l'avance. Aujourd'hui, au moins 95 % des personnes testées présentent une suppression de la CV.

Conclusion : Le DHIS2_Tracker a permis de suivre les patients éligibles à la CV afin d'éviter les rendez-vous manqués avec une amélioration de l'accès des patients à la CV.

Mots clés : DHIS2 ; Charge Virale ; PVVIH

[C009] Vécu des décisions Gouvernementales pour la lutte contre la Covid-19 par une population transfrontalière : cas de Ouangolodougou depuis le couvre-feu jusqu'à la fermeture des frontières.

Kouassi Damus Paquin^{1,2}, Soumahoro Sory Ibrahim^{1,2}, Yao Gnissan Auguste^{1,2}, Irika Opri^{1,2}, Coulibaly M'begnani², Kouadio Arsene Deby^{1,2}, Oussou Roland^{1,2}, Yeo Salifou², Ouaga Jean-Marie², Beugre Gnangbo Isaac¹.

1.Université Alassane OUATTARA

2.Antenne régionale d'hygiène publique

Introduction : Après l'éclosion de la Covid-19 en Asie, sa propagation progressive s'est faite par les flux importants des voyages internationaux qui ont déplacé le foyer de la maladie de l'Asie vers l'Europe, Amérique, puis en Afrique. Des mesures ont été prises par les états pour contenir la maladie, partant des couvre-feux à la fermeture des frontières. A l'instar des autres pays du monde, cette situation a impacté les habitudes sociales, mais également l'économie de la Côte d'Ivoire. Nous menons cette étude pour apprécier les effets des mesures gouvernementales contre la Covid-19 sur le vécu de la population de Ouangolodougou, ville frontalière avec le Mali et le Burkina.

Méthode : Nous avons mené une étude transversale à visée descriptive dans les ménages de la ville de Ouangolodougou. La taille d'échantillon calculée était de 422 ménages. La collecte des données s'est faite en face-à-face à l'aide d'un questionnaire structuré, anonyme et standardisé. Les données ont été saisies et traitées par le logiciel SPSS 17.0.

Résultats : Au total, nous avons interrogé 423 personnes avec une moyenne de $40,89 \pm 11,277$ ans, commerçants (50,6%) ou agriculteurs (14,4%) pour la plupart. Ils affirmaient n'avoir pas apprécié l'isolement du reste du pays (39,2%), de même que l'éviction des rassemblements (11,6%). Ces mesures auraient impacté négativement leurs activités (69,7%) jusqu'à la perte de marchés (32,2%) et même l'arrêt des activités (53,4%). Ils affirmaient que les mesures restrictives avaient suscité des déplacements clandestins à travers la frontière (60,8%), l'accentuation du niveau de pauvreté (48,7%) et la perte d'emploi (29,3%) dans la localité.

Conclusion : Les mesures de lutte contre la Covid-19 se sont avérées éprouvantes pour les populations. Elles devraient être adaptées au regard du profil épidémiologique de la maladie dans le pays.

Mots clés : Covid-19 – Mesures de lutte – Impacts – Côte d'Ivoire

[C010] Production et consommation de la viande de lapin au Sud Bénin : un enjeu pour l'approche One Health

Karim Youssao Djibrila¹, Assouma Chabi Mama Baba Daouda², Souladjou Alassane², Antoine-Moussiaux Nicolas³, Ouassa Kouaro Monique¹

1.Laboratoire d'Anthropologie Appliquée et d'Education au Développement Durable, UAC/Bénin)

2.Laboratoire de Biotechnologie Animale et de Technologie des Viandes, UAC/Bénin)

3.Faculté de Médecine Vétérinaire, ULiège/Belgique

Introduction : L'approche One Health est essentielle dans la compréhension de la logique des acteurs impliqués dans la production et la valorisation de la viande de lapin au Sud Bénin. En effet, cette approche permet de prendre en compte les interactions entre les animaux, les humains et l'environnement, ce qui est crucial pour garantir la sécurité sanitaire des produits et la santé des populations. L'objectif de la présente contribution est de comprendre les influences de la production et la consommation de la viande de sur la santé des acteurs.

Méthode : Cette recherche est de nature qualitative et les informations ont été collectées auprès de 40 acteurs clés composés des éleveurs et des consommateurs, des agents de santé et des diététiciens par l'entremise d'un guide d'entretien semi-structuré. Les techniques d'échantillonnage de choix raisonné et celle des itinéraires ont permis d'identifier les enquêtés. Les données recueillies ont été analysées par la théorie de l'interaction symbolique (Lacaze, 2013).

Résultats : Il ressort des informations collectées que la production et la consommation de la viande de lapin participent au bien-être sanitaire des acteurs et contribuent à la préservation de l'environnement. En effet, l'élevage de lapins est une alternative durable à l'élevage intensif de bovins ou de porcs, qui nécessite moins de ressources en eau et en alimentation. De plus, la viande de lapin est reconnue pour sa faible teneur en matières grasses et sa richesse en protéines, ce qui en fait un choix sain pour les consommateurs.

Conclusion : De sa production à sa consommation, le lapin est perçu comme un animal dont les interactions sont dépourvues de zoonose et participe à une alimentation saine.

Mots clés : interaction, cuniculture, acteur, One Health, Sud Bénin

[C011] Facteurs associés à la gale chez les enfants de 0-15 ans dans une commune au sud du Bénin en 2023

Mongbo Virginie¹, Thamra Kamardine Hamadi¹, Elegbede Adegbite Nadege² Bedie Vignon¹, Johnson Roch Christian³

1.Département Politiques et systèmes de Santé, Institut Régional de Santé Publique, Université d'Abomey-Calavi

2.Centre de santé de la commune de Lalo

3.Centre Interfacultaire de Formation et de Recherche en Environnement pour le Développement durable (CIFRED), Université d'Abomey-Calavi

Introduction : La gale est une maladie tropicale négligée qui suscite peu d'attention de la communauté internationale. Cette recherche visait à étudier les facteurs associés à la gale dans la commune de Lalo au Bénin en 2023.

Méthode : Il s'agissait d'une étude cas-témoins, dont la taille de l'échantillon, calculée à l'aide du logiciel OPEN EPI était de 226 enfants. Les cas, retenus par choix exhaustif, étaient appariés aux témoins sur l'âge et le village, à raison d'un cas pour un témoin, retenu par sondage aléatoire à deux degrés. Les données étaient collectées par administration d'un questionnaire aux mères ou gardiennes des enfants. Le test chi 2 de Mc Nemar a permis de comparer les cas et les témoins. Les facteurs associés à la gale ont été identifiés par la régression logistique conditionnelle.

Résultats : Au total 122 cas et 122 témoins d'âge moyen de 5,02 ans $\pm$ 3,01 ans ont été impliqués dans l'étude. Le partage des couchettes (ORa [IC 95%] = 6,32 [1,30 ; 30,82]), la taille du ménage (ORa [IC 95%] = 2,76 [1,05 ; 7,29]), la sensibilisation sur la gale (ORa [IC 95%] = 3,27 [1,68 ; 6,38]) et l'hygiène corporelle (ORa [IC 95%] = 3,08 [1,02 ; 9,25]) étaient associés à la gale dans la commune de Lalo au Bénin en 2023.

Conclusion : Les facteurs associés identifiés montrent que la gale est effectivement liée à la pauvreté mais aussi à des facteurs comportementaux qu'on pourrait modifier par la communication pour un changement de comportement.

Mots clés : Gale, facteurs associés, enfants, Lalo, Bénin.

[C015] Mortalité et tuberculose pulmonaire à bacilles multirésistants à Abidjan Côte d'Ivoire

Zakaria Kone ¹, Jean Fabien Bomouan ²

1. Service de pneumophtisiologie CHU de Treichville

2. Département de santé publique INSP

Introduction : si le taux de mortalité de la TB-MR est connu, les facteurs associés au décès des patients TB-MR en traitement hospitalisés dans les services de PPH des CHU d'Abidjan sont inconnus.

Méthode : Nous avons mené une étude de cohorte rétrospective, à visée analytique, qui a porté sur les dossiers de patients hospitalisés dans les services de PPH des CHU de Treichville et Cocody, de janvier 2016 à janvier 2021. La survie était le délai entre la date de début d'hospitalisation et la date de survenue du décès toutes causes confondues, et a été estimée par la méthode de Kaplan Meier. Le modèle de cox a été utilisé pour identifier les facteurs de mortalités.

Résultats : 131 dossiers ont été inclus dans notre étude, 61,07% des patients étaient de sexe masculin, avec une moyenne d'Age de 38,71 ans (extrêmes : 15ans – 73 ans). 66 patients étaient décédés, ce qui fait une proportion de décès de 50,38%. 10 patients provenaient d'une zone rurale, soit 7,63%, contre 92,37% provenant d'une zone urbaine. 41,98% des patients avaient un antécédent de tuberculose pulmonaire, 45 patients étaient consommateurs de tabac. La radiographie thoracique a été systématiquement analysée chez les 131 patients, la majorité (81) avait des lésions initiales étendues. La médiane de survie était de 14 jours. En analyse multi variée, les facteurs associés au décès des patients hospitalisés pour TB-MR étaient : la provenance rurale, la présence d'un antécédent de tuberculose, le tabagisme et des lésions radiographiques initiales étendues.

Conclusion : la mortalité liée à la TB-MR reste élevée en hospitalisation de pneumologie, les patients continuent de payer le lourd tribut de la tuberculose. Les efforts de lutte contre cette affection doivent être renforcés en tenant compte des facteurs retrouvés dans cette étude.

Mots clés : Tuberculose pulmonaire multirésistantes – facteurs de risque – mortalité – cote d'ivoire.

**[C016] Harcèlement sexuel en milieu professionnel hospitalier du Burkina Faso :
prévalence et facteurs associés**

Mohamed Sélim Ouedraogo¹, Tieba Millogo¹

1. Institut Africain de Santé Publique, Institut de Recherches en Sciences de la Santé, Université Saint Thomas d'Aquin

Introduction : Le harcèlement sexuel est un problème majeur de santé publique dans les différents hôpitaux du monde associé à plusieurs facteurs et causant d'importantes conséquences sur la santé des travailleurs qui ne sont pas à négliger. D'où l'intérêt d'étudier le harcèlement sexuel chez les agents de santé de sexe féminin en milieu professionnel hospitalier du Burkina Faso.

Méthode : Il s'est agi d'une étude transversale à visée descriptive et analytique conduite du 31 mars au 15 avril 2023 chez le personnel hospitalier féminin des centres hospitaliers universitaires Yalgado Ouédraogo et Bogodogo de la ville de Ouagadougou. Pour cela un échantillonnage aléatoire simple a été utilisé. Et un questionnaire auto rempli et standardisé a été administré. Un modèle de régression logistique a été utilisé pour déterminer les facteurs associés.

Résultats : 460 femmes ont répondu au questionnaire. La prévalence du harcèlement sexuel était de 44,57%. Parmi elles, 20,98% ont déclaré avoir été harcelées au moins une fois, 14,15% deux fois et 64,88% plus de deux fois. Les principaux auteurs étaient les supérieurs hiérarchiques avec 33,26%, les collègues de travail 19,13%, les accompagnants 10,43%. Les facteurs significativement associés retrouvés en analyse bivariée étaient : la catégorie "sages-femmes/infirmières" (OR 2,9 ; P-value 0,029 ; IC 95% [1,11-7,49]) ; la catégorie "étudiantes en médecine" (OR 2,4 ; P-value 0,039 ; IC [1,04-5,65]) et l'estime de soi avec la catégorie "belle forme" (OR 1,91 ; P-value 0,009 ; IC 95% [1,18-3,11]). Et en analyse multivariée la catégorie "sages-femmes/infirmières" (OR 6,2 ; P-value 0,022 ; IC95% [1,29-29,77]) était le seul facteur associé retrouvé.

Conclusion : Le harcèlement sexuel est bien présent dans le milieu hospitalier. Une étude de grande envergure multicentrique est nécessaire pour avoir des données généralisables.

Mots clés : Harcèlement sexuel, Hôpital, Burkina Faso

[C017] Acceptabilité de la vaccination antipaludique chez les mères d'enfants âgés de 0 à 24 mois, Abidjan, Côte d'Ivoire, 2023

Douba Alfred^{1,2}, Ahoussou Eric Martial Kouakou^{1,2}, Akani Bangaman Christian^{1,2}, Oussou Konan Roland^{1,2}, Ano Ama Marie Noelle^{1,2}, Djoman Christiane^{1,2}, Abina Audrey Marie-Michelle², Konan Loukou Gilbert^{1,2}, Samassi-Sokodogo Awa^{1,2}, Aka Lepri Bernadin Nicaise^{1,3}, Ekra Kouadio Daniel^{1,3}, Issaka Tiembre^{1,2}

1 Université Félix Houphouët-Boigny, Abidjan-Cocody, Côte d'Ivoire

2 Institut National d'Hygiène Publique, Côte d'Ivoire

3 Direction de Coordination du Programme Elargi de Vaccination

Introduction : La Côte d'Ivoire prévoit introduire le vaccin antipaludique dans le Programme Elargi de Vaccination en 2024. Nous avons donc réalisé une enquête afin d'analyser l'acceptabilité de la vaccination antipaludique.

Méthode : Nous avons réalisé une enquête transversale à visée analytique. La population d'étude était constituée des mères ou des accompagnants d'enfants âgés de 0 à 24 mois. Les données ont été collectées en août 2023 dans les centres de vaccination de 2 districts sanitaires d'Abidjan (Abobo Ouest et Cocody-Bingerville). L'outil de collecte des données était une fiche d'enquête. Les données ont été analysées en deux étapes (descriptive et analytique) à l'aide du logiciel SPSS.

Résultats : Au total, 617 femmes ont été enquêtées. L'âge moyen et l'âge médian étaient respectivement 30,52 ans et 31 ans. L'âge minimum était 15 ans et l'âge maximum 45 ans. Les enquêtées n'avaient aucun niveau d'étude dans 32,9% des cas ; les niveaux primaire, secondaire et supérieur étaient respectivement de 20,4%, 31,8% et 14,9%. Les chrétiennes et les musulmanes représentaient respectivement 54,6% et 45,1% des enquêtées. Les ménagères et les travailleuses du secteur informel représentaient 30,1% et 20,1% des enquêtées. La majorité des enquêtées (96,3%) avaient l'intention de faire vacciner leurs enfants. Les principales raisons pour lesquelles certaines mères n'avaient pas l'intention de faire vacciner leurs enfants contre le paludisme étaient le manque de confiance au vaccin (54,5%) et la peur des effets secondaires (22,7%). Au plan analytique, l'âge (test exact de Fisher = 11,22 ; $p = 0,003$) et le niveau d'étude (test exact de Fisher = 12,93 ; $p = 0,003$) étaient liés à l'intention vaccinale.

Conclusion : L'intention vaccinale antipaludique est très élevée chez les mères d'enfants âgés de 0 à 2 ans. Le défi de la vaccination antipaludique est la disponibilité du vaccin.

Mots clés : acceptabilité, vaccin antipaludique, mères, Côte d'Ivoire

[C018] Facteurs associés à la croyance à l'existence de la COVID-19, Côte d'Ivoire, 2022

Douba Alfred^{1,2}, Ahoussou Eric Martial Kouakou^{1,2}, Akani Bangaman Christian^{1,2}, Oussou Konan Roland^{1,2}, Ano Ama Marie Noelle^{1,2}, Djoman Christiane^{1,2}, Abina Audrey Marie-Michelle², Konan Loukou Gilbert^{1,2}, Samassi-Sokodogo Awa^{1,2}, Aka Lepri Bernadin Nicaise^{1,3}, Ekra Kouadio Daniel^{1,3}, Issaka Tiembre^{1,2}

1 Université Félix Houphouët-Boigny, Abidjan-Cocody, Côte d'Ivoire

2 Institut National d'Hygiène Publique, Côte d'Ivoire

3 Direction de Coordination du Programme Elargi de Vaccination

Introduction : L'enquête sur l'acceptation de la vaccination contre la COVID-19 réalisée en Côte d'Ivoire, en 2021, a révélé diverses raisons de non-vaccination y compris l'inexistence de la maladie. Nous avons réalisé la présente étude pour déterminer les facteurs associés à la croyance à l'existence de la COVID-19.

Méthode : Nous avons réalisé une enquête transversale par sondage en grappe à 2 degrés. Le premier degré a consisté en la sélection des quartiers et le second degré en la sélection des ménages. Dans chaque ménage, c'est le chef du ménage qui était interrogé. Les données ont été collectées à Abidjan et à Bouaké. Les données ont été analysées à l'aide du logiciel SPSS. La recherche des facteurs associés à la croyance à la COVID-19 s'est faite par la réalisation d'une régression logistique binaire. La mesure d'association était l'Odds Ratio ajusté avec son intervalle de confiance à 95% et un degré de significativité $p < 0,05$.

Résultats : Au total, 3 611 personnes ont été enquêtées. La majorité des enquêtés (53%) étaient de sexe féminin. Les personnes âgées de 18 à 59 ans représentaient respectivement 86% des enquêtés. La majorité des enquêtés (84%) croyait à l'existence de la COVID-19. Les facteurs associés à la croyance à l'existence de la COVID-19 étaient la connaissance d'une personne testée positive (ORaj = 3,71 ; IC95% = 2,41-5,70), le portage d'une maladie chronique (ORaj = 1,63 ; IC95% = 1,15-2,31), la religion (ORaj = 1,53 ; IC95% = 1,06-2,21), la vie en couple (ORaj = 1,4 ; IC95% = 1,16-1,70) et le niveau d'études (ORaj = 0,6 ; IC95% = 0,43-0,84).

Conclusion : Les facteurs associés à la croyance à l'existence de la COVID-19 étaient la connaissance d'une personne testée positive, le portage d'une maladie chronique, la religion, la vie en couple et le niveau d'études.

Mots clés : facteurs associés, croyance, COVID-19, Côte d'Ivoire

[C020] La valeur d'intégrer des algorithmes de prise en charge clinique et de sécurité sanitaire au niveau des structures de santé primaire au Sénégal

Pelle G. Karell^{1,2}, Barry Aliou², Ndaye Amadou Moustapha², Gaye Aboubacry² Coulibaly Penda³, Drame Codou², Cisse Mamadou², Talla Cheikh², Loucoubar Cheikh², Ndaye Codou³, Taieb Fabien^{2,4}, Sall Amadou Alpha², Dittrich Sabine¹

1.FIND, Geneva, Switzerland

2.Institut Pasteur de Dakar, Dakar, Sénégal

3.Dimagi Inc., Dakar, Sénégal

4.Institut Pasteur Paris, Paris, France

Introduction : La gestion des fièvres en milieu communautaire reste un défi clinique pour lequel il existe peu de diagnostics permettant de guider l'antibiothérapie. Les fièvres ont des origines multiples, y compris les virus, qui sont à l'origine de nombreuses épidémies. Nous démontrons la valeur d'intégrer des algorithmes de prise en charge, antibiothérapie et surveillance au Sénégal.

Méthode : Il s'agissait d'un essai contrôlé randomisé mené dans 4 centres de santé primaires au Sénégal. Les enfants âgés de 6 mois à 14 ans souffrant de fièvre et/ou de diarrhée aiguë non-sévère étaient éligibles à l'étude. Les agents de santé (AS) du groupe témoin ont fourni des soins conformément à la pratique courante. Dans le groupe d'intervention, une boîte à outils composée d'une application d'aide à la décision clinique et des tests de diagnostic rapide, a appuyé les consultations. Les cas répondant aux définitions communautaires du Système de Surveillance Syndromique du Sénégal ont été notifiés numériquement. Les critères d'évaluation comprenaient la proportion de participants ayant 1) une maladie résolue à J7 et 2) un antibiotique prescrit à J0. Les données ont été analysées dans R.

Résultats : 252 et 218 participants ont été recrutés respectivement dans le bras contrôle et d'intervention. L'âge moyen des participants était de 3,7 ans, 48,1 % étaient des femmes et 79,8 % avaient de la fièvre. Il n'y a pas eu de différence significative dans les résultats cliniques entre la pratique courante (100 %) et la boîte à outils ADS (97,6 %), p-value= 0,033, mais une réduction significative de la prescription d'antibiotiques avec la boîte à outils a été observée (45,5 %, p-value< 0,001). Les syndromes grippaux, arboviraux et diarrhéiques ont été enregistrés numériquement avec un taux d'exhaustivité de 99,98 %.

Conclusion : Les innovations numériques intégrant la prise en charge clinique et soutiennent la sécurité sanitaire mondiale sont réalisables pour les contextes communautaires.

Mots clés : Aide à la décision clinique, fièvre, gestion des antibiotiques, surveillance des maladies

[C024] Facteurs associés à la tuberculose multirésistante chez les patients diagnostiqués dans la région du Centre, Burkina Faso, 2020-2022

Yanogo Pauline Kiswendsida¹, Balima Clarisse¹, Meda Nicolas¹

1.Département de Santé Publique, Unité de formation et de Recherche en Science de la Santé, Université Joseph KI-ZERBO

Introduction : L'émergence de la tuberculose multirésistante (TB-MR) est un défi pour le contrôle et la prévention de la maladie à l'échelle mondiale. Les personnes sont infectées par la tuberculose multirésistante soit lorsqu'elles sont exposées à une souche résistante, soit lorsque le traitement conduit à la sélection d'une souche résistante. Notre objectif était d'étudier les facteurs associés à la tuberculose multirésistante chez les patients diagnostiqués dans la région du Centre, Burkina Faso, 2020 à 2022.

Méthode : Nous avons mené une étude cas – témoins non appariés sur les données du 1er Janvier 2020 au 31 Décembre 2022. Les variables utilisées ont été regroupées en caractéristiques sociodémographiques, cliniques, paracliniques et thérapeutiques. Nous avons calculé les odds ratios bruts (ORbruts) et ajustés (aOR) à un intervalle de confiance (IC) à 95% (OR[ICà95%]) et les variables avec une valeur $p < 0,05$ ont été considérées comme statistiquement significatifs.

Résultats : Les facteurs indépendamment associés à la tuberculose multirésistante étaient l'antécédent de traitement de TB [OR=7.36, IC95%= (2.75-19.68), $p=0.0001$] ; le lieu de résidence (milieu rural) [OR=6.04, IC95%= (2.39-15.27), $p=0.0001$] ; la consommation d'alcool [OR=4.20, CI95%= (1.66-10.60), $p=0.002$] ; le résultat des frottis d'expectoration avec BAAR $\geq$ [OR=3.37, CI95%= (1.36-8.36), $p=0.008$] ; l'hospitalisation au cours du traitement [OR=5.20, IC95%= (1.79-15.41), $p=0.002$] ; la méconnaissance de la stratégie DOTS [OR=6.53, IC95%= (2.63-16.21), $p=0.0001$].

Conclusion : Notre étude a identifié plusieurs facteurs associés à la tuberculose multirésistante notamment ceux liés aux comportements tant chez les patients que les prestataires de soins ce sont : l'antécédent de traitement antituberculeux, la consommation d'alcool, et la méconnaissance de la stratégie DOTS. En outre, les futures études devraient viser donc à comprendre l'impact du comportement/des connaissances des patients ou des attitudes des soignants afin que les résultats puissent guider l'utilisation des ressources rares pour optimiser leur impact.

Mots clés : Tuberculose multirésistante, facteurs associés, Burkina Faso

[C027] Fatigue et somnolence sur la route : Profil des conducteurs, type d'accidents et autres facteurs de risque associés en contexte subsaharien

Glele Ahanhanzo Yolaine¹, Kpozehouen Alphonse¹, Hounkpe Dos Santos Bella², Daddah Donatien³, Leveque Alain⁴

1.Département d'Epidémiologie et de Biostatistiques, Institut Régional de Santé Publique, Ouidah, Bénin

2.Direction Départementale de la Santé de l'Atlantique, Abomey-Calavi, Bénin

3.Direction Départementale de la Santé du Mono, Lokossa, Bénin

4.Ecole de Santé Publique, Université Libre de Bruxelles, Belgique

Introduction : La fatigue et la somnolence lors de la conduite sont des facteurs de risque reconnus d'accidents de la route. Ces derniers constituent un problème de santé publique de première place en Afrique car, premier motif de traumatisme et première cause de décès chez les jeunes. Dans ce contexte, parmi les autres facteurs de risque, la fatigue et la somnolence restent insuffisamment documentés d'accidents de la route et font l'objet de peu d'interventions. L'objectif de ce travail est de décrire le profil des conducteurs victimes d'accidents de la route lié à ce facteur de risque et d'identifier les autres facteurs de risque associés.

Méthode : Il s'agit d'une analyse des données d'une cohorte mise en place au Bénin en 2019, cohorte de 1871 victimes d'accidents de la route recrutées dans 5 hôpitaux répartis sur le territoire national. Les données des 1025 patients qui se sont déclarés conducteurs lors de l'accident ont été retenues pour les analyses. Les informations ont été collectées par questionnaire sur base d'un auto rapportage. Les comparaisons ont été faites avec le test de χ^2 au seuil de 5%.

Résultats : La prévalence de la fatigue/somnolence lors de la conduite était de 12,5%. Elle était plus élevée chez les hommes ($p=0,016$), les porteurs d'antécédents de maladies chroniques ($p=0,001$), lors des déplacements liés au travail ($p=0,007$), mais ne variait pas selon le type d'engin. Elle était aussi plus élevée lors des accidents survenus la nuit ($p=0,000$) et des accidents survenus sur les Routes Nationales Inter Etats ($p= 0,001$). Les autres facteurs de risque d'accident de la route associés étaient la non-utilisation de matériel de protection, l'excès de vitesse, la conduite sous influence de substances dopantes et la consommation d'alcool.

Conclusion : La fatigue/somnolence lors de la conduite est un facteur de risque d'accident de la route au Bénin, associé à d'autres facteurs de risque faisant des profils identifiés des groupes particulièrement vulnérables. L'intégration des politiques de prévention basée sur l'identification de ces facteurs cumulés de risque contribuera en efficience à l'amélioration de la situation.

Mots clés : Fatigue, accidents de la route, épidémiologie descriptive, facteurs de risque, prévention

[C029] Continuité des soins liés au VIH dans les Districts centres du Sénégal en période de Pandémie COVID 19 entre Mars 2020 et Février 2021

Diop Cheikh Tacko¹, Gueye Boubacar¹

1.UFR Santé Communautaire Université Alioune DIOP de BAMBEY

Introduction : La pandémie à VIH /SIDA est un problème majeur de santé publique. L'infection à COVID 19 a impacté le système sanitaire national. Ainsi, une étude sur la continuité de services a été menée au Sénégal pendant la pandémie à COVID 19.

Méthode : Une étude transversale analytique a été menée chez les PVVIH ayant adhéré la file active entre Mars 2020 et Février 2021 au Sénégal. Un sondage à plusieurs degrés a été effectué au niveau de chaque district. Des analyses univariée et multivariée ont été effectuées grâce au logiciel SPSS version 2022.

Résultats : L'âge moyen des patients était de 43,38 ans $\pm$ 13,22. Plus de la moitié des PVVIH était instruite (53,13%) et mariée (55,47%). Le sexe féminin était majoritaire 66,41%. Parmi les enquêtés, 66,13% exerçaient une activité génératrice de revenu. Plus de la moitié des enquêtés 67,50% avait un revenu mensuel de moins de 55 000 FCFA. La télévision était la principale source d'information (51,56%). La presque totalité des PVVIH (96,88%) avait continué à demander des services de consultation. La majorité (93,55%) avait effectué au moins un bilan de suivi avec un délai moyen de 7,54 $\pm$ 8,64 mois. Parmi les 85 PVVIH enquêtées, (9,41%) étaient enceintes ou ont accouché durant les 12 derniers mois et avaient bénéficié de traitement ARV dans un délai de 3,57 $\pm$ 2,15 mois. La discontinuité des services de PEC du VIH était plus élevée chez les sujets de sexe masculin avec un ORaj 4,61[1,58-13,51]. Les sujets qui n'avaient aucune activité génératrice de revenu étaient plus à risque de subir une discontinuité des services pour leur prise en charge avec un ORaj 3,13[1,10-9,23]

Conclusion : Les autorités sanitaires devraient réorganiser le système sanitaire et adopter une politique basée sur l'approche communautaire pour permettre aux populations de surmonter la « peur de la COVID 19 ».

Mots clés : Continuité services, VIH, COVID 19, Sénégal.

[C038] Recours aux ambulances du Service d'Aide Médicale Urgente par les patients admis aux urgences des hôpitaux de Yaoundé (Cameroun) en 2022

Woromogo Sylvain Honore¹, Goumeni Kouemaha Yannick¹, Tebeu Pierre Marie¹

1.Département d'Epidémiologie - CIESPAC

Introduction : Le service d'aide médicale d'urgence (SAMU) est une organisation de gestion préhospitalière des menaces vitales. Il fonctionne 24 heures sur 24 et intervient lors des situations menaçant éminemment la vie nécessitant par conséquent une prise en charge immédiate. L'objectif de l'étude est d'étudier le recours aux ambulances du SAMU par les patients admis aux urgences des hôpitaux de Yaoundé (Cameroun) en 2022.

Méthode : Il s'est agi d'une étude descriptive transversale, réalisée auprès de 379 personnes : patients du Centre des Urgences et de Réanimation de Yaoundé et du service d'urgence de l'hôpital général de Yaoundé. Les variables liées aux connaissances (SAMU, numéro du SAMU), aux attitudes (appel du SAMU dans le passé, recours au SAMU en situation de détresse vitale, etc.) et aux pratiques (moyen de transport des patients transférés, à qui on a proposé une ambulance, raisons invoquées pour ne pas recourir à l'ambulance) ont été collectées. Les fréquences ont été calculées pour les variables qualitatives. La médiane avec les quartiles 1 et 3 ont été déterminés concernant les variables quantitatives.

Résultats : Seulement 76 patients sont arrivés aux urgences dans une ambulance. Seuls 21(5%) sont arrivés aux urgences par l'ambulance du SAMU, parmi lesquels 14 femmes. On note que 15/21 résidaient dans des quartiers accessibles de la ville. Des 379 patients enquêtés 243 (64%) ont déclaré avoir une connaissance du SAMU ; 76/243 (31%) connaissaient le bon numéro. A la question « Que feriez-vous en cas de détresse vitale ? », 198/379 (52%) disaient qu'ils iraient directement à l'hôpital ; 74 (19%) répondaient qu'ils iraient dans un centre de santé ; 51 (13%), qu'ils appelleraient un médecin.

Conclusion : Les difficultés de recours aux ambulances du SAMU résident dans sa méconnaissance par les usagers, la non-fonctionnalité du centre d'appel et l'exigence de frais de transfert.

Mots clés : Recours, difficulté, SAMU, Service d'urgence.

[C039] Déterminants de la survie chez les personnes vivant avec le VIH après dix ans de traitement antirétroviral au Centre Hospitalier Universitaire de Zone de Suru-Léré (CHUZ-SL) à Cotonou, Bénin

Damien Barikissou Georgia¹, Afangnihoun Aldrick^{2,3}, Aguemon Badirou⁴, Zannou Marcel⁴, Gangbo Flore²

1.Centre de Formation et de Recherche en matière de Population, UAC

2.Unité de santé publique, Faculté des Sciences de la Santé, Université d'Abomey-Calavi

3.Programme National de lutte contre le Sida - PNLS, Cotonou, Bénin

4.Unité de santé publique, Faculté des Sciences de la Santé, Université d'Abomey-Calavi, Cotonou, Bénin

Introduction : La thérapie antirétrovirale (TARV) a été instituée au Bénin en 2002 d'abord dans deux sites puis passée à l'échelle avec 117 sites en 2021. L'objectif de l'étude était d'identifier les déterminants de la survie des personnes vivant avec le VIH (PVVIH) sous TARV après 10 ans de traitement au CHUZ-SL.

Méthode : Une étude cohorte rétrospective a été réalisée au Centre Hospitalier Universitaire de Zone de Suru-Léré (CHUZ-SL) de Cotonou. Toutes les PVVIH qui avaient consulté de 2004 à 2009 et répondant aux critères ont été enrôlées. Le critère de jugement était la survie et l'évènement le décès. Les comparaisons des courbes de survie ont été faites grâce aux courbes de Kaplan-Meier avec les tests Log Rank. Le modèle de risque proportionnel de Cox a été utilisé pour déterminer les facteurs prédictifs de la mortalité due au VIH.

Résultats : Sur le 1052 PVVIH, 64,3 % étaient de sexe féminin. Après 10 ans de suivi, 273 décès étaient enregistrés avec une probabilité de survie de 74,0 % contre 92,9 % à la première année. Les hommes (OR : 1,69 [1,37 – 2,65]), les malades à indice de bien économique faible (OR : 1,39 [1,29 – 2,16]), qui consommaient de l'alcool (OR : 3,33 [2,14 – 5,18]), et non observants à la TARV (OR : 2,84 [1,48 – 5,45]) avaient une probabilité de mortalité élevée.

Conclusion : Au terme de l'étude les déterminants de la survie identifiés sont : le sexe, l'indice de bien-être économique, la consommation de l'alcool et l'observance au TAR. La prise en compte de ces facteurs servirait à améliorer la prise en charge des PVVIH.

Mots clés : PVVIH, survie, décès, facteurs prédictifs, Bénin

[C043] Identification des sources allergéniques les plus sensibilisantes chez les patients atopiques suivis en consultation allergologique au chu de Cocody Abidjan (Côte d'Ivoire)

Assi-Sahouin Ursule Aniela

Introduction : Contexte : les maladies allergiques sont devenues les premières maladies chroniques dans de nombreuses régions du monde. Le diagnostic précis en allergologie demande la connaissance précise des allergènes de l'environnement de vie. Objectif : Répertoire les sources allergéniques les plus sensibilisantes dans le contexte de vie ivoirien.

Méthode : une étude rétrospective, transversale à visée descriptive et analytique a été menée de septembre 2022 à mars 2023, sur des dossiers de patients reçus en consultation dans le service d'allergologie du CHU de Cocody pour suspicion d'allergie chez qui des prick-tests ont été réalisés. Les données ont été analysées par les logiciels Excel et SPSS Version 29.

Résultats : 403 patients ont été inclus. Parmi toutes les sources allergéniques répertoriées, quatre (4) sources natives de trophallergènes ont été reconnues comme sources allergéniques majeures en considérant le nombre de patients testés à ceux-ci ≥ 20 personnes. Il s'agissait des sources natives à l'arachide, à l'œuf, au crabe et à la tomate. La responsabilité de ces 4 sources allergéniques a été déterminée dans les manifestations allergiques présentées par les patients.

Conclusion : l'établissement du répertoire des sources allergéniques sensibilisantes dans notre contexte nous a permis d'incriminer le plus les trophallergènes dans les différentes manifestations allergiques que présentaient les patients en consultation d'allergologie.

Mots clés : allergie – allergènes – IgE – sensibilisation – prick-tests

[C048] Barrières à la vaccination contre la Covid 19 au Sénégal

Sougou Ndèye Marème¹

1. Service de médecine préventive et santé publique/ Institut de Santé et Développement, Université Cheikh Anta Diop de Dakar

Introduction : Au Sénégal, plusieurs stratégies de vaccination ont été développées au niveau local pour faire face aux barrières persistantes et relancer ainsi la campagne de vaccination. Toutefois, ces stratégies n'ont pas permis pour autant de relever le taux de couverture vaccinale. L'objectif de cette étude est d'identifier les barrières à la vaccination contre la Covid 19.

Méthode : Il s'agit d'une étude qualitative de type « étude de cas multiple » dans 3 localités du Sénégal Dagana, Mbacké et Tambacounda. Cette étude a concerné 225 informateurs clés, des acteurs communautaires, des prestataires de santé, des leaders de la communauté et des bénéficiaires. Des entretiens individuels approfondis et focus groupe avaient été menés. Il s'agissait d'une analyse thématique avec Nvivo 12.

Résultats : La vaccination contre la Covid 19 a été acceptée par une partie de la population composée de prestataires de santé, de leaders de la communauté, de personnes âgées et de celles vivant avec des comorbidités. La vaccination des femmes en général est le plus souvent soumise à la décision de leur partenaire/époux. Les vaccins ont été jugés accessibles malgré quelques problèmes de ruptures de doses ne permettant pas de continuer le schéma thérapeutique choisi. Les informations concernant la vaccination ont suivi surtout le canal des médias de masse surtout la radio. Cependant beaucoup de personnes ont été informées via les réseaux sociaux. Cette situation a contribué à une forte circulation de rumeurs et à la désinformation. Les principales barrières restent donc les rumeurs. Ainsi, plusieurs rumeurs concernant la vaccination ont circulé. Certaines concernaient en grande partie la fertilité des femmes et ont découragé une partie importante des jeunes à ne pas se faire vacciner.

Conclusion : La promotion de la vaccination contre la Covid 19 devrait se poursuivre en ciblant la partie de la population la plus jeune et en s'intéressant aux rumeurs.

Mots clés : Covid 19, vaccination, barrières, Sénégal

[C050] Épidémiologie des amputations non traumatiques des membres inférieurs en Afrique de l'Ouest : Données nationales du Togo

Martin Kouame Tchankoni^{1,2}, Romeo Medesse Togan¹, Gregoire Anani Abalo³, Latame Komla Adoli¹, Atchi Walla⁴, David Ekoue Dosseh⁵, Boyodi Tchangaï⁶, Pierre-Marie Preux², Victor Aboyans², Didier Koumavi Ekouevi¹

1.Département de santé publique, Faculté des sciences de la santé, Université de Lomé, Togo

2.Inserm U1094, IRD U270, Univ. Limoges, CHU Limoges, EpiMaCT - Epidémiologie des maladies chroniques en zone tropicale, Institut d'Epidémiologie et de Neurologie Tropicale, Omega Health, Limoges, France

3.Service de traumatologie-orthopédie du CHU Sylvanus Olympio de Lomé, Faculté des sciences de la santé de l'Université de Lomé, Togo

4.Département d'orthopédie, CHU Campus médical, Lomé, Togo

5.Département de chirurgie générale, Faculté des sciences de la santé, Université de Lomé, Lomé, Togo

6.Service de chirurgie viscérale, CHU, Lomé, Togo

Introduction : L'amputation non traumatique d'un membre inférieur (ANT-MI), a des conséquences majeures. Les données en population générale en Afrique subsaharienne (ASS) sont rares et souvent liées à des séries monocentriques. Notre étude visait à estimer l'incidence des ANT-MI (mineures et majeures) et à décrire leurs aspects épidémiologiques, cliniques et pronostiques au Togo.

Méthode : Il s'est agi d'une étude rétrospective, menée auprès de tous les patients ayant subi une ANT-MI. Les données sociodémographiques, cliniques et de bilan ont été recueillies à partir des dossiers cliniques dans toutes les formations sanitaires togolaises du 01/01/2016 au 31/12/2021. Les taux d'incidence par âge ont été calculés et ajustés sur l'âge.

Résultats : Au total, 352 patients (59% d'hommes) ont subi une ANT-MI (âge moyen de $60 \pm 15,7$ ans). Le taux d'incidence moyen des ANT-MI ajusté sur l'âge était de 8,5 par million/an (IC 95% = [7,6-9,4]). Le risque relatif d'ANT-MI était 48 fois plus élevé chez les diabétiques que chez les non-diabétiques. Environ 61% des ANT-MI sont survenus dans la tranche d'âge 50-74 ans et 54,3% étaient atteints de diabète sucré. Parmi les amputés, 54,5% souffraient d'artériopathie oblitérante des membres inférieurs (AOMI) et 52,8% souffraient d'ulcères diabétiques, avec la coexistence de plusieurs facteurs. Seuls <5% des amputés avaient des antécédents de tabagisme. La durée moyenne du séjour à l'hôpital était de 12 jours. Le taux de mortalité à l'hôpital était de 8,8%. Seulement 18,2% ont eu une échographie et 1,7% un angioscanner avant l'amputation.

Conclusion : Des interventions à grande échelle sont nécessaires pour améliorer la prise en charge du diabète et de l'AOMI et améliorer les infrastructures pour une prise en charge optimale des patients à risque d'amputation en Afrique.

Mots clés : Épidémiologie, incidence, amputation de membre, maladie artérielle périphérique, Afrique subsaharienne, diabète.

[C052] Profil de la réponse cellulaire T chez les agents de santé infectés par le SRAS-CoV-2 à Abidjan : vaccinés contre non vaccinés

Memel Lasme Roselle Charline¹, Adou Adjoumanvoule Honore², Yeboah Oppong Richard², Goran-Kouacou Amah Patricia², Assi Aya Ursule Aniela², Moussa Salimata³, Seri Yida Jocelyne², Oura Doris³, Koya Hebert Gautier¹, N'Guessan Koffi², Siransy Kouabla Liliane³, Dasse Sery Romuald²

1.Service d'Immunologie, Centre Hospitalier et Universitaire de Bouaké (Côte d'Ivoire)

2.Service d'Immunologie-Allergologie, Centre Hospitalier et Universitaire de Cocody, Abidjan (Côte d'Ivoire)

3.Centre National de Transfusion Sanguine, Abidjan (Côte d'Ivoire)

Introduction : En Côte d'Ivoire, les campagnes de vaccination ont débuté en avril 2020, ciblant les agents de santé du fait de leur contact permanent avec les patients atteints de COVID-19. Quel est l'état de la réponse immunitaire chez ce personnel ? Afin de contribuer à la réponse à cette question, nous avons réalisé cette étude qui avait pour objectif général de comparer le profil de la réponse cellulaire adaptative au SARS-CoV-2 du personnel de santé infecté vacciné à celui du personnel infecté non-vacciné à Abidjan.

Méthode : Une étude transversale, a été menée pendant trois mois, chez le personnel de santé infecté par le SRAS-CoV-2, des CHU d'Abidjan dont 52 avaient été vaccinés contre la COVID-19 sur les 106 participants. La numération des lymphocytes TCD4+ et TCD8+ a été réalisée sur le cytomètre de flux BD FACS CANTOTM II après marquage des lymphocytes par des anticorps spécifiques couplés à des fluorochromes. Les données ont été analysées par le logiciel SPSS version 22.0 considérant une valeur $p < 0,05$ comme une différence significative.

Résultats : Sur les 106 participants, le sexe féminin prédominait dans 64,2% des cas avec un sex-ratio à 0,56. Les catégories professionnelles les plus représentées étaient les médecins, les infirmiers et les aides-soignants. Les taux des lymphocytes T CD4+ chez les infectés vaccinés et les infectés non-vaccinés contre le COVID-19 étaient approximativement les mêmes. Cependant, les taux des lymphocytes T CD8+ étaient légèrement plus élevés chez les infectés vaccinés par rapport aux infectés non vaccinés.

Conclusion : L'immunité hybride (primovaccination associée à une infection naturelle) semble meilleure que l'infection naturelle induite par le SRAS-Cov-2. Par ailleurs, ce constat reste limité par la non-réalisation de la numération des lymphocytes T CD8+ mémoires qui nous aurait permis une meilleure appréciation des résultats.

Mots clés : Lymphocytes T, Agents de Santé, Vaccination, COVID-19, Abidjan

[C055] Enablers to the implementation of one health strategies in developing countries

Danièle Sandra Yopa¹, Douglas Mbang Massom², Gbetogo Maxime Kiki³, Ramde Wendkoaghenda Sophie⁴, Sylvie Fasine⁵, Oumou Thiam⁶, Lassane Zinaba⁷, Patrice Ngangue⁸

1.Faculty of Medicine and Biomedical Sciences, University of Yaounde 1, Cameroon

2.Faculty of Medicine and Pharmaceutical Sciences, University of Douala, Cameroon

3.Laval University, 2325 University Street, Quebec, QC G1V 046

4.Ministry of Health and Public Hygiene, Burkina Faso

5.National Institute of Biomedical Research, Ministry of Public Health, Democratic Republic of Congo

6.Ministry of Health and Public Hygiene, Guinea

7.Institute for Interdisciplinary Training and Research in Health Sciences and Education, Burkina Faso

8.Faculty of Nursing Sciences, Université Laval, Quebec, Canada

Introduction: One Health (OH) is a concept that establishes the link between humans, animals and the environment in a collaborative approach. Since OH's inception, several interventions have been developed in many regions and countries worldwide to tackle complex health problems, including epidemics and pandemics. In the developed world, many collaborative platforms have been created with an international strategy to address issues specific or not to their environment. However, there is limited knowledge about the facilitating factors and the existing opportunities LMICs have to efficiently implement OH interventions.

Methods : Following The Preferred Reporting Elements for PRISMA Systematic Reviews and Meta-Analyses (PRISMA), we conducted a systematic review. We applied a search strategy to electronic bibliographic databases (PubMed, Embase, global health, Web of Science and CINAHL). We assessed the included articles' quality using the Mixed Methods Appraisal tool (MMAT). A total of 424 articles were initially identified through the electronic database search. After removing duplicates (n = 68), 356 articles were screened for title and abstract, and 16 were retained for full-text screening.

Results : We identified numerous enabling factors such as the existence of a reference framework document for One Health activities, good coordination between the different sectors at the various levels, the importance of joint and multisectoral meetings that advocated the OH approach and the availability of funds and adequate resources coupled with the support of Technical and Financial partners.

Conclusion: One Health strategy and interventions must be implemented widely to address the rising burden of emerging infectious diseases, zoonotic diseases, and antimicrobial resistance. Reinforcing the enablers to promote managing global health challenges is necessary.

Mots clés : Enablers, One Health, interventions, LMICs

[C057] Evaluation de l'efficacité et de la tolérance des vaccins anti-COVID-19, Côte d'Ivoire, 2022

Ahoussou Eric Martial Kouakou^{1,2}, Douba Alfred^{1,2}, Akani Bangaman Christian^{1,2}, Oussou Konan Roland^{1,2}, Ano Ama Kounangui Marie Noëlle^{1,2}, Djoman-Mangou Christiane Antoinette^{1,2}, Abina-Ebrotie Audrey Marie-Michelle^{1,2}, Konan Loukou Gilbert^{1,2}, Samassi-Sokodogo Awa², Aka Lepri Bernadin Nicaise^{1,3}, Ekra Kouadio Daniel^{1,3}, Issaka Tiembre^{1,2}, Dagnan N'cho Simplicie¹

1.Département de Santé Publique et Spécialités, UFHB, Côte d'Ivoire

2.Institut National d'Hygiène Publique, MSHPCMU, Côte d'Ivoire

3.Direction de Coordination du Programme Elargi de Vaccination, MSHPCMU, Côte d'Ivoire

Introduction : Le Comité National d'Experts Indépendants pour la Vaccination et les Vaccins de Côte d'Ivoire (CNEIV-CI) a réalisé une étude pour déterminer la tolérance et la durée de protection des vaccins contre le Covid-19 après une série complète.

Méthode : Une étude transversale à visée analytique a été réalisée dans les 10 districts sanitaires d'Abidjan de février 2022 à août 2023. Elle a inclus les personnes âgées de 18 ans et plus, complètement vaccinées contre la COVID-19 entre mars 2021 et octobre 2022. Les variables étudiées étaient les caractéristiques sociodémographiques, le type de vaccin, le nombre de doses reçues, les effets indésirables et les taux d'anticorps. Les données ont été collectées à l'aide d'un questionnaire. Les échantillons de sang prélevés ont été analysés au laboratoire d'immunologie du CHU de Cocody. Les données ont été analysées à l'aide du logiciel Epi-Info7.

Résultats : Au total 2085 sujets vaccinés ont été enquêtés. Parmi ceux-ci, 1% (21) ont développé des taux d'anticorps faibles (<250 BAU/ml). Par contre, 99% ont développé des anticorps protecteurs avec un taux moyen de 2053 BAU/ml. Ce taux moyen n'a pas varié avec les types de vaccin, l'âge, le sexe, la vaccination complète à une dose ou deux doses ou trois doses ($p < 0,05$). Les taux moyens d'anticorps produits à 3, 6, 9 et 12 mois pour les vaccins (AstraZeneca, Janssen et Pfizer) ne différaient pas significativement d'un vaccin à un autre. Environ 26% des sujets vaccinés ont présenté des événements indésirables mineurs à type de douleurs au point d'injection (63%) et de fièvre (48%). Aucun cas de MAPI grave n'a été rapporté.

Conclusion : Le taux moyen d'anticorps produits est à un niveau protecteur jusqu'à 12 mois et les vaccins sont bien tolérés. Le CNEIV-CI recommande que les rappels de vaccins COVID-19 soient effectués 12 mois après la dernière dose.

Mots clés : Efficacité, tolérance, vaccin, COVID-19, Côte d'Ivoire

[C058] Incidence élevée des grossesses chez les adolescentes infectées par le VIH en milieu urbain en Afrique de l'Ouest

Amédée Junior Wawa¹, Désiré Lucien Dahourou^{2,3,4}, Clément Tisseron^{3,4}, Marie-Sylvie N'Gbeche⁵, Caroline Yonaba⁶, Corinne Moh⁵, Kouakou Kouadio¹, Patricia Nindjin¹, François Eboua⁷, Belinda Bouah⁷, Karen Malateste⁸, Jean-Claude Azani⁹, Eulalie Kangah⁹, Elisabeth Thio¹⁰, Julie Jesson^{3,4}, Philippe Msellati⁹, Valériane Leroy^{3,4}

1.CIRBA, Abidjan, Côte d'Ivoire)

2.Département Biomédical et de Santé Publique, Institut de Recherche en Sciences de la Santé (IRSS/CNRST), Ouagadougou, Burkina Faso

3.Center for Epidemiology and Research in POPulation Health (CERPOP)

4.Inserm, Université de Toulouse III, Toulouse, France)

5.CePReF, Abidjan, Côte d'Ivoire

6.Université Joseph Ki-Zerbo, Département de pédiatrie, Ouagadougou, Burkina Faso)

7.Centre de Traitement Ambulatoire Pédiatrique, CHU Yopougon, Abidjan, Côte d'Ivoire)

8.Bordeaux Population Health - Centre INSERM U1219, Université de Bordeaux, Bordeaux, France)

9.Programme ANRS-PACCI, Abidjan, Côte d'Ivoire)

10.Centre de Recherche Internationale pour la Santé, Ouagadougou, Burkina Faso)

Introduction : Les adolescentes vivant avec le VIH (AVVIH) font face à des enjeux importants en termes de sexualité et santé reproductive (SSR). Elles sont exposées au risque de grossesse non désirée, ce qui peut compromettre leur prise en charge et leur devenir. Nous avons estimé l'incidence des grossesses et décrit le vécu de la grossesse chez les AVVIH.

Méthode : Nous avons conduit une étude mixte, quantitative auprès des 111 AVVIH de plus de 14 ans suivies ans le projet OPTIMISE-AO-ANRS 12390 (renforçant l'annonce et l'observance au traitement antirétroviral) à Abidjan et à Ouagadougou mesurant l'incidence des grossesses pour 100 personnes-années (PA) à 18 mois ; complétée à Abidjan, par une étude qualitative avec des entretiens semi-directifs en français avec 8 adolescentes ayant été enceintes.

Résultats : Après 18 mois de suivi, 12 grossesses ont été rapportées pour 153 PA, soit un taux d'incidence de 7,8/100PA (intervalle de confiance à 95 % [IC95%] : 4,4-13,7). Stratifié sur l'âge, l'incidence des grossesses était de 2,19 (IC95%: 0,3-15,5), 7,6 (IC95%: 2,8-20,3), 13,1 (IC95% : 5,4-31,4), 11,5 (IC95%: 2,8-45,8) pour 100PA chez les adolescentes âgées de 14, 15, 16 et 17 ans, respectivement. Toutes les grossesses ont été déclarées non désirées. Pour les huit adolescentes à Abidjan, la découverte de la grossesse a été un choc, avec comme conséquences le rejet de l'entourage, des tentatives d'avortement provoqué, la déscolarisation et la mauvaise observance au traitement antirétroviral. Les six enfants nés ont tous reçu une prophylaxie de la transmission mère-enfant du VIH ; les autres grossesses sont en cours. Trois de ceux de plus de 2 mois ont eu un diagnostic précoce du VIH à 6 semaines, tous non-infectés.

Conclusion : Il est urgent de mettre en place des interventions visant à répondre aux besoins de SSR des AVVIH en Afrique de l'Ouest.

Mots clés : Adolescents, VIH, Sexualité, santé reproductive

[C059] Identification des barrières à la disponibilité des antiépileptiques au Gabon

Ibinga Euloge^{1,2}, Bisvigou Ulrick Joly^{1,2}, Maghendji Nzondo Sydney^{1,2}

1.Université des Sciences de la Santé, Département d'Epidémiologie Biostatistique et Informatique Médicale (DEBIM)

2.Unité de Recherche en Epidémiologie des Maladie Chroniques, Santé Environnement (UREMSCE), Libreville, Gabon

Introduction : En Afrique, l'insuffisance des ressources, la faible accessibilité aux antiépileptiques et leur coût élevé contribuent au déficit thérapeutique des sujets souffrant de l'épilepsie. L'objectif de l'étude était d'évaluer les barrières à la disponibilité des antiépileptiques au Gabon

Méthode : Il a été réalisé une étude observationnelle transversale quantitative (chez les sujets souffrant de l'épilepsie, dans les officines et les médecin) et qualitative (auprès les organes administratifs des grossistes répartiteurs). Les résultats des deux approches avaient été intégrés dans un diagramme d'Ishikawa pour identifier les barrières à la disponibilité des anti-épileptiques.

Résultats : Il a été inclus 135 sujets dont 7 médecins, 25 responsables de pharmacies et 103 sujets souffrant de l'épilepsie, l'office pharmaceutique national, l'Agence du Médicament et deux grossistes répartiteur. Les sujets qui avaient un traitement antiépileptique représentaient de 97,1%(100). La rupture du traitement était de 44,8% (39) des sujets traités par monothérapie et de 61,5% (8) pour les sujets qui bénéficiaient d'une bithérapie. La rupture du traitement était significativement associée au lieu d'approvisionnement en antiépileptique, à la durée du traitement du traitement. Les ruptures des stocks étaient retrouvées dans 86% d'officines. L'Office Pharmaceutique National ne disposait pas de stocks d'antiépileptique. Il avait été retrouvé que la commande des antiépileptiques reposait sur une collaboration entre les officines, les grossistes répartiteurs et l'agence du médicament. Cette collaboration obéissait à longue et lourde procédure administrative pour l'obtention des autorisations d'importation. Aussi, les quantités annuelles à importer étaient soumises à un quota.

Conclusion : Les procédures administratives d'importation, les ruptures de stocks chez les grossistes et dans les officines, les modalités thérapeutiques, la durée du traitement contribueraient à l'inaccessibilité au traitement des sujets souffrant de l'épilepsie. L'identification ces barrières devrait servir à la sensibilisation des différentes administrations pour améliorer l'observance et la qualité de vie des sujets souffrant de l'épilepsie.

Mots clés : Barrière - Disponibilité - Antiépileptique - Gabon

[C060] Facteurs associés à de la recherche des soins suite à une morsure à risque rabique au Gabon.

Ibinga Euloge^{1,2}, Makaya Igor³, Maghendji Nzondo Sydney^{1,2}

1.Université des Sciences de la Santé, Département d'Epidémiologie Biostatistique et Informatique Médicale (DEBIM),

2.Unité de Recherche en Epidémiologie des Maladie Chroniques, Santé Environnement (UREMSCE), Libreville, Gabon

3.Programme de lutte contre les maladies Infectieuses

Introduction : La rage est une zoonose virale hébergée par les animaux à sang chaud. Elle touche plus de trois-quarts des populations rurales. La vaccination post-exposition, seul traitement curable, reste peu accessible dans les pays en développement. Au Gabon, peu données sont disponibles sur la rage. Ce travail avait pour objectif d'identifier les facteurs associés à la recherche des soins chez les sujets ayant subi une morsure à risque rabique.

Méthode : Il a été réalisé une étude rétrospective descriptive et analytique à partir des données des registres, couvrant la période janvier 2017 à décembre 2019, des structures sanitaires des communes d'Akanda, Libreville et Owendo et quelques autres localités du Gabon. L'âge moyen des sujets suivant les structures sanitaires de pris en charge a été comparé avec le test l'analyse de variance. Un lien a été recherché entre d'une part l'âge, le sexe, le lieu de vie de l'animal et d'autre part l'administration de la première dose du traitement en estimant l'Odds-Ratio et son intervalle de confiance. Le seuil de significativité a été fixé à 5%.

Résultats : Il a été inclus 352 cas de morsures suspectes de rage. L'âge médian des sujets ayant été mordus était de 26 ans. Le chien a été impliqué dans les morsures 91,2% (321) dont 5,3% (11) étaient vaccinés. La Direction générale de l'élevage était la structure la plus fréquentée par les sujets mordus 47,5% (153). Il n'a pas été retrouvé de lien entre l'âge moyen des sujets mordus et la fréquentation d'une structure sanitaire ($p=0,74$). Le statut domiciliaire de l'animal était un facteur limitant la réception de la première dose de la prévention post-exposition (OR= 0,3 ; IC95% : [0,2 – 0,5]).

Conclusion : L'accessibilité au traitement prophylactique post-exposition doit être améliorée en la rendant disponible dans toutes les structures sanitaires urbaines et rurales.

Mots clés : Morsure - Rage – Soins – Gabon

[C064] Étude des accidents du travail dans une entreprise du Bâtiment et des Travaux Publics (BTP) à Abidjan de 2017 à 2021

Aholia Cyriaque¹, Kilanko Grace¹, Breml Privat¹, Kohion Aristide¹, N'goan Pacome¹, Anoh Etche², Guiegui Chimene^{2,3}, Aka Irel^{2,3}, Tchicaya Aime², Kouassi Mathias^{2,3}, Wognin Sangah², Bonny Jean-Sylvain²

1. Service de médecine du travail et pathologie professionnelle. Centre Hospitalier et Universitaire d'Angré, Abidjan – Côte d'Ivoire

2. Département de santé publique et spécialités. UFR Sciences Médicales, Université Félix Houphouët-Boigny. BP V 166 Abidjan - Côte d'Ivoire

3 Service de médecine du travail et pathologie professionnelle. Centre Hospitalier et Universitaire d'Angré, Abidjan – Côte d'Ivoire

Introduction : Les accidents du travail (AT) figurent parmi les principaux problèmes de santé retrouvés en milieu professionnel et le secteur du BTP (bâtiment et des travaux publics) est l'un des plus touchés.

Méthode : Il s'est agi d'une étude rétrospective descriptive des accidents du travail d'une entreprise de BTP d'août 2022 à février 2023. L'étude a concerné l'ensemble des dossiers des travailleurs victimes d'AT enregistrés dans le service de santé au travail durant la période de 2017 à 2021. Les données ont été recueillies à l'aide de fiches de collecte et traitées à l'aide du logiciel Epi Info 7.

Résultats : Sur 133 dossiers d'accidents du travail la quasi-totalité des accidentés était de sexe masculin (96,2%) avec une moyenne d'âge de 35,49 +/- 7,02 ans et 87,2% avait moins de 5 années d'ancienneté professionnelle. Les manœuvres et les ouvriers représentaient 82,7 % des victimes d'accidents du travail et 57,89% n'étaient pas scolarisés. Les accidents du travail survenaient principalement au cours des manutentions manuelles (46,6 %) et mécaniques (15,8 %). Les principaux agents matériels incriminés étaient le moule (21,8%), les barres de fer (12,8%) et les véhicules (10,5%). Les lésions prédominaient aux membres inférieurs (27,1 %) et supérieurs (24,9 %). La quasi-totalité des accidents recensés étaient des accidents de travail proprement dit (91,7%). Pour ce qui est des conséquences médico-légales les AT ont nécessité des Incapacités Temporaires de Travail (ITT) d'une durée moyenne de 19,7 jours. Par ailleurs 9,50% des accidentés avaient bénéficié d'un changement de poste de travail.

Conclusion : Le moyen le plus efficace pour réduire l'incidence des accidents du travail demeure la prévention qui exige une étroite collaboration entre les différents acteurs du milieu professionnel.

Mots clés : Accidents du travail -Secteur BTP-Abidjan

[C066] Profil de Résistance des Microorganismes issus de l'Environnement Hospitalier de deux CHU du sud Bénin

Soclo Dansi Senami Evelyne¹, Degbey Comlan Cyriaque¹

1. Institut Régionale de Santé Publique – Comlan Alfred QUENUM Ouidah, CNHU-HKM Cotonou

Introduction : L'environnement hospitalier est un maillon capital dans la diffusion et la transmission des microorganismes résistants aux antibiotiques dans les centres hospitaliers. Ce phénomène est considéré comme un problème de santé publique associé à une morbidité et une létalité élevées. L'Objectif de ce travail était d'étudier le profil de résistance des microorganismes issus de l'environnement hospitalier de deux CHU du Sud du Bénin.

Méthode : il s'agissait d'une étude transversale et descriptive dans les services de réanimation, de pédiatrie, du bloc opératoire et des urgences du CNHU-HKM et de CHUZ d'Abomey-calavi. Les prélèvements ont été effectués à l'aide d'écouvillons stériles et de bio-collecteur. La mise en culture est faite sur des milieux spécifiques. Les germes ont été identifiés par la galerie API 20E. Le profil de résistance aux antibiotiques a été déterminé par l'antibiogramme en milieu gélosé.

Résultats : Sur 241 échantillons prélevés, 203 (84%) étaient positifs avec identification de 436 microorganismes pathogènes. La répartition de ces germes montre une prédominance des entérobactéries à 30,96% avec 23,23% de *Klebsiella pneumoniae*. *Acinetobacter* et *Pseudomonas* étaient respectivement de 18 et de 12%. *Staphylococcus aureus* et *Staphylococcus* à coagulase négative étaient respectivement de 11% et de 23,17%. Les entérocoques étaient de 11,70% et les *Bacillus* 18, 35%. L'analyse du profil de résistance a montré que 80, 7% des Entérobactéries produisaient une bêta-lactamase à spectre élargi. 70, 83% de souche de *Staphylococcus aureus* étaient résistants à la méticilline.

Conclusion : l'environnement hospitalier, constitue un nid de microorganismes résistants aux antibactériens. Il doit être régulièrement évalué à travers une surveillance de l'écologie microbienne et de la résistance bactérienne.

Mots clés : profil de résistance, microorganisme, environnement hospitalier, CHU, Bénin

[C067] Evaluation de la qualité du test au sulfure d'hydrogène sur bande de papier modifié pour le contrôle de contamination fécale de l'eau de consommation

Soclo Dansi Senami Evelyne¹, Degbey Comlan Cyriaque¹

1. Institut Régionale de Santé Publique – Comlan Alfred QUENUM Ouidah, CNHU-HKM Cotonou

Introduction : Le coût et la complexité des méthodes conventionnelles d'analyse microbiologique pour la détection des bactéries indicatrices de la contamination fécale, notamment les coliformes fécaux, entravent le contrôle de qualité de l'eau de consommation, en particulier dans les pays à faible revenu. Cette étude avait pour objectif d'évaluer le test au sulfure d'hydrogène (H₂S) sur bande de papier de Manja qui est une méthode de détection des coliformes, simple et peu coûteuse qui pourrait être mise en œuvre au niveau communautaire.

Méthode : Après la modification du test H₂S appelé « self test », il a été comparé à un milieu de culture de référence « Rapid' E. Coli » considéré comme un « gold standard ». Pour ce faire, une étude a été réalisée auprès de 300 ménages dans l'arrondissement d'Agamè dans le département du Mono.

Résultats : Les résultats de cette étude ont montré que, pour le test de référence Rapid'E. Coli, les coliformes fécaux sont présents dans 92% (276/300) des échantillons et le test H₂S donnait des résultats positifs dans 88% (264/300) des échantillons. Le temps minimum de réaction du test (H₂S) était de 15h, sa sensibilité était de 95,28% (263/276) et sa spécificité de 95,83% (23/24) avec une Valeur Prédictive Positive (VPP) de 99,62% et une Valeur Prédictive Négative (VPN) de 72,22%. Son Coefficient kappa ($\kappa = 0,7419$).

Conclusion : Il existe une concordance réelle de 74,19% entre le test au sulfure d'hydrogène (Self Test) et le Rapid'E. Coli. Ce résultat témoigne d'une concordance satisfaisante entre les deux tests.

Mots clés : Evaluation, qualité, test au sulfure d'hydrogène, contamination fécale, eau de consommation.

[C075] Disponibilité des prestataires de soins à fournir des soins complets d'avortement en Afrique sub-saharienne : une revue systématique qualitative de la littérature

Compaore Rachidatou^{1,2}, Kouanda Seni^{1,2}

1.Institut de Recherche en Sciences de la Santé (IRSS/CNRST), Ouagadougou

2.Ecole Doctorale Sciences, Santé et Technologies (ED2ST/USTA), Ouagadougou

Introduction : Cette étude visait à comprendre comment la connaissance de la loi, les facteurs contextuels et individuels influençaient la disponibilité des agents de santé à fournir des services de soins complets d'avortement en Afrique subsaharienne.

Méthode : Nous avons conduit une revue systématique qualitative de la littérature de 47 articles scientifiques, rapports d'études et chapitres de livres, à travers une recherche électronique et un examen des références bibliographiques de tous les articles sélectionnés dans trois bases de données. Toutes les publications portant sur les attitudes des agents de santé impliqués dans la fourniture de soins d'avortement complets dans des pays africains subsahariens ayant entrepris des réformes sur leurs lois et politiques de santé sur l'avortement depuis 1995 ont été incluses. Une évaluation critique et une analyse thématique pour synthétiser les données extraites ont été réalisées.

Résultats : La loi était souvent méconnue ou jugée ambiguë par les agents de santé qui, par ailleurs étaient confrontés en général à un dilemme éthique et moral entre leurs valeurs morales et religieuses en conflit avec leurs obligations professionnelles et leur préoccupation pour la santé des femmes. En réponse à ces préoccupations personnelles et aux influences contextuelles, les agents de santé exerçaient souvent un pouvoir discrétionnaire sous forme d'objection de conscience, notamment en Afrique du Sud et au Ghana. Le manque de connaissance de la loi révisée par le grand public et les agents de santé, la stigmatisation sociale et institutionnelle, le manque d'engagement politique et des ressources financières, structurelles et matérielles nécessaires pour mettre en place des services de qualité et faire connaître ces services influençaient les attitudes des agents de santé.

Conclusion : Une approche multidimensionnelle est nécessaire pour améliorer la disponibilité des agents de santé à offrir des services d'avortement sécurisé par le renforcement du cadre juridique et des capacités individuelles et institutionnelles.

Mots clés : Agents de santé ; Soins complets d'avortement ; Disponibilité ; attitudes ; Objection de conscience; Afrique subsaharienne

[C076] Evaluation du système de surveillance intégrée de l'influenza aviaire hautement pathogène en Côte d'Ivoire à travers la riposte face à l'épizootie de 2021 à Grand-Bassam.

Keita Ibrahima Mamby^{1,2}, Seck Rosalie Martine Ndew¹, Kouakou Yao Christophe^{2,3}, Ouattara Douyeri Thierry^{3,4}, Kallo Vessaly^{3,4}, Thys Severine⁵, Antoine-Moussiaux Nicolas¹, Bonfoh Bassirou^{1,6}, Kone Valentin Bognan⁵, Tiembre Isaac^{7,8}

1. Master de spécialisation en Gestion intégrée des Risques sanitaires (MSpé. GIRIS) et Université de Liège (ULiège)
2. Direction départementale de la Santé animale (DDSA) de Jackville
3. Ministère des Ressources animales et halieutiques (MIRAH)
4. Direction des Services vétérinaires (DSV)
5. MSpé. GIRIS et Université de Montpellier (CIRAD)
6. Centre Suisse de Recherches en Scientifiques (CSRS)
7. Institut national d'Hygiène publique (INHP)
8. Ministère de la Santé et de l'Hygiène publique (MSHP)

Introduction : Etant le plus ubiquitaire et endémique des sous-types d'influenza aviaire hautement pathogène (IAHP), H5N1 persiste en Côte d'Ivoire malgré les efforts de lutte. La coordination et l'opérationnalisation de la surveillance intégrée de maladie et la riposte (SIMR) reste un défi d'où l'étude de la gestion de la riposte de 2021 à Grand-Bassam.

Méthode : Une étude transversale, rétrospective et phénoménologique était réalisée en mai 2023 sur le vécu des acteurs de la SIMR à Grand-Bassam. L'échantillonnage raisonné était guidé par les répondants (n=22 acteurs centraux et périphériques) sur base du principe de saturation. Des entretiens semi-structurés selon les fonctions de SIMR ont permis une analyse thématique avec le logiciel QDAMinerLite (version 1.4.1). La réflexivité était gérée par un carnet de bord. L'étude s'est réalisée dans le respect des règles éthiques, environnementales et du bien-être animal.

Résultats : Cinq thèmes émergeaient de l'analyse des données. Une coordination systémique, transdisciplinaire et décentralisée était effective grâce aux leçons apprises bien intégrées dans la police sanitaire pendant la préparation. Cependant la culture d'évaluation formative intégrée de la lutte n'était pas très présente. La communication sur les risques et l'engagement communautaire était un facteur clé de la riposte et a réduit la psychose, augmenté la confiance, la prise de conscience des communautés et l'appropriation de la riposte. La prévention et le contrôle proactifs (abattages anticipés) et écologiques (gestion des cadavres) de l'infection ont vu l'adhésion des aviculteurs et des maires aux principes de nettoyage et désinfection. La surveillance s'est caractérisée par une vigilance et une réactivité sur le terrain avec des investigations conjointes à travers la plateforme One Health. La gestion des ressources, marquée par leur mutualisation, devrait y associer l'indemnisation opportune, la disponibilité des fonds d'urgences et la digitalisation de la SIMR.

Conclusion : La clé d'une riposte intégrée réside dans sa transdisciplinarité et sa préparation.

Mots clés : IAHP, Surveillance intégrée de maladies et riposte, Perceptions, Grand-Bassam.

[C077] Analyse intégrée des perspectives des décideurs dans la lutte contre l'influenza aviaire hautement pathogène en Côte d'Ivoire avec la méthodologie « Soft system » de Checkland.

Keita Ibrahima Mamby¹, Seck Rosalie Martine Ndew¹, Kouakou Yao Christophe^{2,3}, Ouattara Douyeri Thierry^{3,4}, Kallo Vessaly^{3,4}, Melard François¹, Antoine-Moussiaux Nicolas¹, Bonfoh Bassirou^{1,5}, Irabor Thomas-Julian¹, Tiembre Isaac^{6,7}

1. Master de spécialisation en Gestion intégrée des Risques sanitaires (MSpé. GIRIS) et Université de Liège (ULiège)
2. Direction départementale de la Santé animale (DDSA) de Jackville
3. Ministère des Ressources animales et halieutiques (MIRAH)
4. Direction des Services vétérinaires (DSV)
5. Centre Suisse de Recherches en Scientifiques (CSRS)
6. Institut national d'Hygiène publique (INHP)
7. Ministère de la Santé et de l'Hygiène publique (MSHP)

Introduction : La lutte contre l'influenza aviaire hautement pathogène (IAHP) nécessite une stratégie intégrée, synchrone, participative et inclusive pour être efficiente. En Côte d'Ivoire, elle est décentralisée et incluse dans la police sanitaire mais manque de vision commune et de ponts stables d'échanges intersectoriels pour une planification conjointe sur les défis sanitaires majeurs. De nouvelles méthodes sont nécessaires pour l'identification de leviers d'actions à travers les perspectives des décideurs sectoriels clés de la lutte intégrée.

Méthode : Une étude qualitative transversale, rétrospective a été réalisée en mai 2023, avec les décideurs nationaux des secteurs (publics et privés) des santés humaine, animale et environnementale, en Côte d'Ivoire. L'échantillonnage raisonné était guidé par sept répondants sur la base du principe de saturation. Une grille d'entretien semi-structurée selon les composantes CATWOE (Smyth D. & Checkland P. en 1975) a permis l'analyse, des perspectives des décideurs enquêtés, avec le logiciel QDAMinerLite (version 1.4.1). La réflexivité était gérée par un carnet de bord d'enquêteurs.

Résultats : Trois perspectives émergeaient selon le profil des décideurs. Les vétérinaires (2) prônaient pour un monde mieux préparé à faire face à l'IAHP avec des exercices de simulation, investigations et formations conjointes, créations de pôles régionaux réactifs et autonomes à plateau technique relevé, etc. Le secteur privé de la filière avicole (1) avec l'idée de fonds communs pré-mobilisés à travers la cotisation d'aviculteurs pour faciliter les indemnités futures. Les médecins (2) priorisaient le partage intersectoriel d'informations digitalisées en temps réel, la mutualisation de ressources et l'intégration des réseaux de surveillances existants. Les environnementalistes (2) étaient dans une dynamique d'intégrer les aspects d'autres secteurs clés dans leurs outils sectoriels de surveillance afin d'être plus alertes et proactifs dans les dynamiques écologiques.

Conclusion : La préparation conjointe, le décloisonnement, l'anticipation et la mutualisation des ressources proportionnellement aux bénéfices sont les leviers clés de la lutte intégrée.

Mots clés : IAHP, Intégration, Processus de transformation, Perspectives des décideurs, CI.

[C083] Impact de la Covid-19 sur les activités des pharmacies d'officine dans la ville de Lomé en 2020

Fifonsi Adjidossi Gbeasor-Komlanvi^{1,2}, Kossi Mawuko Noël Doleagbenou¹, Agbelenko Kossivi Afanvi¹, Innocent Kpeto³, Mounerou Salou¹, Martin Kouame Tchankoni², Didier Koumavi Ekouevi^{1,2}

1. Université de Lomé, Faculté des Sciences de la Santé, Lomé, Togo,
2. Centre Africain de Recherche en Epidémiologie et en Santé Publique
3. Ordre National des Pharmaciens du Togo

Introduction : Au 05 mars 2020, le Togo a enregistré son premier cas de Covid-19. Un couvre-feu et la fermeture des frontières ont été adoptés pour freiner la propagation de la maladie. Le rôle des pharmacies d'officine est de mettre à la disposition du public et sans interruption les produits de santé. L'objectif de cette étude était de décrire l'impact de la Covid-19 sur les activités pharmaceutiques dans le Grand-Lomé en 2020.

Méthode : Une étude transversale a été réalisée auprès des pharmaciens d'officine du Grand-Lomé de juillet à octobre 2020. Un questionnaire en ligne a été utilisé pour le recueil des données sociodémographiques, l'impact de la Covid-19 sur les activités, les mesures de protection et l'impact psychologique de la Covid-19.

Résultats : Trente-neuf pharmaciens (28,2% d'hommes) d'âge médian 50 ans, intervalle interquartile [39-55] ont été recrutés. Parmi eux, 7,7% avaient fermé leur pharmacie et 10,4% avaient interrompu les tours de garde. Une pénurie a été rapportée pour l'insuline (62,5%), les anticancéreux (40,6%), les antihypertenseurs (40,6%). Des ruptures de masques (87,9%) et solutions hydro-alcooliques (81,8%) ont été rapportées. Tous les pharmaciens ont mis en place des mesures de protection pour le personnel et les clients. Un cas d'anxiété liée à la Covid-19 a été rapporté chez un pharmacien.

Conclusion : La Covid-19 a affecté la disponibilité des traitements de certaines maladies chroniques. Un plan d'adaptation de l'approvisionnement et du fonctionnement des pharmacies doit être élaboré pour éviter la pénurie en produits de santé en cas de crise sanitaire.

Mots clés : Covid-19 ; impact ; activités des pharmacies ; Grand-Lomé ; Togo.

[C085] Facteurs associés à la planification familiale au Sénégal en 2019

Sougou Ndeye Mareme¹, Ba Fally², Seck Ibrahima¹

1. Service de Médecine préventive et santé publique, Université Cheikh Anta Diop, Dakar

2. Institut de Santé et Développement, Université Cheikh Anta Diop de Dakar

Introduction : La planification familiale reste une intervention de santé publique prioritaire pour la santé maternelle et néonatale. Plusieurs études ont montré que les femmes en Afrique subsaharienne sont confrontées à de nombreux obstacles socio-culturels et démographiques concernant l'utilisation des méthodes contraceptives modernes l'objectif de cette étude est d'étudier les déterminants de la planification familiale au Sénégal

Méthode : Cette étude est une analyse secondaire des données de l'EDS 2019 au Sénégal. Le fichier IR de l'EDS a été utilisé. La variable dépendante était l'utilisation d'une méthode de contraception moderne qui est une variable binaire. Les variables indépendantes étaient les caractéristiques sociodémographiques des femmes et celles en rapport avec l'accès aux services de planification familiale. Des analyses univariées, bivariées et multivariées avaient été faites. Les analyses avaient été faites avec stata 15.

Résultats : Un total de 8 649 femmes a été inclus dans l'étude. Treize pourcent (13,4%) des femmes de 20-24 ans utilisent les méthodes de contraception moderne. Les femmes du niveau supérieur d'étude utilisent plus la contraception (23,2%). Seul 13,8% des femmes qui étaient sans emploi utilisaient une méthode. Les facteurs associés à la planification familiale étaient le niveau d'instruction (primaire (OR : 1,48 [1,21 ; 1,81], secondaire (OR : 1,37[1,07 ; 1,76]) l'emploi (OR : 1,21 (1,04 ; 1,41), le niveau socio-économique (moyen 1,58 (1,18 ; 2,12), riche (OR : 1,62{1,15 ; 2,27}), le fait d'être mariée(OR : 7,18 [5,29 ; 9,74]) et le fait d'avoir reçu des informations concernant la PF à travers la radio (OR : 1,31 [1,08 ; 1,58]).

Conclusion : Pour adresser la planification, il faudra nécessairement en plus du renforcement de l'accès aux services de planification, des interventions multisectorielles pour lever les barrières sociodémographiques.

Mots clés : Planification familiale, facteurs associés, Sénégal

[C087] Profil épidémiologique des Décès Maternels de la région sanitaire du Guémon, Côte d'Ivoire janvier 2019- juin 2022.

Grah L. Constant¹, Meless David²

1.Médecin chef de l'Action Sanitaire de la région du Guémon

2.Professeur de Santé Publique

Introduction : En Côte d'Ivoire, Selon l'Enquête démographique et de santé (EDS) 2021, le taux de mortalité maternelle est de 315 décès pour 100 000 naissances vivantes. Les données de surveillance des décès maternels de 2018 ont montré que la région du Guémon était au cinquième (5ème) rang parmi les trente et trois (33) régions du pays, avec un taux estimé à 219,11 pour 100 000 naissances. L'objectif de cette étude est d'analyser les données des décès maternels de la région du Guémon de janvier 2019 à juin 2022

Méthode : Il s'agit d'une étude descriptive. Les données ont été extraites de la base MAGPI pour la période de janvier 2019 à juin 2022. Les variables prises en compte ont concerné les caractéristiques sociodémographiques, cliniques et les données de la grossesse. Le traitement et l'analyse des données ont été faits à travers les logiciels Excel et Epi Info 7.2. Des mesures de tendances centrales, des proportions et taux ont été calculés.

Résultats : Au total 110 décès ont été enregistrés entre janvier 2019 et juin 2022. La tranche d'âge de 18 à 35 ans était la plus représentée (73,15%). Dans la majorité des cas (79%), ces décès maternels se sont produits dans le chef-lieu de région qui est Duékoué et les hémorragies du post partum immédiat constituent la cause principale dans 51,82% des cas. Le taux de mortalité a légèrement baissé de 2019 à 2022 mais il reste encore élevé avec 18 décès pour 10 000 naissances vivantes en 2019, 21 décès pour 10 000 naissances vivantes en 2020, 13 décès pour 10 000 naissances vivantes en 2021 et 10 décès pour 10 000 naissances vivantes au premier semestre 2022.

Conclusion : La tranche d'âge de 18 à 35 ans était la plus représentée et L'hémorragie du post partum immédiat demeure la première cause. Cependant nous avons constaté une légère diminution du taux de mortalité dans la région du Guémon sur la période de 2019 à juin 2022. Renforcer la surveillance et l'audit des décès maternels dans la région.

Mots clés : Profil, Décès maternels, Guémon, Côte d'Ivoire

[C089] Utilisation des services de soins prénatals et complétude des carnets de consultation : enquête transversale au Togo, 2020

Fifonsi Adjidosi Gbeasor-Komlanvi^{1,2}, Arnold Junior Sadio^{1,2}, Brou Christelle Tano², Martin Kouame Tchankoni¹, Rodion Konu^{1,2}, Baguillabe Douaguibe^{3,4}, Samadou Abdoul Aboubakari^{5,6}, Didier Koumavi Ekouevi^{1,2}

- 1.Centre Africain de Recherche en Epidémiologie et en Santé Publique, Lomé, Togo
- 2.Université de Lomé, Faculté des Sciences de la Santé, Département de Santé Publique, Togo
- 3.Université de Lomé, Faculté des Sciences de la Santé, Département de Gynécologie et Obstétrique, Togo
- 4.Centre Hospitalier Universitaire Sylvanus Olympio, service de Gynécologie et Obstétrique, Lomé Togo
- 5.Université de Kara, Faculté des Sciences de la Santé, Département de Gynécologie et Obstétrique, Togo
- 6.Centre Hospitalier Universitaire de Kara, service de Gynécologie et Obstétrique, Lomé Togo

Introduction : Le carnet de consultation prénatale (CPN) est indispensable pour garantir la continuité et la qualité des soins. Depuis 2016, l'Organisation mondiale de la Santé (OMS) recommande au moins huit CPN durant la grossesse. L'objectif de cette étude était d'estimer la prévalence et les facteurs associés à la complétude des carnets de CPN dans la commune de Lomé en 2020.

Méthode : Une étude transversale à visée descriptive et analytique a été réalisée en 2020 dans deux services d'obstétrique à forte affluence (Centre Hospitalier Universitaire Sylvanus Olympio et de l'hôpital secondaire de Bè) à Lomé. Les femmes en post-partum immédiat disposant d'un carnet de CPN ont été recrutées. Un carnet était défini comme bien rempli si étaient renseignés, (i) les antécédents obstétricaux, (ii) la sérologie VIH, (iii) la sérologie VHB, (iv) le groupage-rhésus et (v) un résultat d'échographie obstétricale.

Résultats : Au total, 404 couples femmes-carnets ont été inclus. L'âge médian des femmes était de 29 ans, étendue interquartile (EIQ) [25-33]. Parmi elles, 75,2% avaient réalisé au moins quatre CPN et 3,2% avaient réalisé au moins huit CPN. Les antécédents obstétricaux, la sérologie VIH, la sérologie VHB, le groupage-rhésus et un résultat d'échographie étaient rapportés respectivement dans 94,3%, 73,5%, 68,6%, 85,1% et 71,5% des carnets. Sur la base des cinq critères majeurs, 36,4% des carnets étaient correctement remplis. Avoir un niveau socio-économique « moyen ou élevé » et consulter à l'hôpital secondaire de Bè étaient associés au bon remplissage des carnets.

Conclusion : L'utilisation des services et la qualité du remplissage des carnets de CPN n'étaient pas optimales dans les centres étudiés. Une restructuration des services dans les centres à forte affluence, ainsi que des campagnes de sensibilisation doivent être envisagées pour améliorer la qualité et l'utilisation des services de CPN à Lomé.

Mots clés : Consultation prénatale ; remplissage des carnets ; facteurs associés ; Togo.

[C091] Portage asymptomatique des plasmodies et microfilaires sanguicoles chez les donneurs de sang au CNTS d'Abidjan en 2022

Dou Gonat Serge Pacôme¹, Adjo Gl², Tamboura Mta², Nassoue Dmo², Aka Nad¹, Adoubryn Kd¹

1.Laboratoire de Parasitologie, UFRSM, UFHB

2.Laboratoire de Parasitologie, CHU Cocody

Introduction : Introduction : La transfusion sanguine peut être à l'origine de la transmission des parasites sanguicoles. Cependant, en Côte d'Ivoire, les parasites sanguicoles endémiques tels que les microfilaires et les plasmodies ne font l'objet d'aucune recherche lors des dons de sang.

Objectif : Rechercher les plasmodies et microfilaires sanguicoles chez les donneurs de sang au Centre national de transfusion sanguine à Abidjan.

Méthode : Il s'agissait d'une étude transversale descriptive, réalisée du 20 juin au 20 juillet 2022 au Centre National de Transfusion Sanguine d'Abidjan. Elle a concerné les personnes venues dans ledit centre pour don de sang. Pour chaque donneur ayant accepté de participer à l'étude, il a été réalisé un frottis sanguin, une goutte épaisse et une leuco- concentration selon la technique de KNOTT.

Résultats : Au total 369 donneurs ont participé à notre étude dont 321 hommes ; soit un sex-ratio de 6,7. L'âge moyen des donneurs de Sang était de 36 ans. Les donneurs ayant moins de 50 ans représentaient 93,3 % des cas. Seuls 21,3 % des donneurs utilisaient la moustiquaire imprégnée comme moyen prophylactique. La prévalence du portage asymptomatique de *Plasmodium* spp était de 2,7 %. La seule espèce plasmodiale retrouvée était *Plasmodium falciparum*. Aucune microfilarie sanguicole n'a été retrouvée.

Conclusion : Le portage asymptomatique de plasmodies est une réalité chez les donneurs de sang en CI. Il est donc nécessaire de mettre en place des mesures de lutte contre le paludisme post transfusionnel. Certains donneurs de sang sont porteurs asymptomatique de plasmodies.

Mots clés : Donneurs de sang - *Plasmodium* Spp - microfilaires sanguicoles - CNTS Abidjan - Cote d'Ivoire.

[C092] Utilisation de la plateforme éducative du Global Alliance for Rabies Control (GARC) dans la formation des acteurs de lutte contre la Rage en Côte d'Ivoire.

Djoman Christiane Antoinette¹, Zogbé Sromon Bérengère², Tetchi Sopi Mathilde², Ouattara Douyeri³, Tiembré Issaka^{1,2}

1.Département de santé publique et informatique de l'UFR Sciences Médicales de l'Université FHB

2.Institut National d'Hygiène Publique, Abidjan, Côte d'Ivoire

3.Direction des Services Vétérinaires

Introduction : La rage est une maladie répandue dans le monde et responsable de milliers de morts chaque année. Cette étude avait pour objectif de renforcer les capacités des acteurs de lutte contre la rage afin de les outiller pour l'éducation et la sensibilisation de la communauté.

Méthode : il s'agit d'une étude transversale portant sur les séances de formation en ligne. La séance débute par l'inscription en ligne, lecture des différents modules avec des pré et post tests suivis de l'évaluation finale.

Résultats : Les modules déroulés étaient le Certificat de formateur sur la rage (REC), le Certificat de soins de santé la rage (RHC), le Certificat de manipulation et de Vaccination des Animaux (AVC) et le Certificat de Coordonnateur de la Communauté pour la rage (CCC). Chaque participant est tenu d'obtenir au moins un certificat. La plupart de ces formations sont réalisées au cours des journées mondiales de lutte contre la rage (JMR) et des stages dans les services de prise en charge. Les personnes concernées étaient les agents de santé humaine, de santé animale, leaders communautaires et les enseignants du primaire et du secondaire. La Côte d'Ivoire vient en première position avec 1790 certificats de formateur sur la rage (REC) obtenus et 151 certificats de soins de santé contre la rage (RHC) devant l'Afrique du Sud et le Pakistan. Concernant le Certificat de Coordonnateur de la Communauté pour la rage (CCC), elle est classée en troisième position après le Pakistan et le Nigeria.

Conclusion : L'élimination de la rage à l'horizon 2030 constitue un défi énorme à relever. En Côte d'Ivoire, pour y arriver, les acteurs de lutte contre la rage mettent l'accent sur l'éducation, la formation et la sensibilisation des enfants et des adultes.

Mots clés : Rage, formation, éducation, sensibilisation, communauté.

[C093] Détection de parasites intestinaux humains dans les fruits et légumes commercialisés à Abidjan : étude préliminaire

Dou Gonat Serge Pacôme¹, Nassoue Dmo², Tamboura Mta², Adjo GI², Aka Nad¹, Adoubryn KD³

1.Laboratoire de Parasitologie, UFRSM, UFHB

2.Laboratoire de Parasitologie, CHU Cocody

3.Laboratoire de Parasitologie, UFRSM, UAO

Introduction : Consommer des fruits et légumes est fortement recommandé pour la santé. Cependant, ces derniers peuvent être source de transmission de parasitoses humaines.

Objectif : Contribuer à la connaissance de l'état de salubrité des fruits et légumes consommés crus, commercialisés à Abidjan.

Méthode : Matériel et méthodes : Il s'est agi d'une étude transversale conduite d'avril à juin 2022, dans le district autonome d'Abidjan à la recherche de parasites intestinaux humains sur 5 fruits et légumes qui sont : la laitue, le persil, l'oignon vert, le chou et la tomate. Ces fruits et légumes ont été échantillonnés aussi bien chez les producteurs que sur les marchés. La recherche parasitologique a consisté en l'examen direct de l'eau de rinçage des échantillons associé à des frottis colorés selon la technique de Zielh-Neelsen modifiée.

Résultats : Résultats : La prévalence de l'infestation parasitaire était de 39,2 %. La laitue représentait le légume le plus infesté (77,9 %) suivie de l'oignon vert (75,3 %). Les helminthes étaient les parasites prédominants avec en tête, les ankylostomes (76,8 %). Quant aux protozoaires, il s'agissait d'E. nana et d'E.coli. Les échantillons achetés sur les lieux de production étaient plus infestés que sur les marchés ($p = 0,000$).

Conclusion : Cette étude révèle un taux élevé d'infestation parasitaire des fruits et légumes à Abidjan. Par conséquent, les populations sont exposées au risque de contamination. Des mesures doivent donc être prises par les autorités à l'endroit des commerçants et des consommateurs.

Mots clés : fruits - légumes – parasites intestinaux humains- Abidjan- Côte d'Ivoire.

[C099] Microorganismes isolés des aliments et risques potentiels de toxi- infections alimentaires collectives en Côte d'Ivoire.

Yapi Adompo Jaures Cedric¹, Coulibaly Kalpy Julien², Yao Djeha Rosine², Okpo-Boyoun Sophia¹, Kangah-N'goran Tatiana¹, Dosso Mireille¹

1.Département de Bactériologie-virologie, Institut Pasteur de Côte d'Ivoire

2.Département Environnement et Santé, Institut Pasteur de Côte d'Ivoire

Introduction : La sécurité sanitaire des aliments représente une véritable préoccupation dans les secteurs agroalimentaires et de santé dans le monde. En Côte d'Ivoire, les toxiinfections alimentaires sont à déclaration obligatoire. L'organisation d'un système de surveillance intégré avec investigation microbiologique des matrices incriminées au laboratoire est cruciale. L'objectif de cette étude était d'étudier les microorganismes d'altération responsables potentiels de TIAC.

Méthode : Les échantillons d'aliments ont été prélevés entre Juillet 2020 et Août 2023. Les aliments suspects ont été recueillis lors des investigations de Toxi-infection alimentaires collective dans les différents districts sanitaires. Les données épidémiologiques et cliniques des cas ont été collectées. Les mesures de tendances centrales et de fréquences ont été calculées. La recherche et le dénombrement des germes de contamination et les germes potentiellement pathogènes ont été effectués au Département de Bactériologie-Virologie de l'Institut Pasteur de Côte d'Ivoire selon les normes conventionnelles.

Résultats : Au total, 35 échantillons alimentaires provenant de six épisodes de TIAC ont été colligés. Les districts sanitaires concernés étaient ceux de Korhogo (n=4), Bouaké (n=8), Dabou (n=4), Bondoukou (n=15), Biankouman (n=4). Les aliments les plus incriminés étaient des produits laitiers (27,8%), l'eau de consommation (25%), les pâtisseries (25%). La qualité microbiologique était non satisfaisante dans 28% des cas avec des fréquences respectives de germes d'altération : Anaérobies sulfito-réducteurs (22,8%), Pseudomonas (20%), Escherichia coli (14,3%), Staphylococcus aureus (11,4%), levures (20%), Moisissures (11,4%)

Conclusion : Ces toxi-infections alimentaires collectives surviennent surtout en milieu rural avec des étiologies bactériennes et fongiques diverses. Le renforcement de la surveillance épidémiologique passe par une investigation épidémiologique immédiate et une prompt riposte.

Mots clés : TIAC, Risque, sécurité alimentaire, microorganismes, Côte d'Ivoire

[C100] Evaluation of the meningitis surveillance system in Cameroon after 20 years of implementation

Chanceline Bilounga Ndongo^{1,2}, Linda Easo^{1,3}, Armelle Ngomba^{1,2}, Nestor Atangana Onana¹, Hortense Flore Kamguia Guifo¹, Rosanne Ngome⁴, Sandra Yopa¹, Natacha Nsiewe¹, Laure Ngando^{3,5}, Nadia Mandeng¹, Boris Kompuguep¹, Protas Etene⁶, Nicole Fouda⁷, Emmanuel Douba Epee⁷, Georges Nguefack-Tsague¹, Léon Jules Owona Manga¹, Adama Ndir⁸, Georges Etoundi Mballa Linda Easo^{1,2}, André Bitu Fouda^{2,9}

1. Department for the Control of Disease, Epidemics and Pandemics, Ministry of Public Health, Yaounde, Cameroon
2. Faculty of Medicine and Pharmaceutical Sciences, University of Douala, Cameroon
3. Faculty of Medicine and Biomedical Sciences, Université of Yaounde I, Cameroon
4. Centre Pasteur of Cameroon, Yaounde, Cameroon
5. National Laboratory of Public Health, Yaounde, Cameroon
6. Cameroon Field Epidemiology Training Program, Yaounde, Cameroon
7. World Health Organization, country office, Yaounde, Cameroon
8. Centers for the Control of Disease, country office, Yaounde, Cameroon
9. World Health Organization, Africa office, Brazzaville, Congo

Introduction: Cameroon is part of the meningitis belt and is committed to eliminate meningitis by 2030 and a good surveillance system is required. MenAfriVac project held from 2007 to 2015 improved the meningitis surveillance. Data collected between 2004 and 2022 were analyzed and attributes of the meningitis surveillance system assessed in order to generate evidence for its improvement.

Methods : We conducted a cross-sectional study in 2022 and attributes were assessed using CDC guidelines (2001). Two health districts were chosen per region countrywide. A questionnaire was administered to surveillance staff at different levels of health system. Epidemiologic and laboratory data collected on the field and from DIHS2 were analyzed.

Results : From 2004 to 2022, the number of annual cases notified varied between 366 (in 2008) to 4840 (2019) with a peak of 1465 cases in 2022. There was a decrease in case fatality rate from 14.6% in 2004 to 2.6% in 2022. During this period, 54% of health districts have crossed the alert threshold. All regions have reported suspected cases, with the highest in northern part of the country. After the end of MenAfriVac project in 2015, the most found serotype of microorganism was *Neisseria Meningitidis* W135 followed by serotype A, unlike the classic profile which was dominated by *Neisseria Meningitidis* A. Of the 114 surveillance actors interviewed, 71% were nurses and 82.5% not trained on surveillance. The surveillance system was found useful, acceptable, representative of all health districts. However, the system was complex in structure, unstable and not very sensitive. The positive predictive value varied between 4.29% and 20%.

Conclusion: From 2004 to 2022, there was a decrease of suspected cases and fatality rate of meningitis. The surveillance system was useful but complex in structure. Sustainability of project implemented like Menafrivac and allocated funds should be put in place in Cameroon to achieve 2030 elimination.

Mots clés : Meningitis, surveillance system, attributes, fatality rate, Cameroon

[C106] Public health emergency preparedness through simulation exercise in Cameroon

Chanceline Bilounga Ndongo^{1,2}, Christie Tiwoda¹, Linda Ezzo^{1,2}, Weassam Mankoula³, Mary Stephen⁴, Denis Charles⁵, Avery Kerrethel⁶, Armelle Ngomba^{1,2}, Georges Nguetack-Tsague², Léon Jules Owona Manga², André Bitu Fouda^{2,4}, Georges Etoundi Mballa Linda Ezzo^{1,2}

1. Department for the Control of Disease, Epidemics and Pandemics, Ministry of Public Health, Yaounde, Cameroon

2. Faculty of Medicine and Pharmaceutical Sciences, University of Douala, Cameroon

3. Africa CDC

4. World Health Organization, Africa office, Brazzaville, Congo

5. World Health Organization, Geneva

6. CDC Atlanta

Introduction : Le Cameroun, comme la plupart des pays du monde, est exposé à une diversité de risques sanitaires. Afin d'y faire face, il est recommandé d'organiser des exercices de simulation pour tester et renforcer les capacités nationales de gestion des urgences de santé publique.

Méthode : A l'issue de l'exercice de simulation sur table de la réponse multisectorielle à une urgence de santé publique d'origine zoonotique en novembre 2019, un questionnaire d'évaluation a été soumis à l'ensemble des participants.

Résultats : Il ressort de l'analyse des questionnaires que pour plus de 77% des participants, l'exercice était bien structuré et organisé. Le scénario était réaliste et la séance d'orientation préalable a préparé à l'exercice selon 90% des participants. Cet exercice a permis de discuter des systèmes d'intervention en cas d'urgence de santé publique, de mieux comprendre les rôles et responsabilités des acteurs et d'identifier les points forts et les points faibles du mécanisme national de gestion des urgences de santé publique. En outre, la majorité des participants, soit plus de 80%, a également estimé que le niveau de préparation aux urgences de santé publique est faible notamment en raison de la complexité des mécanismes de coordination existants. Par ailleurs, certains participants ont regretté que la perspective multisectorielle ait parfois été omise lors des discussions. Les évaluateurs quant à eux ont suggéré le choix d'une thématique moins large ainsi que la formulation des questions de discussions avant l'élaboration du scénario.

Conclusion : Au terme de l'exercice et des échanges fructueux avec les intervenants clé de l'approche « une santé », l'auto-évaluation a permis d'effectuer une analyse des Forces, Faiblesses, Opportunités et Menaces. Il en ressort une forte implication et une adhésion des parties prenantes. L'une des recommandations majeures était de développer un programme d'exercices pour un système de santé résilient face aux urgences de santé publique.

Mots clés : Exercice de simulation, urgences de santé publique, préparation, Evaluation

[C107] Apport des automates dans le diagnostic bactériologiques de septicémies a l'unité de bactériologie clinique de l'institut pasteur de Côte-d'Ivoire de 2019 à 2021

Okpo-Boyoun Sophia¹, Kangah-N'goran Asseh Tatiana¹, Kouame Elogne Clarisse¹, Anne Blessa Jean Claude¹, Yapi Adompo Jaures Cedric¹, Dosso Mireille¹

1.Département Bactériologie-virologie Institut Pasteur de Côte d'Ivoire

Introduction : Les bactériémies ou septicémies constituent des urgences. Devant leur gravité, une détection rapide de l'agent étiologique est essentielle en vue d'une prise en charge précoce. L'acquisition d'automates pourrait ainsi contribuer à l'amélioration de la qualité des résultats et la précocité de la détection des microorganismes d'où l'intérêt leur utilisation. L'objectif est de mettre en évidence l'amélioration de la qualité du diagnostic des bactériémies avec l'utilisation des automates tel que le BACT/ALERT 3D et le VITEK COMPACT II.

Méthode : Etude rétrospective de 2019 à 2021 ; Les échantillons de sang ont été analysés après une incubation dans l'automate Bact/Alert 3D. Les agents bactériens ont été identifiés par la bactériologie classique (24-48h) et aussi avec l'automate VITEK compact II (8h). Un antibiogramme a été réalisé selon les normes du CASFM sur les souches isolées selon la méthode de KIRBY BAUER (24-48h) mais également avec le VITEK II (8h-10h).

Résultats : Sur 3177 échantillons, analysés, Le taux de détection de flacons positifs par l'automate Bact/Alert 3D était de 43,5% avec un délai moyen de détection de 1,77 jour. Le taux de positivité le plus élevé était J1 (53,2%) puis à J2 (16,4%). L'identification bactérienne à l'aide du VITEK a permis d'isoler plusieurs bactéries dont celles du genres *Burkholderia pseudomallei*, *Raoultella ornithinolytica* et les espèces bactériennes telle qu'*Enterobacter sakazakii*, *Salmonella enterica*, *Staphylococcus haemolyticus*.

Conclusion : L'utilisation d'automates dans le diagnostic des septicémies a permis d'améliorer le délai de diagnostic et l'identification bactérienne permettant ainsi une prise en charge plus précoce des patients.

Mots clés : Septicémie, automate, diagnostic

[C112] Détection, traitement et contrôle de l'hypertension artérielle en population générale au Bénin en 2019

Houehanou Yessito Corine Nadège¹, Behanzin Luc¹, Agonnoude Maurice¹, Houeto David¹

1.École nationale de formation des techniciens supérieurs en santé publique et surveillance épidémiologique - ENATSE, Université de Parakou, Bénin

Introduction : L'hypertension artérielle (HTA) représente un problème de santé publique à l'échelle mondiale. Les données au Bénin pour l'évaluation de sa prévention secondaire sont insuffisantes. L'objectif de cette étude était de déterminer les niveaux de détection, de traitement et de contrôle de l'HTA en population générale au Bénin en 2019.

Méthode : Une étude transversale a été menée au cours d'une campagne de dépistage de l'HTA de mai à juin 2019. Elle a porté sur des adultes de 18 ans et plus, ayant donné leur consentement écrit pour participer. Un échantillonnage de volontaires a été réalisé dans 25 localités rurales et urbaines du Bénin. Des informations sociodémographiques, comportementales et médicales ont été recueillies lors d'un entretien individuel structuré, en mode face à face, grâce à une fiche de collecte de données standardisée comportant un questionnaire. La pression artérielle a été mesurée avec un tensiomètre électronique OMRON® suivant les normes de la société internationale d'hypertension. L'HTA était définie par une pression artérielle élevée (systolique ≥ 140 mm Hg et/ou diastolique ≥ 90 mm Hg) et/ou la prise de traitement anti-hypertenseur.

Résultats : Un total de 3637 sujets a été inclus dont 2226 femmes. L'âge moyen était de $44,4 \pm 16,2$ ans. Parmi eux, 1134 avaient une pression artérielle élevée et 1349 étaient classés hypertendus dont 833 (62,2%) connaissaient leur statut et 554 (41,1%) étaient sous traitement. La majorité (79,5%) était sous monothérapie. Sur ces 554 sujets hypertendus sous traitement, 203 (36,6%) avaient une HTA contrôlée, soit 15,0% de l'ensemble des sujets hypertendus.

Conclusion : Cette étude montre une faible proportion d'HTA traitée et contrôlée bien que la détection de l'HTA soit relativement importante. Il convient de renforcer les mesures visant l'amélioration de la prise en charge et du contrôle de l'HTA dans la population béninoise.

Mots clés : Hypertension artérielle – détection – traitement – contrôle - Bénin

[C113] Connaissances, attitudes et pratiques des femmes en âge de procréer sur la prévention du cancer du col de l'utérus à Impfondo, au Congo Brazzaville

Mavoungou Yvonne Valerie Yolande¹, Dzon Etou Raiye Andre¹

1.Faculté des Sciences de la Santé, Université Marien Ngouabi, Congo Brazzaville

Introduction : Au Congo Brazzaville, le Cancer du Col de l'Utérus (CCU) est souvent découvert tardivement, rendant sa prise en charge difficile. La situation du milieu semi rural est peu documentée. L'objectif de ce travail était d'étudier les connaissances attitudes et pratiques des femmes en âge de procréer, sur la prévention du CCU.

Méthode : Il s'agit d'une étude transversale analytique réalisée de novembre 2019 à Janvier 2020, chez les femmes âgées de 15-49ans dans la localité semi rurale d'Impfondo au Congo Brazzaville. Les caractéristiques socio démographiques, les connaissances, attitudes et pratiques ont été étudiées et les niveaux de scores appréciés. Les données ont été collectées à l'aide d'un questionnaire puis analysées avec le logiciel Epi info version 7.2.2.6. Les Odds ratio et leurs intervalles de confiance à 95% ont été calculés au seuil de significativité de 5%.

Résultats : Sur 352 femmes enquêtées, l'âge moyen était 26,04 +/-7,74 ans ; la majorité (67,1%) avaient un niveau d'instruction secondaire ; 54% avaient au moins un enfant et 36,9% étaient en couple. Le niveau des connaissances sur le CCU était jugé insuffisante chez (61,7%) des femmes ; leur attitude face à la prévention du CCU était favorable (74,4%) ; la plupart d'entre elles (78,1%) avaient un niveau de pratique de dépistage du CCU insuffisante. Les femmes en couple avaient plus de chances d'avoir des connaissances sur le CCU (OR =4,04 [(1,25-13,13), p=0,0201]) ; le niveau de connaissance acceptable ne semble pas influencer l'attitude (OR =1,11 [(0,39-3,10), p=0,8489]). Les niveaux de connaissances acceptables (OR = 2,99[(1,18-7,60), p=0,0214]) et l'attitude favorable (OR 3,71[(1,70-8,10), p=0,0010]) ont été significativement associées à une meilleure pratique de prévention du CCU.

Conclusion : Le renforcement de la sensibilisation axés sur les facteurs de risque, les moyens de prévention et l'organisation des campagnes de dépistage sont nécessaires pour améliorer la prévention du CCU à Impfondo.

Mots clés : Cancer du col de l'utérus, Connaissances, Attitudes, Pratiques, Femmes en âge de procréer, Prevention, Impfondo Congo Brazzaville.

[C115] Recherche des parasites intestinaux humains manuportés chez les élèves du groupe scolaire baptiste missionnaire la paix Abobo-PK 18

Tamboura Mariétou Timité Adiaffi¹, Dou Gonat Serge Pacome¹, Aka Ad¹, Nassoue Dobré Maryse Olivia¹, Adjo Guy Landry¹, Adoubryn Koffi Daho²

1.Laboratoire de parasitologie et mycologie SMA- UFHB

2.Laboratoire de parasitologie et mycologie Sciences médicales de bouaké

Introduction : Le lavage des mains est un geste simple qui permet d'éviter de nombreuses maladies et de sauver des vies. Le risque sanitaire que représente les mains sales a été largement documenté pour les infections bactériennes et virales. Cependant, peu de données existent concernant le manuportage des parasites.

Objectif : Déterminer le degré d'infestation parasitaire des mains des écoliers du groupe scolaire baptiste missionnaire la paix d'Abobo pk 18.

Méthode : Il s'agissait d'une étude transversale a visée analytique réalisée du 25 mai au 01 juin 2022. Elle a concerné les élèves de tout âge et de tout sexe ayant donné leur assentiment et dont les parents ont donné leur consentement pour participer à l'étude. Pour chaque participant, il a été réalisé un lavage des mains. L'eau de rinçage recueilli a servi à l'examen parasitologique. Les données ont été recueillies à l'aide d'une fiche d'enquête élaborée à cet effet.

Résultats : Au total 123 élèves ont été inclus dont 19 étaient porteurs de parasites au niveau des mains ; soit une prévalence globale de 15,4 %. Les protozoaires prédominaient à 13 %. Parmi ces derniers, Entamoeba coli représentait 47,37% des cas. Quant aux helminthes, Ascaris lumbricoides et Strongyloides stercoralis étaient retrouvés à 10,52% et à 5,26%. Par ailleurs, il n'y avait pas de lien entre la présence de parasites manuportés et les caractéristiques sociodémographiques recherchées.

Conclusion : Le portage manuel des parasites intestinaux est une réalité chez les enfants d'âge scolaire. Il est donc nécessaire d'encourager le lavage correct des mains afin d'éviter la survenue de parasitoses liées au péril fécal.

Mots clés : Parasites Intestinaux, Manuporté, Abidjan, Côte D'Ivoire

[C117] Analyse et utilisation des données sanitaires pour la prise de décision par le niveau opérationnel au Bénin en 2022

Glele Ahanhanzo Yolaine¹, Hounkpe Dos Santos Bella², Paraiso N. Moussiliou³, Kpozehouen Alphonse¹

1.Département d'Epidémiologie et de Biostatistiques, Institut Régional de Santé Publique, Ouidah, Bénin

2.Direction Départementale de la Santé de l'Atlantique, Abomey-Calavi, Bénin

3.Département de Promotion de la Santé, Institut Régional de Santé Publique, Ouidah, Bénin

Introduction : L'étude vise à apprécier les capacités des acteurs des formations sanitaires (FS) du Bénin pour l'analyse des données collectées et leur utilisation pour la prise de décisions et la planification en vue d'améliorer la qualité, l'efficacité et l'impact des interventions.

Méthode : Il s'agit d'une étude évaluative transversale descriptive qualitative ayant consisté à des entretiens individuels et discussions de groupe avec les acteurs de 30 FS dans les 6 communes pilotes réparties sur l'ensemble du territoire national.

Résultats : L'évaluation montre que, les 3 derniers mois, la moitié des structures a présenté des analyses de leurs données au cours des réunions techniques et 80% l'ont fait lors des réunions avec les représentants de la communauté. La prise de décisions suite à ces analyses et le suivi des recommandations variaient entre 50 et 60%. L'affichage des indicateurs sur la performance des services est fait par 73% des FS mais n'est basé sur des données récentes que dans 5 structures. Aucun membre de la communauté impliqué dans la cogestion, enquêté, n'a de compétence et n'a été formé en analyse de données. Concernant l'utilisation des données, seize structures sur 30 avaient intégré une analyse situationnelle à leur microplanification annuelle mais seuls 7 microplans mettaient en évidence un lien entre cette analyse et les actions proposées. A l'auto-appréciation, les acteurs se sentent plus capables de compiler les données (86%), faire la saisie sur DHIS2 (63%), organiser les réunions (60%) et faire le suivi des microplans (80%). Ils avaient une faible appréciation (entre 7% et 40%) de leur capacité à contrôler la qualité des données, faire l'analyse des données, organiser le monitoring, afficher les données et faire une microplanification à partir d'une analyse situationnelle.

Conclusion : Un renforcement de capacités des acteurs sur les aspects spécifiques et la mise en place d'un mentorat pourraient aider à améliorer leurs performances dans ce domaine. Un focus devrait être mis sur les acteurs communautaires.

Mots clés : Analyse des données, Systèmes d'Information sanitaire, Prise de décision

[C118] Prévalence de bactéries productrices de carbapénèmes dans les pieds diabétiques infectés isolés à l'unité de bactériologie clinique de l'IPCI de 2019 à 2022

Okpo-Boyoun Sophia Lurette¹, Anne Blessa Jean Claude¹, Yapi Adompo Jaures Cedric¹, Kangah-N'goran Asseh Tatiana¹, Koffi Kouadio Stéphane², Kouame-Elogne Clarisse¹, Guessend Nathalie¹, Dosso Mireille¹

1.Département de Bactériologie Virologie, Institut Pasteur de Côte d'Ivoire

2.UFR Sciences médicales Abidjan, Université Felix Houphouët Boigny de Côte d'Ivoire

Introduction : L'identification de la flore bactérienne infectante du pied diabétique demeure essentielle pour assurer le succès de l'antibiothérapie. Cependant l'usage abusive des antibiotiques à entrainer l'émergence de bactéries résistantes chez ces patients traités en ambulatoire, compromettant ainsi leur pronostic vital. L'objectif de cette étude est de déterminer la prévalence des bactéries productrices de carbapénémases dans les pieds diabétiques infectés.

Méthode : Etude rétrospective de 2019 à 2022 portant sur tous les pus provenant de pieds diabétiques. Les échantillons ont été analysés suivant la bactériologie classique. L'antibiogramme a été réalisé selon la méthode de Kirby-Bauer et l'interprétation s'est faite selon le CA-SFM de 2019 à 2022.

Résultats : 475 échantillons ont été colligés, 69% des cas sont revenus positifs. Le sexe ratio H/F était de 1,47. Parmi ces cas positifs, les Staphylocoques représentaient 36,6% des cas, suivi des entérobactéries avec 34,5% des cas, les Pseudomonas 22,5% des cas et les Acinetobacter 2,4%. Concernant le profil de résistance, les souches résistantes à l'imipénème représentaient 5,7% et celles résistantes à l'ertapénème étaient de 1,8%.

Conclusion : l'émergence de bactérie productrices de carbapénémases pourrait constituer un problème dans la prise en charge des pieds diabétiques.

Mots clés : Pied diabétique, bactéries, carbapénémase, antibiothérapie

[C123] Compétences professionnelles des médecins et ses facteurs prédictifs : étude transversale portant sur les médecins formés à l'Université Saint Thomas (USTA)

Millogo Tieba^{1,2}, Compaoré Mitibkèta Martine², Koiné Maxime Drabo³

1. Institut Africain de Santé Publique,

2. Université Saint Thomas d'Aquin

3. Institut de Recherche en Sciences de la Santé

Introduction : Le niveau de compétence professionnelle des personnels soignants est déterminant pour la qualité et la sécurité des soins de santé. Pendant longtemps l'insuffisance en personnel qualifié et le faible accès et utilisation des services de santé, ont relégué au second plan la question de la qualité des soins prodigués aux utilisateurs des services de santé. Les efforts ont plus souvent visé à accroître l'accès et l'utilisation des services considérant que les soins qui y sont délivrés répondront aux besoins de santé des utilisateurs. Cependant, l'utilisation accrue des services coexistent parfois avec des résultats défavorables de santé, questionnant la capacité des soignants à adéquatement répondre à la demande de soins. Dans cette étude nous avons évalué les compétences techniques et non techniques des médecins formés à l'USTA ainsi que les facteurs prédictifs.

Méthode : Il s'est agi d'une étude transversale auprès de médecins formés à l'USTA et de leurs collaborateurs. Les médecins formés à l'USTA ont répondu à un questionnaire comportant des informations générales. Deux collaborateurs ont été inclus dans l'étude pour chaque médecin. Les collaborateurs ont répondu à un questionnaire sur les compétences techniques et non techniques des médecins formés à l'USTA. Une échelle de Likert avec cinq niveaux (allant de très insatisfaisant à excellent) permettait d'apprécier les différentes dimensions des compétences. Nous avons utilisé une régression par équations d'estimation généralisée pour déterminer les facteurs associés aux différents types de compétences.

Résultats : Au total 160 médecins et 320 collaborateurs ont participé à l'étude. Les compétences techniques et non techniques des médecins formés à l'USTA ont été globalement jugées satisfaisantes ou très satisfaisantes. Les compétences non techniques (communication, la gestion du temps) faisaient l'objet de plus d'insatisfaction. Les compétences aussi bien techniques que non techniques étaient meilleures chez les médecins célibataires, les médecins évalués par des collègues et les médecins exerçant dans des structures privées.

Conclusion : Les compétences techniques et non techniques des médecins formés à l'USTA sont globalement satisfaisantes même si des efforts sont requis en ce qui concerne les compétences non techniques.

Mots clés : compétences professionnelles, formation médicale

[C124] Rétention dans les soins VIH adultes au Togo et facteurs associés : ajustement d'une régression de Cox par modélisation d'un effet dépendant du temps

Arnold Junior Sadio^{1,2,3}, Fifonsi Adjidossi Gbeasor-Komlanvi^{1,2}, Akila Wimima Bakoubayi^{1,2}, Anoumou Claver Dagnra⁴, Didier Koumavi Ekouevi^{1,2,3}

1.Université de Lomé, Département de Santé Publique

2.Centre de Formation et de Recherche en Santé Publique

3.Université de Bordeaux, INSERM-IRD, Bordeaux Population Health Centre, UMR 1219

4.Université de Lomé, Département des Sciences Fondamentales ; Laboratoire de Biologie Moléculaire

Introduction : Une faible rétention dans les programmes du VIH constitue un frein à l'atteinte des objectifs 3X95 de l'ONUSIDA en matière de contrôle du VIH. L'objectif de cette étude était de décrire la rétention dans les soins VIH ainsi que les facteurs associés à une sortie des soins (attrition) au Togo.

Méthode : Une étude de cohorte rétrospective a été menée au Togo. Les dossiers de patients âgés de 15 ans et plus et ayant initié un traitement antirétroviral ont été sélectionnés proportionnellement à la file active dans chaque région. La rétention dans les soins a été définie comme la proportion de patients ni décédés, ni perdus de vue (PDV). Un modèle de régression de Cox a été réalisé pour décrire les facteurs associés à une sortie des soins VIH. Pour prendre en compte la non proportionnalité des risques, une approche par modélisation d'un effet dépendant du temps a été utilisée.

Résultats : Au total, 2100 personnes (69,2% de femmes) vivant avec le VIH (PVVIH) ont été incluses. L'âge médian (Écart interquartile) était de 44 ans (36-51). La mortalité a été estimée à 7,0% avec un intervalle de confiance à 95% (IC95) de [5,9-8,0] et 22,0% IC95% [20,2-23,8] des patients étaient PDV. La rétention a été estimée à 68,4% IC95% [66,4-70,4]. Les facteurs associés à une augmentation du risque de sortie des soins étaient : le sexe masculin (HRa=1,29 ; p=0,002), l'âge inférieur à 50 ans (HRa=1,28 ; p=0,004), être suivi dans un centre public (HRa=1,37 ; p=0,005), et avoir présenté une infection opportuniste (HRa=1,43 ; p=0,014).

Conclusion : La rétention dans les soins VIH au Togo n'est pas optimale. La priorité doit rester le dépistage/traitement précoce ainsi que la lutte contre la stigmatisation chez les jeunes PVVIH et de sexe masculin. Il est nécessaire d'améliorer les conditions de travail dans les formations sanitaires publiques offrant des soins VIH.

Mots clés : Rétention, Soins VIH, Afrique de l'Ouest, Togo.

[C125] Mode de vie et prévalence de l'hépatite B chez les adolescents de la rue au Togo

Arnold Junior Sadio^{1,2,3,4}, Valentine Marie Ferré⁵, Oumarou I. Wone Adama³, Harold Régis Kouanfack³, Anoumou Claver Dagnra⁶, Amivi P. Amenyah-Ehlan⁶, Laté Mawuli Lawson-Ananissoh⁷, Diane Descamps⁵, Charlotte Charpentier⁵, Didier Koumavi Ekouevi^{1,2,3,4}

1.Université de Lomé, Département de Santé Publique

2.Centre de Formation et de Recherche en Santé Publique

3.Centre Africain de Recherche en Epidémiologie et en Santé Publique

4.Université de Bordeaux, INSERM-IRD, Bordeaux Population Health Centre, UMR 1219

5.Service de Virologie, Université Paris Cité, INSERM, IAME, UMR 1137, AP-HP, Hôpital Bichat-Claude Bernard, F-75018 Paris, France

6.Université de Lomé, Département des Sciences Fondamentales ; Laboratoire de Biologie Moléculaire

7.University of Lomé, Department of Medicine and Medical Specialties; Hepatology and Gastroenterology Unit of the Campus Teaching Hospital of Lomé, Togo

Introduction : Les adolescents, particulièrement ceux en situation de rue, sont par leur mode de vie vulnérables au virus de l'hépatite B (VHB). Cependant, il n'existe quasiment aucune donnée sur l'infection par le VHB au sein de cette population en Afrique subsaharienne. L'objectif de cette étude était d'estimer la prévalence de l'infection par le VHB chez les enfants de la rue et secondairement de décrire leur profil immunologique vis-à-vis du VHB ainsi que leur mode de vie (sexualité et consommation de drogues).

Méthode : Une étude transversale a été réalisée entre juin et juillet 2021 à Lomé. Les adolescents âgés de 13 à 19 ans vivant dans la rue depuis au moins trois mois étaient éligibles. Un échantillon de sang a été prélevé afin de rechercher les différents marqueurs du VHB.

Résultats : Au total, 299 adolescents des rues (5,2% de femmes), dont l'âge médian (intervalle interquartile) était de 15 ans (14-17 ans), ont été inclus dans cette étude. Une activité sexuelle a été déclarée par 70,6% des adolescents et 70,6% de ces derniers n'avaient pas utilisé de préservatif au cours de leur dernier rapport sexuel. Une consommation active de drogues a été estimée à 42,1%. Les substances les plus consommées étaient le cannabis (39,0%), la cocaïne (36,6%) et les solvants pour colle (19,5%). Une infection en cours par le VHB (AgHBs+) a été détectée chez 3,7% (IC95% : 1,9-6,5) des adolescents. Des anticorps anti-HBc isolés étaient présents chez 5,3% d'entre eux. Un profil non infecté et non vacciné a été identifié pour 71,6% des adolescents de la rue enquêtée.

Conclusion : Près d'un adolescent de la rue sur 10 a présenté des marqueurs d'une infection par le VHB et sept adolescents de la rue sur 10 peuvent encore être infectés par le VHB. Vu les pratiques sexuelles et les comportements à risque qui ont été rapportés, il est urgent de concevoir des politiques spécifiques de prévention des infections y compris le VHB et le VIH, ainsi que des addictions au sein de cette population au Togo.

Mots clés : Hépatites B, Prévalence, profil immunologique, adolescents de la rue, Togo.

[C127] Défis dans la prévention des infections associées aux soins : état des lieux sur l'hygiène des mains dans les trois CHU du Togo en 2016

Roméo M. Togan¹, Serge E. Gbadoe¹, Taïssiri Adedjouma¹, Didier K. Ekouevi¹, Yao Kassankogno¹ (In Memoriam)

1.Université de Lomé, Faculté des Sciences de la Santé, Département de Santé Publique

Introduction : Les Infections Associées aux Soins (IAS) représentent un problème majeur pour la sécurité des patients et leur prévention doit être une priorité des établissements de santé. L'objectif de cette étude était de faire un état des lieux sur la promotion de l'hygiène des mains dans les trois Centres Hospitaliers et Universitaires (CHU) du Togo en 2016.

Méthode : Trois études transversales descriptives ont été réalisées d'août 2015 à décembre 2015 dans les trois CHU du Togo : i) une enquête sur les Connaissance Attitude et Perception (CAP) du personnel soignant sur l'hygiène des mains ; ii) une évaluation des pratiques d'hygiène des mains au cours des soins par les personnels soignants et iii) une évaluation des infrastructures disponibles dans les CHU pour l'hygiène des mains. Des questionnaires adaptés de l'OMS ont été utilisés.

Résultats : Au total 852 personnels de santé ont participé. La médiane d'âge était de 36 ans avec des extrêmes de 18 ans et de 65 ans. Le sex ratio (homme/femme) était de 1,8 en faveur des hommes. Seul 327 (38,4%) avaient reçu de formation sur l'hygiène des mains. Le niveau de promotion de l'hygiène des mains dans les CHU est inadéquat associant un manque de programme de promotion de l'hygiène des mains, avec un taux d'observance globale de l'hygiène des mains faible estimé à 12,6%, une indisponibilité d'infrastructure pour l'hygiène des mains avec un ratio lavabo/lit d'hospitalisation de 1/25 et une faible proportion de 18,2% de salles d'hospitalisation équipées de lavabo. Enfin, seulement 23% des services dans les trois CHU disposaient de Solution Hydro Alcoolique.

Conclusion : D'importants défis étaient à relever dans la prévention des IAS par promotion de l'hygiène des mains dans les CHU du Togo en 2016.

Mots clés : Hygiène des mains ; Infections Associées aux Soins (IAS) ; Togo

[C128] Prévalence ponctuelle des infections associées aux soins au centre hospitalier et universitaire d'Angré, 2023

Diallo Maky^{1,2}, Yapi Ivanne Ad^{2,3}, Bahan Gninnissem A. J^{2,3}, N'goran Sodji E. K², Ano Marie N³, Kouadio Meilleure N², Kacou-N'douba A^{2,3}

1.Laboratoire de Biostatistique et Informatique Médicale, UFR Sciences Médicales, Université Félix Houphouët Boigny

2.Service de Biologie Médicale, CHU d'Angré

3.Département de Microbiologie, UFR Sciences Médicales d'Abidjan, Université Félix Houphouët Boigny

Introduction : La problématique des infections associées aux soins (IAS) est liée à l'émergence des bactéries multi-résistantes qui rend la prise en charge thérapeutique difficile. L'objectif de notre étude était de déterminer la prévalence des IAS et décrire le profil de résistance aux antibiotiques des bactéries.

Méthode : Une étude transversale « un jour donné » a été menée dans les services cliniques (médecine, chirurgie, néonatalogie, pédiatrie et réanimation.) du CHU d'Angré du 17 au 21 Avril 2023. Les patients hospitalisés depuis au moins 48 heures et qui étaient présents le jour de l'enquête ont été inclus. Les critères d'une IAS étaient basés sur des définitions simplifiées de l'Organisation Mondiale de la Santé (OMS). Les données ont été analysées sur le logiciel SPSS IBM version 26. Le seuil de significativité était de 0,05.

Résultats : Les IAS représentaient 23.63% (13/55). La moyenne d'âge des patients était de 30 ans. Les IAS étaient plus fréquentes en chirurgie (30.76%) et en néonatalogie (30.76%). Les principales infections étaient celles du site opératoire (38.46%), les bactériémies (30.76%) et les pneumopathies acquises (23.07%). Les entérobactéries prédominaient avec *Escherichia coli* (57.14%). Les Staphylocoques à coagulase négative (SCN) représentaient 28.57%. Les entérobactéries produisaient une beta lactamase à spectre étendu (E-BLSE) et une carbapénémase (EPC) dans 50% et 33,33%. SCN était résistant à la méticilline dans 16.66%. La survenue d'une IAS était significativement associée à l'intervention chirurgicale ($p=0,04$) et aux durées de séjour ($p=0,009$).

Conclusion : Ces données sur les IAS devraient être prises en compte dans les algorithmes thérapeutiques et dans les stratégies de lutte de ces infections.

Mots clés : Infections Associées aux Soins- Bactéries résistantes-Hôpital- Abidjan.

[C129] Effets de l'application PANDA (Pregnancy and Newborn Diagnostic Assessment) sur la qualité des soins prénatals au Burkina Faso : essai clinique randomisé contrôlé

Abou Coulibaly¹

1.Département Biomédical et Santé Publique, Institut de Recherche en Sciences de la Santé, Ouagadougou, Burkina Faso.

Introduction : Le système PANDA est une application mobile qui a pour but de faciliter le diagnostic et la prise de décision en matière de soins prénatals. La présente étude avait pour objectif d'évaluer son effet sur la qualité des soins prénatals.

Méthode : Il s'est agi d'un essai contrôlé randomisé dans deux groupes de centres de santé (groupe d'intervention ayant reçu l'application PANDA et groupe de comparaison) dans le district sanitaire de Koupéla (région du Centre-Est, Burkina Faso). Nous avons inclus les femmes enceintes de moins de 20 semaines lors de leur première consultation prénatale (CPN) dans 12 établissements de santé et nous les avons suivies jusqu'à leur sixième semaine de post-partum. Le résultat principal était le score de qualité de la CPN, variable binaire codée 1 (oui) pour les femmes ayant obtenu au moins 75% du score total et 0 dans le cas contraire. Nous avons comparé les résultats ajustés entre les deux groupes d'étude en utilisant les modèles linéaires généralisés.

Résultats : Dans cette étude, 319 et 272 femmes ont été incluses, respectivement dans le groupe d'intervention et de comparaison. Dans le groupe d'intervention, 50 femmes sur 319 (15,67%) avaient au moins 75% du score total de qualité de la CPN contre 17 femmes sur 272 (6,25%) dans le groupe de comparaison. Les résultats ajustés ont montré que les chances de bénéficier d'une bonne qualité de la CPN chez les femmes du groupe d'intervention étaient de 2,70 fois (IC95%=1,60-4,60) celles des femmes du groupe de comparaison ($p<0,001$).

Conclusion : Cette étude a montré que l'application PANDA améliore significativement la qualité des soins prénatals. Ces résultats sont d'une importance capitale car le Burkina Faso, a décidé d'utiliser les registres électroniques pour les soins en maternité et pour les soins des enfants.

Mots clés : consultation prénatale, qualité, application

[C132] Accidents de la voie publique et gradient social de santé à Cotonou en 2021

Koukponou DC¹, Goukodadja O¹, Houéto DS²

1.Faculté des Sciences de la Santé, Cotonou, Université d'Abomey-Calav

2.École de Santé Publique, Université de Parakou

Introduction : L'une des caractéristiques des accidents de la voie publique (AVP) au Bénin est qu'ils affectent davantage les populations défavorisées. L'objectif était d'étudier ces accidents au regard du gradient social de santé sous-tendant les inégalités sociales de santé.

Méthode : Il s'agissait d'une étude transversale, descriptive à visée analytique portant sur les patients hospitalisés pour des lésions consécutives à des accidents de la voie publique dans les hôpitaux de Cotonou pendant la période du 1er au 30 septembre 2021.

Résultats : Au total, 185 patients ont été inclus dans notre étude. Ils représentaient 24,97 % des admissions. Les traumatisés de la voie publique étaient de sexe masculin (70,81 %) avec une sex-ratio (H/F) de 2,42. Ils avaient majoritairement entre 18 et 40 ans, soit 71,88 % et étaient, sur la plan professionnel, fonctionnaires/employés (29,19 %), artisans/ouvriers (28,11), commerçants (14,05) et élèves/étudiants (12,43). Parmi eux, 57,84 % avaient un niveau socio-économique bas. Les parties du corps les plus touchées étaient tête-cou et extrémités des membres. Les fractures étaient la lésion la plus fréquente (62,70 %). Les accidents impliquant une moto représentaient 83,06 % des cas. La fréquence des fractures était plus élevée dans le groupe des accidentés ayant un niveau socio-économique et un niveau d'instruction bas.

Conclusion : Les accidents de la voie publique à Cotonou suivent un gradient social de santé. Les sujets en situation de précarité sont les plus durement touchés. L'amélioration de la sécurité routière devrait promouvoir des alternatives de transport sécurisées à travers l'amélioration des conditions socio-économiques et la littératie des sujets à risque des AVP. Ceci implique une action coordonnée au-delà du secteur de la santé pour l'amélioration des conditions de vie de l'ensemble de la population gage de la réduction des AVP dans la ville de Cotonou.

Mots clés : Accidents de la voie publique, Gradient social de santé, Cotonou, Bénin

[C133] Déterminants individuels et contextuels du diabète chez l'adulte âgé de 20 à 70 ans en Côte d'Ivoire en 2017

Ekissi Orsot Tetchi¹, Yao Eugène Konan¹, Daniel Ekra¹, Apolinaire Yapi¹, Erick Martial Ahoussou¹, Christian Bangaman Akani¹, Nicaise Aka¹, Odile Tano-Ake¹

1.Département de santé publique et spécialités (UFR SMA, UFHB, Abidjan-Côte d'Ivoire)

Introduction : Le diabète de type 2 est une maladie multifactorielle qui est répartie différemment selon les régions sanitaires de Côte d'Ivoire. La présente étude avait pour objectif d'analyser les facteurs individuels et contextuels du diabète chez l'adulte en Côte d'Ivoire.

Méthode : Il s'agit d'une analyse secondaire de données provenant de l'Enquête de prévalence et caractéristiques du diabète en Côte d'Ivoire en 2017. Les données ont été analysées avec le logiciel stata 15.1. La régression logistique multiniveau a permis d'identifier les déterminants individuels et contextuels du diabète chez l'adulte en Côte d'Ivoire.

Résultats : Sur un total de 3 089 personnes âgées de 20 à 79 ans incluses, plus des trois quarts avaient moins de 60 ans. Les femmes représentaient 56,59% de cette population dont près de la moitié (47,81%) n'était pas scolarisée. La majorité résidait en milieu urbain (54,90%), vivait avec un conjoint (72,22%). Le faible niveau d'activité physique, le grignotage et la consommation d'alcool étaient observés chez respectivement 38,17%, 25,38% et 39,27% de cette population. La surcharge pondérale, l'hypertension artérielle, l'hypertriglycémie et l'hypercholestérolémie total étaient observées respectivement chez 39,82%, 42,96%, 6,15% et 34,35%. L'analyse multiniveau montre une influence de la région dans la distribution du diabète (variance du modèle vide $\neq 0$). Le passage du modèle vide ($\sigma^2_1 = 0,113946$ et ICC1 = 0,033476) au modèle à effets fixes ($\sigma^2_2 = 0,054560$ et ICC2 = 0,016313) montre que l'introduction de variables individuelles diminue la variance entre les régions. La variation de prévalence du diabète entre les régions est imputable au contexte régional à 1,63%. Les déterminants individuels associés au diabète étaient le milieu de vie, la situation matrimoniale, la consommation d'alcool, l'HTA, le diabète familial, hypertriglycémie, le LDL cholestérol élevée indépendamment des autres variables.

Conclusion : Le diabète dépend aussi bien de facteurs individuels que contextuels. La prévention du diabète doit absolument être fondée sur le contexte social et culturelle qui influence la santé des populations.

Mots clés : Diabète, facteurs contextuels et individuels, adulte de 20 à 79 ans, Côte d'Ivoire.

[C134] Qualité de vie des personnes âgées de 50 ans et plus d'une mutuelle des travailleurs et retraites du secteur privé d'Abidjan en 2022

Konan Yao Eugène¹, Tetchi Ekissi Orsot¹, Yapi Apollinaire², Adesola Buremoh Ismaël¹, Ake-Tano Sassor Odile Purifine¹

1.Département de Santé Publique et Spécialités, UFR Sciences Médicales Abidjan

2.Institut National de Santé Publique, Abibjan-Côte d'Ivoire

Introduction : La qualité de vie (QdV) est une mesure importante dans l'évaluation du bien-être et de l'état de santé de la population. En Côte d'Ivoire, l'absence de données sur la QdV chez les personnes âgées justifie la réalisation de la présente étude. Elle a pour objectif d'explorer la QdV et identifier les facteurs associés chez les personnes âgées de 55 ans et plus d'une Mutuelle des Travailleurs et des Retraités du secteur Privé de Cote d'Ivoire (MUTREPCI).

Méthode : Il s'agissait d'une étude transversale à visée analytique qui s'est déroulée de juin 2021 à mai 2022. Elle a concerné 172 personnes âgées suivies au pool médical de la MUTREPCI. Le questionnaire de l'OMS sur la QdV (WHOQOLBREF) a été utilisé. Les facteurs associés ont été recherchés par l'analyse multivariée à l'aide d'une régression logistique au seuil de 5%.

Résultats : Parmi les enquêtés, 59,3% étaient satisfaits de leur état de santé et 61,05% évaluaient leur QdV globale comme bonne. Les scores normalisés moyens variaient de 59,57 (environnement) à 68,91 (relations sociales). La santé physique avait le score normalisé minimal le plus bas (6). La santé mentale avait le score normalisé maximal le plus élevé (100). Les facteurs associés à la bonne santé physique étaient le niveau d'instruction supérieur ($P=0,02$, Coef = +7,57 IC = [1,46 - 13,66]), l'absence de maladie chronique ($P=0,001$ Coef = + 10,7, IC = [6,02 - 15,21]) et la pratique régulière de sport ($P=0,01$, Coef = -5,67, IC = [-9,81 - -1,53]). Aucun facteur associé n'a été retrouvé pour les autres dimensions.

Conclusion : La majorité des personnes évaluées avaient une bonne QdV. Pour renforcer les résultats de cette étude, d'autres études sont nécessaires pour mieux cerner la problématique de la QdV dans des sous-populations distinctes.

Mots clés : Evaluation, qualité de vie, personnes âgées, facteurs associés, Abidjan

[C136] Investigation des cas de rougeole du district sanitaire d'Andéramboukane, Région de Ménaka, 2023.

Keita Ibrahima Dit Boua¹, Sangho Oumar²

1.District sanitaire d'Andéramboukane

2.Département d'Enseignement et de Recherche en Santé Publique et Spécialités (DERSP) / FMOS / USTTB)

Introduction : La rougeole est une maladie très contagieuse. Elle est la quatrième cause majeure de mortalité chez les enfants de moins de 5 ans. La surveillance épidémiologique de la rougeole avec des normes constitue un des piliers des différentes stratégies adoptées du plan d'élimination 2013-2020. Objectif : Investiguer les cas survenus le 29 janvier 2023.

Méthode : Etude transversale descriptive avec enquête individuelle et revue documentaire des supports des cas suspects de la rougeole.

Résultats : Tous les cas venaient du site des déplacements internes du quartier Abattoir. Le sexe féminin était de 67% des cas, l'âge médian de 7,5 ans. Aucun cas n'était vacciné contre la rougeole. La source était verbale. La fièvre, l'éruption cutanée généralisée, la toux et la conjonctivite étaient présents chez tous les cas suspects. Tous les cas ont été prélevés. Le délai moyen d'acheminement des prélèvements était de 4 jours. Un taux global de couverture vaccinale et d'administration de vitamine A de riposte de 23,31% a été enregistré. La sensibilisation a concerné la présence de 35% des hommes et 65% de femmes.

Conclusion : L'investigation a détecté six cas suspects, tous prélevés. Elle a renforcé les mesures sanitaires (isolement des cas, la vaccination des cibles pendant les activités PEV de routine entre autres). Cependant l'acheminement des prélèvements a connu un long délai. La correction de cette insuffisance permettra d'améliorer les indicateurs de la politique nationale d'élimination de la rougeole.

Mots clés : Investigation, Rougeole, District sanitaire

[C137] Soins maternels centrés sur la patiente au profit des femmes des zones non loties de la ville de Ouagadougou : Une analyse comparative entre établissements de santé publics et privés

Kadari Cissé ^{1,2}, Safia Jiwani ³ Anne Marie Wedraogo ^{1,2}, Fatou Sissoko ^{1,2}, Agbessi Amouzou ³, Cheikh Mbacke Faye ⁴

1. Institut de recherche en sciences de la santé
2. Centre national de recherche scientifiques et technologique
3. Johns Hopkins University Department of International Health
4. African Population and Health Research Center

Introduction : Au Burkina Faso, plusieurs efforts ont été consentis pour améliorer l'accès aux services de santé maternelle et néonatale (SMN) surtout dans les structures publiques de soins. Les soins maternels centrés sur la patiente (SMCP) sont une composante essentielle de la qualité des soins d'accouchement. Le but de notre étude était d'analyser les différences entre structures de santé privées et publiques en matière de SMPC.

Méthode : Nous avons conduit une étude transversale auprès des clientes des services d'accouchement dans les zones non loties de la ville de Ouagadougou. Les clientes ayant accouchées dans les sept jours ont été identifiées dans les établissements sanitaires et rejoint à domicile pour les entretiens. Un modèle linéaire à effets mixtes a été utilisé pour rechercher les facteurs associés au SMCP.

Résultats : Au total, 401 clientes ont été interviewés dont 264 ayant accouché dans les établissements sanitaires publics et 137 dans ceux du privé. Le score moyen de SMCP était de 71,4% dans le public contre 78,4% dans le privé ($p < 0,001$). L'analyse par domaine montre que le score de la composante dignité et respect était de 81,7% dans le public contre 86,4% dans le privé ($p = 0,006$). Pour la composante communication, le score était de 56,7% dans le public et 62,2% dans le privé ($p = 0,002$). Pour la composante soins de soutien, le score était de 76,2% dans le public et 85,0% dans le privé ($p < 0,005$).

Conclusion : Les résultats montrent un score SMCP significativement plus élevé dans les établissements privés comparativement au public malgré la gratuité des soins en cours dans le publique. Aussi les facteurs associés au SMCP semble différés entre le publique et le privé. Les efforts d'amélioration de l'accès au SMN doivent s'accompagner d'une mise en œuvre effective de l'approche de SMCP pour une expérience positive des soins au profit des femmes

Mots clés : Accouchement, soins centrés sur la patiente, zone non lotie, Burkina Faso

[C138] Peur et prévention des infections associées aux soins chez le personnel soignant à l'Hôpital de la mère et de l'enfant Lagune (HOMEL) à Cotonou : une analyse du point de vue du système de santé

Meliho Pierre Codjo¹, Gbokede Sandrine², Akpi Eric², Agbodjavou Mena², Ottokou Adam²

1.Université Nationale d'Agriculture de Porto-Novo

2.Université d'Abomey-Calavi

Introduction : Les infections nosocomiales périnatales demeurent une préoccupation grandissante de santé publique très peu explorées dans les grands hôpitaux des contextes à ressources limitées. Au Bénin, elles restent encore citées dans les rapports de Surveillance de Décès Maternels, Néonataux et Riposte (SDMR) comme l'une des quatre principales causes de décès du couple mère enfant au cours du séjour en milieu hospitalier.

Méthode : A travers une démarche qualitative, des données sur les perceptions relatives aux infections associées aux soins, la peur de contamination et les connaissances des normes standards et les comportements préventifs du personnel soignant ont été recueillies auprès de vingt-deux soignants retenus par la technique du choix raisonné et la boule de neige. Il s'agit des aides-soignants, des sage-femmes, des médecins responsables des unités de soins, des soignants internes et des infirmiers. Ces derniers ont participé à des entretiens individuels semi-structurés complétés par des observations directes à l'issue desquels les matériaux obtenus ont été présentés en corpus puis analysés par l'analyse thématique et de contenu des représentations sociales.

Résultats : Du point de vue de la gouvernance, les prestataires ont indiqué une lourdeur dans la longue chaîne d'approvisionnement des équipements de protection adéquate pour assurer les soins de qualité. En ce qui concerne les ressources humaines, les prestataires chargés de surveiller pendant le travail d'accouchement et le nettoyage des tables d'accouchement ont évoqué la peur de contamination. Aussi, cette catégorie de prestataires n'était-elle pas unanime sur les procédures de préparation de solution de décontamination ainsi que les protocoles officiels adoptés par l'hôpital à ce propos. Cette peur est également liée aux ruptures régulières des équipements de protections (bavette, bottes, casques) ainsi que le doute sur la qualité de lavage des champs recyclables.

Conclusion : Ces résultats montrent que la notion du risque de la contamination est une variable pertinente qui influence la qualité des soins que produisent les soignants du CHU-MEL.

Mots clés : Infections associés aux soins, risque d'infection, valeur absolue, système de santé, HOMEL, Cotonou

[C139] Profil des diabétiques de 20 ans à 79 ans de l'enquête nationale sur la prévalence et caractéristiques du diabète en Côte d'Ivoire

Ekissi Orsot Tetchi¹, Yao Eugène Konan¹, Daniel Ekra¹, Bomouan Jean-Fabien¹, Erick Martial Ahoussou¹, Nicaise Aka¹, Odile Tano-Ake¹

1.Département de santé publique et spécialités UFR SMA, UFHB, Abibjan-Côte d'Ivoire

Introduction : Le diabète constitue un problème de santé publique en Côte d'Ivoire. L'objectif général de la présente étude est de dresser le profil des diabétiques de l'enquête nationale sur la prévalence et les caractéristiques du diabète en Côte d'Ivoire chez les personnes de 20 ans à 79 ans.

Méthode : Il s'agit d'une étude transversale à visée analytique à partir d'une analyse secondaire des données de l'enquête nationale sur la prévalence et les caractéristiques du diabète en Côte d'Ivoire, réalisée du 25 Novembre au 22 Décembre 2017. Elle concerne 193 sujets sur un total de 197 ayant participé à l'étude. Les facteurs associés au statut de diabétique (diabétique connu ou diabétique méconnu) ont été recherchés par la régression logistique binaire.

Résultats : L'étude primaire a porté sur 3198 personnes âgées de 20 ans à 79 ans. Les participants, en majorité de sexe féminin (59,05%), avaient un âge moyen de 48,72 ans, vivaient en milieu urbain (78,1%) et n'avaient pas de protection sociale ou assurance maladie (92,51%). De l'analyse multivariée, la probabilité d'ignorance de l'état d'hyperglycémie chronique chez les personnes âgées de 20 ans et 79 ans était plus élevée chez les diabétiques vivant en zone rurale, grignotant entre les principaux repas, non hypertendus et sans antécédent de diabète familial ($p < 0,05$, $OR > 1$). Cependant celle-ci est faible chez les diabétiques de plus de 50 ans ($p < 0,05$, $OR < 1$).

Conclusion : Cette étude souligne la nécessité de l'adoption de stratégies appropriées et de la mise en oeuvre d'interventions en faveur de la prévention, du dépistage, du diagnostic du diabète et de la prise en charge précoce des diabétiques en Côte d'Ivoire.

Mots clés : profil, diabétique, diabète non diagnostiqué, facteurs associés, Côte d'Ivoire

[C140] Une offre de soins très insuffisante : étude des déterminants relatifs aux services de santé influençant la prise en charge sanitaire des violences physiques et sexuelles basées sur le genre (VBG) selon les agents de santé de la maternité du Centre hospitalier régional (CHR) de Banfora, Burkina Faso.

Meda Ziemlé Clément¹, Barro Sié Hyacinthe², Savadogo Gueswendé Blaise Léon¹, Sombie Issiaka¹

1.Département de Santé publique, Institut supérieur des sciences de la santé (INSSA) de l'Université Nazi Boni

2.Direction régionale de Bobo Dioulasso de l'Ecole nationale de santé publique (ENSP)

Introduction : Les violences basées sur le genre (VBG), en particulier les violences physiques et sexuelles constituent un problème majeur de santé publique et source de graves problèmes de santé physique, mentale, sexuelle et reproductrice chez les femmes si elles ne sont pas bien prises en charge. La présente recherche a étudié les déterminants relatifs aux services de santé influençant la prise en charge (PEC) des VBG selon les agents de santé de la maternité du Centre hospitalier régional (CHR) de Banfora, au Burkina Faso.

Méthode : Il s'est agi d'une étude transversale à collecte prospective conduite du 30 juillet au 30 août 2022 auprès des 72 prestataires de soins de la maternité du CHR de Banfora. L'enquête (entretien individuel à l'aide d'un questionnaire semi-structuré et auto-administré) et la revue documentaire (analyse du contenu des fiches de stock de gestion des médicaments et registres de consultation...) ont été les méthodes de l'étude. L'analyse des données a concerné l'organisation du service et les connaissances des prestataires et leur perception sur l'effectivité de la PEC des VBG.

Résultats : Selon les 61 prestataires inclus dans l'étude, il est ressorti une insuffisance de connaissances des prestataires de soins sur le concept des VBG avec une performance (28,9%), une insuffisance d'organisation du service avec une absence de protocole de soins sur les VBG, la non disponibilité des outils de collectes de données (37,5%), la non disponibilité des médicaments (50,0%) et la non disponibilité des vaccins et tests (55,6%). Selon leur perception, 29,5% des prestataires ont pris en charge au moins un cas de VBG.

Conclusion : Il est suggéré la formation des prestataires sur les VBG et leur PEC, la réorganisation du service et une approche multisectorielle pour prévenir et combattre les VBG.

Mots clés : Accès aux soins, droits en santé, santé de la reproduction, offre de santé.

[C141] Acceptabilité de la fibroscopie œsogastroduodénale (FOGD) dans les structures sanitaires privées de la ville de Bobo-Dioulasso au Burkina Faso

Meda Ziemlé Clément¹, Ouattar Alimata¹, Hien Hervé^{2,3}, Ouattara Cheick Ahmed⁴, Ilboudo Bernard⁵, Traore Isidore¹, Savadogo Gueswendé Blaise Léon¹, Sombie Issiaka¹

1.Département de santé publique, Institut supérieur des sciences de la santé (INSSA), Université Nazi Boni (UNB)

2.Institut de recherche en sciences de la santé (IRSS),

3.CNRST

4.Centre hospitalier universitaire Souro Sanou (CHUSS)

5.Institut national de santé publique (INSP)

Introduction : Les pathologies digestives posent par leur fréquence un véritable problème de santé publique surtout sur le plan diagnostique où la fibroscopie œso-gastro-duodénale (FOGD) est un examen de choix. La présente recherche a étudié les facteurs associés à l'acceptabilité de la FOGD dans les structures sanitaires privées de la ville de Bobo-Dioulasso, au Burkina Faso.

Méthode : Il s'est agi d'une étude transversale à visée analytique avec collecte prospective des données du 13 janvier au 28 février 2020. La méthode de l'étude a été la revue documentaire et l'enquête à travers une fiche de collecte administrée par entretien individuel. Les facteurs de l'acceptabilité de la FOGD ont été identifiés par régression logistique.

Résultats : Sur un échantillon de 180 patients inclus, la moyenne d'âge était de $43 \pm 15,1$ ans avec un sexe ratio de 1,1. Le score moyen de l'acceptabilité de la FOGD était de $107,3 \pm 16,0$ (extrêmes 27 et 189), et 96 (53,3%) patients ayant un score d'acceptabilité ≤ 107 . Aussi, le score moyen de l'information reçue par les patients sur la FOGD était faible avec un score moyen de $1,2 \pm 0,9$ (extrêmes 1 et 6). En analyse univariée, les facteurs de l'acceptabilité étaient : présence de malaises ($p = 0,04$), présence de l'anxiété avant l'examen ($p = 0,039$), envie de renoncer à la réalisation de l'examen ($p = 0,006$). En analyse multivariée, nous n'avons pas retrouvé de facteurs associés à l'acceptabilité de la FOGD.

Conclusion : L'acceptabilité de la FOGD est très importante dans le contexte de l'amélioration de la qualité des soins de santé. L'information préalable du patient et l'amélioration des conditions de réalisation de l'examen sont un atout pour obtenir de meilleurs résultats.

Mots clés : Qualité des soins, adhésion aux soins, examen complémentaire, appareil digestif

[C142] Acceptabilité de la vaccination contre la COVID-19 des usagers deux établissements de santé dans la commune de Yopougon en Côte d'Ivoire

Oussou Konan Roland¹, Agoh Nina¹, Abina Audrey Marie Michelle¹, Attoh-Toure Harvey¹

1. Institut National d'Hygiène Publique

Introduction : La vaccination systématique de la population à ce jour reste le moyen le plus sûr dont nous disposons pour rompre la chaîne de transmission, se protéger et éviter les formes graves de la COVID-19. Cependant la confusion semée dans l'esprit de la population par l'infodémie sur les réseaux sociaux et internet concernant l'opportunité, l'efficacité et l'innocuité des vaccins contre la COVID-19 ont contribué à renforcer les réticences de la population générale vis-à-vis de la vaccination. L'objectif de notre étude était d'évaluer l'acceptabilité de la vaccination contre la COVID-19 dans la population générale.

Méthode : Nous avons mené une étude transversale du 1er juin au 30 septembre 2022 dans deux établissements de santé, l'un privé, l'autre public. Notre population d'étude était constituée de tous les usagers âgés d'au moins 18 ans. Les données ont été collectées à l'aide d'un questionnaire auto-administré.

Résultats : Au total 303 personnes ont participé à l'étude. Parmi les participants, on a enregistré une prédominance féminine (58,7%) et un âge moyen de 38,6 ans. Les principaux antécédents médicaux enregistrés étaient l'HTA (11,2 %) et le diabète (7,9%). Près d'un usager sur deux (49%) avait un doute sur l'efficacité du vaccin anti- COVID-19. Les participants ont affirmé ne pas être à risque de faire une forme grave de COVID-19 et que se faire vacciner pourrait donner la COVID-19 dans respectivement 60,4% et 24,8 % des cas. L'acceptabilité de la vaccination anti-COVID-19 était estimée à 67,7%. La couverture vaccinale globale contre la COVID-19 était de 41%. Parmi les personnes vaccinées, 66 % avait reçu 2 doses et le vaccin de Pfizer-BioNtech était le plus utilisé (55,7%).

Conclusion : une meilleure communication sur la maladie et la vaccination contre la COVID-19 améliorerait l'acceptabilité du vaccin contre la COVID-19.

Mots clés : Acceptabilité-Vaccination- Covid-19

[C143] Facteurs associés à la violence basée sur le genre chez les travailleuses du sexe à berbérati, république centrafricaine

Jean de Dieu Longo^{1,2}, Henri Saint Calvaire Diemer^{1,2}, Sylvain Honoré Woromogo^{1,3,4}, Rodrigue Herman Doyama-Woza¹, Prince Holfadh Farazara Kario¹, Gérard Grésenguet^{1,2}

1.Public Health Department, Faculty of Health Sciences, Bangui, University of Bangui, Central African Republic

2.National Reference Centre for Sexually Transmitted Diseases and AIDS, Bangui, Central African Republic

3.Doctoral School of Human and Veterinary Sciences, University of Bangui, Central African Republic

4.Inter States Centre of Higher Education in Public Health for Central Africa, Brazzaville, Congo

Introduction : Le Centrafrique traverse depuis plusieurs années une crise complexe et profonde avec de graves conséquences humanitaires et de protection. Cela expose encore davantage les groupes les plus vulnérable que sont les femmes et les filles à davantage de violence, notamment au viol et aux agressions sexuelles. Les travailleuses du sexe (TS) font partie des populations les plus vulnérables à la violence basée sur le genre (VBG). C'est dans ce contexte que notre étude vise à décrire les cas de VBG chez les TS à Berbérati.

Méthode : Une étude transversale a été menée en utilisant la technique d'échantillonnage piloté par les répondants (RDS) pour recruter des participants. Il s'agit d'une méthode de recrutement par paires souvent utilisée pour créer un échantillon à partir de graines. Les premières participantes, appelés « seed », sont ensuite invités à recruter d'autres pairs parmi une série de chaînes d'échantillonnage de référence.

Résultats : Au cours de cette période d'étude, 256 TS ont été recrutées. Les principaux déterminants associés à la violence sexuelle chez les TS étaient : la tranche d'âge de moins de 18 ans: (ORa = 2,69 [1,93 -3,28] ; p = 0,001) ; consommation régulière d'alcool : (ORa = 2,58 [1,39 - 4,78] ; p=0,003) ; le travail du sexe est la principale source de revenus : (ORa = 2,13 [1,94-3,08] ; p = 0,001) et avoir un partenaire sexuel (client) militaire ou policier : (ORa = 3,57 [2,81-5,23] ; p=0,001).

Conclusion : Cette étude a révélé que les adolescentes de moins de 18 ans qui vendent des services sexuels ; la consommation régulière d'alcool et d'autres substances psychoactives et le fait d'avoir un client militaire ou policier étaient associés à une forte probabilité d'être victime de violence sexiste. Le développement d'interventions spécifiques pour réduire ces risques est crucial.

Mots clés : Travailleuse du sexe, Violences basées sur le genre, RCA

[C144] Facteurs associés aux troubles dépressifs parmi les étudiants en médecine à bangui

Jean de Dieu Longo^{1,2}, Henri Saint Calvaire Diemer^{1,2}, Sylvain Honoré Woromogo^{1,3,4}, Rodrigue Herman Doyama-Woza¹, Prince Holfadh Farazara Kario¹, Gérard Grésenguet^{1,2}

1.Département de Santé Publique, Faculté des Sciences de la Santé, Bangui, Université de Bangui, République Centrafricaine

2.Centre National de Référence des Maladies Sexuellement Transmissibles et du SIDA, Bangui, République Centrafricaine

3.École Doctorale des Sciences Humaines et Vétérinaires, Université de Bangui, République centrafricaine

4.Centre Inter Etats d'Enseignement Supérieur en Santé Publique pour l'Afrique Centrale, Brazzaville, Congo

Introduction : La dépression est un trouble mental courant. On estime que 3,8% de la population est touchée, dont 5 % des adultes et 5,7 % des personnes de plus de 60 ans. De nombreuses études ont montré que les taux de dépression chez Les étudiants universitaires sont plus nombreux que ceux de la population générale. C'est dans ce contexte que notre étude propose de déterminer la proportion d'étudiants de la Faculté des Sciences de la Santé (FACSS) de l'Université de Bangui qui présentaient des symptômes de dépression et d'en analyser les déterminants.

Méthode : Il s'agissait d'une étude transversale descriptive et analytique. La population étudiée était composée de tous les étudiants du FACSS régulièrement inscrits pour l'année universitaire 2021-2022. Deux des questionnaires ont été utilisés ; Le résumé de BECK pour évaluer le niveau de dépression et un autre questionnaire pour étudier ses déterminants. Les données ont été analysées à l'aide du logiciel Epi info.

Résultats : L'âge moyen des étudiants était de 21 ans ($\pm 2,5$ ans), avec des extrêmes allant de 16 à 31 ans. La majorité des étudiants étaient originaires de zones urbaines (81,8 %) et vivaient avec leurs parents/tuteurs (70,5%). La prévalence de la dépression chez les étudiants était de 52,6 %. Les principaux symptômes dépressifs subjectifs étaient la fatigue (63,5 %), la nécessité d'un effort physique supplémentaire pour travailler (61,4 %) et la tristesse (52,6 %). Difficultés de logement, absence de l'érudition et la pression des parents/tuteurs étaient les principaux facteurs associés à l'apparition de la dépression.

Conclusion : La forte prévalence de la dépression chez les étudiants du FACSS devrait inciter les responsables académiques à mettre en place un dispositif de détecter les élèves présentant des signes de dépression afin de leur proposer un soutien psychosocial.

Mots clés : Troubles dépressifs, Étudiants, Bangui

[C145] L'Endométriose une maladie d'actualité : situation du Gabon

Pegha Moukandja Irène¹, Maghendji N Sydney²

1.Département de Santé publique/ Centre Interdisciplinaire de Recherches Médicale de Franceville, CIRMF

2.Département de Santé publique/Université des sciences de la santé de Libreville, USS

Introduction : Au Gabon, aucune étude sur l'endométriose n'a jamais été publiée. Il s'agit d'une maladie gynécologique inflammatoire chronique qui touche de nombreuses femmes dans le monde. Créée en 1978, le LAP de l'université des sciences de la santé de Libreville a été jusqu'en 2009 le seul laboratoire d'analyses de toutes les pièces opératoires du pays. C'est dans ce contexte, qu'afin d'investiguer pour une première fois sur la prévalence de l'endométriose au Gabon, une étude a été réalisée à partir des registres de ce Laboratoire.

Méthode : Une étude rétrospective descriptive et analytique a été réalisée à partir des données de dossiers médicaux des femmes dont les pièces opératoires ont été reçues au LAP/USS pour des analyses histologiques entre 1987 et 2022.

Résultats : Au total 6666 dossiers ont été colligés entre 1987 et 2022. L'âge moyen des patientes était de 38,1±11,4 ans. La proportion de l'endométriose entre 1987 et 2022 était de 7,3% [6,7 – 7,9]. L'an 2004 avait la prévalence la plus élevée (23,6%). L'endométriose était significativement élevée chez les patientes âgées de 36 à 50 ans (10,8%) suivie de celles de 51 ans et plus (9,6%), ($p<0,001$). L'utérus était la pièce opératoire la plus réséquée (40,3%) et l'organe le plus atteint (72,6%). Les tumeurs malines (23,9%) et bénignes (51,4% dont 29,6% de léiomyomes), étaient les pathologies les plus fréquentes. Dans le modèle final : l'âge, notamment les tranches de [35-50 ans] (OR=11,4 ; (IC95% [2,8 – 46,5]), [51-89 ans] (OR=11,2 ; (IC95% [2,7 – 46,1])), les salpingites (OR=2.6 ; (IC95% [2,1 – 3,3]) et les tumeurs bénignes (OR=1,3 (IC95% [1,1 – 1,6]) étaient des facteurs de risque de survenue d'une endométriose.

Conclusion : Cette étude est la première étude publiée qui révèle que l'endométriose est fréquente chez les femmes en âge de procréer au Gabon. Afin de mieux caractériser cette pathologie dans ce pays, il serait judicieux de mener des études prospectives notamment des études CAP.

Mots clés : Endométriose, Gabon, maladies gynécologiques, épidémiologie, infertilité, EndoFiGabon

[C0148] Épidémiologie du paludisme dans une région désertique, cas de la région de Taoudenni au Mali de 2017 à 2020

Oumar Sangho¹, Moulaye Oumar Koutam Zanouni², Cheick Abou Coulibaly¹, Ould Adahla Jiddou³, Ould Bayes³, Daouda Samaké¹, Aboubacar Sangho⁴, Nouhoum Telly¹, Salia Kéïta¹, Ousmane Boua Togola⁵, Fanta Sangho¹, Titi Simaga⁶, Kassoum Koné⁷, Boureyma Belem⁷, Cheick Oumar Bagayoko¹, Hamadoun Sangho¹

1.Département d'Enseignement et de Recherche en Santé Publique et Spécialités (DERSP), Faculté de Médecine et d'Odontostomatologie (FMOS), Bamako, Mali

2.Université Kankou Moussa, Hippodrome, Bamako, Mali

3.Direction Régionale de la Santé de Taoudenni, Mali

4.Département d'Enseignement et de Recherche (DER) des Sciences Pharmaceutiques, FAPH/USTTB, Mali

5.Direction Générale de la Santé et de l'Hygiène Publique (DGSHP), Bamako, Mali

6.Institut d'Ophthalmologie Tropicale de l'Afrique (IOTA), Bamako, Mali

7.Institut National de Santé Publique (INSP), Bamako, Mali

Introduction : Introduction : Le paludisme est une maladie humaine fébrile aiguë causée par le Plasmodium qui se transmet par les piqûres de l'anophèles femelles infectées. C'est un problème majeur de santé publique. Au Mali la prévalence du paludisme est de 19%. La région de Taoudenni fait partie de la zone sahélo-saharienne à risque d'épidémie de paludisme avec des incidences annuelles inférieures à 100 cas pour 1000 personnes-années. L'objectif était d'étudier l'épidémiologie du paludisme dans cette zone désertique.

Méthode : Méthodes : Il s'agissait d'une étude transversale d'Août 2021 à Juillet 2022. Nous avons analysé les données du paludisme de 2017 à 2020. Les rapports mensuels sous format Excel® ont été utilisés. L'analyse a été faite avec le logiciel SPSS® version 18. Les fréquences, ratios et moyennes ont été déterminés. Les comparaisons de fréquences ont été faites avec le test de Khi2 de Pearson ou le test Exact de Fisher.

Résultats : Résultats : Au total, 10.084 patients ont été recensés comme cas suspects de paludisme dont 4.202 cas confirmés soit 41,67%. Le sex-ratio était de 1,07 en faveur du féminin. Les plus de 15 ans avaient la proportion de confirmation la plus élevée avec 47,65% suivis des 5-14 ans avec 41,08% (p-value=2*10⁻⁵). Le paludisme était simple dans 91,2% des cas et grave dans 8,8% des cas (p-value=5*10⁻⁵). Les pics d'incidences étaient surtout observés entre septembre et octobre. L'incidence annuelle la plus élevée fut observée en 2020 et la plus faible en 2017 avec 82 et 21 cas pour 10000 habitants respectivement.

Conclusion : Conclusion : De 2017 à 2020 nous avons observé une tendance à la hausse des cas de paludisme dans la région de Taoudenni. Une étude intégrant les données de pluviométrie pourrait être envisagée pour mieux expliquer les tendances observées.

Mots clés : Mots clés : Paludisme, Désert, Taoudenni, Mali

[C151] Facteurs associés à l'échec thérapeutique de la tuberculose pharmaco sensible chez les patients suivi au centre hospitalier universitaire Sylvanus Olympio (CHU SO) de Lomé au TOGO de 2020 à 2021

Agbemadon E. Kokou^{1,2}, Togan M. Roméo³, Diongue B. Fatoumata¹, Ba F. Mohamadou¹, Diallo A. Ibra¹, Dogo M. F⁴, Faye Adama¹

1.Institut Santé Et Développement (ISED) de Université Cheick Anta Diop (UCAD) de Dakar

2.Institut Africain de Santé Publique (IASP), Ouagadougou, Burkina Faso

3.Université de Lomé, Département de Santé Publique de la Faculté des Sciences de la Santé

4.Programme National de Lutte contre la Tuberculose (PNLT), Lomé, Togo

Introduction : L'échec thérapeutique dans le traitement de la tuberculose pharmaco-sensible est un phénomène grandissant qui augmente le risque de multirésistance du bacille de Koch. Cette étude visait à décrire les facteurs associés à l'échec thérapeutique des patients atteints de tuberculose pharmaco-sensible.

Méthode : Une étude transversale rétrospective descriptive et analytique a été réalisée du 1er janvier 2020 au 31 décembre 2021. La population d'étude était constituée des patients traités pour tuberculose pulmonaire à microscopie positive et pharmaco-sensible suivi au Centre Hospitalier Universitaire Sylvanus Olympio (CHU SO) de Lomé. L'échec thérapeutique a été défini comme des cas d'échec confirmés biologiquement et des décès après initiation au traitement de première ligne. Les données ont été collectées dans les dossiers de prise en charge des patients dans le service et par interview direct avec ces patients ou leurs répondants en cas de décès ou par un entretien téléphonique. Les analyses ont été réalisées avec le logiciel R version 4.2.0. Une régression logistique binaire a été réalisée avec un seuil de significativité fixé à 0,05.

Résultats : Au total 149 cas de tuberculose pharmaco sensible ont été inclus. L'âge moyen de la population d'étude était de 38,7 ans avec un écart type de 15,1 ans. Le sexe ratio était de 2,3 à prédominance masculine. Le taux d'échec thérapeutique était de 34,2%. Les facteurs associés à l'échec thérapeutique étaient une indice masse corporelle faible (maigreur) (ORa=6,1 [1,7- 21,7]) ; la présence de l'infection à VIH (ORa=10,6[3,0-37,2]); l'éthylisme pendant traitement (ORa=11,06 [1,3-95,1]) ; la non visite d'un agent de santé (ASC) (ORa=5,92 [2,4-14,7]).

Conclusion : Le renforcement des stratégies de lutte, l'implication communautaire, la gestion de trouble de l'usage abusif l'alcool pourrait contribuer à la réduction le taux d'échec et la mortalité liée à la tuberculose au Togo

Mots clés : Tuberculose, échec thérapeutique, facteurs associés, Togo

[C152] Etude de la dispensation des médicaments anticancéreux au CHU du Point G de Bamako au Mali en 2021

Oumar Sangho¹, Fatoumata Sidibé², Ousmane Boua Togola³, Fanta Sangho⁴, Aboubacar Sangho⁴, Sadio dite Yehia Sarro^{1,5}, Housseini Dolo¹, Baba Diallo⁶, Cheick Abou Coulibaly¹, Nouhoum Telly¹, Aminata Tiéba Traoré², Titi Simaga⁷, Sékou Bah², Hamadoun Sangho¹

1.Département d'Enseignement et de Recherche en Santé Publique et Spécialités (DERSP), Faculté de Médecine et d'Odontostomatologie (FMOS), Bamako, Mali

2.Pharmacie hospitalière du Centre Hospitalier et Universitaire du Point-G, Bamako, Mali

3.Direction Générale de la Santé et de l'Hygiène Publique (DGSHP), Bamako, Mali

4.Département d'Enseignement et de Recherche (DER) des Sciences Biologiques et Médicales, Faculté de Pharmacie (FAPH), Université des Sciences, des Techniques et des Technologies de Bamako (USTTB), Mali

5.Centre de Recherche et de Lutte contre la Drépanocytose (CRLD), Bamako, Mali

6.CHU Centre National d'Odonto-Stomatologie (CNOS), Bamako, Mali

7.Institut d'Ophthalmologie Tropicale de l'Afrique (IOTA), Bamako, Mali

Introduction : Introduction : Le cancer est une maladie non transmissible dont la prise en charge est multisectorielle. Le but de cette étude était de contribuer à l'amélioration de la dispensation de ses médicaments.

Méthode : Il s'agissait d'une étude transversale descriptive qui a porté sur la dispensation des médicaments anticancéreux dans la pharmacie hospitalière du CHU-Point G. Elle a permis d'examiner toutes les ordonnances provenant du service d'hématologie et d'oncologie médicale validées par la pharmacie hospitalière du 1er janvier au 31 décembre 2021. Des ratios, proportions ont été calculés pour les variables qualitatives et la moyenne $\pm$ écart type pour celles quantitatives.

Résultats : Résultats : Un total de 477 ordonnances a été examiné. La moyenne d'âge était de $49,22 \pm 15,66$ ans avec 44,4% de 51-70ans. Le sex-ratio était de 2,27 en faveur du féminin. Environ 63,2% avaient moins de 70kg, l'IMC était normal pour 44,2%. Le prescripteur était un médecin spécialiste dans 87,2% des cas et le dispensateur un pharmacien pour 7,4%. Environ 61% des ordonnances étaient mal rédigées. Les cancers du sein (42%) et de l'œsophage (8,7%) étaient les plus fréquents. La molécule cytotoxique la plus prescrite était le Paclitaxel avec 23,1% suivi de l'Acide Zoledronique avec 12,4%. L'Ondansétron et le Dexaméthasone étaient les adjuvants les plus prescrits avec respectivement 41,1% et 22,2%. Les types de protocole les plus utilisés étaient le Paclitaxel avec 26% et le Paclitaxel-Cisplatine avec 16,4%. Le nombre de cure variaient de 10-24 pour 6% des patients. Le Paclitaxel était indisponible dans 3% de cas.

Conclusion : Conclusion : Cette étude montre la fréquence élevée de cancer chez les femmes et de cure, et l'insuffisance dans la qualité de l'offre de soins. Il en ressort une nécessité d'organisation de la chaîne de prise en charge. Une étude étiologique pourra déterminer les facteurs associés pour une meilleure amélioration.

Mots clés : Mots clés : Dispensation, médicaments anticancéreux, pharmacie hospitalière.

[C153] Développement d'une échelle de satisfaction des usagers des mutuelles de santé dans le cadre de la couverture maladie universelle

Diallo Amadou Ibra¹, Ndiaye Ibrahima¹, Ridde Valery¹, Leye Mamadou Makhtar Mbacké¹, Faye Adama¹

1. Service de Médecine Préventive et de Santé Publique, Institut de Santé Et Développement, Université Cheikh Anta Diop de Dakar/Sénégal

Introduction : Le Sénégal dans le cadre de l'atteinte des objectifs de couverture maladie universelle, a développé de nouvelles stratégies comme la départementalisation des mutuelles de santé à travers les Unités Départementales d'Assurance Maladie (UDAM). Cette stratégie est mise en pilote dans deux départements. Dans une perspective de mise à l'échelle, il était important d'évaluer la satisfaction des bénéficiaires. C'est dans cette perspective que cette échelle a été développée.

Méthode : Il s'agissait d'une enquête transversale et analytique réalisée auprès des bénéficiaires des UDAMs. L'échantillonnage par tirage systématique stratifié suivant les postes de santé d'affiliation a été réalisé sur les bases de données des adhérents ayant utilisés des mutuelles au cours des quatre dernières semaines précédant le tirage. Le questionnaire a été construit sur des travaux d'évaluation de la satisfaction des usagers de services de santé. La collecte est réalisée à partir d'un centre d'appel téléphonique synchronisé à un serveur internet concernant : les caractéristiques personnelles, les items de satisfactions mesurés par une échelle de Likert à 5 niveaux liés à l'accueil, aux procédures d'adhésion, à la contribution financière, aux paquets de services fournis, au système de recours et à la confiance dans la gestion. Les analyses ont été réalisées avec le logiciel JASP et le package SEMinR.

Résultats : L'étude a été réalisée chez 398 bénéficiaires. L'âge moyen était de 38 ans ($\pm 15,8$ ans). Ils étaient en prédominance de sexe féminin (71,6%), sans instruction (69,1%). L'échelle d'évaluation comportait 21 items. Le test de Kaiser-Meyer-Olkin $> 0,70$ et la significativité du test de sphéricité de Bartlett justifiaient l'analyse factorielle exploratoire qui a retenu 5 facteurs ou dimensions sur la base de la normalisation de Kaiser et d'une rotation promax. Cette échelle a été confirmée avec les paramètres d'ajustement GFI, CFI, TLI supérieurs à 0,95 et SMSEA et SRMR proches de 0,05. L'échelle présentait une bonne fiabilité avec des alphas de Cronbach et des fiabilités composites supérieurs à 0,7. La validité était aussi bonne avec une convergence (AVE) supérieure à 0,5 et le critère HTMT de la validité discriminante inférieur au seuil de 0,85. L'analyse structurelle a permis l'établissement des relations entre les dimensions.

Conclusion : Cette étude a permis de montrer que cette échelle pourrait être utilisée pour l'évaluation de la satisfaction des mutuelles de santé pour une amélioration des services dans l'accès universel à la couverture maladie universelle

Mots clés : Échelle, Satisfaction, Mutuelle de santé, Validité, Analyse structurelle, Sénégal

[C164] Pratiques alimentaires et apports nutritionnels des enfants de 6 à 36 mois à abidjan-cote d'ivoire

Coulibaly Amed¹, Sable Stéphane Parfait T¹, Assi Kaudjhis Régine², Ake-Tano Odile¹, Dagnan N'cho Simplicie¹

1.UFHB, UFR Sciences Médicales, Département de Santé Publique et Spécialités

2.Institut National de Santé Publique (INSP) Côte d'Ivoire

Introduction : La malnutrition constitue un problème de santé publique et touche surtout les enfants de 6 à 36 mois. L'objectif de cette étude était d'évaluer les pratiques alimentaires et les apports nutritionnels de ces enfants, en vue de l'élaboration de stratégies de lutte contre cette maladie.

Méthode : Il s'est agi d'une étude transversale à visée descriptive qui a porté sur 405 enfants âgés de 6 à 36 mois dans 3 structures sanitaires à Abidjan. L'évaluation des apports nutritionnels a été faite à l'aide du rappel de 24 heures et de la table des valeurs alimentaires de la FAO. Les variables quantitatives et qualitatives ont été décrites respectivement par la moyenne, les écarts types et les proportions.

Résultats : L'âge moyen des enfants était de 14,21 mois $\pm$ 7,55. La majorité des enfants étaient à l'alimentation de complément (68%). Les aliments les plus consommés en proportion et en fréquence étaient le lait (64%) et les céréales (21%). Le poisson n'était consommé que dans une proportion de 2%. Le nombre minimum de repas était respecté chez 56,6% des enfants. La diversité alimentaire était bonne chez 37,8% des enfants et seul 15,7% avaient reçu l'apport alimentaire minimum acceptable. L'apport moyen en énergie, en protéines et en fer était respectivement de 917 Kcal, de 26 g et de 7,1mg. Les besoins nutritionnels des enfants n'étaient pas couverts chez 68% pour le fer, chez 47% pour l'énergie et chez 9% pour les protéines.

Conclusion : Les pratiques et apports alimentaires doivent être améliorés chez les enfants de 6 à 36 mois à Abidjan afin de leur garantir un bon état nutritionnel. Pour ce faire, les aliments devront être diversifiés et un accent particulier devra être mis sur la consommation d'aliments riches en fer.

Mots clés : Pratiques alimentaires, apports nutritionnels, enfants, Côte d'Ivoire

[C166] Connaissances, attitudes et pratiques du personnel soignant de l'hôpital général de Jacqueville sur la gestion des déchets hospitaliers en 2021

Kilanko Grace Esther¹, Aholia Cyriaque Valencia¹, Kohion Aristide Romaric Odré¹, Adagra Ophélie Irma Charlene², Bremi Amoussan Privat¹, Guiegui Chimène Pulchérie², Aka Irel Narcisse², Tchicaya Aimé François², Kouassi Yao Mathias².

1. Service de médecine du travail et pathologie professionnelle. Centre Hospitalier et Universitaire d'Angré, Abidjan – Côte d'Ivoire

2. Département de santé publique et spécialités. UFR Sciences Médicales, Université Félix Houphouët-Boigny. BP V 166 Abidjan - Côte d'Ivoire

Introduction : Les déchets hospitaliers, quels qu'ils soient, constituent un véritable problème de santé publique. L'objectif était d'évaluer les connaissances du personnel soignant de l'hôpital général de Jacqueville et de décrire leurs attitudes et pratiques sur la gestion des déchets hospitaliers.

Méthode : Nous avons réalisé une étude transversale et descriptive de mai à novembre 2021 (6 mois) à l'hôpital général de Jacqueville, en Côte d'Ivoire. Le recueil des données s'est fait à l'aide d'un auto-questionnaire renseignant sur le niveau de connaissances, attitudes et pratiques du personnel soignant concernant la gestion des déchets des activités de soins et d'une deuxième fiche destinée à la direction de l'hôpital qui renseignait sur l'aspect administratif et réglementaire de la gestion des déchets. La saisie et l'analyse des données ont été effectuées au moyen des logiciels Word et Excel 2016.

Résultats : Notre étude a porté sur 65 agents de soins dont 67,7% de femmes. L'âge moyen était de $39,96 \pm 6,82$ ans. Il s'agissait principalement d'infirmiers (27,7 %), de sages-femmes (21,5%), d'agents d'hygiène (15,4%) et de médecins (12,3%) avec une ancienneté professionnelle moyenne de $7,78 \pm 5,66$ ans. En rapport avec le niveau de connaissance, trente agents (46,15 %) désignaient les déchets ménagers et assimilés comme étant aussi des déchets hospitaliers et plusieurs affirmaient que les risques sanitaires d'une mauvaise gestion des déchets étaient dominés par les infections nosocomiales (69, 2%). Concernant l'attitude des travailleurs, 36,9 % ne faisaient pas de tri de déchets. Ceux qui en faisaient (63,1%), utilisaient les boîtes de sécurité (84,6 %) et les poubelles couvertes (70,8 %). Selon les travailleurs, les déchets étaient stockés à l'extérieur des services (58,5 %) dans de mauvaises conditions (32,3%). Lors du transport des déchets, environ la moitié des agents portait les EPI. Pour leur élimination, il n'y avait pas d'incinérateur, les déchets étaient donc brûlés à l'air libre. Au niveau administratif et réglementaire, les mesures indispensables à la gestion efficace des déchets hospitaliers n'étaient pas effectives.

Conclusion : Ces constats imposent la mise en place d'une politique de gestion des déchets hospitaliers mettant l'accent sur la formation des agents et la mise à disposition du personnel soignant d'un équipement adéquat.

Mots clés : Mots clés : Etude CAP – Déchets hospitaliers – Personnel soignant – Jacqueville

**[C171] Fièvre charbonneuse à *Bacillus anthracis* et espèces apparentées :
Connaissances, Attitudes et Pratiques de la population à risque en zone urbaine,
Abidjan 2023**

Bahan Ginissemment A. J¹, Diallo Maky², Yapi Ivanne A. D¹, Kean Mayouka⁴, Ano Marie N³, Tetchi Orso³, Kouassi Monique C⁵, Kacou-N'douba Adèle¹

1.Département de Microbiologie, UFR Sciences Médicales d'Abidjan, Université Félix Houphouët Boigny

2.Laboratoire de Biostatistique, Méthode et Informatique Médicale, UFR Sciences Médicales, Université Félix Houphouët Boigny

3.Département de Santé publique et spécialités, UFR Sciences Médicales d'Abidjan, Université Félix Houphouët Boigny

4.Université Félix Houphouët Boigny d'Abidjan (UFHB)

5.AFROHUN, UFR Sciences Médicales d'Abidjan, Université Félix Houphouët Boigny

Introduction : La fièvre charbonneuse ou anthrax est une zoonose émergente causée par *Bacillus anthracis*. Elle entraîne d'importantes pertes de production chez le bétail et des maladies graves chez les humains avec des épidémies sporadiques. En Côte d'Ivoire, plusieurs cas ont été identifiés en 2001 dans les forêts tropicales humides du centre et du nord-est. L'objectif de notre étude était d'évaluer le niveau de connaissances, attitudes et pratiques (CAP) de la population à risque sur l'anthrax à Abidjan.

Méthode : Une étude transversale a été menée sur les CAP chez les éleveurs, bouchers et les transporteurs de bétail dans trois communes d'Abidjan (Abattoir de Port-Bouët, zone de pâturage d'Abobo et d'Anyama) de juin à septembre 2023. Un score de connaissance, une analyse univariée et des tests du Chi carré ont été réalisés pour explorer les déterminants du CAP.

Résultats : Parmi les 450 répondants, 99,10 % (446/450) étaient des hommes, l'âge moyen était de 39,40±10,82 ans et la majorité 54,90% était des revendeurs ou acheteurs de bétail suivi des éleveurs 36,70% et des transporteurs de bétail 2,70%. Parmi eux, 45,60% avaient fait l'école coranique, 25,80% avaient le niveau d'éducation secondaire et 13,30% étaient analphabètes. Seul 21,60% des personnes interrogées avaient entendu parler de la maladie du charbon. Les connaissances des participants sur les signes cliniques chez l'animal étaient variées : 15,30% ont mentionné des saignements des orifices ; 5,60% ont signalé une mort subite de l'animal tandis que 75,80% n'étaient au courant d'aucun signe clinique. Seul 5,30% des interrogés savaient que la maladie était dû à un germe. Le niveau d'éducation ($p \leq 0,000$) et la profession ($p = 0,000$) étaient significativement associés aux connaissances.

Conclusion : La CAP des participants concernant l'anthrax était faible. Il n'y avait pas de compréhension cohérente de la maladie parmi les participants. L'étude a également révélé que les participants n'ont pas reçu une éducation cohérente, adéquate et continue concernant la maladie.

Mots clés : Fièvre charbonneuse- Connaissances, Attitudes et Pratiques (CAP)-Abidjan.

[C175] Prédiction de l'incidence de la rougeole en Côte d'Ivoire de 2023-2027

Calixte Haba Hebane Guehi¹, Kouadio Daniel Ekra², Ghislain Nono Gueye³, Eric Martial Ahoussou², Lépri Nicaise Aka²

1.Direction de Coordination du Programme Elargi de vaccination, Côte d'Ivoire

2.Département de Santé Publique, Université Félix Houphouët Boigny, UFR des Sciences Médicales, Côte d'Ivoire

3.Economics & Finance Department, Louisiana Tech University, USA

Introduction : Le Plan stratégique pour la vaccination 2021-2030 de l'OMS/Afrique vise à éliminer la rougeole d'ici 2030. Il importe donc de prédire l'incidence de celle-ci en Côte d'Ivoire en vue de prendre les mesures nécessaires pour son élimination. L'objectif de l'étude est de prédire sur les cinq prochaines années, l'incidence de la rougeole avec le modèle de moyenne mobile intégrée autorégressive (ARIMA).

Méthode : Les données de surveillance de la rougeole en Côte d'Ivoire de 2010-2022 ont servi pour ajuster le modèle ARIMA. Les modèles construits ont été évalués avec le critère d'information d'Akaike (AIC) et le test de Ljung-Box. Le modèle ARIMA ajusté a été appliqué pour obtenir l'incidence de rougeole ajustée de 2010-2022 et le comparer avec les valeurs observées correspondantes. Pour évaluer la validité du modèle proposé, le pourcentage d'erreur absolu moyen (MAPE) entre l'incidence observée et ajustée (2010-2022) a été calculé. Enfin, le modèle ARIMA ajusté a été utilisé pour prévoir l'incidence de rougeole de 2023 à 2027. Toutes les analyses ont été effectuées à l'aide du logiciel R4.2.1 avec significativité de $p < 0,05$

Résultats : Le test d'ajustement du modèle optimal ARIMA (1,1,0) a montré des autocorrélations non significatives dans les résidus du modèle (statistique Ljung-Box $Q=3,04$; $p=0,384$). Les valeurs ajustées réalisées par le modèle ARIMA (1,1,0) pour les années 2010-2022 suivaient de près les valeurs observées pour les mêmes années, avec un MAPE de 10,23%. L'incidence prédite de rougeole de 2023-2027 est respectivement de 47,4 ; 44,5 ; 42,6 ; 41,2 et 39,6 cas/1000000 habitants.

Conclusion : Les modèles ARIMA appliqués aux données historiques de surveillance de la rougeole constituent un outil important pour prévoir l'occurrence de la maladie. L'on observe une baisse progressive mais non suffisante pour parvenir à l'élimination de la rougeole d'ici 2030. Il est donc important d'adopter des stratégies vaccinales innovantes en vue de parvenir à cet objectif.

Mots clés : Prédiction - rougeole - ARIMA - Côte d'Ivoire

[C176] Profil épidémiologique de la rougeole de 2010-2022 en Côte d'Ivoire

Kouadio Daniel Ekra ¹, Calixte Haba Hebane Guehi ², Eric Martial Ahoussou ¹, Lépri Nicaise Aka ¹

1.Département de Santé Publique, Université Félix Houphouët Boigny, UFR des Sciences Médicales, Côte d'Ivoire

2.Direction de Coordination du Programme Elargi de vaccination, Côte d'Ivoire

Introduction : En 2011, les pays africains prévoyaient l'élimination de la rougeole à l'horizon 2020. Cet objectif n'étant pas atteint, quel a été le profil épidémiologique de la rougeole en Côte d'Ivoire de 2010 à 2022 ?

Méthode : Il s'agissait d'une étude transversale portant sur les données de surveillance de la rougeole et de couverture vaccinale (CV) contre la rougeole/rubéole (RR) du Programme Elargi de Vaccination de 2010-2022. Ces données proviennent des notifications des districts sanitaires et du diagnostic biologique de l'Institut Pasteur de Côte d'Ivoire. A l'aide du logiciel R4.2.1, nous avons analysé les données nationales et fait les cartes avec le logiciel ArcGIS 10.7.

Résultats : Un total de 6584 (24,3%) cas confirmés de rougeole a été rapporté sur 27090 cas notifiés de 2010-2022. Au plan national, l'incidence annuelle de la rougeole a régulièrement augmenté passant de 23 à 53 cas/1000000 habitants entre 2018-2022 avec un pic observé en 2021 (67 cas/1000000 habitants). L'incidence était constante à 2 cas/1000000 habitants entre 2012 et 2017. La courbe épidémiologique note une hausse des cas de rougeole les 6 premiers mois de chaque année. L'âge médian était de plus en plus élevé au fil des années ($p=0,001$). Les enfants de 0-5 ans représentaient 67% des cas et 81% des cas étaient non vaccinés. L'analyse cartographique montre que les incidences élevées (≥ 100 cas/1000000 habitants) étaient pour la plupart observées dans les districts avec une bonne notification de cas suspects et une CV $< 95\%$.

Conclusion : L'augmentation des cas de rougeole est sous l'effet conjugué de deux facteurs que sont une couverture vaccinale non optimale et une amélioration du système de surveillance en rapport avec les formations des épidémiologistes terrain, le déploiement de consultants dans les districts, les réunions hebdomadaires de suivi avec les districts et l'accroissement du nombre de district en 2019.

Mots clés : Epidémiologie – rougeole – 2010-2022 – Côte d'Ivoire

**[C184] Disponibilité de produits de santé et Financement des approvisionnements :
Quelle Stratégie ?**

OGA Agbaya¹

1.UFR Sciences Pharmaceutiques et Biologiques, UFHB

Introduction : L'accès, pour tous, à des produits de santé sûrs, efficaces, de qualité pharmaceutique, à un prix abordable ne peut être effectif que si lesdits produits sont disponibles. Objectifs : (i) déterminer la disponibilité d'un panier de produits de santé dans des établissements de soins et pharmaceutiques ; (ii) montrer des enjeux du financement pour l'accès universel aux produits de santé ; (iii) résumer des éléments de financement stratégique durable des approvisionnements.

Méthode : La disponibilité a été calculée comme le pourcentage de situations où un produit étudié était présent dans un point de vente visité sur le nombre de paire produit de santé et point de vente. Une recherche documentaire a été réalisée pour examiner des approches stratégiques visant à garantir l'accès de tous aux produits de santé.

Résultats : La disponibilité globale de la marque d'origine était 14,6% et celle du générique équivalent était 42,6%. Cette faible disponibilité résultait d'une absence de mise en place des produits dans les points de vente visités : 83,3% pour la marque d'origine et 52,2% pour le générique équivalent. Dans 46,4% des situations, marque d'origine et générique équivalent n'étaient pas mis en place. Dans les officines privées de pharmacie, la disponibilité était 48,6% et 57,4% pour la marque d'origine et le générique équivalent, respectivement ; alors que la non mise en place était 46,2% pour la marque d'origine et 34,8% pour le générique équivalent. Cette absence de mise en place concernait davantage des produits chers et/ou délicats. Cela soulève des questions de stratégie d'approvisionnement au triple niveau institutionnel, national et international. En outre, la soutenabilité du financement exige des mécanismes de régulation des prix des produits, en suivant, par exemple, la Directive OMS sur les politiques nationales de prix des produits pharmaceutiques.

Conclusion : Assurer l'accès universel à des produits de santé, de plus en plus chers, dans des chaînes d'approvisionnement de plus en plus contraintes, exige d'élaborer une stratégie actualisée.

Mots clés : Produits de santé ; Financement ; Stratégie ; Disponibilité durable

[C185] Déterminants de la Disponibilité de produits de santé dans des points de vente en Côte d'Ivoire

OGA Agbaya¹

1.UFR Sciences Pharmaceutiques et Biologiques, UFHB

Introduction : Afin de garantir l'accès, pour tous, à des produits de santé sûrs, efficaces, de qualité pharmaceutique, à un prix abordable, les États et leurs partenaires doivent surmonter des difficultés et obstacles variés.

Objectif : identifier, parmi un ensemble de caractéristiques communes, pharmaceutiques, d'approvisionnement, de distribution, administratives, des facteurs associés à la disponibilité

Méthode : A partir d'un panier de 50 produits de santé dans des points de vente à l'intérieur des établissements de soins ou constituant des établissements pharmaceutiques, Une régression logistique a permis d'estimer des odds ratios ajustés de l'association des facteurs étudiés à la disponibilité.

Résultats : Les produits non exempts de taxes étaient moins disponibles, (OR[IC95%] = 0,22 [0,12-0,42]), et aussi les médicaments de marque d'origine et les génériques premiers arrivés sur le marché en Côte d'Ivoire (OR[IC95%] = 0,5 [0,3-0,7]) et les produits réservés exclusivement aux centres hospitaliers universitaires (OR[IC95%] = 0,57 [0,33-0,97]) et hôpitaux régionaux et généraux (OR[IC95%] = 0,48 [0,31-0,72]). Étaient trouvés plus disponibles, les produits non subventionnés par le gouvernement (OR[IC95%] = 1,99 [1,38-2,89]), ou par des partenaires (OR[IC95%] = 1,40 [1,01-1,95]). Les produits de santé étaient plus disponibles dans deux régions sanitaires (OR[IC95%] = 1,53 [1,1-2,1]) et (OR[IC95%] = 49,1 [12,1-199,6]) ainsi que dans les officines privées de pharmacie (OR[IC95%] = 2,19 [1,59-3,01]) et les dépôts pharmaceutiques (OR[IC95%] = 1,91 [1,14-3,20]). N'étaient pas associés à la disponibilité l'importation, le prix de vente unitaire.

Conclusion : Assurer l'accès universel à des produits de santé nécessite une analyse multifactorielle de l'approvisionnement

Mots clés : Produits de santé ; Disponibilité ; déterminants

[C186] Qualité de vie des diabétiques suivis au centre antidiabétique d'Abidjan en 2023

Konan Yao Eugène^{1,2}, Tetchi Ekissi Orsot¹, Ekou Franck Kokora¹, Ankon Yappih Zephyrin¹, Diallo Maky¹, Boumouan Jean Fabien^{1,2}, Ake-Tano Sassor Odile Purifine^{1,2}

1.Département de Santé Publique et Spécialités (UFR Sciences Médicales Abidjan, Université Félix Houphouët Boigny)

2.Institut National de Santé Publique (Côte d'Ivoire)

Introduction : En Côte d'Ivoire, très peu d'études se sont intéressées à la qualité de vie (QDV) des diabétiques. La présente étude a pour objectif d'évaluer la QDV des diabétiques suivis au Centre antidiabétique d'Abidjan et identifier les facteurs qui peuvent l'influencer.

Méthode : Il s'agissait d'une étude transversale à visée descriptive et analytique ayant inclus 180 diabétiques et qui s'est déroulée de juin 2022 à Avril 2023. La QDV a été évaluée par l'échelle ADDQOL comprenant trois scores. Le premier concerne la QDV générale. Le deuxième interroge le patient sur sa QDV s'il n'était pas diabétique. Le dernier est un score composé de 19 items concernant différents domaines de la vie. Le score varie de -9 : impact négatif maximal à +3 : impact positif maximal. Une analyse multivariée en régression logistique a été réalisée au seuil de 5% afin d'identifier les facteurs associés à une QDV altérée.

Résultats : Les diabétiques en majorité de sexe féminin (57,6%) avaient un âge moyen de 49,5 ans. Le score moyen de « QDV générale » était de 0,7. Le score de « QDV sans diabète » était de -3,25. Le score composite moyen était de -3,4. Les domaines de vie impactés étaient la liberté de manger, la liberté de boire, la vie familiale et les relations sentimentales (vie sexuelle). La présence d'une hypertension artérielle était associée à une détérioration de la QDV ($p=0,03$).

Conclusion : La QDV des diabétiques interrogés était mauvaise. Elle serait meilleure en l'absence de diabète. Son évaluation devrait s'intégrer dans la prise en charge des patients suivis au Centre antidiabétique d'Abidjan afin de dépister précocement les multiples problèmes liés à cette maladie chronique.

Mots clés : Evaluation, qualité de vie, diabétique, facteurs associés, Centre antidiabétique d'Abidjan

[C190] Analyse des données de surveillance de la Dengue, district sanitaire de Cocody-Bingerville, Côte d'Ivoire, Septembre 2023

Ese N'gbesso Roland Baudouin¹, P. Wilnique, J. Otshudiandjeka², I. Tiembre, J. Benie³

1.FETP Frontline

2.AFENET

3.INHP

Introduction : La dengue est endémique en Côte d'Ivoire. Après une baisse initiale sur cinq mois, une augmentation des cas a été observée à partir de la semaine 25 à Cocody-Bingerville. Une épidémie a été confirmée, déclenchant un plan de riposte. Concentrée dans le grand Abidjan, cette 6ème épidémie nécessite une analyse approfondie des données pour formuler des recommandations.

Méthode : Etude transversale à visée descriptive a été menée. Les données ont été extrait de la base MAGPI de la première à la 39e semaines épidémiologiques (SE) de 2023. Cas suspect : toute personne présentant une fièvre ou antécédent de fièvre dans les 10 derniers jours. Cas confirmé : cas suspect + sérologie positive et/ou TDR positif. Les variables sociodémographiques, cliniques et facteurs de risques ont été pris en compte. Des prélèvements de sang et de gîtes larvaires ont été faits. Les données collectées ont été saisies et analysées sur Excel et Epi-Info 7.2. Les mesures statistiques telles que : la médiane et fréquences ont été calculées.

Résultats : Au total 13015 cas suspect pour 576 positifs à la dengue ont été saisis soit un taux de positivité de 4,4%. L'âge médian est 36 ans [1-98], le ratio homme/femme est de 0,96. 14% (81/576) personnes des cas positifs ont eu une forme sévère et 5 d'entre eux sont décédées soit un taux de létalité de 6,2% (5/81). L'incidence cumulée de la dengue est de 0,06% (576/9500033) avec une augmentation du nombre de cas aux semaines 30-32. Les données entomologiques montrent que les deux communes (Cocody-Bingerville) du district sont touchées avec des gîtes larvaires positifs à 88% (3671/4172) aux moustiques Aedes

Conclusion : Épidémie de dengue en hausse à la semaine 32, touchant principalement les adultes, les femmes et les résidents de Cocody, avec une faible létalité. Lien avec la pluviométrie et le cadre de vie. Recommandation : maintenir la lutte antivectorielle et enquêter sur les facteurs déclencheurs.

Mots clés : Analyse, surveillance, Dengue, Cocody-Bingerville, Côte d'Ivoire

[C191] Effets de l'accès des ménages à des installations d'approvisionnement en eau de boisson, d'assainissement et d'hygiène sur la mortalité des enfants de moins de cinq ans en Afrique saharienne

Nicolas Gaffan¹, Alphonse Kpozèhouen¹, Cyriaque Degbey², Yolaine Glèlè Ahanhanzo¹

1.Département d'Epidémiologie et de Biostatistiques, Institut Régional de Santé Publique, Université d'Abomey-Calavi, Ouidah, Bénin

2.Département de Santé Environnement, Institut Régional de Santé Publique, Université d'Abomey-Calavi, Ouidah, Bénin

Introduction : Des études récentes ont obtenu des résultats discordants sur la question relative à l'association entre le niveau d'accès à des sources d'approvisionnement en eau de boisson, d'assainissement et d'hygiène (WASH) et les indicateurs de santé de l'enfant. La présente étude tire parti d'un grand ensemble de données démographiques et de santé des pays d'Afrique subsaharienne, pour tester l'hypothèse selon laquelle le niveau d'accès des ménages à des installations WASH détermine la survie à cinq ans des enfants.

Méthode : La population d'étude était constituée des enfants nés au cours des cinq années précédant les différentes enquêtes retenues. La variable dépendante était le statut (1 = décédé vs 0 = vivant) des enfants au jour de passage de l'enquêteur. Les conditions WASH dans lesquels vivent les enfants ont été évaluées dans leur environnement immédiat. Une régression logistique mixte a permis d'identifier les déterminants de la mortalité des moins de cinq ans au terme de laquelle les effets des conditions WASH ont été déduits.

Résultats : Les analyses ont concerné 303 985 participants. Globalement, 6,36% des enfants étaient décédés avant cinq ans. Après ajustement sur les potentiels facteurs de confusion, les enfants vivant dans des ménages utilisant des installations non-améliorées d'eau de boisson (ORa = 1,10 ; IC95% = 1,04-1,16) ou de l'eau de surface (ORa = 1,11 ; IC95% = 1,03-1,20) étaient plus susceptibles de décéder que ceux venant de ménages avec des installations de niveau élémentaire. Les enfants vivant dans des ménages utilisant des installations d'assainissement non-améliorées ont un risque de décès supérieur de 11% (ORa = 1,11 ; IC95% = 1,04-1,18) par rapport à ceux couverts par des services élémentaires d'assainissement.

Conclusion : Les interventions de réduction de la mortalité des moins de cinq devraient inclure une composante WASH et ciblées les enfants les plus à risque sur la base des facteurs qui ont été identifiés.

Mots clés : eau, assainissement, hygiène, mortalité, Afrique

LIVRET DES RÉSUMÉS

COMMUNICATIONS AFFICHÉES (POSTER)

1^{er} Congrès de la société africaine de santé publique

[C003] Renforcer les capacités des professionnels de santé en suivi et évaluation dans un établissement sanitaire publique : expérience de l'institut national de santé publique de côte d'ivoire.

Essis Esme Marie Laure¹, Manouan N'guetta Mathilde¹, Kouamé Ethmonia², Bissouma Anna-Corine Estell Liema², Tetchi E. Orsot³, Yayo Sagou Olivier⁴, Claon Stephane⁴, Konan Yao Eugene³, Yavo William⁴, Oga Agbaya Stephane⁴, Yeo Tenenan Jean Marie³, Aka Joseph³

1. Institut national de santé publique d'Abidjan, Côte d'Ivoire ; Cellule de Recherche en Santé de la Reproduction de Côte d'Ivoire

2. Institut national de santé publique d'Abidjan

3. Institut national de santé publique d'Abidjan ; UFHB, UFR des sciences médicales

4. Institut national de santé publique d'Abidjan ; UFHB, UFR des Sciences Pharmaceutiques et Biologiques

Introduction : L'insuffisance de compétences en suivi et évaluation (S&E) du personnel médical a fait l'objet d'un axe prioritaire du plan national de S&E de la lutte contre le VIH (2006-2010) visant le renforcement des capacités des acteurs dans la thématique. L'Institut National de Santé Publique (INSP) d'Abidjan en partenariat avec le projet MEASURE Evaluation (agence d'exécution de l'USAID) a dispensé une formation en S&E des programmes VIH/Sida aux professionnels de santé de 2011 à 2016.

Méthode : Une collaboration fructueuse entre l'INSP et le Projet MEASURE Evaluation, a abouti à la révision d'un cours national francophone de S&E des programmes VIH/sida. L'objectif était d'amener les participants à maîtriser : (i) les concepts, outils et méthodes de S&E, (ii) les critères de choix des indicateurs appropriés et (iii) à concevoir des plans de S&E cohérents à une approche pédagogique adaptée à l'apprentissage des adultes. Les sessions de formation ont été encadrées par des pré et post-tests puis des évaluations quotidiennes et finales portant sur le déroulement et le contenu de l'agenda.

Résultats : Quelques 89 professionnels de santé (69% d'hommes et 31% de femmes) œuvrant au niveau national (51% au niveau central dont 58% dans les programmes de santé) et dans les agences des partenaires au développement (37%) ont participé à ce programme de renforcement de capacité. La majorité des participants étaient des cadres supérieurs de la santé (56%), des gestionnaires de données (23%) ainsi que des statisticiens et informaticiens (10%). La presque totalité des formations était financée par 16 partenaires techniques et financiers (85%) principalement projet MEASURE Evaluation (27%).

Conclusion : La formation en S&E a permis de répondre aux besoins en formation identifiés en S&E au niveau national et d'accroître à moindre coût la masse critique des compétences nationales conduisant à une certaine culture en S&E.

Mots clés : Formation de courte durée, renforcement de capacité, suivi et évaluation, professionnel de santé, Afrique, Cote d'Ivoire

[C004] Détection Phénotypique de Staphylococcus aureus résistant à la méticilline et résistance associée au Centre Hospitalier et Universitaire de Bouaké (2019-2021)

Gawa KJ¹, Monemo P^{1,2}, N'Guessan M^{1,2}, Tadet JON^{1,2}, Konan AS¹, Vaho M¹, Wayoro OZ¹, Akoua Koffi C^{1,2}

1.Laboratoire Bactériologie-Virologie, Centre Hospitalier et Universitaire de Bouaké

2.UFR des Sciences Médical, Université Alassane Ouattara, BP 1174 Bouaké

Introduction : Staphylococcus aureus résistant à la méticilline (SARM) est une bactérie multirésistante qui pose un problème de santé publique en milieu de soins. L'objectif de cette étude était de déterminer la prévalence de SARM et le niveau de sensibilité aux autres antibiotiques au CHU de Bouaké

Méthode : Il s'est agi d'une étude rétrospective réalisée sur les dossiers microbiologiques de patients consultants le Laboratoire de Bactériologie-Virologie du CHU de Bouaké de janvier 2019 à décembre 2021. Les souches de Staphylococcus aureus ont été isolées selon les méthodes de Bactériologie conventionnelle à partir de produits biologiques prélevés au cours d'épisodes infectieux divers. Ces souches ont bénéficié d'antibiogrammes réalisés par la méthode de diffusion en milieu gélosé de disques imprégnés d'antibiotiques. La résistance à la méticilline a été recherchée à l'aide d'un disque de cefoxitine (30ug).

Résultats : au cours de la période d'étude, 2564 souches bactériennes ont été testées. Ces souches étaient isolées de pus (47%), d'urines (29,1%), d'hémocultures (16%), qui provenaient de patients ambulatoires (18%) et hospitalisés (78%). Parmi ses souches, 473 étaient des Staphylocoques aureus dont 117 étaient méticillino-résistant (SARM) (24,7%). Les SARM étaient isolées majoritairement dans les échantillons de pus (69%), d'hémocultures (23%), chez les patients hospitalisés en Pédiatrie (29%), Traumatologie (17,9%) et les patients en ambulatoire (18,8%). Certaines des souches de SARM exprimaient une résistance à d'autres familles d'antibiotiques tels que les fluoroquinolones (60,6%), aminosides (43,6%), macrolides (phénotype MIsbc) (24%), acide fusidique (30%).

Conclusion : La prévalence élevée de SARM chez les patients hospitalisés ainsi qu'en ambulatoire nécessite une mise en application stricte des mesures d'hygiène de base ainsi que la promotion du bon usage des antibiotiques afin de limiter la propagation de ces bactéries multirésistantes.

Mots clés : SARM, CHU Bouaké, Antibiorésistance

[C005] Epidémiologie et agents étiologiques des infections urinaires infantiles au Centre Hospitalier et Universitaire (CHU) de Bouaké, Côte d'Ivoire

Gawa KJ¹, Monemo P¹, N'Guessan M¹, Tadet Jon¹, Oka KH², Konan AS¹, Akanji IA², Vaho M¹, Wayoro OZ¹, Sokodogo AM¹, Akoua Koffi C¹.

1.Laboratoire Bactériologie-Virologie, CHU de Bouaké

2.Service de Pédiatrie Médicale, CHU de Bouaké

Introduction : les infections urinaires (IU) sont fréquentes en milieu pédiatrique. L'écologie microbienne est souvent modifiée par la prescription abusive des antibiotiques dans la pratique des soins intensifs. L'objectif de cette étude était de déterminer la prévalence et les agents étiologiques responsables d'IU pédiatrique pour une meilleure prise en charge des enfants à Bouaké.

Méthode : L'étude a été réalisée au service de Pédiatrie en collaboration avec le Laboratoire de Microbiologie du CHU de Bouaké durant une période 30 mois allant de Juin 2020 à Décembre 2022. Un total de 219 enfants a été inclus et des échantillons d'urines ont été prélevés au cours de la période d'étude. Les souches bactériennes ont été isolées et identifiées selon les techniques de bactériologie conventionnelle. Le test de sensibilité des bactéries aux antibiotiques a été réalisé par la méthode de diffusion en milieu gélosé Mueller-Hinton et l'interprétation a été faite selon les recommandations CASFM/EUCAST 2022.

Résultats : Parmi les 219 enfants inclus, 28 cas d'infections urinaires ont été diagnostiqués (12,8%) et les anomalies de l'appareil urinaire 21,4% (6/28). L'âge médian = 8 ans (96 mois). La proportion des femmes était de 60,7% (17/28) avec un sex-ratio H/F= 0,65. La fièvre et les signes d'appel urinaire étaient évoqués respectivement 47% et 17,3%. Par ailleurs, le taux d'infection urinaire d'origine communautaire était de 25 % (7/28) contre 75 % (21/28) en milieu hospitalier. *Escherichia coli* (60,7%), *Klebsiella pneumoniae* (17,9%) étaient les principales bactéries isolées. Les taux de résistance aux bêtalactamines usuels étaient variables de 56,3 à 62,3%.

Conclusion : l'épidémiologie des infections urinaires pédiatrique était dominé par *Escherichia coli* avec des taux de résistances élevés vis-à-vis des antibiotiques usuels au CHU de Bouaké.

Mots clés : infections urinaires, Pédiatrie, Antibiorésistance, Bouaké

[C006] Epidémiologie descriptive des cancers gynécologiques et mammaires au Burkina Faso

Ouedraogo Smaïla¹, Zongo Nayi², Djiguemde Adéline², Zamane Hyacinthe³, Ouedraogo Aimé Sosthène⁴, Thieba Blandine³

1.Département de santé publique, UFR-SDS, Université Joseph Ki-Zerbo, Ouagadougou, Burkina Faso)

2.Département de Chirurgie et spécialités, UFR-SDS, Université Joseph Ki-Zerbo, Ouagadougou, Burkina Faso

3.Département de gynécologie-obstétrical, UFR-SDS, Université Joseph Ki-Zerbo, Ouagadougou, Burkina Faso

4.Département des Sciences Fondamentales et Mixtes, UFR-SDS, Université Joseph Ki-Zerbo, Ouagadougou, Burkina Faso

Introduction : Le cancer constitue un problème majeur de santé publique du fait de sa gravité, de sa prévalence et son incidence élevées. Toutefois, il n'existe pas de données sur son ampleur exacte au Burkina Faso du fait de l'absence d'un registre national fonctionnel. L'objectif de cette étude est de déterminer les incidences des cancers gynécologiques et mammaires entre 1988 et 2018.

Méthode : Il s'est agi d'une étude de série de cas effectuée entre décembre 2019 et août 2020. Elle a porté sur les cas de cancers gynécologiques et mammaires survenus entre 1988 et 2018. Les données ont été collectées des registres des laboratoires d'anatomie pathologique du Burkina Faso. Les paramètres étudiés ont été l'âge, le sexe, le siège, le type histogénétique et histologique. Les incidences globale et moyenne annuelle ont été estimées pour l'ensemble des cancers gynécologiques et mammaires et la tendance de ces cancers a été décrite à l'aide de deux courbes de tendance.

Résultats : 5471 cas de cancers gynécologiques et mammaires ont été recensés au cours de l'étude. L'âge moyen des patientes était de 48,1 ans avec un écart-type de 13,6 ans. Les cancers du sein (55,3%), du col de l'utérus (26,5%) et du corps de l'utérus (11%) étaient les plus fréquents. Les carcinomes (92,8%) et les adénocarcinomes (62,8%) étaient respectivement les types histogénétiques et histologiques les plus fréquents. L'incidence moyenne annuelle des cancers était de 176,4 cas avec un écart-type de 15,8 cas. Le taux d'augmentation global était de 121,8 en 31 ans, soit un taux d'augmentation moyen annuel de 3,9. Dans l'ensemble, l'incidence des cancers gynécologiques et mammaires a progressé entre 1988 et 2018.

Conclusion : Les cancers féminins sont fréquents et surviennent à un âge relativement jeune. Il est important de mettre en place des mesures de prévention et de dépistage accessibles à toute la population cible tout en veillant à opérationnaliser le registre du cancer pour des statistiques plus fiables.

Mots clés : cancers - gynécologiques - mammaires - épidémiologie

[C012] Evaluation du système logistique pour la préparation et la riposte aux épidémies au Bénin en 2023

MONGBO Virginie¹, GUEDJO Grâce Wylliam Arthur¹, PARAÏSO Moussiliou Noël²

1.Département Politiques et systèmes de Santé, Institut Régional de Santé Publique, Université d'Abomey-Calavi

2.Département Promotion de la Santé, Institut Régional de Santé Publique, Université d'Abomey-Calavi

Introduction : Face aux menaces d'urgences sanitaires auxquelles sont exposés les systèmes de santé et conformément au Règlement Sanitaire International, chaque pays devrait se préparer à y riposter. La présente étude visait à évaluer le système logistique pour la préparation et la riposte aux épidémies en 2023 au Bénin.

Méthode : Il s'agissait d'une étude évaluative, ayant porté sur les acteurs des structures impliquées dans le système logistique de préparation et de riposte aux épidémies au Bénin. Ils ont été sélectionnés aux niveaux central et intermédiaire du système de santé, par choix raisonné. Le système logistique a été évalué à travers ses composantes : opérations logistiques, transport, infrastructures et coordination, déclinées en sous-composantes, notées 0, 1 ou 2, selon que l'élément soit présent ou non et selon son importance, puis exprimées en score. Le système logistique était apprécié par le score par rapport au total des points obtenus, avec l'échelle à deux niveaux, bon si supérieur ou égal à 80% et mauvais si inférieur. Les données ont été collectées par exploitation documentaire, entretien, observation et enquête par questionnaires. Les référentiels étaient ceux de l'Organisation Mondiale de la Santé

Résultats : Au total, 23 acteurs ont participé à l'étude qui a révélé que le système logistique pour la préparation et riposte aux épidémies au Bénin présentait des insuffisances, avec un score global de 71,15%. Les scores étaient respectivement de 71,64%, 80,00%, 100,00% et 10,00% pour les composantes opérations logistiques, transport, infrastructures et coordination.

Conclusion : Il urge d'améliorer la mise en œuvre des opérations logistiques et la coordination du système logistique en vue d'une meilleure préparation et riposte aux épidémies au Bénin.

Mots clés : Système logistique, préparation, riposte, épidémies, Bénin

[C013] Facteurs sociodémographiques et économiques associés à la bilharziose urinaire dans les communes de Sô-ava, Aguégus et N'dali au Bénin

AHAMIDE Olutobi Josias¹, SOSSA Charles², SISSINTO Yolande³, YETONGNON Edmond Y⁴, BOKO-COLLINS Pélégie⁵, SITONDI Franck⁶, TCHEBE Romaric⁷, OUENDO Edgard-Marius⁸

1.Département des Politiques et Systèmes de Santé, IRSP-OUIDAH

2.MCA Santé Publique-Nutrition, Département des Politiques et Systèmes de Santé, IRSP-OUIDAH, Université d'Abomey-Calavi

3.Laboratoire de Parasitologie ; Faculté des Sciences de la Santé / Université d'Abomey-Calavi

4.Laboratoire d'Analyse des Dynamiques Sociales et de Développement (LADYSD) / Faculté des Sciences Agronomiques (FSA) / Université d'Abomey-Calavi

5.Sightsavers Bénin-Togo

6.Family Heath International; FHI

7.Programme National de lutte contre les Maladies Transmissibles (PNLMT-Ministère de la Santé)

8.Professeur Titulaire de Santé Publique ; Epidémiologie-Biostatistique, Ancien Directeur de l'IRSP-OUIDAH ; Université d'Abomey-Calavi

Introduction : La bilharziose urinaire, ou schistosome, une maladie répandue en Afrique subsaharienne, occupe le deuxième rang des maladies tropicales négligées de par sa prévalence et pour son importance en termes de santé publique après l'ankylostomose.

Ce contexte de la situation épidémiologique du Bénin a motivé une étude sur la détermination des facteurs sociodémographiques et économiques liés à la bilharziose. L'objectif général est d'étudier les facteurs sociodémographiques et économiques associés à la bilharziose urinaire dans les communes de Sô-Ava, Aguégus et N'dali.

Méthode : Cette étude a pour cible les populations constituées par les ménages des communes de Sô-Ava, Aguégus et N'dali. La sélection des sites de collecte a été faite par un choix probabiliste avec tirage au sort des écoles de façon aléatoire parmi toutes les écoles de chaque commune. L'étude est transversale, descriptive, à visée analytique et s'est déroulée de Mai à Juillet 2022.

Résultats : La population d'étude constituée des enfants est répartie dans les 3 tranches d'âge [8-10], [11-12] et [13-14] respectivement dans des proportions de 45,54%, 33,01%, et 21,45%. Les chefs de ménages autochtones (95,42%) sont en proportion beaucoup plus importante que les allochtones (4,58%). Sur une proportion de 100% seulement 26% disposent de latrines tandis que 73,01% n'en possèdent pas. Une proportion de 76,63% déclarent que l'eau est très chère contrairement à 23,37% qui se disent capables de s'en procurer. Les enfants qui fréquentent les cours d'eau sont en proportion très élevée soit 73,49% et 84,59% des enfants qui fréquentent l'eau y vont quotidiennement (une périodicité de 7 et 15 fois par semaine). Le point d'eau potable le plus proche est situé à moins de 500 m pour 83,51% et à plus de 500 m pour 16,43% des enquêtés. La disponibilité en eau potable est avérée dans 97,11% et réfutée par 2,89% de la population d'étude. Le forage constitue le point d'eau potable utilisé par 70,6% des enquêtés contrairement à 28,43% de personnes qui utilisent l'eau de la Soneb.

Conclusion : L'étude des facteurs sociodémographiques et économiques associés à la bilharziose réalisée dans les communes de Sô Ava, de N'dali et des Aguégus a permis de constater la persistance de la maladie dans toutes les localités parcourues. La nécessité s'impose donc de maintenir le cap dans la chimiothérapie qui cependant demeure une arme insuffisante en considérant les pratiques et les comportements observés auprès des populations en rapport avec l'hygiène de vie qui ne sont pas en concordance avec l'élimination de la maladie.

Mots clés : Schistosomiase ; Prévalence ; Facteurs Socio-démographiques et économiques ; Municipalités ; Enfants d'âge scolaire ;

[C014] Connaissances, attitudes et pratiques (CAP) des adultes sur les usages et rapports avec l'eau dans les communes de So-ava, Aguégus et N'dali au Bénin

AHAMIDE Olutobi Josias¹, SOSSA Charles², SISSINTO Yolande³, AYALE Achille⁴, OUENDO Edgard-Marius⁵

1.Département des Politiques et Systèmes de Santé, IRSP-OUIDAH

2.MCA Santé Publique-Nutrition, Département des Politiques et Systèmes de Santé, IRSP-OUIDAH, Université d'Abomey-Calavi

3.Laboratoire de Parasitologie (Faculté des Sciences de la Santé) / Université d'Abomey-Calavi)

4. Laboratoire d'Anthropologie Médicale Appliquée (LAMA) (Faculté des Arts et Sciences Humaines (FASH) / Université d'Abomey-Calavi

5.Professeur Titulaire de Santé Publique ; Epidémiologie-Biostatistique, Ancien Directeur de l'IRSP-OUIDAH ; Université d'Abomey-Calavi

Introduction : La schistosomiase est une maladie grave dont les risques de contamination sont très élevés en milieu rural, en particulier dans les zones riches de plaine et les rivières. La proportion du risque en Afrique de l'Ouest et dans le monde entier augmente encore lorsque l'on se trouve dans des zones déclarées endémiques]. L'objectif général de cette étude est d'identifier les connaissances, attitudes et pratiques des adultes des communes de Sô-Ava, Aguégus et N'dali sur la schistosomiase urinaire. Elle est déclinée en trois (3) objectifs spécifiques qui s'articulent autour de l'identification des attitudes et pratiques liées aux usages et rapports à l'eau dans les communes de Sô-Ava, Aguégus et N'dali ; étudier l'impact des problèmes socio-sanitaires liés aux usages et rapports à l'eau dans les communes de Sô-Ava, Aguégus et N'dali et enfin la collecte d'informations adéquates relatives aux pratiques endogènes favorisant la persistance et l'émergence de la schistosomiase dans les communes de Sô-Ava, Aguégus et N'dali.

Méthode : La présente étude CAP est une approche quantitative et qualitative ; à visée transversale, descriptive et analytique réalisée de Juillet à Août 2021 auprès de 415 cibles dans les communes de Sô-Ava, Aguégus et N'dali.

Résultats : L'enquête réalisée sur les connaissances attitudes et pratiques (CAP) des adultes sur les usages et rapports avec l'eau dans les localités des Aguégus, de Sô Ava et de N'dali a révélé que le chef de ménage exerce une influence et un pouvoir de décision au sein du ménage. Ainsi, les caractéristiques de celui-ci (chef de ménage) pourraient vraisemblablement rendre compte de l'image du ménage tout entier. Leur âge évoluait de 22 à 95 ans avec une moyenne de 36 ans. Dans la population enquêtée, près de 50% des répondants ont reçu une éducation moderne. D'autres par contre ont été initiés à l'alphabétisation en langue locale (18%). Le christianisme est la religion la plus pratiquée par 61,9 % des chefs ménages. Plus de la moitié des enquêtés sont mariés (73,6) ; dont 85,3% sont mariés monogames et près de 14,7% sont mariés polygames. La proportion de ménages dirigés par des veufs/veuves est de 1,9 %. La taille moyenne des ménages est estimée à 10 personnes. L'agriculture est l'activité la plus dominante au niveau des enquêtés, avec 43,37 % des enquêtés. La majeure partie des ménages enquêtés sont des autochtones avec 95,2 % (395), contrairement aux allochtones qui ne représentent que 4,8%. Les connaissances, attitudes et pratiques de la bilharziose recensée dans les communautés parcourues sont caractérisées par des critères spécifiques quantifiables.

Conclusion : L'étude de cette maladie fait appel aux concepts de nosologie (nom populaire attribué à la bilharziose), de sémiologie (les symptômes de cette maladie) et celui de l'étiologie (origine de la maladie). Il urge donc que les actions de lutte contre cette maladie soient renforcées avec de nouvelles stratégies en partant de l'implication des populations à la base et la mise en place d'un dispositif efficace de communication pour un changement de comportement afin d'éviter les lourds tributs payés par lesdites populations

Mots clés : Connaissances, Attitudes et Pratiques, Shistosomiase, Eau.

[C019] Schéma vaccinal à dose unique contre le HPV en Côte d'Ivoire : position du Comité National des Experts Indépendants pour la Vaccination et les vaccins

DOUBAA Alfred^{1,2}, AHOUSSOU Eric Martial Kouakou^{1,2}, AKANI Bangaman Christian^{1,2}, OUSSOU Konan Roland^{1,2}, ANO Ama Marie Noelle^{1,2}, DJOMAN Christiane^{1,2}, ABINA Audrey Marie-Michelle², KONAN Loukou Gilbert^{1,2}, SAMASSI-SOKODOGO Awa^{1,2}, AKA Lépri Bernadin Nicaise^{1,3}, EKRA Kouadio Daniel^{1,3}, ISSAKA Tiembre^{1,2}

1.Université Félix Houphouët-Boigny, Abidjan-Cocody, Côte d'Ivoire

2.Institut National d'Hygiène Publique, Côte d'Ivoire

3.Direction de Coordination du Programme Elargi de Vaccination

Introduction : En mars 2023, le Ministre en charge de la santé a adressé une saisine au CNEIV-CI afin d'obtenir son avis sur l'adoption d'un schéma vaccinal à dose unique du vaccin contre le HPV dans le PEV en Côte d'Ivoire. Le présent travail précise la démarche et la recommandation du CNEIV-CI sur le schéma vaccinal à dose unique contre le HPV.

Méthode : Un groupe de travail a été mis en place. Un cadre de la recommandation comprenant 4 composantes a été élaborée pour guider la recherche documentaire. Des mots-clés ont été identifiés et ont servi de base à la recherche documentaire. Les publications issues de cette recherche documentaire ont été évaluées en utilisant l'outil CASP.

Résultats : Dans un essai randomisé, d'une dose unique du vaccin bivalent ou nonavalent contre les HPV chez 2 275 kenyanes âgées de 15 à 20 ans, l'efficacité du vaccin bivalent de même que celle du nonavalent était de 97,5%. Dans un essai randomisé, chez 930 Tanzaniennes âgées de 9 à 14 ans, au 24e mois après la vaccination, 99% des participantes ayant reçu une dose des vaccins contre le HPV (bivalent ou nonavalent) étaient séropositifs pour les anticorps IgG contre le HPV 16, contre 100% des participantes ayant reçu deux doses et 100% des participantes ayant reçues trois doses. Au Costa Rica, dans une étude ayant inclus 1 365 femmes vaccinées et 1 783 non vaccinées âgées de 18 à 25 ans, l'efficacité vaccinale contre l'infection par le HPV 16 ou 18 était de 80,2%, 83,8% et 82,1% chez les femmes ayant reçu respectivement trois, deux et une dose du vaccin HPV.

Conclusion : L'efficacité d'une dose est semblable à celle de deux ou trois doses du vaccin HPV. Le CNEIV-CI a donc recommandé le schéma vaccinal à dose unique dans le PEV en Côte d'Ivoire.

Mots clés : vaccination, HPV, dose unique, Côte d'Ivoire

[C021] : Grandes collisions routières en Afrique et facteurs de risque : Qu'en est-il de la conduite sous influence chez les poids lourds au Bénin en 2023 ?

GLELE AHANHANZO Yolaine ¹, MOHAMMED Nouriat ¹, GAFFAN Nicolas ², DADDAH Donatien³, KPOZEHOUE Alphonse¹

¹Département d'Epidémiologie et de Biostatistiques, Institut Régional de Santé Publique, Ouidah, Bénin

²Direction Départementale de la Santé du Zou, Abomey, Bénin

³Direction Départementale de la Santé du Mono, Lokossa, Bénin

Introduction

Les conducteurs de Véhicules Poids Lourds (VPL) sont un groupe de professionnels connus pour être exposés à des conditions de travail et des comportements à risque dont la consommation de Substances Psychoactives (SPA). Au Bénin, comme ailleurs, ils représentent, un maillon incontournable de l'économie et de la chaîne logistique qui permet d'assurer le transport de marchandises dans et entre les pays. La présente étude visait à déterminer la prévalence du mésusage de SPA chez les conducteurs de VPL et les facteurs qui y sont associés.

Méthodes

C'est une étude transversale réalisée en Avril 2023 sur les parcs de stationnement de VPL dans la ville de Cotonou. La population d'étude était constituée des conducteurs VPL enregistrés. La variable dépendante était le mésusage de SPA. Les variables indépendantes étaient liées à leurs caractéristiques socio-démographiques et professionnelles. La prévalence du mésusage de SPA a été déterminée et les facteurs associés au mésusage de SPA ont été identifiés par régression logistique multiple.

Résultats

Au total, sur 425 conducteurs de VPL inclus, 53 conducteurs, soit 12,47% (IC_{95%} = 9,64-15,98) avaient une consommation modérée ou à risque (mésusage), tous SPA confondus. En comparaison aux conducteurs de 35 ans et plus, ceux âgés de moins de 25 ans (OR_a = 10,67 ; IC_{95%} = 3,55-32,03) et de 25 à 34 ans (OR_a = 3,47 ; IC_{95%} = 1,37-8,82) étaient plus à risque ; de même que ceux sans instruction formelle (OR_a = 2,32 ; IC_{95%} = 1,03-5,26). Un excès de risque de mésusage de SPA a également été observé chez les conducteurs qui ont déclaré faire des pauses (OR_a = 3,11 ; IC_{95%} = 1,57-6,18) et chez les porteurs de maladies cardio-vasculaires (OR_a=3,08 ; IC_{95%} = 1,08-8,81).

Conclusion

La prise en compte des facteurs identifiés dans des stratégies de prévention par approche intégrée permettra d'avoir des résultats plus probants.

Mots-clés : transport, alcool, substance-psychoactive, conducteur, professionnel, véhicule poids-lourd, Bénin

[C022] Facteurs sociodémographiques et économiques associés à la bilharziose urinaire dans les communes de Sô-ava, Aguégus et N'dali

SOSSA Charles¹, AHAMIDE Olutobi Josias², SOSSA Charles³, SISSINTO Yolande⁴, YETONGNON Edmond Y⁵, BOKO-COLLINS Pélagie⁶, SITONDJI Franck⁷, TCHEBE Romaric⁸, OUENDO Edgard-Marius⁹

1.IRSP

2.Département des Politiques et Systèmes de Santé, IRSP-OUIDAH

3.MCA Santé Publique-Nutrition, Département des Politiques et Systèmes de Santé, IRSP-OUIDAH, Université d'Abomey-Calavi

4.Laboratoire de Parasitologie (Faculté des Sciences de la Santé) / Université d'Abomey-Calavi

5.Laboratoire d'Analyse des Dynamiques Sociales et de Développement (LADYSD) / Faculté des Sciences Agronomiques (FSA) / Université d'Abomey-Calavi

6.Sightsavers Bénin-Togo

7.Family Heath International ; FHI

8.Programme National de lutte contre les Maladies Transmissibles (PNLMT-Ministère de la Santé

9.Professeur Titulaire de Santé Publique ; Epidémiologie-Biostatistique, Ancien Directeur de l'IRSP-OUIDAH ; Université d'Abomey-Calavi

Introduction : Cette étude caractérise les facteurs sociodémographiques en lien avec la bilharziose. Elle est réalisée de mai à juillet 2022 sur la bilharziose au Bénin dans les communes des Aguégus, (au Sud), Sô Ava (au Sud), et N'dali (au Nord) situées respectivement dans les départements de l'Ouémé, de l'Atlantique et du Borgou auprès d'une population constituée de 415 enfants d'âge scolaire de 8 à 14 ans (moyenne d'âge:11 ans) et provenant de 28 écoles réparties dans 19 villages ;

Méthode : Des données épidémiologiques (urines) ont été collectées et examinées aux bandelettes réactives pour évaluer la présence d'hématurie terminale ; la prévalence de l'infestation et de la densité parasitaire ont été quantifiées par l'utilisation de la technique de filtration. Les facteurs sociodémographiques et économiques ont été recensés grâce à un questionnaire pour évaluer la corrélation qui existe avec la maladie

Résultats : Des prévalences de 34,53% (N=48 sur 139) 13,53%, (N=18 sur 133) et 11, 88% (N=17 sur 143) respectivement pour les communes des Aguégus, N'dali et Sô Ava ont été calculées. L'étude a montré que les variables "âge", "sexe", "religion" ainsi que l'activité "socioprofessionnelle" ne sont pas significativement corrélées à la bilharziose ($p > 0,05$) et il en ressort que ces facteurs ne sont pas en lien avec la bilharziose au sein des ménages enquêtés. Cependant, les variables "agriculture" et "pêche" représentées par l'activité professionnelle présentent un risque plus élevé et sont statistiquement fortement significatives ($p < 0,005$) au même titre que la variable "lieu de résidence" au seuil de 1% ($p = 0,000$) pour un résultat d'estimation efficace.

Conclusion : Les facteurs sociodémographiques et économiques liés à la bilharziose ne facilitent pas l'élimination de la schistosomiase dans les zones d'étude. La réalisation d'une étude sur les connaissances attitudes et pratiques (CAP) auprès des ménages est nécessaire pour avoir des informations plus approfondies.

Mots clés : Schistosomiase ; Prévalence ; Facteurs Socio-démographiques et Economiques ; Municipalités ; Enfants d'âge scolaire

[C023] Connaissances, attitudes et pratiques (cap) des adultes sur les usages et rapports avec l'eau dans les communes de so-ava, aguegues et n'dali au benin

AHAMIDE Olutobi Josias¹, SOSSA Charles², SISSINTO Yolande³, AYALE Achille⁴, OUENDO Edgard-Marius⁵

1.Département des Politiques et Systèmes de Santé, IRSP-OUIDAH

2.MCA Santé Publique-Nutrition, Département des Politiques et Systèmes de Santé, IRSP-OUIDAH, Université d'Abomey-Calavi

3.Laboratoire de Parasitologie (Faculté des Sciences de la Santé) / Université d'Abomey-Calavi

4.Laboratoire d'Anthropologie Médicale Appliquée (LAMA) (Faculté des Arts et Sciences Humaines (FASH) / Université d'Abomey-Calavi

5.Professeur Titulaire de Santé Publique ; Epidémiologie-Biostatistique, Ancien Directeur de l'IRSP-OUIDAH ; Université d'Abomey-Calavi

Introduction : La bilharziose est une maladie tropicale négligée répandue dans les zones endémiques et qui cause de nombreux problèmes de santé liés à l'assainissement de l'eau. Objectif : Cette étude a pour objectif de déterminer les connaissances, attitudes et pratiques des adultes sur les usages et rapports avec l'eau qui bien ayant un caractère vital pour l'homme est parfois génératrice des maladies hydriques dont la bilharziose dans les zones endémiques.

Méthode : Il s'agit d'une étude transversale, descriptive et analytique des connaissances, attitudes et pratiques (CAP) réalisée auprès 415 ménages sur les usages et rapports avec l'eau. L'échantillonnage calculé a permis d'enquêter 415 ménages ciblés. Les données qualitatives recueillies sont transcrites et analysées. L'analyse des données quantitatives est réalisée grâce au test t de Student et de Barlett à l'aide du logiciel STATA version 2015.

Résultats : L'étude a montré que 92,54% des enquêtés connaissent les symptômes de la maladie, 62,40% l'associent à la consommation de l'eau insalubre, 86,75% déclarent comme symptôme principal l'apparition du sang dans les urines, 73,01 % des ménages utilisent l'eau du marigot à des fins domestiques, 84,34 % des enquêtés sont disposés à participer à une communication pour un changement de comportement

Conclusion : Les communes des Aguégus, Sô Ava et N'dali demeurent des zones à potentialités endémiques à l'infestation bilharzienne. Les attitudes et pratiques telles que les baignades, les mictions dans les eaux douces, les activités de la pêche et de l'agriculture sans aucune précaution sanitaire d'hygiène observées et recensées sont défavorables à l'élimination de la schistosomiase.

Mots clés: Connaissances, Attitudes et Pratiques, Schistosomiase, Eau.

[C025] Evaluation de la charge de travail du personnel infirmier du Service d'Accueil des Urgences (SAU) du Centre Hospitalier Régional de Ziguinchor (CHRZ)

BOP Martial Coly¹, GUEYE Boubacar¹, FAYE Abdoulaye¹, KA Ousseynou¹

1. Unité de Formation et de Recherche en Santé et Développement Durable, Université Alioune DIOP, Bambey

Introduction : Avec le fonctionnement (h24, 7j/7), l'absence d'exigence de paiement préalable et de pièce d'identité, et le manque de moyens dans le secteur de la santé, les constats sont une fréquentation sans cesse croissante des patients et des dysfonctionnements dans l'organisation des SAU. L'objectif de ce travail est d'évaluer la charge de travail des infirmiers du SAU.

Méthode : L'étude est transversale mixte et descriptive. Elle s'est déroulée sur deux mois et quinze jours. L'analyse de la charge de travail est basée sur le prescrit, le réel et le subjectif. Les Infirmiers Diplômés d'Etat, Assistants Infirmiers d'Etat et Aides infirmiers représentent la population d'étude. L'échantillon comprend dix-sept agents dont cinq Infirmiers Diplômés d'Etat, six Assistants infirmiers, deux aides-soignants, trois filles de salle et un agent breveté. Les données sont collectées à travers la revue documentaire, l'observation participante active et l'entretien semi-directif.

Résultats : 65% des agents sont stagiaires et 25% contractuels (hôpital et collectivités territoriales). Tous les infirmiers et auxiliaires travaillent à temps plein avec un système de garde de 8 h à 14 h ou de 14 h à 20 h pour le jour et de 20 h à 8 h pour la nuit. Les infirmiers ne disposent pas de protocoles affichés pour la réalisation des soins. Pour la plupart des agents interrogés, la charge de travail est lourde. Elle est plus importante les samedis, lundis et vendredis, et durant les gardes de 20 heures à 8 heures. La gestion de l'accueil, la surveillance et l'administration des soins sont les postes où la charge de travail est élevée. La gestion de l'accueil occupe respectivement 52,77% et 26,38% du temps réglementaire (6 h pour la permanence et 12 h pour la garde). La surveillance et l'administration des soins occupent respectivement 41,11% et 20,55% du temps réglementaire. Les infirmiers ne travaillent que 44% du temps réglementaire. Le personnel infirmier n'a pas une charge de travail élevée si l'on se réfère à la réglementation.

Conclusion : Le SAU n'a pas besoin d'augmentation du personnel. Cependant, il y a nécessité d'une réorganisation du travail et d'un programme de formation en techniques de prise en charge des urgences.

Mots clés : Urgence, charge de travail, personnel infirmier, Centre Hospitalier Régional de Ziguinchor et Sénégal

[C026] Déterminants de l'utilisation des mutuelles de santé dans la région de Diourbel

BOP Martial Coly^{1,2}, KA Ousseynou¹, GUEYE Boubacar¹, SOW Papa Gallo¹, DIOP Cheikh Tacko¹

1. Unité de Formation et de Recherche en Santé et développement Durable, Université Alioune DIOP, Bambey

2. Ecole Doctorale Développement Durable et Société (ED-2DS), Université Iba Der Thiam de Thiès (UIDT)

Introduction : Les difficultés rencontrées dans la mise en œuvre des politiques d'accès aux soins ont conduit à l'émergence des mutuelles de santé. Cependant, l'accès aux soins demeure une préoccupation. L'objectif est d'analyser les déterminants liés l'adhésion aux mutuelles de santé dans la région de Diourbel

Méthode : Il s'agit d'une étude transversale, mixte, descriptive et analytique. La collecte des données s'est déroulée du 12 mai au 4 juin 2023 dans la région de Diourbel à partir d'un échantillonnage (n=1161) stratifié à deux degrés pour les patients des structures sanitaires, un recrutement exhaustif pour les chefs de services et responsables de mutuelles, un sondage raisonné pour les OCB, les GPF, les associations de jeunesse... et un échantillonnage « boule de neige » pour les acteurs du niveau central. L'analyse des données a été faite par une technique bivariée et une régression logistique.

Résultats : Le niveau d'adhésion aux mutuelles est de 18% dans la région. Avec l'analyse bivariée, l'adhésion est associée au sexe, au niveau d'étude, au statut socio-professionnel, à l'appartenance à une association, à la connaissance des mutuelles, à la perception des compétences des prestataires et à la perception du délai d'attente. Tandis que la régression a montré que l'adhésion est associée au niveau d'étude, au statut socioprofessionnel, à l'appartenance à une association, au revenu et au délai d'attente.

Conclusion : Pour contribuer à l'amélioration de l'adhésion aux mutuelles de santé, il est important de prendre en compte les facteurs associés à l'adhésion.

Mots clés : mutuelle de santé, déterminants liés à l'adhésion, accès aux soins, région de Diourbel.

[C028] Evaluation de la pratique de transfusion sanguine au Centre Hospitalier Universitaire Pédiatrique Charles De Gaulle, Ouagadougou, Burkina Faso.

Daniel DORI^{1,2,3}, Idrissa ILBOUDO¹, Amédée KOMBOIGO¹, Nicolas MEDA³, Rasmané SEMDÉ²

1.Centre Hospitalier Universitaire Pédiatrique Charles De Gaulle

2.Centre d'excellence Africain de Formation, de recherche et d'Expertises en sciences du médicament de l'Université Joseph KI-ZERBO

3.Laboratoire de santé publique de l'Université Joseph KI-ZERBO

Introduction : La transfusion sanguine est l'un des soins courants pourvoyeurs d'incidents et d'accidents graves voire mortels surtout en milieu pédiatrique. Cette étude a pour objectif d'évaluer la pratique de ce soin en vue d'améliorer la qualité de la prise en charge des patients.

Méthode : Il s'est agi d'une étude transversale descriptive qui a concerné le personnel infirmier et les médecins. Elle a été réalisée à travers une la technique de l'observation directe non participante des prestataires de sept unités de soins pendant le processus de réalisation de la transfusion sanguine suivant des critères élaborés sur la base du guide de bon usage des produits sanguins labiles édité par le Centre National de Transfusion Sanguine du Burkina Faso.

Résultats : Au total 58 agents de 7 unités de soin ont participé à l'étude dont 48 infirmiers diplômés d'Etat, 7 infirmiers brevetés, 2 attachés de santé et 1 médecin. Les résultats montrent globalement un niveau de conformité de 62% comparé à un seuil acceptable fixée à 80%. Les plus faibles niveaux de conformité (<50%) étaient le matériel et les conditions d'hygiène (18%), suivi de la surveillance du patient transfusé (32%). La gestion des poches vides (54,19%), les contrôles ultimes pré-transfusionnels au lit du patient (64,34%) et la transfusion sanguine proprement dite (67,53%) ont obtenu des scores moyens (entre 50 et 80%). Les meilleures pratiques ont été enregistrées au niveau de l'identification du patient/prescription de la transfusion (80%), de la préparation des produits sanguins labiles (83,73%) et de la gestion des complications (99%). Les résultats par unité indiquent l'existence d'une pratique similaire de l'acte transfusionnel avec un score moyen de conformité de 50%.

Conclusion : La culture de bonnes pratiques de transfusion sanguine était peu développée. Le plan d'amélioration proposé permettrait de mieux assurer la sécurité des prestations de transfusion sanguine au CHUP-CDG.

Mots clés : Transfusion sanguine, évaluation, pratique, produits sanguins labiles, soins

[C030] Dénutrition du sujet âgé au service de gériatrie et gérontologie du CHNU Fann : aspects épidémiologiques, diagnostiques, thérapeutiques et évolutifs à propos de 100 cas

DIOP Cheikh Tacko¹, Mareime Sougou¹

1.UFR Santé Communautaire Université Alioune DIOP de Bambey

Introduction : Le Sénégal à l'instar des autres pays africains vit une transition démographique et épidémiologique avec une augmentation rapide de sa population âgée. Ce vieillissement s'accompagne de modifications physiologiques qui peuvent altérer l'état nutritionnel du sujet âgé et être à l'origine d'une dénutrition qui constitue un véritable problème de santé publique. Sa survenue est associée à des conséquences désastreuses en termes de morbi-mortalité

Méthode : Une étude transversale descriptive et analytique a été réalisée entre SEPTEMBRE 2022 et AVRIL 2023. Les patients ayant séjourné au service de gériatrie et gérontologie du CHNU Fann et qui présentaient une dénutrition sur la base d'un score MNA inférieur à 17 ont été inclus.

Résultats : Un total de 100 patients sur de 192 a été colligé, l'âge moyen était de 77,98 $\pm$ 8,52ans. Le sex-ratio H/F était de 0,82. Plus de la moitié des patients étaient mariés (63%) et le 1/3 de la cohorte (33%) provenait du SAU. Les comorbidités les plus fréquemment retrouvées étaient les pathologies cardiovasculaires avec en tête l'hypertension artérielle. Plus des 2/3 des patients, 70% étaient poly pathologiques et 77% étaient polymédiqués. Les diagnostics d'admission les plus fréquemment retrouvés étaient les AVC (29%) suivi des pneumopathies infectieuses (13%). Au terme de l'évaluation gériatrique, tous les patients présentaient au moins 2 syndromes gériatriques. La perte d'autonomie aiguë et la fragilité étaient les plus fréquentes.

Conclusion : Tous les patients avaient systématiquement bénéficié d'un enrichissement alimentaire et plus de la moitié des patients (59%) avaient bénéficié d'une prise en charge nutritionnelle par les CNO. La durée moyenne d'hospitalisation était de 10,5 $\pm$ 6 jours. L'évolution vers le décès était observée dans 22% des cas.

Mots clés : Dénutrition, personne âgée, gériatrie, Sénégal

[C031] Evaluation de la viabilité des mutuelles de santé communautaires de Ziguinchor de 2016 à 2018 dans le contexte de couverture sanitaire universelle au Sénégal

DIOP Cheikh Tacko¹

1.UFR Santé Communautaire Université Alioune DIOP de Bambey

Introduction : L'atteinte des objectifs de couverture sanitaire universelle demeure l'un des objectifs prioritaires du Sénégal en vue de la réduction des inégalités. L'extension du système assurantiel communautaire était retenu comme levier fondamental. C'est dans cette lancée que les mutuelles de Ziguinchor ont été mis en place entre 2012 et 2015. Notre objectif était d'étudier leur viabilité.

Méthode : Un devis mixte a été adopté : un volet quantitatif comparé aux standards du guide de suivi et d'évaluation des systèmes de micro-assurance santé (STEP/CIDR, 2001) et volet qualitatif basé sur les critères de saturation.

Résultats : Les résultats ont montré que le fonctionnement de toutes les mutuelles était régi par un statut encadré par un règlement intérieur, donc viables sur le plan institutionnel. Sur le plan technique le mode d'adhésion permettait de maîtriser les risques de sélection adverse et les mécanismes de gestion des garanties limitait la sur prescription et la surconsommation. Concernant la viabilité fonctionnelle, le taux croissance brute et celui de pénétration étaient positifs respectivement à 20,18% et à 16,99% témoignant d'une bonne dynamique d'affiliation aux mutuelles. Sur le plan financier, les mutuelles n'avaient pas la capacité d'honorer leurs dettes sans recourir à l'emprunt avec un ratio de liquidité immédiate à 0,1, un ratio de sinistralité à 282,7% et un ratio des frais de fonctionnement à 45,1% reflétant leur dépendance à la subvention de l'Etat.

Conclusion : L'amélioration de la participation des mutuelles dans le financement était assujettie à la sensibilisation des populations pour une massification desdites mutuelles garantissant la pérennisation du financement, l'allègement des procédures d'adhésion et de demande des soins et l'amélioration du paquet de soins.

Mots clés : Assurance maladie, Mutuelles de santé, Viabilité, Evaluation

[C032] Perception de l'obligation vaccinale par le personnel de sante en côte d'ivoire

ATTOH-TOURE Harvey¹, ABINA Audrey Marie-Michelle¹, N'GUESSAN Konan²

1.Département de Santé publique et Spécialités

2.Institut National d'Hygiène Publique

Introduction : L'obligation vaccinale du personnel de santé a pour but de réduire les risques d'être contaminés et aussi d'être des sources de contamination notamment pour les malades. Toutefois, la pandémie à Covid-19 a mis en évidence le refus vaccinal du personnel de santé. L'objectif de cette étude était d'étudier la perception du personnel de santé vis-à-vis de l'obligation vaccinale.

Méthode : il s'agissait d'une étude transversale, à visée analytique réalisée à l'Institut National d'Hygiène Publique et à l'Hôpital Général de Port-Bouët. Elle a porté sur tout le personnel des services de soins curatifs et préventifs et s'est déroulée de Janvier à Mars 2023.

Résultats : Au total, 390 personnes ont été interrogées. La population d'étude était à prédominance féminine (52,30%) avec un âge moyen de 38 ans. Le personnel paramédical était majoritaire (73,85%). La nécessité de vacciner le personnel de santé était connue par 64,61% et la prévention était citée comme motif dans 95,64% des cas. La fièvre jaune (58,20%) et la Covid-19 (52,82%) étaient les vaccins pour lesquels la plupart des enquêtés étaient à jour. Plus des 2/3 d'entre eux était consentants (88,72%) à la vaccination obligatoire. La peur des effets indésirables était le motif de refus le plus fréquemment retrouvé (86,41%). Les vaccins les moins acceptés pour l'obligation vaccinale étaient le vaccin contre la grippe et celui contre la fièvre typhoïde. L'acceptation de l'obligation vaccinale était associée au fait de disposer d'un carnet de vaccination, et à la catégorie socioprofessionnelle, notamment le fait d'être médecin.

Conclusion : Des freins à la vaccination du personnel de santé demeurent. Une communication adaptée et orientée vers le personnel paramédical est nécessaire à leur levée. Face à l'émergence de maladies à potentiel épidémique, telles que la Covid-19 et Ebola, il est important de mettre en place une loi ou une réglementation, permettant de régir cette vaccination.

Mots clés : Vaccination obligatoire – Maladies transmissibles- Professionnel de santé

[C033] Méthodes contraceptives chez les jeunes filles élèves et grossesses en milieu scolaire dans un établissement secondaire à Abidjan

N'GUESSAN Konan¹, ATTOH-TOURE Harvey¹, KONAN Sidoine², AKANI Bangaman Christian¹, EKRA Kouadio Daniel³

1. Institut National d'Hygiène publique, Abidjan, Côte d'Ivoire

2. Centre National de Transfusion Sanguine, Abidjan, Côte d'Ivoire

3. Direction de Coordination du Programme Elargi de Vaccination, Abidjan, Côte d'Ivoire

Introduction : La grossesse est un état physiologique qui requiert l'attention de tous. Cependant, elle devient problématique quand elle survient chez les jeunes élèves. Nous avons initié cette étude dont l'objectif général était d'identifier les méthodes contraceptives et de déterminer leur impact sur la survenue des grossesses chez les jeunes filles en milieu scolaire. Le but est de réduire au mieux les grossesses en milieu scolaire.

Méthode : Une étude transversale descriptive a été réalisée. Une étude nous avons interviewé 200 (deux cent) jeunes filles du Lycée Moderne de Cocody Angré dont l'âge était compris entre 10 et 17 ans. Notre étude s'est déroulée du 1er au 15 Décembre 2020. Les critères d'inclusion et de non inclusion ont permis de retenir 200 jeunes filles.

Résultats : Soixante-quatre pour cent (64%) de filles n'a eu aucun rapport sexuel. La contraception a été très peu utilisée car 92% des filles ne l'utilisaient pas. Les méthodes plus citées étaient : les pilules, les préservatifs, les pilules du lendemain avec respectivement 41%, 57% et 25%. Les jeunes filles n'avaient pas accepté les contraceptions à 67% et 75% d'entre elles n'ont pas reçu de formation en la matière. La majorité des jeunes filles (73%) a abandonné sa scolarité pour cause de grossesses. Des filles (80%) ont répondu qu'il n'était pas possible de partir à l'école et de s'occuper d'un bébé.

Conclusion : Les grossesses des jeunes filles élèves participent à l'échec scolaire de celles-ci. Ces grossesses des jeunes filles élèves en pleine année scolaire favorisent le décrochage scolaire de celles-ci et constituent une hantise pour les parents. La lutte doit être intensifiée afin de venir à bout de ce fléau.

Mots clés : contraception, grossesses, précoces, milieu scolaire.

[C034] Etudier la perception et l'intérêt du dossier médical physique par le personnel de santé de trois centres hospitaliers et Universitaires de Côte d'Ivoire.

N'Guessan Konan¹, Attoh Touré Harvey¹, ANO Ama Marie Noëlle¹, Kroman Savane Sita¹, Ekra Kouadio Daniel²

1.Institut National d'Hygiène Publique

2.Direction de la coordination du Programme Elargi de Vaccination

Introduction : Le dossier médical est la mémoire du passage et du contact du client avec l'hôpital. Aujourd'hui il est de plus en plus question de sa transformation en dossier médical électronique. Nous avons initié cette étude dont l'objectif est d'étudier la perception et l'intérêt du dossier médical physique par le personnel de santé de trois C.H.U de Côte d'Ivoire.

Méthode : Nous avons effectué une étude transversale à visée descriptive portant sur le dossier médical physique. Cette étude s'est déroulée durant quatre mois. Un échantillon de 312 agents de santé à enquêter a été constitué à raison de 102 agents par Centre Hospitalier et Universitaire. Les logiciels Epi info 2002 et le test du khi2 pour l'analyse statistique avec un seuil de signification $p < 0,05$ ont été utilisés.

Résultats : Notre échantillon était composé de sujet avec un âge compris entre 25 et 35 ans. Les enquêtés étaient majoritairement de sexe masculin avec un sex-ratio (H/F) de 1,23. Les sujets dont l'âge est compris entre 25 et 35 ans étaient prédominants. L'emploi d'infirmier est prédominant avec 39,7%. Les enquêtés d'au moins 10 ans d'ancienneté sont prédominants à 68,7%. Le cahier de malade est le support le plus renseigné avec 48,9%. L'information médicale n'est pas sécurisée dans 22% des cas. La tranche d'âge et le sexe influence statistiquement la continuité du dossier médical physique.

Conclusion : La population masculine est prédominante avec une sex-ratio de 1,23. Le cahier de malade est le support le plus renseigné avec 48,9%. L'information médicale est sécurisée dans 22% des cas. Une part non négligeable du dossier médical est de mauvaise qualité. Les jeunes et les hommes préfèrent changer de dossiers médicaux. Le cahier de malade est le support médical le plus important d'une structure sanitaire. Cependant il pose aujourd'hui le problème de conservation malgré son importance.

Mots clés : dossier médical, perception, intérêt, hôpital

[C035] Vers une Meilleure Prise en Charge de la Prééclampsie et de l'Éclampsie au Burkina Faso : Analyse des Capacités de Dépistage et de Gestion dans le District de Garango

ZAPRE Drissa¹, KABORE Souleymane²

1.District Sanitaire de Garango

2.Médecin de Santé Publique à Engenderhealth

Introduction : Les complications de la prééclampsie et de l'éclampsie figurent parmi les principales causes de décès maternels au Burkina Faso. Cette étude a été réalisée pour évaluer les capacités de dépistage et de prise en charge de ces pathologies dans le district sanitaire de Garango.

Méthode : Une étude transversale descriptive a été menée. La population d'étude incluait les prestataires de services de maternité, les parturientes atteintes de prééclampsie ou d'éclampsie, et les patientes interrogées concernant leurs connaissances et opinions sur ces affections.

Résultats : L'étude a révélé une disponibilité limitée des ressources essentielles pour le diagnostic et la gestion de la prééclampsie et de l'éclampsie. Seules 45,16 % des formations sanitaires disposaient d'un personnel formé ou recyclé pour gérer ces pathologies, et respectivement seulement 16,22 % et 18,92 % des CSPS étaient équipés du sulfate de magnésium et de la clonidine, indispensables pour le traitement. En outre, 36,67 % des prestataires connaissaient bien la définition et les signes graves de la prééclampsie, tandis que 61,49 % des patientes en avaient entendu parler, bien que leur compréhension générale de la maladie fût limitée.

Conclusion : Les défis identifiés à travers cette étude constituent des obstacles au dépistage et à la prise en charge efficaces de la prééclampsie et de l'éclampsie. Il est impératif de développer des actions coordonnées pour adresser ces lacunes, impliquant tous les acteurs du système de santé

Mots clés : Eclampsie/Prééclampsie, Dépistage, Burkina Faso

[C036] Les immunoglobulines G anti-SRAS-CoV-2 chez le personnel de sante vaccine contre la covid-19 à Abidjan

SERI yida Jocelyne¹, DASSE Sery Romuald¹, ADOU Adjoumanvoulé Honoré¹, YEBOAH Opong Richard¹, SIRANSY Kouabla Liliane¹, KABORE Saydou², MEMEL Roselle Charline³, KOYA Herbert³, ASSI Aniela Ursule¹, KOFFI Adjo Melissa¹, N'GUESSAN Koffi¹, SEKONGO Yassongui²

1.Laboratoire d'immunologie, UFR sciences médicales, UFHB

2.Laboratoire CNTS

3.Laboratoire CHU Bouaké, UFR sciences médicales, UAO

Introduction : Le personnel de santé, lors de la pandémie à coronavirus, a été lourdement impacté. Les résultats des essais cliniques des vaccins développés dans l'urgence avaient démontré qu'ils provoquaient tous la production d'anticorps IgG et IgM dirigés contre le SRAS-CoV-2 avec des proportions élevées de séroconversion. Cependant, l'ampleur des réponses post vaccinales en IgG anti SRAS-CoV-2 chez le personnel de santé n'est pas suffisamment élucidée dans notre contexte africain. Objectif : contribuer à expliquer la réponse vaccinale anti SRAS-CoV-2 chez le sujet africain.

Méthode : Une étude transversale, à visée analytique a été menée de mars à Mai 2022, chez le personnel de santé embauché dans les CHU d'Abidjan et vacciné contre la COVID-19. Des dosages de IgG et IgM ont été réalisés avec des tests sérologiques de fluorescence enzymatique (ELFA). Les données ont été analysées par le logiciel SPSS version 22.0 considérant une valeur $p < 0,05$ comme une différence significative.

Résultats : 154 personnels de santé ont été inclus. Tous ont développés des IgG anti-SRAS-Cov-2 dont 88,3% étaient des réponses fortes (titre ≥ 250 BAU/mL). Les titres des IgG variaient de manière significative en fonction du sexe. Il existait 5 fois plus de chance de développer une réponse post-vaccinale forte en IgG avec un antécédent d'infection à coronavirus.

Conclusion : Les réponses humores post-vaccinales en IgG développées contre le SRAS-CoV-2 étaient robustes et seraient influencées par diverses facteurs.

Mots clés : IgG - IgM – SRAS-CoV-2 – personnel de santé – vaccination

[C037] Influence de la gratuité ciblée des soins sur les indicateurs de la santé maternelle et infantile dans le district sanitaire de Bozoum-Bossemptélé (RCA) 2021-2022

WOROMOGO Sylvain Honoré¹, DOTAR BELLET Bertrand¹, TEBEU Pierre Marie¹

1.CIESPAC

Introduction : La gratuité ciblée de soins est une stratégie définie comme l'exemption ou la suppression du paiement direct des soins pour les femmes enceintes et allaitantes, enfants de moins de 5 ans et les victimes des violences basées sur le genre. L'objectif était d'analyser les effets de la gratuité ciblée des soins sur les indicateurs de la santé maternelle et infantile dans un district sous Financement Basé sur la Performance (FBP) en République Centrafricaine.

Méthode : Il s'agissait d'une étude analytique transversale de type quasi-expérimental "avant et après" la mise sur pied de la gratuité ciblée. La population d'étude était constituée de 26 formations sanitaires (FOSA) et 73 agents de santé mettant en œuvre cette approche. Une analyse documentaire et des entretiens avec le personnel de santé ont été utilisés. La comparaison des indicateurs avant et après a été faite à l'aide des rapports de cote avec leur IC à 95 %.

Résultats : L'effectif des FOSA mettant en œuvre le paquet minimum d'activités a augmenté de 6 à 18. Aucun agent ne disposait de l'arrêté d'application de la gratuité ciblée des soins et 13/73 disposaient du Décret présidentiel instituant la gratuité ciblée des soins. La couverture en CPN4+ était passée de 17,49 % avant à 39,41% après, OR 3,07 (2,86-3,28). La couverture en accouchement assisté de 82,17% avant était passée à 83,66% après OR 1,10 (1,02-1,20). La consultation des moins de 5 ans était de 43,06% avant a atteint 56,94% OR 2,93 (2,87-2,99). Tous ces résultats étaient significatifs avec $p < 0,001$.

Conclusion : Cette gratuité ciblée, malgré les difficultés, a permis une amélioration de certains indicateurs de soins de la santé maternelle et infantile. Des ajustements sont nécessaires pour son effectivité véritable afin d'atteindre les objectifs fixés par la RCA pour la Couverture Sanitaire Universelle

Mots clés : gratuité ciblée, soins, FBP, RCA

[C040] Facteurs associés à la mortinaissance dans la zone sanitaire Savè-Ouèssè (ZS_SAO), Bénin, 2018 à 2020

Damien Barikissou Georgia¹, Toudonou Serge², Aguemon Badirou²

1. Centre de Formation et de Recherche en matière de Population, Unité recherche Population-santé, Université d'Abomey- Calavi

2. Unité de santé publique, Faculté des Sciences de la Santé, Université d'Abomey-Calavi, Cotonou, Bénin

Introduction : La mortinaissance est une préoccupation majeure de santé publique au Bénin. La connaissance des causes des décès et les facteurs associés est essentielle pour réduire ce fléau. La présente étude avait pour objectif d'identifier les causes ainsi que les facteurs associés à la mortinaissance dans la zone sanitaire Savè-Ouèssè (ZS_SaO) de 2018 à 2020.

Méthode : Il s'agissait d'une étude cas-témoins qui avait porté sur une période de 36 mois allant du 1er janvier 2018 au 31 décembre 2020 dans les maternités de la zone sanitaire ZS_SaO au Bénin. Une analyse univariée et multivariée a permis de mettre en évidence les facteurs de risque de la mortinaissance.

Résultats : Au total, 132 cas et 264 témoins ont été. La mortalité périnatale était estimée à 12,30‰ et la mortinaissance représentait une proportion de 42,86% de la mortalité périnatale. Les causes étaient le faible poids de naissance (23,48%) et les malformations congénitales (12,12%). Les facteurs de risque de la mortinaissance étaient chez la mère l'absence d'instruction ($p=0,016$), les antécédents de fausses couches ($p=0,0110$), la multiparité ($p<0,0001$), l'automédication à la tisane ($p=0,0030$), la faible utilisation des consultations prénatales ($p<0,0001$), les prééclampsies/éclampsies ($p=0,0270$) et l'hyperthermie ($p=0,0100$).

Conclusion : La survenue de la mortinaissance était liée essentiellement aux facteurs maternels. L'amélioration continue du niveau d'instruction des femmes, du suivi prénatal et la prise en charge précoce et efficiente de tout événement morbide survenu au cours de la grossesse sont essentielles pour la prévention de la mortinaissance.

Mots clés : mortinaissance, faible poids de naissance, malformation congénitale, multiparité, consultations prénatales, Bénin

[C041] Pratique de la référence et de la contre-référence des patients : circuit en zone frontalière au sud-ouest Bénin en 2020

Damien Barikissou Georgia¹, Mongbo Virginie², Glèlè-Ahanhanzo Yolaine², Aguemon Badirou³

1. Centre de Formation et de Recherche en matière de Population, Université d'Abomey- Calavi

2. Institut Régional de Santé Publique, Ouidah, Bénin

3. Unité de santé publique, Faculté des Sciences de la Santé, Université d'Abomey-Calavi, Cotonou, Bénin

Introduction : La référence consiste à envoyer un patient d'un niveau inférieur au supérieur. La contre référence envoie le patient du niveau supérieur à l'inférieur. L'objectif de cette étude était d'étudier dans la pratique quelques aspects du circuit de la référence et de la contre-référence dans la zone frontalière du sud-est du Bénin.

Méthode : Il s'agissait d'une étude transversale descriptive évaluative conduite dans les communes de Sèmè-Podji et d'Adjarra de juillet à octobre 2020. L'unité statistique était constituée des formations de santé (FS) de niveau périphérique autorisés. Un échantillonnage non probabiliste a été réalisé par recensement exhaustif de toutes les FS avec la méthode de boule de neige. Un questionnaire a permis de collecter les données relatives à la localisation géographique des FS, aux responsables des formations sanitaires, à l'itinéraire de référencement des malades. Le logiciel ArcGIS version 10.1 a permis de réaliser les cartes.

Résultats : Au niveau des FS publiques, deux centres de santé de communal (soit 1 par commune) et 14 centres de santé d'arrondissement ont été recensés. Il n'existe pas d'hôpitaux de zone/district et aussi des équipements y afférent. Plus on se rapproche de la frontière, une diminution du nombre de FS, surtout privées était observée. La référence vers le CHD-O était de 78,33%. Peu de FS réfèrent vers les FS communales (6,67%). Toutes les FS d'arrondissement réfèrent directement vers le CHD-O et le CNHU-HKM au lieu du CS communal. 71,67% des FS référaient avec une fiche et seulement 16,67% recevaient des fiches de contre-référence.

Conclusion : Un dysfonctionnement du circuit du système de référence et de contre-référence a été observé en zone frontalière. La construction des infrastructures dans les zones frontalières ainsi que la réorganisation du système de référence et de contre-référence sont nécessaires pour l'amélioration de la qualité des soins.

Mots clés : formations sanitaires, référence, contre-référence, circuit, dysfonctionnement

[C042] SARS-CoV-2 Seroprevalence in Healthcare Workers from the Three Teaching Hospitals in Abidjan (Côte D’Ivoire) during Pandemic Waves of 2022

AUTEURS: Dasse Sery Romualde¹, Kouassi-Mbengue Aya Alphonsine, Siransy Kouabla Liliane¹, Attoh-Toure Harvey, Kouassi Yao Mathias, Adou Adjoumanvoule Honoré¹, Yeboah Oppong Richard¹, Assi Aya Ursule Aniela¹, Kouacou Amah Patricia-Victorine¹, Seri Yida Jocelyne², Moussa Salimata¹, Oura Doris¹, Kakou-Ndouba Adèle

1. Laboratoire d'immunologie, UFR sciences médicales, UFHB

2. Laboratoire d'immunologie et hématologie, CHU de Cocody

Introduction: In view of the concern about the nosocomial character of SARS-CoV-2 known for its high variability and its strong ability to spread, this study was conducted to assess the immunogenicity status through the seroprevalence of COVID -19 among healthcare workers in the three University hospitals of Abidjan (Cocody, Angré, Treichville).

Methods: On a sample of 275 healthcare workers randomly chosen from the different professional strata taking into account the levels of risk intensity of contamination according to services and workstations, we measured total antibodies IgG / IgM and antibodies (neutralizing) anti RBD IgG of SARS-CoV-2 using the following kits respectively: Diagnostics Evolution CHORUS Diesse® Ref 81401 SARS-CoV-2 IgM and 81400 SARS-CoV-2 IgG and Diagnostics Evolution CHORUS Diesse® Ref 81408 SARS- CoV-2 Neutralizing Ab by a technique based on double enzyme fluorescence labeling (ELFA – Enzyme Linked Fluorescence Assay) which combines a two-step sandwich enzyme immunoassay method with fluorescence detection.

Result: The predominantly female study population was characterized by young age with rates of vaccination coverage and history of COVID-19 infection, which amount to 65,96% and 50,4% respectively. Among these health agents of which 44.1% and 46.16% worked in a context of intermediate level of risk contamination, considering respectively the department and the workstation, a very strong immunization was noted with a high seroprevalence at 93.5% of the population having produced total antibodies of IgG isotype but no IgM while 6.5% produced both IgG and IgM anti-SARS-CoV-2. Regarding anti-RBD neutralizing antibodies, 99.6% of agents are carriers.

Conclusion: This strong immunization is the response both to the vaccine, whose coverage is quite broad, and to the history of contact with the virus circulating in the population. This degree of protection obtained among healthcare workers, can be considered as collective immunity, and should be reassuring.

Keywords: Anti-RBD neutralizing antibodies ; seroprevalence of COVID-19; healthcare workers; Ivory Coast

[C044] Facteurs influençant la motivation des ressources humaines en santé d'un centre hospitalier universitaire en Côte d'Ivoire, 2019

Samassi Sokodogo Awa Madaho¹, Acray-Zengbe Pétronille², Botchi Anatole², Akani Bangaman Christian², Ane Banouankon³, Konan Loukou Gilbert¹

1. Institut National d'Hygiène Publique
2. Université Félix Houphouët Boigny
3. Organisation mondiale de la santé

Introduction : La motivation des agents au travail est un facteur déterminant pour atteindre l'objectif de performance pour toutes organisations. Mais cette motivation reste un besoin pour les travailleurs et une préoccupation pour les dirigeants. Identifier les facteurs de motivation des ressources humaines permet d'apporter une réponse à cette préoccupation.

Méthode : Nous avons adopté une méthodologie quantitative sur un échantillon de 215 agents de santé au CHU de Cocody. La collecte des données a été réalisée à l'aide d'un questionnaire préétabli. Nous avons utilisé le test de chi-Deux avec un seuil de significativité de 5% et le test de régression pour mesurer la relation entre les facteurs retenus sur la motivation des ressources humaines. Pour le test de régression, la significativité des coefficients de régression des facteurs retenus sur la motivation des ressources humaines était donnée par le test t de Student.

Résultats : Les résultats descriptifs ont montré que 76,6% de nos enquêtés n'étaient pas motivés à travailler au CHU de Cocody. Ensuite, le test de régression a mis en évidence que les facteurs liés à la motivation intrinsèque (la prise de décision, l'environnement du travail et enfin les œuvres sociales ou les réjouissances collectives) influencent plus la motivation que les facteurs sociodémographiques et les facteurs extrinsèques.

Conclusion : Pour réussir à motiver le personnel de santé du CHU de Cocody il serait important de mettre l'accent sur les facteurs intrinsèques de la motivation.

Mots clés : Motivation, gestion des ressources humaines

[C045] Vaccination contre le COVID-19 : Comprendre l'hésitation vaccinale des personnels de santé en Côte d'Ivoire (2022)

Martial BAMA¹, ZAMINA Bi Yourou Guillaume¹, YAPI Ellele Marius¹, GOUZILE Assikohon Pulchérie¹, TIEMBRE Issaka², DAYORO Zoguéhi Arnaud Kevin³

1. Institut National d'Hygiène Publique

2. Institut National d'Hygiène Publique, UFHB Département de Santé Publique

3. Université Félix Houphouët-Boigny, Département de sociologie

Introduction : Le COVID-19 a saturé dans sa propagation les systèmes sanitaires réputés les plus robustes. Faute d'un traitement efficace, la Côte d'Ivoire, à l'instar d'autres pays, a initié la vaccination contre le COVID-19 depuis le 1er Mars 2021 avec un objectif de taux de couverture de 70%. Cependant sa mise en œuvre se heurte à des réticences au sein du personnel de santé en dépit de leur niveau de littératie en santé. L'objectif de cette étude était donc de comprendre les catalyseurs sociaux de leur hésitation vaccinale.

Méthode : Une étude socio-anthropologique menée du 29 Août au 10 Septembre 2022 en Côte d'Ivoire dans les districts sanitaires de Cocody-Bingerville, Treichville-Marcory, San-Pedro et Korhogo¹ a permis de réaliser 184 entretiens individuels semi-directifs. Les données ont été traitées et analysées à travers la technique de l'analyse de contenu.

Résultats : Les personnels de santé ont des perceptions contrastées sur le vaccin contre le COVID-19 dominées par des idéologies complotistes et génocidaires. Fondées sur des constats empiriques, elles tendent également à héroïser les africains supposés résilients au covid-19. L'hésitation vaccinale conséquente, indépendamment de la catégorie sociale, tire sa quintessence des connaissances structurées par un écosystème infodémique et catalyseur d'incertitudes sur l'innocuité, le caractère immunitaire et le schéma vaccinal. Par ailleurs le délitement des rapports sociaux, l'ellipse du capital symbolique et la disqualification sociale des personnels de santé dans l'élaboration et la mise en œuvre de la stratégie d'intervention structurent également leur hésitation vaccinale qui évolue selon la temporalité de la pandémie.

Conclusion : La bonification des indicateurs de vaccination contre la COVID-19 des personnels de santé, dont l'attitude est perçue comme catalytique ou inhibitrice de l'engagement des populations en matière de vaccination, est tributaires de ces catalyseurs sociaux.

Mots clés : vaccination contre le COVID-19, hésitation vaccinale, personnels de santé, Côte d'Ivoire

[C046] Vaccination contre le COVID-19 : Comprendre l'hésitation vaccinale des personnels de santé en Côte d'Ivoire (2022)

Bama Martial¹, Zamina Bi Yourou Guillaume¹, Yapi Ellele Marius¹, Gouzile Assikohon Pulcherie¹, Tiembre Issaka^{1,2}, Dayoro Zoguehi Arnaud Kevin²

1. Institut National d'Hygiène Publique

2. UFHB/ Département de Sociologie

Introduction : Le COVID-19 a saturé dans sa propagation les systèmes sanitaires réputés les plus robustes. Faute d'un traitement efficace, la Côte d'Ivoire, à l'instar d'autres pays, a initié la vaccination contre le COVID-19 depuis le 1er Mars 2021 avec un objectif de taux de couverture de 70%. Cependant sa mise en œuvre se heurte à des réticences au sein du personnel de santé en dépit de leur niveau de littératie en santé. L'objectif de cette étude était donc de comprendre les catalyseurs sociaux de leur hésitation vaccinale.

Méthode : Une étude socio-anthropologique menée du 29 Août au 10 Septembre 2022 en Côte d'Ivoire dans les districts sanitaires de Cocody-Bingerville, Treichville-Marcory, San-Pedro et Korhogo¹ a permis de réaliser 184 entretiens individuels semi-directifs. Les données ont été traitées et analysées à travers la technique de l'analyse de contenu.

Résultats : Les personnels de santé ont des perceptions contrastées sur le vaccin contre le COVID-19 dominées par des idéologies complotistes et génocidaires. Fondées sur des constats empiriques, elles tendent également à héroïser les africains supposés résilients au covid-19. L'hésitation vaccinale conséquente, indépendamment de la catégorie sociale, tire sa quintessence des connaissances structurées par un écosystème infodémique et catalyseur d'incertitudes sur l'innocuité, le caractère immunitaire et le schéma vaccinal. Par ailleurs le délitement des rapports sociaux, l'ellipse du capital symbolique et la disqualification sociale des personnels de santé dans l'élaboration et la mise en œuvre de la stratégie d'intervention structurent également leur hésitation vaccinale qui évolue selon la temporalité de la pandémie.

Conclusion : La bonification des indicateurs de vaccination contre la COVID-19 des personnels de santé, dont l'attitude est perçue comme catalytique ou inhibitrice de l'engagement des populations en matière de vaccination, est tributaires de ces catalyseurs sociaux.

Mots clés : vaccination contre le COVID-19, hésitation vaccinale, personnels de santé, Côte d'Ivoire

[C047] La cartographie de processus des soins : une méthode qualitative permettant l'exploration des pratiques soins Exemple du projet d'amélioration de prise en charge des maladies intégrées de l'enfant dans les postes de santé de Thiès au Sénégal

Sougou Ndeye Mareme¹

1. Service de médecine préventive et santé publique, Université Cheikh Anta Diop de Dakar

Introduction : En Afrique, l'accès aux services de soins reste une priorité de santé publique. Selon Taddeus et Maine, le 3ème retard intéresse le retard de prise en charge des patients à l'intérieur des services de santé. L'objectif de cette étude est de présenter l'utilisation de la cartographie de soins (process mapping) pour explorer les goulots d'étranglement dans la prise en charge des enfants de moins de 5 ans dès leur arrivée dans une structure de santé. Cette dernière a été utilisée dans le contexte d'implémentation d'un projet d'amélioration de la prise en charge intégré des maladies de l'enfant (TIMCI) incluant l'intégration d'outils tel que l'oxymètre de pouls et un algorithme de prise en charge PCIME numérique (CDSA).

Méthode : La cartographie de processus des soins (process mapping) est un outil schématique illustrant le circuit de prise en charge de l'enfant au sein de la structure. Elle fait appel à une méthodologie qualitative incluant des entretiens individuels approfondis et une observation non participante. Son utilisation dans le cadre du projet TIMCI a permis de définir le circuit de prise en charge, d'explorer les pratiques de soins et d'analyser les relations soignants-soignés.

Résultats : La cartographie du processus de soins a permis de mettre en évidence le circuit « normal » c'est à dire habituel de prise en charge des enfants dans les structures de santé (5 postes de santé), mais également elle a permis de mettre en évidence les circuits parallèles objectivant dans des cas particuliers des relations sociales singulières entre le personnel de santé et le patient. Ainsi elle a permis d'identifier les goulots d'étranglements de la prise en charge des enfants dans des postes de santé dans un district de santé au Sénégal.

Conclusion : Les méthodes qualitatives permettent l'évaluation des pratiques de soins et leur impact sur la qualité des prestations de services

Mots clés : Méthode qualitative, cartographie des soins, PCIME, Senegal

[C049] L'itinéraire des sujets vaccinés lors de rupture de stock de vaccins : coûts supplémentaires et manque à gagner pour l'INHP de Bouaké, 2023.

Irika Opri¹, Kouassi Damus Paquin¹, Yao Gnissan Auguste¹

1. Département de santé publique et Spécialités

Introduction : Selon l'OMS, la vaccination prévient plus de deux à trois millions de décès par an dans le monde. Les perturbations de la disponibilité des vaccins exposent le programme national de vaccination au risque de ne pas atteindre ses propres cibles et objectif de protection de ses populations contre les maladies évitables par la vaccination. L'objectif de notre étude était d'évaluer l'influence des ruptures de stock des vaccins à l'INHP sur les usagers et la structure.

Méthode : Nous avons réalisé une étude transversale à visée descriptive qui s'est tenue sur une période de 3 mois chez tout usager venu se faire vacciner à l'antenne régionale de Bouaké de l'Institut National d'Hygiène Publique. Il s'agissait d'un échantillonnage exhaustif. Les données ont été analysées à partir du logiciel Epi info7.2.5.0.

Résultats : Notre étude a porté sur 60 personnes, dont l'âge moyen était de $37,75 \pm 16,304$ ans et étaient en majorité des hommes (53,3%) avec un sexe ratio (H/F) de 1,14. Ils étaient des commerçants (45,1%). Les raisons de vaccination étaient, les voyages (76,6%) ou le travail (20%). Les vaccins demandés par les clients étaient l'hépatite B (48,3%), la fièvre typhoïde (33,3%), la méningite ACYW135 (26,7%) et la fièvre jaune (13,3%). La plupart des clients ne revenaient plus à l'INHP pour leur vaccination (76,7%). D'autres prétendaient se faire vacciner ailleurs (52,2%) ou parce qu'ils n'avaient plus d'argent (37%) pour acquérir les vaccins. Le coût supplémentaire pour acquérir le vaccin en officine était de 65450 FCFA. Le manque à gagner pour l'INHP était estimé à 216500 FCFA.

Conclusion : Les ruptures de stock des vaccins pourraient entraîner des occasions manquées de vaccination et impacter la confiance des usagers.

Mots clés : Itinéraire, sujets vaccinés, rupture de stock, coûts supplémentaires, manque à gagner, INHP, Bouaké.

*

[C051] Perception des parents d'élèves sur la vaccination en milieu scolaire dans la ville de Bouaké (Côte d'Ivoire)

Kouame Arsene Deby^{1,2}

1. Antenne Régionale de l'institut d'hygiène publique de Bouaké

2. Department de santé publique, université Alassane Ouattara de Bouaké

Introduction : Au siècle dernier, la vaccination a été l'intervention médicale la plus efficace pour réduire la mortalité et la morbidité causées par les maladies infectieuses. En Côte d'Ivoire selon le rapport annuel sur la Situation Sanitaire en 2020, une baisse de la couverture vaccinale a été observée par rapport à l'année 2019. Etant donné que les parents sont les principaux décideurs médicaux des enfants, cette étude a été menée afin de déterminer leurs perceptions de la vaccination avec pour but de rehausser les couvertures vaccinales, et de lutter contre les maladies de l'enfance évitables par la vaccination

Méthode : Il s'agissait d'une étude transversale descriptive chez les parents d'élèves. Nous avons utilisé un échantillonnage aléatoire simple. Un questionnaire a permis de recueillir les données. L'analyse des données s'est faite à l'aide du logiciel Epi info 7.2.5.0

Résultats : Nous avons pu interroger 344 parents d'élèves, avec une prédominance féminine à 60,2%. Nos enquêtés avaient un âge moyen de $38,44 \pm 8,673$ ans, et un niveau d'étude supérieur (48,5%). Ils étaient majoritairement fonctionnaires avec un revenu mensuel supérieur à 250.000 FCFA. Ils avaient de bonnes connaissances sur les maladies évitables par la vaccination et ils appréciaient la vaccination (96,3%). Pour ceux qui exprimaient de la réticence, ils évoquaient les effets indésirables liés aux vaccins et le manque d'efficacité. Leurs enfants avaient déjà présenté des manifestations adverses post-vaccinales dans 36,3% des cas.

Conclusion : Les parents d'élèves considèrent que les maladies évitables par la vaccination sont graves et qu'il serait important de vacciner les enfants afin de les protéger. Les raisons de réticence à la vaccination étaient les effets indésirables, le manque d'argent et le manque d'efficacité.

Mots clés : perception, parents d'élèves, vaccination, Bouaké.

[C053] Qualité des activités de surveillance épidémiologique dans le département du Borgou au Bénin, 2019-2020

Béhanzin Luc¹, Yaacoub Mouhammadou Nazaal¹, Houéhanou-Sonou Yessito Corine Nadège¹, Salabanzi Banzouzi Mycha hérésa¹, Dèfodji Yéломè Reine¹, Agonnoudé Togbédji Maurice¹

1.École nationale de formation des techniciens supérieurs en santé publique et en surveillance épidémiologique, Université de Parakou, Parakou, Bénin

Introduction : L'évaluation du système de surveillance épidémiologique (SSE) est indispensable pour s'assurer de la qualité des activités de la surveillance des maladies, ses déterminants et conséquences. L'objectif de l'étude était d'apprécier la qualité des activités de surveillance épidémiologique dans le département du Borgou au Bénin de 2019 à 2020.

Méthode : Il s'est agi d'une étude transversale à visée évaluative ayant ciblé toutes les structures sanitaires (SA) des trois zones sanitaires (ZS) Bembèrèkè-Sinendé, Tchaourou et Parakou-N'Dali. Observation directe, entrevue individuelle, revues documentaire et électronique ont servi de techniques de collecte de données. Les outils étaient élaborés à partir de l'Outil d'Analyse des Systèmes de Surveillance. S'inspirant du guide de la Surveillance Intégrée de la Maladie et la Riposte au Bénin, la qualité des activités était appréciée par des indicateurs de performance sur la base des rapports de surveillance et cas notifiés. Elle a été jugée bonne, acceptable et mauvaise pour des proportions moyennes, respectivement $\geq 80\%$, $50-80\%$, $< 50\%$.

Résultats : Au total, les données ont été collectées dans 86 SA. Les critères de jugement appréciés étaient : simplicité (74,64%), acceptabilité (78,24%), sensibilité (38,98%), spécificité (97,05%), valeur prédictive positive (66,55%), représentativité (40,94%), réactivité (74,81%), complétude (83,27%) et promptitude (73,21%). Globalement, la qualité des activités du SSE était acceptable à $69,74\% \pm 18,87$ avec coefficient de variation de 27%. La sensibilité dans Parakou-N'Dali était significativement la plus faible (19,63%) comparativement à celles de Bembèrèkè-Sinendé et de Tchaourou, respectivement de 56,41% (intervalle de confiance à 95 %, IC95% : [37 - 75]) et 40,90 % (IC 95% : [24 - 57]).

Conclusion : La quasi-totalité des indicateurs de suivi des activités de la SE étaient en deçà de l'objectif des 80% au Bénin. Il urge de prendre des mesures afin d'améliorer davantage ces indicateurs pour une meilleure qualité des activités de surveillance épidémiologique dans le Borgou.

Mots clés : Évaluation - Qualité - Activités de surveillance épidémiologique - Bénin

[C054] Déterminants de l'administration en temps voulu de la dose de naissance du vaccin anti-hépatite B au Sénégal en 2019 : Analyse secondaire de l'enquête démographique et de santé

Bassoum Oumar¹, Mbengué Babacar², Seck Ibrahima¹

1. Service de médecine préventive et santé publique, Faculté de médecine, de pharmacie et d'odontologie, Université Cheikh Anta Diop, Dakar, Senegal

2. Service d'immunologie, Faculté de médecine, de pharmacie et d'odontologie, Université Cheikh Anta Diop, Dakar, Senegal

Introduction : Dans les pays en développement, l'hépatite B se propage principalement par la voie périnatale ou horizontale. Ainsi, le gouvernement sénégalais préconise l'administration du vaccin anti-hépatite B dans les 24 heures suivant la naissance (HepB0). L'objectif était d'identifier les déterminants de l'administration en temps voulu du HepB0 au Sénégal en 2019.

Méthode : Il a été procédé à une analyse secondaire de l'enquête démographique et de santé conduite dans tout le pays. La population étudiée était constituée des enfants âgés de 12 à 23 mois dont le statut vaccinal est documenté à partir d'une fiche de santé conservée à domicile. Un sondage en grappes, stratifié en milieu urbain et rural, tiré à deux degrés, était réalisé. Des entretiens individuels étaient menés. La couverture vaccinale est estimée sous forme de proportion. La régression logistique a permis d'identifier les déterminants de la ponctualité (dans les 24 heures suivant la naissance) de la vaccination à l'aide de l'odds ratio ajusté (ORa) et de son intervalle de confiance à 95%.

Résultats : Au total 747 enfants étaient inclus. Parmi eux, 47,7% sont nés de mères âgées de 25 à 34 ans, 46,9% sont de sexe masculin et 86,6% sont nés dans les établissements de santé. Le délai moyen entre la naissance et l'administration du HepB0 était de $13,1 \pm 46,6$ jours. Seuls 65,2% ont reçu le HepB0 dans les 24 heures suivant la naissance. Les déterminants étaient l'âge maternel d'au moins 35 ans (ORa= 2,03 [1,29 – 3,20]), l'appartenance aux régions centre (ORa=0,22 [0,11 – 0,44]) et nord (ORa= 0,18 [0,08 – 0,40]), le niveau d'éducation primaire de la mère (ORa=1,94 [1,13 – 3,35]), au moins quatre consultations prénatales (ORa=1,74 [1,12 – 2,69]) et l'accouchement en établissement sanitaire (ORa=3,42 [1,90 – 6,15]).

Conclusion : L'éducation et le maintien des filles à l'école, les soins postnatals de proximité dans les régions difficiles d'accès, la promotion des consultations prénatales et l'accouchement en établissement sanitaire devraient améliorer la ponctualité de la vaccination par le HepB0.

Mots clés : Vaccination, Hépatite B, Ponctualité, Naissance, Sénégal

[C056] Facteurs influençant l'acceptabilité du vaccin contre la covid-19 dans la ville de Ouagadougou au Burkina Faso selon le « Health Belief Model » en 2022

Ahmed Kabore^{1,2}, Gaël Kayabh Zoungrana¹

1. Département de Santé Publique, UFR- SDS, Université Joseph KI ZERBO, Burkina Faso

2. Institut des Sciences du Sport et du Développement Humain, Université Joseph KIZERBO, Burkina Faso

Introduction : Jusqu'en Juillet 2022 le taux de vaccination au Burkina Faso était de moins de 8% de sa population. L'Organisation Mondiale de la Santé (OMS) préconisait une vaccination d'au moins 40% de la population des pays d'ici la fin d'année 2021. L'objectif est d'étudier les facteurs influençant l'acceptabilité du vaccin contre la covid-19 dans la ville de Ouagadougou selon le Health Belief Model en 2022.

Méthode : Il s'agit d'une étude transversale qualitative exploratoire utilisant le Health Belief Model. Après avoir collecté les données par des entretiens individuels et focus group, les données ont été transcrites et analysées à l'aide du logiciel NVIVO 12.

Résultats : Cette étude a inclus au total vingt-sept (27) participants dont vingt-deux hommes et cinq femmes. Les participants étaient composés d'enseignants, de commerçants, de policiers, de secrétaires et de gestionnaires de structures privées. L'analyse des données a permis de faire ressortir comme perceptions sur le vaccin contre la covid-19 le doute du vaccin, l'absence de nécessité et l'utilité ; comme bénéfices il est ressorti la protection collective et individuelle, et la protection contre les cas graves ; comme barrières il y a le doute sur l'existence de la maladie, rumeurs et réseaux sociaux, mauvaise communication ; les facteurs qui incitent à accepter sont la communication, la sensibilisation et la libre circulation.

Conclusion : Cette étude a permis d'identifier les facteurs qui peuvent influencer l'acceptabilité du vaccin contre la covid-19 et de faire des recommandations susceptibles de favoriser l'adhésion à la campagne de vaccination contre la covid-19.

Mots clés : vaccination, covid-19, acceptabilité du vaccin

[C061] Evaluation préliminaire du Projet « M-Vaccin » dans cinq districts sanitaires de Côte d'Ivoire en 2020

Ekra Kouadio Daniel^{1,2}, Ahoussou Eric Martial Kouakou¹, Kambire Sié³, Ahi Moro Janus²

1. Département de Santé Publique et Spécialités, UFHB, Côte d'Ivoire

2. Direction de Coordination du Programme Elargi de Vaccination, MSHPCMU, Côte d'Ivoire

3. VillageReach, Côte d'Ivoire

Introduction : Le projet M-Vaccin, application issue d'un partenariat tripartite utilisant le fort taux de pénétration de téléphonie mobile pour le renforcement des actions du Programme Elargi de Vaccination (PEV) afin d'atteindre l'ensemble des cibles vaccinales par la communication. L'objectif de notre étude était d'évaluer le projet « M-Vaccin » dans les 5 sites de déploiement du lot 1.

Méthode : Une étude descriptive a été menée en 2020, dans les districts sanitaires de Nassian, Duékoué, Koro, Ouaninou et Toubia. Des interviews téléphoniques ont permis de collecter des informations chez les agents de santé (83), les agents de santé communautaire (ASC) (18) et les mères (192). Les données analysées ont porté sur les compétences des acteurs de santé, la fonctionnalité et performances de l'application.

Résultats : Les infirmiers représentaient 82,4% des agents de santé. Parmi ceux-ci, 60,1% exerçaient en milieu rural, de même que les ASC 66,7%. Les mères qui vivaient en zones rurales représentaient 48,3%. L'âge moyen des enfants des mères enquêtées était 9,4 mois. Le test de compétence des acteurs de santé comprenait 20 questions. Les agents de santé (24) impliqués dans l'utilisation de la solution M-Vaccin ont obtenu un score moyen de 61,5% et ont tous apprécié les méthodes d'apprentissage utilisées (formation en salle, mentorat sur site et à distance). Toutefois 42,4% des agents de santé ont trouvé certaines fonctionnalités difficiles. Les agents de santé ont estimé que 66,7% des ASC étaient actifs et les mères ciblées (72,0%) ont reçu un suivi rapproché de relances. Parmi les ASC enquêtés, 94,4% ont rapporté recevoir les messages ou appels téléphoniques rappelant les rendez-vous de vaccination au centre de santé pour leurs cibles. Les mères dans 64,4% ont indiqué recevoir des messages de rappels.

Conclusion : Les résultats de l'évaluation préliminaire ont permis d'élaborer un plan d'amélioration pour le déploiement progressif de l'application à l'ensemble des districts.

Mots clés : Evaluation – Projet « M-Vaccin » – Districts sanitaires – PEV – Côte d'Ivoire

[C062] Première revue intra action de la réponse à l'épidémie de choléra au Cameroun, mars 2023 : leçons clés

Armelle Viviane Ngomba¹, Linda Lovet Ezzo Endalle², Chanceline Bilounga Ndongo¹, Nadia Jacqueline Mandeng³, Natacha Nsiewe¹, Gile Loïc Kongne Choupo², Armel Evouna⁴, Thomas Vukugah⁵, Georges Alain Etoundi Mballa^{1,3}

1. Direction de la Lutte contre la Maladie, les Epidémies et les Pandémies. Cameroun, Faculté de Médecine et des Sciences Pharmaceutiques de l'Université de Douala

2. Direction de la Lutte contre la Maladie, les Epidémies et les Pandémies. Cameroun, Faculté de Médecine et des Sciences Biomédicales de l'Université de Yaoundé I

3. Centre de Coordination des Opérations d'Urgences de Santé Publique. Cameroun, Faculty of Health Sciences of University of Bamenda

4. Cameroon Field Epidemiology Training Program (CAFETP)

5. JHPIEGO, Cameroon country office

Introduction : En 2011, le Cameroun a connu une épidémie majeure de choléra avec 22 433 cas incidents et une létalité de 3.49%. Depuis lors, le choléra y évolue en mode endémo-épidémique et touche davantage les grandes villes du pays. La plus récente épidémie a débuté en Octobre 2021 et en Mars 2023, 15 309 cas étaient notifiés avec une létalité de 2,03%.

Méthode : En mars 2023 à Yaoundé, s'est tenu la première Revue Intra Action (RIA) de la gestion de l'épidémie de choléra en cours au Cameroun. L'outil standard de l'OMS a été utilisé afin d'identifier les défis, les meilleures pratiques et les points d'actions prioritaires.

Résultats : Durant 04 jours d'atelier, 71 participants représentants des sectorielles et partenaires impliqués à tous les niveaux de la réponse ont pris part aux groupes de discussions thématiques. Cinq piliers ont été passés en revue : i) la coordination, la recherche opérationnelle, la planification, et le suivi ; ii) la communication sur les risques et l'engagement communautaire, iii) la surveillance, les investigations, et les capacités de laboratoires iv) la prise en charge, la Prévention et le contrôle des Infections, v) le soutien logistique et la vaccination. Il en ressort que le leadership du secteur de l'eau, une stratégie communicationnelle efficace, le partenariat public/privé pour la détection, le diagnostic, la mise en œuvre des stratégies « Case Area Targeted Intervention », ainsi qu'un mécanisme de financement conséquent des opérations d'urgences constituent les priorités nationales actuelles pour un meilleur contrôle des épidémies de choléra.

Conclusion : La revue intra-action de gestion de l'épidémie de choléra au Cameroun a été conduite selon une approche multisectorielle et pluridisciplinaire. Le partage d'expérience et l'analyse commune des stratégies de réponse sont des facteurs positifs d'engagement et de mutualisation des ressources disponibles auprès des détenteurs d'enjeux.

Mots clés : choléra, Revue Intra-Action, Préparation, Réponse.

[C063] Identification des facteurs associés à la positivité de la COVID-19 chez les patients dans les districts sanitaires de Cocody-Bingerville et Marcory Treichville (Abidjan, Côte d'Ivoire).

Gouzile Assikohon Pulchérie¹, Bama Martial¹, Bi Yourou Guillaume Zamina¹, Amani Yao Me Raphael¹, Yapi Ellélé Aimé¹, Issiaka Tiembré^{1,2}

1. Institut National d'Hygiène Publique (INHP)
2. Université Félix Houphouët Boigny de Cocody

Introduction : La maladie à coronavirus (COVID19) est une maladie infectieuse due au virus SARS-CoV-2 dont les symptômes les plus courants sont la fièvre, la fatigue et une toux sèche. Environ une personne sur six contractant la maladie présente des symptômes plus graves, notamment une dyspnée. Les personnes âgées et celles porteuses de comorbidités ont plus de risques de présenter des symptômes graves. En Côte d'Ivoire, il a été demandé à toute personne qui présente les signes évocateurs de consulter un médecin. Cependant la majorité des établissements sanitaires du pays ne disposait pas de capacité propre pour effectuer des tests de sorte que les données sur les cas positifs de COVID-19 ne traduisaient pas nécessairement la réalité sur le terrain, notamment chez les usagers des hôpitaux d'Abidjan présentant des signes respiratoires. L'objectif de cette étude était donc d'estimer le taux de positivité de la COVID-19 chez les patients présentant des signes évocateurs de la maladie dans les districts sanitaires de Cocody-Bingerville et de Treichville-Marcory.

Méthode : Il s'agit d'une étude transversale à visé analytique qui s'est déroulée du 19 mai au 1er juin 2021 dans les hôpitaux de tous les niveaux de la pyramide sanitaire dans les districts sanitaires de Cocody-Bingerville et de Treichville-Marcory.

Résultats : Les résultats ont montré que sur 1046 prélèvements effectués, 25 (2,7%) étaient positifs au SARS-COV 2. Cette positivité à la covid-19 n'était pas liée aux principaux signes évocateurs ou les symptômes. Les tests statistiques non significatifs ($Pr = 0.472$) et ($Pr = 0.107$) respectivement pour les facteurs toux et fièvre l'attestent.

Conclusion : Cette étude dans l'ensemble a permis de comprendre que les symptômes ou les signes évocateurs ne déterminaient pas forcément la présence du virus SARS-CoV-2 chez un patient.

Mots clés : Facteurs associés, Positivité, Covid-19, Côte d'Ivoire

[C065] Facteurs d'augmentation des enfants « zero doses » et « sous-vaccinés » dans le district sanitaire de Ouaninou dans la région du Bafing de janvier à juillet 2023.

Otokore Garou L H¹, Gramboute Bassouffou²

1. Consultant UNICEF initiative « 0 doses » pour la région du BAFING
2. Coordonnateur du Programme Elargie de Vaccination du district sanitaire de OUANINOU

Introduction : Les enfants « 0 doses » sont définies comme étant ceux n'ayant pas la première dose de vaccin combiné contre la diphtérie, le tétanos et la coqueluche (DTC1). Les enfants « sous-immunisés » ou « sous-Vaccinés » sont ceux qui n'ont pas reçu la troisième dose de vaccin contenant de la diphtérie, du tétanos et de la coqueluche (DTC3). Le district de OUANINOU est situé dans la région du BAFING avec au Nord et à l'Ouest la République de GUINEE au Sud le district de BIANKOUA et à l'Est district de TOUBA.

Méthode : Etude réalisée à partir d'une approche qualitative basée sur des entretiens auprès de quarante (40) mères ayant en charge un enfant de 0 à 59 mois, d'une part et d'autre part auprès de dix (10) prestataires de santé exerçant dans le district.

Résultats : la communauté a révélé que 49,62% des mères interrogées avaient des enfants de 0 à 59 mois, soit « 0 doses » ou « sous-vaccinées » du fait des MAPI apparues chez leurs enfants ou ailleurs après les vaccins. 31,76% des mères interrogées étaient des issues de familles migrantes de la GUINEE. 18,32% des mères avaient signifié une méconnaissance de la vaccination. L'enquête au niveau des prestataires comme facteurs, l'absence de moyens de mobilité des prestataires pour la réalisation des stratégies avancées de vaccination (54,13 %), les mutations fréquentes des agents de santé du district vers d'autres destinations (28,25%) et 17,62% des prestataires relèvent comme facteurs l'irrégularité des appuis en carburant pour la réalisation des stratégies avancées.

Conclusion : L'augmentation du nombre enfants « 0 doses » et « sous-vaccinées » permettent de mettre en évidence la performance en vaccination du district de OUANINOU influencé par les facteurs énumérés.

Mots clés : Augmentation, zéro-doses, sous-vaccinés, OUANINOU.

[C068] Apport de la digitalisation dans les soins de santé communautaire en zone décentralisée : expérience du projet PROXISANTE en matière de prévention de la tuberculose, du paludisme et du VIH à Toumodi, République de Côte d'Ivoire.

Bangali Maïka¹, Adahourman Paul², Ehui Eboua³, Azani Jean-Claude¹, Kadja Françoise⁴, Kouakou Jacquemin⁵, Tanoh Antoine⁶, Msellati Philippe¹, Moh Raoul^{1,7,8}

1. Programme PAC-CI, Abidjan, Côte d'Ivoire
2. Direction Départementale de la santé, Toumodi, Côte d'Ivoire
3. Programme National de Lutte contre le Sida, Abidjan, Côte d'Ivoire
4. Direction de la santé communautaire, Abidjan, Côte d'Ivoire
5. Programme National de lutte contre la tuberculose, Abidjan, Côte d'Ivoire
6. Programme National de lutte contre le paludisme, Abidjan, Côte d'Ivoire
7. Unité Pédagogique de Dermatologie et Infectiologie, UFR Sciences Médicales, Abidjan, Côte d'Ivoire
8. Inserm 1219, Université de Bordeaux, Bordeaux, France

Introduction : En Côte d'Ivoire, le Système d'Informations Sanitaires présente des insuffisances concernant la visibilité et le rapportage des activités communautaires. Afin d'améliorer les capacités des agents de santé communautaire (ASC), l'offre des soins et le recueil des données en routine, le programme PAC-CI a mis en place PROXISANTE pour développer des stratégies visant à améliorer l'intégration de la prévention du dépistage et de la prise en charge du VIH, de la tuberculose et du paludisme aux systèmes de santé. Des ASC ont été recrutés, formés et équipés de tablettes pour le recueil quotidien de données en vue d'améliorer le rapportage des données communautaires.

Méthode : Cette étude s'est déroulée de septembre 2021 à Aout 2023 dans des ménages du district sanitaire de Toumodi, avec : - configuration des tablettes pour le recueil en routine d'indicateurs communautaires nationaux dans le DHIS2. – Formation de 24 ASC sur l'utilisation de la tablette. - Saisie quotidienne, synchronisation et monitoring des données, avec requêtes électroniques pour correction et complétion des données manquantes. – Enfin, édition d'un tableau de bord mensuel récapitulant les indicateurs du projet.

Résultats : 24 ASC ayant majoritairement un niveau secondaire (74%) recrutés autour de 3 centres de santé. 1377 ménages inclus, 27133 visites à domicile dans ces ménages et 20 rapports d'activités mensuels. 100% des rapports mensuels complets disponibles au district sanitaire et immédiatement intégrables dans le DHIS2.

Conclusion : Dans ce projet innovant, la tablette vient remplacer les outils papiers fastidieux à remplir au cours d'un suivi longitudinal. Le monitoring quotidien de la base permet d'avoir des données de qualité. Ainsi, pour répondre au défi de la qualité des données issues des activités communautaires et de la visibilité des soins de santé communautaire, il est primordial dès lors d'adopter la digitalisation du rapportage des données.

Mots clés : Données de santé communautaires – Digitalisation- Côte d'Ivoire

[C069] Identification des barrières à la disponibilité des antirétroviraux au Gabon

Sydney Maghendji-Nzondo¹, Euloge Ibinga¹, Pamela Ngouanfo-Ifouet¹, Amandine Frédérique Iwenga-Yattara¹, Ulrick Bisvigou¹, Irène Pegha-Moukandja^{1,2}, Edgard Brice Ngoungou¹

1. Département d'Epidémiologie Biostatistiques, Informatique Médicale et Santé publique, Université des Sciences de la Santé (USS), Libreville/Gabon

2. Centre international de recherches médicales de Franceville (CIRMF)

Introduction : L'utilisation des antirétroviraux a considérablement amélioré la prise en charge et l'espérance de vie des patients atteints du VIH. L'absence ou l'interruption des ARV mettrait en danger les vies des millions de personnes. Cette étude avait pour objectif d'identifier les barrières à la disponibilité des antirétroviraux au Gabon.

Méthode : De décembre 2021 à juin 2022, une étude mixte (quantitative et qualitative) a été réalisée d'une part au sein institutions publiques responsables de la réglementation, de l'importation et de la distribution des médicaments et d'autre part, dans les structures sanitaires de prise en charge du VIH et leur pharmacie.

Résultats : L'étude quantitative a porté sur 400 sujets âgés de 20 à 83. L'âge médian était de 46,5 [20-83] ans et les tranches d'âge de 40 à 49 ans (30%), 50 à 59 ans (30%) étaient les plus représentées. TDF + 3TC + DTG était le protocole thérapeutique le plus utilisé (96%). Pour 263 patients, la covid-19 avait eu un impact sur la disponibilité des antirétroviraux et la diminution des quantités de boîtes servies était plus évoquée (82,9%). Au cours de leur traitement, 59% des patients avaient observé une rupture de médicaments qui avait duré plusieurs mois pour 78,3% d'entre eux. La raison rapportée pour 52,5% des cas était une rupture de stock. L'étude qualitative a révélé que les barrières à la disponibilité des ARV étaient les retards de livraison lié à la non priorisation du traitement des commandes du Gabon, les lenteurs administratives pour le décaissement des fonds et la pandémie à covid-19 avec la fermeture des frontières.

Conclusion : Bien que des avancées considérables soient observées avec l'utilisation des ARV, il ressort néanmoins des obstacles à l'approvisionnement en ARV au Gabon. Ces freins pourraient entraver les conditions de prise en charge thérapeutique des patients.

Mots clés : Antirétroviraux, obstacle, VIH, patients, Gabon.

[C070] Les défis de la qualité des soins et des services de santé des unités de soins périphériques pour une couverture sanitaire universelle au Togo

AZIALEY Kwami Gagnon¹, Kassouta N'tapi²

1. Département de Santé Publique, UL

2. Direction Régionale de la Santé de la Centrale

Introduction : La qualité des soins garantie la confiance des usagers à l'égard des services de santé et améliore leur utilisation. Cette étude a pour but d'évaluer le niveau de la qualité des soins et des services dans les unités de soins périphériques (USP).

Méthode : il s'est agi d'une étude descriptive de type transversale réalisé du 1er au 30 Septembre 2022 dans 30 USP des 5 districts sanitaire de la région centrale. Les USP ont été évaluées sur les 7 dimensions de la qualité des soins et des services de santé.

Résultats : La dimension « sureté » est la dimension la moins performante dans l'ensemble des USP. Aucune USP n'est classée au premier niveau de la qualité des soins ou qualité offerte excellente (performance supérieure à 80%) ni au deuxième niveau ou qualité offerte bonne (performance entre 60 et 80%). 37% des USP avaient un niveau de qualité des soins au troisième niveau ou qualité offerte insuffisante (performance entre 40 et 60%). 63% des USP avaient un niveau de qualité des soins au quatrième niveau ou qualité offerte très insuffisante (performance en dessous de 40%).

Conclusion : La qualité des soins dispensés dans les USP de la région centrale est insuffisante avec des dysfonctionnements graves des services de santé. Des mesures d'interventions en fonction de ces insuffisances devraient être entreprises

Mots clés : Qualité, Soins, Centrale, Togo

[C071] Evaluation de la gestion des centres de soins de santé primaire et de la gestion des médicaments dans lesdits centres à l'ère de la couverture sanitaire universelle : cas de 30 unités de soins périphériques dans la région centrale du Togo

Azialey Kwami Gagnon¹, N'tapi Kassouta², N'djao Akawulu³

1. Département de Santé Publique, UL

2. Direction Régionale de la Santé, Région Centrale

3. Direction préfectorale de la santé, Préfecture de Tchaoudjo

Introduction : A la faveur de l'initiative de Bamako, il a été mis en place des comités de gestion (CoGes) dans les centres de santé publiques. La bonne gestion générale des centres est un élément fondamental garantissant l'accès des populations à des services de santé de qualité. Cette étude a pour but d'évaluer la gestion générale des centres de soins de santé primaire y compris la gestion des médicaments

Méthode : il s'est agi d'une étude descriptive de type transversale réalisé décembre 2022

Résultats : 30 CoGes des 5 districts sanitaires ont été évalués. Seuls 4 CoGes étaient conformes aux normes de conformité. Aucun des 30 CoGes n'était fonctionnel. 4 CoGes avaient une performance d'au moins 30% et 4 avaient une performance nulle (0%). Seuls 26% des des unités de soins périphériques (USP) disposaient des médicaments de première nécessité. Les prix de vente des médicaments essentiels et génériques ne respectent pas la tarification nationale. Les USP ne disposent pas de tous les outils de gestion des médicaments

Conclusion : La contre-performance des CoGes reside dans une crise qui caractérise l'état de gestion des centres de santé primaire. L'amélioration de la gestion générale des centres de soins de santé primaire y compris des médicaments est une composante non négligeable de la marche des pacouverture santé universelle pour tous

Mots clés : Evaluation, Gestion, USP, Togo

[C072] Profil Epidémiologique des accouchements à domicile dans deux villages du district sanitaire de Tehini, Côte d'Ivoire 2023

Ano Ama K Marie Noelle¹, Ekra Kouadio Daniel¹, Diallo Maky², Ekou Franck Kokora¹, Sangare Seydou³, Douba Alfred¹, Ahoussou Eric Martial¹, Dagnan N'cho Simplicie¹

1. Département de Santé Publique et Spécialités, UFHB

2. Laboratoire de Biostatistique, Méthode et Informatique médicale, UFHB

3. CSAS district sanitaire de Tehini

Introduction : Les accouchements à domicile sans assistance médicale continuent d'être une préoccupation pour tous les acteurs de développement dans les pays en voie de développement. L'organisation mondiale de la santé (OMS) estime que chaque année plus de 20 millions de femmes souffrent de séquelles liées à l'accouchement non assisté parmi lesquelles 800 femmes meurent chaque jour des suites de complications obstétricales. L'objectif de cette étude était de décrire le profil épidémiologique des accouchements à domicile chez les femmes de deux villages du district de Tehini, Nord Est de la Côte d'Ivoire.

Méthode : Etude transversale à visée analytique allant de janvier - septembre 2023. Les participantes ont été sélectionnées par sondage aléatoire en grappe, à trois degrés (districts, aires de santé et villages). Seules les femmes des villages de Bolé et Kointa ayant accouché dans les mois précédents la période d'étude ont été interrogé. Les données collectées sur google form lors d'un entretien individuel après obtention de leur consentement libre et éclairé ont été analysées par le test de Khi deux.

Résultats : Au total 123 femmes avaient été enquêté. La proportion des accouchements à domicile était de 97,7%. L'âge moyen était de 30 ans et les jeunes filles de moins de 18 ans représentaient 17,9% des cas avec 75,6% non scolarisées. La majorité des femmes étaient des Lobi dans 58,2% des cas sans aucune confession religieuse dans 70% des cas. Le village de Bolé abritait 53,6% des cas contre 46,4 pour Kointa. Et 44,7% habitaient à plus de 10 kilomètres du centre de santé le plus proche avec 64,2% des infrastructures routières qui étaient des pistes. La moto étaient utilisées dans 56,9% comme moyen de déplacement. Les déterminants indépendants associés à l'accouchement à domicile étaient la faible perception des risques liés à l'accouchement à domicile (OR 330,86[23,19 - 4719,70]), le coût des soins non abordable (OR 289,43[17,51 - 4783,30]), la mauvaise qualité des soins (OR 51,51[7,88 - 336,97]) et l'antécédent d'accouchement à domicile (OR14,99[1,68 - 33,59]).

Conclusion : Il ressort que le phénomène de l'accouchement à domicile en milieu rural continu de sévir malgré les efforts déployés par nos autorités. Des stratégies de sensibilisation plus adaptées devraient être misent en place pour le changement véritable des mentalités.

Mots clés : Epidémiologie, Accouchements à domicile, Tehini, Côte d'Ivoire

[C073] Evaluation de la mise en œuvre du plan stratégique de surveillance et de lutte contre les résistances aux antimicrobiens 2018-2022 au Sénégal.

Keita Ibrahima Mamby^{1,2,3,4}, Leye Mamadou Makhtar Mbacké^{3,4}, Diop Khadija Sandembou², Sow Iyane Ahmed^{4,5}, Seck Ibrahima^{3,4}, Wilane Mouhamed Bachir², Samb Ngoné^{2,6}, Ciss Mamadou⁵, Sow Mouhamadou Moustapha⁵, Diallo Alpha⁷, Diouf Coumba⁷, Niang Ahmadou⁷, Ndiaye Adjaratou Diakhou, Dieye Amadou Moctar⁶

1. Direction générale de la Santé publique (DGSP) du Ministère de la Santé et de l'Action sociale (MSAS)
2. Groupe thématique RAM du Haut Conseil national de Sécurité sanitaire mondiale (HCNSSM) de la Primature
3. Institut de Santé Et Développement (ISED)
4. Université Cheikh Anta DIOP de Dakar (UCAD)
5. Projet « DESIGN » du Laboratoire national de l'Elevage et de Recherche vétérinaire (LNERV)
6. Direction des Laboratoires (DL) du MSAS
7. Organisation pour l'Alimentation et l'Agriculture (FAO)

Introduction : A l'instar des autres pays du monde, le Sénégal avait élaboré un plan d'action national de lutte contre les résistances aux antimicrobiens (PANRAM 2018-2022) selon une approche One Health dont la mise en œuvre a amélioré les capacités du Règlement sanitaire international. Cependant ce plan n'était pas encore évalué en 2022 d'où l'urgence d'analyser le niveau réel de mise en œuvre dudit PANRAM au Sénégal.

Méthode : C'était une étude à devis mixte : (i) Volet quantitatif : transversal, rétrospectif et évaluatif avec un questionnaire fermé structuré sur les indicateurs de couverture et de mise en œuvre ; (ii) Volet qualitatif : phénoménologique avec un guide d'entretien ouvert semi-structuré afin d'identifier les facteurs déterminants de mise en œuvre. Couvrant la période de mise en œuvre de 2018-2022 (5ans), l'étude s'intéressait aux acteurs sectoriels clés de lutte contre les RAM au Sénégal. L'analyse utilisait les logiciels Excel2010® et QDAMinerLite1.4.1©2004. L'approbation du comité d'éthique était obtenue.

Résultats : Les santés humaine, animale et environnementale étaient respectivement représentées à 73,9%, 8,7% et 4,3%. Le niveau régional était représenté à 2,2% contrairement à ceux infrarégionaux. La transdisciplinarité était adéquate à 45% et effective à 40% avec une réalisation globale de 53,6%. Celles spécifiques au laboratoire et à l'hygiène étaient respectivement de 70,6% et 69,2%. La réalisation était retardée globalement à 37,3% et spécifiquement à 75% pour la coordination, communication et recherche avec 38,1% de re-planification d'activités. L'analyse temporelle montre une tendance globale quinquennale en baisse avec de meilleures réalisations en transition annuelle (23% en T4 2020) surtout pour l'hygiène, PCI (54%). Enfin les facteurs déterminants de mise en œuvre étaient le financement, M&E dont la recherche, la formation, l'intégration et la COVID-19 comme facteur bloquant, d'où l'utilité d'un cadre M&E intégrant la mitigation des risques.

Conclusion : Le PANRAM moyennement mis en œuvre, souffrait de financement et de suivi.

Mots clés : RAM ; Gouvernance / Plan d'action national ; Surveillance / Prévention ; Sénégal

[C074] Analyse intégrée et territoriale du risque de dissémination de la flambée épidémiologique d'influenza aviaire hautement pathogène de 2021 à Grand-Bassam.

Keita Ibrahima Mamby^{1,2}, Seck Rosalie Martine Ndew^{1,2}, Kouakou Yao Christophe^{3,4}, Ouattara Douyéri Thierry^{5,4}, Kallo Vessaly^{5,4}, Linard Catherine^{1,6}, Antoine-Moussiaux Nicolas^{1,2}, Bonfoh Bassirou^{1,7}, Yameogo Simplice^{1,2}, Tiembre Isaac^{8,9}

1. Master de spécialisation en Gestion intégrée des Risques sanitaires (MSPé. GIRIS)
2. Université de Liège (ULiège)
3. Direction départementale de la Santé animale (DDSA) de Jackville
4. Ministère des Ressources animales et halieutiques (MIRAH)
5. Direction des Services vétérinaires (DSV)
6. Université de Namur (UNamur)
7. Centre Suisse de Recherches en Scientifiques (CSRS)
8. Institut national d'Hygiène publique (INHP)
9. Ministère de la Santé et de l'Hygiène publique (MSHP)

Introduction : Grand-Bassam contribue à l'économie ivoirienne à travers la filière avicole et le tourisme. Il présente des aires de repos d'avifaune (ARA), recevant périodiquement des oiseaux migrateurs souvent réservoirs d'influenza aviaire hautement pathogène (IAHP), et un marché à volaille (MV) où le respect de mesures de biosécurité est insuffisant. Selon une approche One Health, une analyse territorialisée du risque d'aggravation de la flambée épidémiologique de 2021 à Grand-Bassam a été conduite.

Méthode : Une étude quantitative, transversale, rétrospective, respectant les règles éthiques, environnementales et du bien-être animal, était réalisée en mai 2023 à Grand-Bassam. Un questionnaire sur l'interaction d'acteurs de la riposte a permis d'identifier les acteurs centraux et leur réseau social sur la plateforme Kumu Inc. Une régression logistique, de la notification de mortalité de volaille domestique et d'avifaune, a été réalisée grâce aux données extraites de KoboToolBox afin d'identifier les facteurs de risque sur Stata (version SE/15) avant de les cartographier avec le logiciel Quantum GIS (version 3.22).

Résultats : Les acteurs centraux du réseau social de la riposte étaient certes la direction départementale de la santé animale et la direction des services vétérinaires, mais aussi 60% de non-scientifiques émanant de la préfecture, des fermes et de la chefferie. L'analyse intégrée et territoriale des risques a montré des facteurs déterminants de dissémination de la flambée d'IAHP. En effet il s'agissait des liens statistiquement significatifs entre la notification de mortalités d'IAHP et les facteurs : (i) environnementaux comme la distance ≥ 10 km d'une ARA ($p < 0,027$) et celle > 15 km d'un MV ($p < 0,000$) ; (ii) d'élevage comme le type traditionnel ($p < 0,007$) et l'espèce pintades à cheptel ≥ 85 individus ($p < 0,000$). Par ailleurs, les ansériformes (canards et oies) n'ont pas d'effet significatif retrouvé.

Conclusion : La prévention des risques de propagation de flambée d'IAHP nécessite une focalisation sur les acteurs centraux ainsi que les facteurs environnementaux et d'élevage.

Mots clés : Riposte IAHP, Gouvernance territoriale, flambée, Grand-Bassam, Côte d'Ivoire.

[C078] Investigation des cas de rougeole dans le village de Soungbonon Bambarasso, District Sanitaire Dabakala, Côte d'Ivoire, Mai 2023

Ouattara Issouf¹

1. CSE district sanitaire Dabakala

Introduction : A la semaine 18, 32 cas suspect notifié par le District de Dabakala dont 11 cas notifié par l'aire sanitaire de M'borla-Dioullasso et un (1) cas est revenu positif. Une investigation a été menée dans l'objectif de décrire le cas confirmé, Identifier d'éventuels nouveaux cas et proposer des mesures de prévention et de contrôle

Méthode : Une étude descriptive a été menée à la semaine 19, 2023 à Soungbonon Bambarasso village situé dans l'aire sanitaire de M'borla-Dioullasso, District Sanitaire de Dabakala. Les définitions de cas suspects et confirmés de rougeole du SIMR ont été utilisées. Une liste linéaire a été élaborée et utilisée pour la recherche active des cas. Les caractéristiques sociodémographiques, les informations cliniques et le statut vaccinal du cas confirmé, des contacts et les cas de rumeurs ont été considérées. Les données ont été collectées sur support papier et analysées sur Excel et Epi-Info 7, calculant les mesures de fréquences

Résultats : Enfant âgé de cinq, sexe féminin, ayant été vaccinée, avec aucun signe de la maladie au moment de l'enquête et la maman aurait quitté un village d'orpaillage. Trois personnes contacts vivant sous le même toit dont 1(33%) hommes et 2 (67%) femmes. Deux (2) personnes d'entre elles soit 67% ont eu un statut vaccinal inconnu. De même, la recherche de cas des rumeurs de rougeole a permis de recenser (02) cas suspects, 2(100%) femme. La tranche d'âge variait de 1 à 5 ans avec 91% de couverture vaccinale.

Conclusion : Non existence d'épidémie de rougeole. Remarque d'une faible couverture vaccinale. Absence de nouveau cas de rougeole. Il a été recommandé de faire vacciner tous les enfants de 0 - 5 ans autour du ménage et de respecter le calendrier vaccinal.

Mots clés : Rougeole, Investigation, Soungbonon Bambarasso, Côte d'Ivoire.

[C079] Déterminants de l'élimination du paludisme dans le district sanitaire de Botro, Côte d'Ivoire 2023

Yao Gnissan Henri Auguste^{1,2,3}, Kouassi Damus Paquin^{1,2,3}, Iirica Opri^{1,2,3}, Oussou Rouland^{1,2,3}, Coulibaly M'began^{1,4,3}, Kouadio Deby Arsene^{1,2,3}, Serigbalet Arthur Guy Fiacre Elvis^{1,2,3}, Yeo Moussa⁵, Yeo Salifou³, Ahoussou Eric Martial^{1,4,6}, Soumahoro Sory Ibrahim^{1,2,3}, Dagnan N'cho Simplicie^{1,4,6}

1. Département de santé publique et spécialités connexe
2. UAO
3. INHP Bouaké
4. UFHB
5. Université Alassane Ouattara, Bouaké
6. INHP Abidjan

Introduction : Maladie infectieuse, le paludisme est un véritable problème de santé publique, cause de morbidité et de mortalité élevée. Notre étude visait à faire une analyse des déterminants du paludisme pouvant contribuer à son élimination à l'horizon 2030

Méthode : Nous avons réalisé une étude transversale prospective, descriptive et analytique dans la région sanitaire de Botro, du 20 Juin au 1er Juillet 2023, auprès des chefs de ménage. Les données ont été analysées à l'aide du logiciel SPSS 22.0.

Résultats : Nos enquêtés étaient au nombre de 400. Ils avaient un âge moyen de 40,14 ans, étaient des hommes (54,4%), étaient non scolarisés (36,3%) et cultivateurs, artisans, ménagère ou commerçant (84,5%). Ils habitaient des logements individuels (57,3%). Les ménages comptaient entre 6 et 20 personnes (53,5%). Ils disposaient d'un poste d'une télévision (64,8%). Ils considéraient le paludisme comme une maladie grave (38%), mortelle (42,3%), affectant tout le monde (96,5%), transmis par un moustique (97,8%) et pouvant être évité (87,5%) grâce à plusieurs mesures de lutte dont dormir sous une moustiquaire (66%). Ils savaient que l'insalubrité pouvait contribuer à sa survenue, en favorisant la prolifération des moustiques. Ils se rendaient à l'hôpital en cas de suspicion de paludisme (93%). Ils avaient depuis le début de l'année fait une à cinq épisodes de paludisme (68,3%). Il existait un lien statistiquement significatif entre le fait de dormir sous une moustiquaire et la survenue du paludisme. Ils estimaient que l'assainissement (77%) et la gratuité du traitement pourraient permettre l'atteinte de son élimination.

Conclusion : le paludisme demeure un problème majeur de santé publique dans le district sanitaire de Botro. La sensibilisation des populations à dormir sous une moustiquaire pourrait si elle est associée à l'assainissement des milieux de vie et à la gratuité effective des soins contribuer à l'élimination de cette maladie.

Mots clés : Paludisme, Botro, déterminants, chefs de ménage, élimination, 2023

[C080] Déterminants de l'élimination de la tuberculose dans le suivi des malades tuberculeux au CAT de Bouaké, Côte d'Ivoire 2023

Yao Gnissan Henri Auguste^{1,2}, Kouassi Damus Paquin^{1,2}, Irica Opri^{1,2}, Oussou Rouland^{1,2}, Coulibaly M'bégan^{2,3}, Kouadio Deby Arsene^{1,2}, Serigbalet Arthur Guy Fiacre Elvis^{1,2}, Gbokou Franck⁴, Yeo Salifou², Ahoussou Eric Martial^{2,3}, Soumahoro Sory Ibrahim^{1,2}, Dagnan N'cho Simplicie^{2,3}

1. Département de santé publique et spécialités connexe, UAO
2. INHP Bouaké
3. Département de santé publique et spécialités, UFHB
4. Université Alassane Ouattara, Bouaké

Introduction : Maladie contagieuse, endémo-épidémique, et à transmission interhumaine, la tuberculose est responsable d'une morbidité et une mortalité élevée.

Méthode : Nous avons réalisé une étude transversale prospective, descriptive et analytique au Centre anti tuberculeux (CAT) de Bouaké du 1er au 30 Juin 2023, auprès des tuberculeux et leurs contacts. Les données avaient été saisies et analysé à l'aide du logiciel SPSS 22.0.

Résultats : Nos enquêtés étaient constitués de 137 malades tuberculeux. Ils avaient un âge moyen de 36,32 ans, de sexe masculin (67,9%), non scolarisés (32,8%), de profession libérale (56,9%) et habitaient des cours communes (56,2%). Ils vivaient dans l'insalubrité (32,8%) et la promiscuité (51,9%). Ils avaient moins de 75000 francs CFA (58,3%). Ils avaient des contacts immédiats (91,2%) ; qui n'avaient aucun traitement (82,5 %). Ils considéraient la tuberculose comme une maladie grave (65,7%), contractée par contact avec un tuberculeux (43,1%). Ils avaient une tuberculose pulmonaire (79,2%). Ils connaissaient le port de masque (58,4%) et l'hygiène de la toux (13,9%) comme mesure de prévention, et s'étaient fait dépister du VIH (81,8%) et avaient le VIH (13,1%). Seuls 17,5% de leurs contacts étaient sous traitement. Ils prenaient régulièrement leur traitement (81,9%), et savaient que la mauvaise observance pouvait entraîner des complications (89,8%) telle une rechute (52,8%). Ils trouvaient l'accessibilité au CAT facile (79,6%) et l'accueil bonne (94,2%). Parmi eux 25,5% avaient fait une automédication. Ils étaient arrivés au CAT sur instruction d'un proche (53,3%). Pour ne pas contaminer leurs proches, ils portaient des masque (58,4%) et ne partageaient pas les couverts (73%). Ils existaient un lien statistiquement significatif entre : la présence de tuberculeux dans l'environnement immédiat et la maladie tuberculeuse.

Conclusion : Problème majeur de santé publique, son élimination pourrait reposer sur le dépistage et la mise en place d'une prophylaxie de tous les contacts

Mots clés : Tuberculose, tuberculeux, contacts, déterminants, élimination, CAT, Bouaké, 2023

[C081] Effets de la pandémie covid-19 et continuité des soins de santé sexuelle et reproductive à la maternité du Centre de Santé et de Promotion sociale de Wemtenga, au BURKINA-FASO.

Bationo Nestor¹, Kabore Ahmed¹, Ngangue Patrice², Drabo K. Maxime¹

1. Laboratoire de Santé Publique, UJKZ

2. Département de Santé publique, Université Laval

Introduction : Durant la pandémie de COVID-19, de nombreux services systématiques ou non urgents ont dû être différés ou suspendus dans les établissements de santé, y compris au Burkina Faso. L'objectif de cette étude était d'évaluer les effets du Covid-19 sur la continuité des soins de santé sexuelle et reproductive à la maternité du Centre de Santé et de Promotion Sociale (CSPS) de Wemtenga.

Méthode : Une étude phénoménologique combinée à une revue documentaire des indicateurs à différentes périodes de Covid-19 a été menée. Des entrevues individuelles semi-dirigées ont été conduites auprès de 30 participants. Une analyse de contenu des données collectées a été réalisée à l'aide du logiciel NVIVO version 12.

Résultats : L'étude révèle une offre constante des soins de santé sexuelle et reproductive avant et après l'avènement de la Covid-19. Les participantes avaient une bonne connaissance des mesures barrières, reconnues efficaces dans la lutte contre la covid-19. L'étude a révélé une baisse de la capacité d'accueil et de la demande de soins de la maternité en raison des contraintes liées aux mesures barrières, mais également par crainte du risque de contamination. Une différence significative au risque de 5% entre la demande globale de soins avant le confinement et celle pendant le confinement, de même qu'entre la demande globale de soins pendant le confinement et celle après le confinement a été rapportée.

Conclusion : Des stratégies de résilience en contexte de crises sanitaires devraient être développées afin de maintenir une continuité optimale des soins.

Mots clés : Covid-19, soins de santé sexuelle et reproductive, continuité des soins, Burkina –Faso.

[C082] Facteurs influençant la demande de Césarienne par convenance au Burkina-Faso : une étude qualitative

Bationo Nestor¹, Ngangue Patrice², Kabore Ahmed¹, Drabo K. Maxime¹

1. Laboratoire de Santé Publique, UJKZ

2. Laboratoire de Santé publique, Université Laval

Introduction : Au Burkina-Faso, le taux national de césarienne est d'environ 2,2%. Malgré les complications souvent reliées à la césarienne, il existe des cas de césarienne par convenance. L'objectif de cette étude est d'appréhender les facteurs influençant la césarienne par convenance, afin de contribuer à la réduction de la morbidité maternelle et néonatale.

Méthode : Une méthode qualitative à visée exploratoire a été privilégiée. L'entretien semi-dirigé, l'observation non participante, et la revue documentaire ont été combinées auprès de douze (12) patientes répondant aux critères de sélection. Les critères de rigueur sont la crédibilité, la transférabilité, la confirmation et la fiabilité.

Résultats : La tocophobie, le sentiment positif associé au pouvoir de la technologie, la relation médecin-patient et le cadre de la structure hospitalière en termes d'accueil, d'hygiène et de possibilité de demander la césarienne par convenance sont les principaux résultats.

Conclusion : Le choix de la césarienne par convenance est multifactoriel. Une stratégie d'information d'éducation et de communication sur les modes d'accouchement en fin de grossesse.

Mots clés : césarienne par convenance, étude qualitative, Burkina-Faso.

[C084] Facteurs de la sexualité précoce chez les adolescents scolaires dans la ville de Ouagadougou, au Burkina-Faso : Une étude qualitative

Bationo Nestor¹, Mayala Edouard², Ngangue Patrice³, Drabo K. Maxime¹

1. Laboratoire de Santé Publique, UJKZ

2. IFRISSE

3. Laboratoire de Santé Publique, Université Laval

Introduction : La question de la sexualité des adolescent(e)s est un sujet complexe qui suscite des débats notamment, les difficultés comportementales auxquelles ils sont confrontés. Ce travail porte sur les facteurs de la sexualité précoce chez les adolescents(e)s scolarisé(e)s dans la ville de Ouagadougou au Burkina Faso.

Méthode : Il s'est agi d'une étude qualitative. Les participants à l'étude comprenaient des élèves, des enseignants et des parents d'élèves qui répondaient aux critères de sélection. L'entrevue semi-directive, le focus group ont permis de collecter les informations auprès des participants. L'analyse des données a été faite grâce au logiciel NVIVO12 PLUS.

Résultats : Cette étude a inclus quarante-cinq (45) participants dont dix (10) parents, le moins âgé et le plus âgé avaient respectivement 28 et 57 ans., dix (10) enseignants dont l'âge minimal était de 27 ans et le maximal de 49 ans, vingt-cinq (25) élèves dont l'âge chronologique était situé entre 15 et 19ans. Les normes culturelles étaient les principaux facteurs prédisposants. L'éducation sexuelle et la mauvaise fréquentation constituaient les principaux facteurs facilitants tandis que la situation financière, les réseaux sociaux en étaient les facteurs renforçants.

Conclusion : La revue de la littérature montre que l'éducation sexuelle contribue à développer la pensée critique, la communication et la prise de décision qui permettent aux adolescent(e)s d'assumer la responsabilité de leur vie et de la contrôler. Cette étude a permis de faire ressortir les facteurs prédisposants, facilitants et renforçants influençant la sexualité précoce des adolescents(e)s scolarisés dans la ville de Ouagadougou au Burkina Faso. La prise en compte de ces résultats pourrait permettre une bonne planification pour la lutte contre la sexualité précoce des adolescent(e)s.

Mots clés : adolescent, milieu scolaire, sexualité précoce, Burkina-Faso

[C084] Facteurs de la sexualité précoce chez les adolescents scolaires dans la ville de Ouagadougou, au Burkina-Faso : Une étude qualitative

Bationo Nestor¹, Mayala Edouard², Ngangue Patrice³, Drabo K. Maxime¹

1. Laboratoire de Santé Publique, UJKZ

2. IFRISSE

3. Laboratoire de Santé Publique, Université Laval

Introduction : La question de la sexualité des adolescent(e)s est un sujet complexe qui suscite des débats notamment, les difficultés comportementales auxquelles ils sont confrontés. Ce travail porte sur les facteurs de la sexualité précoce chez les adolescents(e)s scolarisé(e)s dans la ville de Ouagadougou au Burkina Faso.

Méthode : Il s'est agi d'une étude qualitative. Les participants à l'étude comprenaient des élèves, des enseignants et des parents d'élèves qui répondaient aux critères de sélection. L'entrevue semi-directive, le focus group ont permis de collecter les informations auprès des participants. L'analyse des données a été faite grâce au logiciel NVIVO12 PLUS.

Résultats : Cette étude a inclus quarante-cinq (45) participants dont dix (10) parents, le moins âgé et le plus âgé avaient respectivement 28 et 57 ans., dix (10) enseignants dont l'âge minimal était de 27 ans et le maximal de 49 ans, vingt-cinq (25) élèves dont l'âge chronologique était situé entre 15 et 19ans. Les normes culturelles étaient les principaux facteurs prédisposants. L'éducation sexuelle et la mauvaise fréquentation constituaient les principaux facteurs facilitants tandis que la situation financière, les réseaux sociaux en étaient les facteurs renforçants.

Conclusion : La revue de la littérature montre que l'éducation sexuelle contribue à développer la pensée critique, la communication et la prise de décision qui permettent aux adolescent(e)s d'assumer la responsabilité de leur vie et de la contrôler. Cette étude a permis de faire ressortir les facteurs prédisposants, facilitants et renforçants influençant la sexualité précoce des adolescents(e)s scolarisés dans la ville de Ouagadougou au Burkina Faso. La prise en compte de ces résultats pourrait permettre une bonne planification pour la lutte contre la sexualité précoce des adolescent(e)s.

Mots clés : adolescent, milieu scolaire, sexualité précoce, Burkina-Faso

[C086] Adhésion des individus aux gestes barrières durant la COVID-19 au Burkina Faso : une enquête nationale.

Meda Ivlabèhirè Bertrand^{1,2}, Millogo Tieba³, Ouattara San Maurice⁴, Ouedraogo Henri Gautier^{1,2}, Kouanda Seni³

1. Département Biomédical et Santé Publique
2. Institut de Recherche en Sciences de la Santé, IRSS/CNRST
3. Institut Africain de Santé Publique, IASP
4. Groupe de Recherche Action en Santé, GRAS

Introduction : L'adhésion des populations aux mesures de prévention est déterminante dans la lutte contre une épidémie. Elle permet également de tirer des leçons pour faire face à d'éventuelles futures épidémies. Durant l'épidémie de COVID19, les études, en Afrique subsaharienne, ont été pour la plupart menées sur des échantillons issus des réseaux sociaux ou par téléphone ne garantissant pas la représentativité de populations largement illettrées. Cette étude avait pour objectif d'évaluer l'adhésion des populations aux gestes barrières dans la prévention de la COVID19

Méthode : C'est une étude transversale nationale conduite entre août et octobre 2021 auprès de 6592 ménages stratifiés selon les 13 régions du pays. Dans chaque ménage, un questionnaire a été administré à un adulte de 18 ans ou plus sur son adhésion au lavage des mains, à l'utilisation des désinfectants, au port du masque et à la distanciation sociale, au début de la pandémie et les 30 jours précédents l'enquête.

Résultats : Sur les 6592 personnes enquêtées, 24,9%, 18,1%, 26,3% et 11,9% avaient déclaré adhérer, tous les jours au début de la pandémie, au lavage des mains, à l'utilisation de désinfectants, au port du masque et à la distanciation sociale respectivement. Mais les 30 jours précédents l'enquête, elles n'étaient plus que 7,3%, 3,7%, 5,7% et 1,4% à adhérer tous les jours au lavage des mains, à l'utilisation des désinfectants, au port du masque et à la distanciation sociale respectivement.

Conclusion : L'adhésion de la population aux gestes barrières était faible au début de l'épidémie au Burkina Faso (mars-avril 2020) et elle s'est pratiquement effondrée avec le temps. Cette faible adhésion pourrait traduire le déni de la présence de la COVID19 dans le pays, renforcé en cela par le faible nombre de cas expérimentés par la population, et aussi l'inadéquation de la communication sur la COVID19

Mots clés : COVID19, Gestes barrières, Burkina Faso, Adhésion, Etude transversale

[C088] Prédiction du statut allergique lié aux immunoglobulines E totales chez les donneurs de sang

Oura Doris^{1,2}, Assi Aniela³, Moussa Salimata^{1,2}, Seri Jocelyne³, Adou Honore³, Koya Hebert⁴, Memel Roselle⁴, Kouacou Amah³, Yeboah Richard³, Siransy Liliane^{1,2}, Dasse Sery³

1. Laboratoire CNTS
2. Service d'immunologie faculté de médecine, UFHB
3. Service d'immunologie - allergologie CHU de Cocody
4. Service d'immunologie CHU de Bouaké

Introduction : Les immunoglobulines E(IgE) sont le support de l'hypersensibilité de type I. Leur taux s'élève dans le sang lors d'un contact avec un allergène mais aussi lors d'affections parasitaires telles que les helminthiases. Dans le contexte de la transfusion sanguine, au vu du risque d'accidents transfusionnels allergiques par transfert d'IgE ; nous avons jugé important d'identifier par un modèle prédictif les donneurs de sang présumés allergiques selon le taux des IgE totales afin de prévenir ce risque d'accident transfusionnel chez le receveur.

Méthode : Nous avons réalisé une étude prospective transversale à visée descriptive et analytique chez les donneurs de sang. Ceux-ci ont bénéficié de prélèvements de sang pour la réalisation de l'hémogramme, le dosage des immunoglobulines E totales et de prélèvement de selles pour l'examen parasitologique afin d'éliminer toute élévation des IgE totales d'origine parasitaire.

Résultats : Dans notre population d'étude faite de 102 donneurs de sang, 44% étaient de la tranche d'âge de [18-35 ans], l'on notait une prédominance masculine à 74,5%, et 35% des donneurs avaient un taux supérieur à 190 UI/mL. 63% des enquêtés avaient réalisé l'examen parasitologique des selles et seulement 2% présentaient une helminthiase. Il existait un lien significatif entre l'âge, le taux des polynucléaires éosinophiles et le taux des IgE totales. Le modèle prédictif établi était globalement significatif avec les facteurs que sont l'âge, le poids, les polynucléaires éosinophiles, le type de chambre, le type de sommier et la présence de plantes comme prédicteurs du taux des IgE totales donc du statut allergique du donneur.

Conclusion : Cette étude montre l'importance d'identifier les donneurs de sang atopiques, par l'utilisation d'un questionnaire spécifique et de poursuivre les bilans allergologiques par la réalisation du dosage des IgE spécifiques et des tests cutanés. Ceci afin de prévenir tout risque d'accidents transfusionnels allergiques chez le receveur.

Mots clés : Statut allergique, immunoglobuline E, donneurs de sang

[C090] Les effets de la gratuité de la planification familiale sur les dépenses médicales directes des utilisatrices : une étude post avec contrôle non équivalent

Meda Ivlabèhirè Bertrand^{1,2}, Kouanda Seni³

1. Département Biomédical et Santé Publique

2. Institut de Recherche en Sciences de la Santé, IRSS/CNRST

3. Institut Africain de Santé Publique, IASP

Introduction : Le Burkina Faso est l'un des premiers pays d'Afrique Subsaharienne à avoir adopté la gratuité de la planification familiale d'abord sous forme pilote dans deux régions en juin 2018 avant un passage à l'échelle un an plus tard. L'objectif de cette étude est d'estimer, pour la première fois, l'effet de cette gratuité sur les dépenses médicales directes des utilisatrices de la planification familiale.

Méthode : Une enquête transversale nationale a été conduite en décembre 2019 par exit interviews dans 242 formations sanitaires publiques sélectionnées aléatoirement. Le questionnaire concernait les paiements directs pour des dépenses couvertes par la gratuite. Les dépenses médicales directes des utilisatrices des régions sous gratuité ont été comparées au reste du pays en utilisant la régression linéaire multiple.

Résultats : Au total, 143 et 47 femmes respectivement des groupes contrôle et intervention ont été enquêtées. Dans les régions sous gratuité, 78,7% des utilisatrices n'avaient rien payé contre 6,3% pour le reste du pays ($p < 0,001$). En ajustant pour l'âge, le milieu de résidence, le quintile socioéconomique, le niveau d'éducation, le type de formation sanitaire et le type de méthode contraceptive, la gratuité était associée à une diminution de 825 FCFA (IC95% : 530 – 1125) des dépenses médicales directes liées à la planification familiale. Ainsi, une utilisatrice de planification familiale payait en moyenne 225 FCFA (IC95% : 0 – 480) dans les régions sous gratuité contre 1050 FCFA (IC95% : 915 – 1190) pour le reste du pays. Dans les régions sous gratuité, les paiements directs étaient constitués exclusivement des coûts des soins et des médicaments tandis que dans le reste du pays, de façon décroissante, les médicaments, les soins, l'acte et les examens représentaient les dépenses directes.

Conclusion : La gratuité de la planification familiale est positivement associée à une réduction des dépenses médicales directes même si des paiements résiduels subsistent appelant à la vigilance.

Mots clés : Burkina Faso, Politique de gratuité, Planification familiale, Dépenses médicales directes

[C094] Analyse du problème de la qualité des données de surveillance, District sanitaire Dimbokro, Côte d'Ivoire, Avril 2023

Kone Zié Seydou¹

1. District sanitaire de Dimbokro

Introduction : Le Contrôle Qualité des Données, (CQD) à travers l'analyse SWOT nous a permis de mettre en évidence plusieurs insuffisances. Au vu de ces faiblesses, l'équipe cadre du district pense que le problème majeur de la qualité des données de surveillance serait : « La faible implication des agents de santé dans la surveillance épidémiologique au district sanitaire de Dimbokro ».

Méthode : Une étude descriptive qualitative a été menée en avril 2023. De façon raisonnée 17 acteurs impliqués dans la surveillance ont été choisis pour un focus groupe. A l'aide d'un ordinateur, un vidéoprojecteur, un papier pad ex, les causes ont été identifiées par brainstorming. Ces causes ont été catégorisées et présentées à travers le diagramme d'Ishikawa ou arête de poisson et classifiées selon la méthode de priorisation de problème (TPN) en santé publique.

Résultats : Plusieurs causes secondaires au problème principal ont été identifiées, et à l'aide de la méthode de priorisation de problème suivant le degré de contrôle, L'absence d'intégration de la surveillance dans les grilles de supervisions intégrées a été identifiée comme étant la cause critique de la faible implication des agents de santé dans la surveillance. L'intégration effective de la surveillance dans les grilles de supervisions formatives régulières s'avère être la solution majeure de la cause critique. Mais également le renforcement des capacités des agents impliqués dans la surveillance.

Conclusion : la cause critique du problème et les causes secondaires ont été identifiées. La surveillance épidémiologique a été intégrée à la grille de supervision T1 2023. Les capacités des agents ont été renforcées lors de la réunion mensuelle du mois d'Avril. Les outils manquants tels que les directives, les définitions des cas et la liste des MDO ont été distribués.

Mots clés : Qualité, Brainstorming, Analyse, problème, Surveillance, Cause, Supervision, Dimbokro

[C095] Evaluation des effets de l'assurance maladie (AM) du projet assurance du renforcement du capital humain (ARCH) sur l'utilisation effective des services de santé dans la zone sanitaire Djougou/Copargo/Auake. (Benin) du 1er janvier 2020 au 31 décembre 2022

Houkpe Virgile Olivier¹, Agossoukpe Benoît², Missiako Barnabé³

1. Direction Départementale du Borgou/Bénin

2. Bureau OMS / Bénin

3. Zone sanitaire Djougou-Copargo-Ouaké

Introduction : Le volet AM-ARCH a démarré par une phase pilote dans sept communes de trois zones sanitaires au Bénin et a consisté à assurer une prise en charge sanitaire gratuite pour la partie de la population considérée comme étant extrêmement pauvre. Après 02 ans de mise en œuvre, nous avons décidé d'apprécier les effets de ce dispositif sur l'utilisation des services par les bénéficiaires dans la zone sanitaire Djougou/Copargo/Ouaké.

Méthode : Nous avons mené une étude descriptive transversale utilisant les données quantitatives et qualitatives du 1er janvier 2020 au 31 décembre 2022. Les rapports SNIGS et les données collectées auprès de 76 personnels soignants et 212 bénéficiaires ont servi à décrire et à analyser l'effet de l'AM-ARCH sur l'utilisation des services. Les acteurs ont été interrogés à l'aide d'un questionnaire élaboré dans l'outil kobocollect. Les données ont été analysées avec Epi info 7.2 pour calculer les fréquences.

Résultats : Le taux d'utilisation des services par les pauvres extrêmes a varié entre 28% et 11% avec un pic les premiers mois du début de la phase pilote. La tranche d'âge de 0 à 10 ans a le plus fréquenté (55%) les services. Les affections les plus fréquentes étaient le paludisme (64%), les accouchements (17%) et les infections digestives (12%). Le coût moyen par cas est de 1567 FCFA (Centre de santé) et 13455 FCFA (hôpitaux). 27% des affections étaient hors paniers et sont majoritairement les maladies non transmissibles et les pneumopathies. Les facteurs associés à la baisse progressive de l'utilisation des services étaient l'insuffisance de communication, le contenu du panier de soins très limitatif et le mauvais accueil.

Conclusion : Ce travail souligne la nécessité d'élargir le panier de soins, de renforcer la communication, de prendre en compte d'autres facteurs de recours aux soins et d'améliorer la qualité de l'accueil des bénéficiaires

Mots clés : assurance maladie, couverture universelle santé, ARCH, évaluation, utilisation des services de santé, facteurs, Donga, Bénin

[C096] Flambée de diarrhée au district sanitaire de Cocody-Bingerville, Côte d'Ivoire, février 2023

Ese N'gbesso Roland Baudouin¹, C. Kouame, P. Wilnique, J. Otshudiandjeka, I. Tiembre, J. Benie

1. Chargé de la Surveillance épidémiologique, District Sanitaire de Cocody-Bingerville

Introduction : 12 février 2023, le district sanitaire de Cocody-Bingerville a été alerté par la pharmacie Saints André et Marthe d'une demande élevée de personne de l'aire desservie fréquentant leur pharmacie pour des épisodes de diarrhées. Etant informé, le district sanitaire Cocody-Bingerville a constitué une équipe pour mener une investigation afin de trouver la source, identifier la cause à cette diarrhée et proposer des mesures de préventions et de contrôle.

Méthode : Etude transversale à visée descriptive a été menée. Cas suspect est défini comme toute personne vivant dans la cité d'Adjamé-Bingerville, présentant plus de 3 dépositions diarrhéiques par jour au cours de la période du 10 au 14 février 2023. Cas confirmé : Isolement de germe sur les échantillons prélevés. Un questionnaire semi-structuré a été utilisé. Les variables sociodémographiques, cliniques et facteurs de risques ont été pris en compte. Des prélèvements de selles et d'eau de boisson ont été faits. Les données collectées ont été saisies et analysées sur Excel et Epi-Info 7.2. Les mesures de tendances et de fréquences ont été calculées.

Résultats : Résultats : Au total 26 cas de diarrhées ont été identifiés, pour un taux d'attaque de 0,65% (26/4000) Aucun décès n'a été déclaré. L'âge médian est 16 ans (1-30). Le ratio homme/femme est de 1 :1. Pour les signes cliniques la diarrhée représentait 100% (26/26) de cas, suivant de la douleur abdominale avec 61,5% (16/26) de cas pu été investigués. Les 26 cas ont fait des selles de plus de 5 fois par jour. La majorité des cas provenait de la localité appelée nouvelle gare avec 76,9% (20/26) de cas. L'interrogatoire a révélé une suspicion de consommation d'eau courante présentant une coloration anormale. Les résultats des prélèvements réalisés sont en cours.

Conclusion : Létalité nul. Les jeunes enfants sont plus affectés et habitent en majorité dans la localité de nouvelle-gare. Pas de différence entre les deux sexes. Contamination possible de l'eau potable. Adoption des mesures d'hygiènes et traitement de l'eau de boisson. Réalisation d'une étude supplémentaire dans cette communauté.

Mots clés : Toxiinfection, Alimentaire, Bingerville, Cote d'Ivoire

[C097] Profil Epidémiologique de la rougeole dans la région sanitaire du Béré, Cote d'Ivoire, Janvier 2021-Juin 2023

Koffi Koidio Marcel Venance¹

1. Direction Régionale de la santé du Béré

Introduction : La rougeole maladie infectieuse contagieuse qui constitue en Côte d'Ivoire un problème de santé publique. La rougeole a été mise sous surveillance dans le but de déterminer son ampleur, détecter à temps les épidémies et apprécier les efforts pour son élimination. Aucune analyse approfondie n'a été réalisée sur les données de rougeole dans le Béré depuis sa création. L'objectif de cette étude est de décrire l'aspect épidémiologique de la rougeole dans le Béré pour des recommandations appropriées.

Méthode : Une étude transversale descriptive a été menée du 1er Janvier 2021 au 30 Juin 2023. Les données secondaires ont été extraites de plateforme de surveillance MAGPI. Les variables sociodémographiques, cliniques et statut vaccinal ont été collectés. Les données ont été traitées sur Excel et analysées sur Epi-Info 7. Des mesures de tendances, fréquences et proportions ont été calculées.

Résultats : 217 cas suspects notifiés dans le Béré dont 18 confirmés (taux de positivité 12% (18/217). Aucun décès enregistré. L'âge médian 3 ans (0-56). Le sexe ratio Homme/Femme 1,49. Les enfants de 1-5 ans les plus affectés 61% (132/217). Seulement 32% des cas vaccinés. Deux enfants parmi les cas confirmés sont vaccinés (11 %) et Dix sont de statut inconnu (56%). Une augmentation des cas au 1er trimestre de chaque année. Le district Kounahiri a l'incidence la plus élevée (0,009%).

Conclusion : Flambées de rougeole constatée au 1er trimestre de chaque année avec survenu chez les enfants vaccinés. La tranche d'âge de 1 à 5 ans et le sexe masculin sont les plus affectés. Faible couverture vaccinale. Il convient de renforcer les capacités du personnel soignant à la surveillance épidémiologique, de sensibiliser les parents et d'organiser des campagnes de vaccination en fin d'année. Conduire des études analytiques sur la survenue de rougeole sur les enfants vaccinés.

Mots clés : Surveillance, Rougeole, Béré, Côte d'Ivoire

[C098] Investigation de cas de rougeole à Fassapla, District Sanitaire Kounahiri, Côte d'Ivoire, Mars 2023.

Koffi Koidio Marcel Venance¹

1. Direction Régionale de la santé du Béré

Introduction : La rougeole, maladie virale respiratoire très contagieuse. En Côte d'Ivoire, 6545 cas suspects de rougeole notifiés en 2022 ce qui fait de la rougeole un problème de santé publique. Le jeudi 23 mars 2023, deux cas suspects notifiés par le District de Kounahiri sont revenus positifs. Une investigation a été menée autour de ces cas confirmés afin d'analyser la situation épidémiologique, déterminer l'ampleur de la flambée et mettre en place des mesures préventives et de contrôle.

Méthode : Une étude descriptive a été menée les 27 et 28 Mars 2023 à Fassapla, village situé dans le District de Kounahiri. Les définitions de cas suspects et confirmés de rougeole du SIMR ont été utilisées. Une liste linéaire a été élaborée et utilisée pour la recherche active des cas. Les caractéristiques sociodémographiques, cliniques et le statut vaccinal ont été pris en compte. Les données ont été collectées et analysées sur Excel. Des mesures de fréquences ont été calculées.

Résultats : Au total, 13 cas suspects dont 02 confirmés au laboratoire. Il s'agit de 2 enfants de sexe opposé âgés respectivement de cinq et dix ans, vaccinés. 05 personnes contacts vivaient sous le même toit dont 3 d'entre elles vaccinées. Parmi les 06 autres cas restant, 2 sont vaccinées. Les enfants non vaccinés représentent 46 % des cas soit une moyenne couverture vaccinale dans cette zone. L'âge médian est 7 (1-11) ans. Le sexe féminin représente 62% des cas suspects (8/13). La tranche d'âge de 5-10 ans est la plus représentée (50%).

Conclusion : Absence d'épidémie de rougeole. Faible couverture vaccinale. Une sensibilisation de la population sur le respect du calendrier vaccinal a été faite suivie d'une riposte vaccinale pour les enfants de 0 à 10 ans dans l'aire sanitaire de Fassapla.

Mots clés : Investigation, épidémie, rougeole, Fassapla, Côte d'Ivoire

[C101] Motivations et accessibilité du vaccin chez les personnes ayant reçu le vaccin contre la Covid-19 à Makokou au Gabon

Ulrick Jolhy Bisvigou^{1,2,3}, Sydney Maghendji^{1,2}, Euloge Ibinga^{1,2}, Edgard Brice Ngoungou^{1,2}

1. Département d'Épidémiologie, Biostatistiques et Informatique Médicale/Santé Publique, Médecine du Travail et Médecine Légale, Faculté de Médecine, Université des Sciences de la Santé, BP 4009, Libreville, Gabon

2. Unité de Recherche en Épidémiologie des Maladies Chroniques et Santé Environnement, Faculté de Médecine, Université des Sciences de la Santé, BP 11587, Libreville, Gabon

3. Centre Hospitalier Régional Bongo Ondimba de Makokou, Psychologue clinicien – Makokou –Gabon

Introduction : La vaccination, moyens de riposte contre la pandémie à Covid-19, a été à l'origine de controverse, hésitation et infodémie dans le monde. Le Gabon s'est lancé dans la vaccination de ses populations au mois de juillet 2021. C'était l'opportunité de décrire les motivations des volontaires, leurs connaissances et niveaux d'acceptation.

Méthode : Une étude transversale descriptive a été menée de mai 2021 à janvier 2022, au sein de l'unique centre de vaccination contre la Covid-19 de Makokou, région sanitaire Est du Gabon. Les volontaires étaient inclus durant leur parcours de vaccination, répondant à un questionnaire lors d'une interview face à face. Ont étudiés le profil sociodémographique, les connaissances de la maladie et du vaccin, les perceptions et l'accessibilité.

Résultats : Au total, 323 personnes ont été interrogées. Elles étaient âgées de 18 à 71 ans, majoritairement entre 30 et 40 ans (120 soit 39%). Le sex ratio était de 2,7. La majorité des participants (86%) était gabonais, vivant à Makokou pour une médiane de séjour de 6 ans. Les professions les plus représentées étaient le personnel de santé (54 soit 18%) et les forces de défense et sécurité (48 soit 16%), cibles principales du programme. Les niveaux d'étude étaient universitaires (130 soit 43%) ou secondaire (118 soit 39%). Les principales sources d'information étaient les media (245 soit 83%) et le personnel médical (168 soit 57%). La vaccination était perçue comme une contrainte dans 51 % des cas. Les situations considérées comme gênantes étaient la longue attente 124 (66%), la longueur des procédures 71 (38%).

Conclusion : Un climat de confiance entre autorités sanitaires, personnel de santé et population est indispensable pour améliorer les couvertures vaccinales. La pandémie à Covid-19 est venu démontrer le rôle central des médias dans la motivation et l'acceptation de la vaccination comme mesures de prévention des maladies.

Mots clés : Connaissances attitudes et pratiques, Covid-19, motivation, hésitation vaccinale, media, Gabon

[C102] Analyse SWOT d'un projet de sante et développement dans quatre communautés rurales en côte d'ivoire

Hounsa Alla Annita¹, Coulibaly Madikiny², Aka Desquith Angèle¹, Sackou Kouakou Julie¹, Kouadio Luc¹

1. Filière Santé Publique et développement

2. Institut National de Santé Publique

Introduction : La participation des communautés à la prise en charge de leurs problèmes de santé a été énoncée dans les Soins de Santé Primaires à Alma Ata en 1978 et renforcée à Astana en 2018. Cependant, la majorité des programmes de santé conçue pour les communautés intègre peu les aspects qui les mobilisent autour de leurs centres d'intérêt. L'objectif de cette étude était de montrer l'intérêt de la participation communautaire dans la mise en œuvre d'un projet de santé et développement par une analyse SWOT.

Méthode : Le projet Santé Engagement Communautaire (SEC) a été mis en place en 2014 dans les villages de Kodjokro et Motobé. Il s'est par la suite étendu en 2020 aux communautés de Kouassiblékro et Frambo, Ces communautés sont situées dans les districts sanitaires d'Adiaké et Alépé. Le projet se déroule en 5 étapes : sensibilisation, mobilisation, sélection et formation des membres du comité de gestion et des Agents SEC, et mise en œuvre des activités de développement et de recherche. Une analyse SWOT (forces, faiblesses, opportunités et menaces) a été réalisée par 3 membres de l'équipe de formateurs en septembre 2023

Résultats : Les principales forces identifiées étaient le diagnostic de pathologies échappant au système de santé périphérique : la hernie inguino-scrotale et les affections bucco-dentaires. D'autres aspects étaient la création de la case santé, la mise en place de l'agriculture biologique et le renforcement des capacités des communautés. Les faiblesses étaient le lent engagement des communautés et leur réticence dans la mise en place des associations d'épargne et de crédit. Les opportunités étaient la possibilité de signer une convention avec la Direction de la Santé Communautaire. Enfin les menaces étaient les conflits entre les villageois et la Chefferie.

Conclusion : Un projet de santé et développement est une opportunité pour adresser les défis sanitaires et assurer l'autonomisation des communautés rurales.

Mots clés : Analyse SWOT, Autonomisation, Communautés rurales, Défis sanitaires, Développement communautaire

[C103] Evaluation de mise en œuvre de l'approche qualité « 5S KAIZEN TQM » à l'Hôpital de Zone de Ouidah-Kpomassè-Tori Bossito en 2023

Degbey Cyriaque Comlan¹, Sossa-Jerome Charles¹, Djitohou Boris Pacem¹, Kpozehouen Alphonse¹, Glele Ahanhanzo Yolaine¹, Paraïso Moussiliou Noël¹

1. Institut Régional de Santé Publique –Université d'Abomey-Calavi –BENIN

Introduction : La recherche de la qualité des soins et services est un défi pour toute structure de santé. Pour faire face à ce défi, l'hôpital de zone Ouidah-Kpomassè-Tori Bossito a adopté l'approche qualité « 5S KAIZEN TQM » depuis 2012. Cette étude avait pour objectif d'évaluer la mise de cette approche.

Méthode : Il s'agissait d'une étude transversale descriptive et évaluative qui s'était effectuée en 2023. Trois techniques de collecte notamment l'entretien, l'enquête par questionnaire, l'observation et la recherche documentaire ont été utilisées pour collecter les données respectivement auprès les personnes ressources, les clients internes et externes, les services de l'hôpital et les documents relatifs à la mise en œuvre de l'approche

Résultats : Les principaux résultats ont montré que la mise en œuvre de l'approche est assez satisfaisante avec les scores respectifs de 80%, 67,11% et 86,28% pour les composants contextes, intrants et résultats.

Conclusion : L'approche qualité 5S KAIZEN TQM est efficace pour l'amélioration de la qualité des soins et services et la mise en œuvre de cette approche souffre de quelques insuffisances.

Mots clés : Evaluation, qualité, 5S, KAIZEN, TQM, hôpital, Ouidah.

[C104] Towards the establishment of a national public health institute in Cameroon

Chanceline Bilounga Ndongo^{1,2}, Christie Tiwoda¹, Linda Ezzo^{1,3}, Sue Binder⁴, Fatima Ravat⁴, Armelle Ngomba^{1,2}, Bernard Metogo⁵, Georges Nguefack-Tsague³, Léon Jules Owona Manga², André Bitia Fouda², Georges Etoundi Mballa Linda Ezzo^{1,3}

1. Department for the Control of Disease, Epidemics and Pandemics, Ministry of Public Health, Yaounde, Cameroon
2. Faculty of Medicine and Pharmaceutical Sciences, University of Douala, Cameroon
3. Faculty of Medicine and Biomedical Sciences, Université of Yaounde I, Cameroon
4. International Association of National Public Health Institute
5. Ministry of Public Health

Introduction: The emergence of COVID-19 pandemic has urged the need to establish a National Institute of Public Health (NPHI) as a coordination platform of public health activities. This work describes the steps taken by Cameroon to establish a NPHI.

Method: With the support International Association of National Public Health Institute (IANPHI) in 2018, many consultation meetings were conducted in three major phases. The objective was to identify the challenges of setting up a NPHI.

Results: First, the project was presented to the leadership of Ministry of Public Health (MOH) to ensure political commitment. It was raised out that most of the core functions of a NPHI already exist in Cameroon but are scattered in various departments with duplication of activities in a context of scarced resources. Secondly, meetings were organized with the main technical and financial partners and related scientific organizations. The need for coordination of activities and resources made available was emphasized by all. The lack of visibility of some data collected and researches conducted by partners in the country was also an issue. The scientific societies also mentioned not being consulted for decisions making by the MOH. The third phase was a workshop with the main departments of MOH. The vision is a Center of excellence that addresses major public health issues in Cameroon and contributes effectively to improve the health of population. Among the ten core functions recommended by Africa CDC, it was agreed to start with four as follow: preparedness, detection and response including surveillance and laboratory; advocacy, communication, and social mobilization; public health workforce development and operational research.

Conclusion: The establishment of a NPHI in Cameroon is ongoing for a better preparation and response to public health emergency. Through discussions, it was highly recommended that the NPHI would be a fully integrated scientific and technical structure inside the MOH.

Keys Words : Coordination, National Public Health Institute, Public Health Emergency

[C105] Évaluation de la mise en œuvre de la prévention et contrôle des infections à l'Hôpital de Zone d'Allada en 2023

Degbey Cyriaque Comlan¹, Hounkpe Dos Santos Bella¹, Abdallah Harda Bienti¹, Kpozehouen Alphonse¹, Glele Ahanhanzo Yolaine¹, Paraïso Moussiliou Noël¹

1. Institut Régional de Santé Publique -Université d'Abomey-Calavi –Bénin

Introduction : La sécurité du personnel soignant et des patients devient un défi majeur en matière de pratique médicale et risques liés aux soins de santé. Cependant, la prévention et contrôle des infections (PCI) ciblent à la fois les infections communautaires et celles associées aux soins (IAS), et les actions promouvant le bon usage des antibiotiques. Notre étude avait pour objectif d'évaluer la mise en œuvre de la PCI dans l'hôpital de Zone ATZ en 2023.

Méthode : Il s'agissait d'une étude rétrospective transversale descriptive évaluative qui a été réalisée en 2023 à l'hôpital de zone d'Allada-Tofo-Zè. Les cibles primaires étaient les différents services de santé de cet hôpital, le personnel soignant, le personnel d'entretien. Les cibles secondaires étaient constituées du personnel administratif et des clients externes. Elles ont été choisies par les techniques de choix raisonné et de commodité. La mise en œuvre de la PCI a été évaluée en tenant compte des composantes structures, processus et résultats selon les normes et objectifs définis par le pays.

Résultats : 16 services ont été évalués, la structure a été jugée acceptable avec un score de 61,71%. Le processus a été jugé acceptable avec un score de 64,06%. Les résultats ont été jugés insuffisants. Entre autres plusieurs insuffisances ont été révélées à savoir l'absence d'élaboration et de validation d'un plan de lutte anti-infectieuse, l'insuffisance des ressources humaines ainsi que l'absence de dispositifs de lavage des mains (DLM).

Conclusion : Au terme de l'étude, la mise en œuvre de la PCI dans l'hôpital de zone ATZ a été classée insuffisante, sur la base de l'analyse logique du score global obtenu à travers la « structure », » le processus » et le « résultat ». Cela signifie que l'accent devrait être mis sur la pratique de l'hygiène des mains favorisée par la formation, la disponibilité des ressources favorables à la pratique (DLM) pour une amélioration significative.

Mots clés : Evaluation, Prévention et Contrôle des Infections, Antibiorésistance, Hôpital de zone, Allada, Bénin

[C108] Le financement basé sur la performance : utilisation des services de santé dans le district sanitaire de Makélékélé au Congo Brazzaville.

Mavoungou Yvonne Valerie Yolande¹, Mangani Chancel Arnold¹, Odzebe Severin Wenceslas Anani¹

1. Faculté des Sciences de la Santé, Université Marien Ngouabi, Brazzaville, Congo

Introduction : Le Financement Basé sur la Performance (FBP) est une importante réforme de management du système santé, pour améliorer la qualité, l'efficacité et l'équité des soins. L'effet recherché est d'accroître l'utilisation des services de santé dans les formations sanitaires. L'objectif de ce travail était d'évaluer l'efficacité du Financement basé sur la performance dans le district sanitaire de Makélékélé au Congo Brazzaville

Méthode : Il s'agit d'une étude rétrospective avec collecte des données de janvier 2014 à décembre 2020 dans les 7 centres de santé du district de Makélékélé, lesquels ont bénéficié du FBP de 2016 à 2018. Les taux annuels d'utilisation de la consultation curative, de la consultation des enfants de moins de 5 ans, de la première consultation prénatale, et celui des accouchements assistés ont été étudiés. Les taux moyens d'utilisation des services ont été comparés avant et pendant le PBF puis pendant et après le FBP avec un test Z au seuil de significativité de 5%.

Résultats : Pendant le PBF, une hausse significative de l'utilisation de la consultation curative (+14%) et de la première consultation prénatale (+7%) a été notée, ce constat a été suivi d'une baisse à l'arrêt du FBP respectivement de -9 % et -8% ($p < 0,05$). Les accouchements assistés ont été augmentés (+13% ; $p < 0,05$) pendant le FBP et maintenu (+1% ; $p > 0,05$) après le FBP. La consultation des enfants de moins de 5 ans a connu une hausse (+1%) non significative pendant le PBF mais s'est accrue après le FBP (+53% ; $p < 0,05$).

Conclusion : L'effet du FBP sur l'utilisation des services de santé est variable, l'impact global dans les formations sanitaires est ainsi très mitigé. Le maintien des tendances croissantes acquises avec le FBP reste un défi majeur. Des études complémentaires approfondies sont nécessaires

Mots clés : Financement basé sur la performance, utilisation des services, district sanitaire, Makélékélé, Congo Brazzaville

[C109] Vaccination dans un service du pev : croyances des parents accompagnateurs d'enfants

ttoh-Toure Harvey¹, Abina Audrey Marie-Michelle¹, Noufe Soualihou², N'guessan Konan², Oussou Roland¹, Ayeva-Adam Edwige², Soumahoro Zakaria, Tiembre Issaka¹

1. Département de Santé publique et Spécialités

2. Institut National d'Hygiène Publique

Introduction : Les couvertures vaccinales en Côte d'Ivoire demeurent insuffisantes. Dans le but d'identifier des actions concrètes de communication visant à accroître la couverture vaccinale du PEV, nous avons décidé d'étudier les connaissances et les croyances des parents d'enfants.

Méthode : Il s'est agi d'une étude mixte transversale à visée descriptive portant sur les parents de nourrissons à l'unité du Programme Elargi de Vaccination (PEV) de l'Institut National d'Hygiène Publique (INHP). L'étude s'est déroulée du 1er Mars 2023 au 31 Mai 2023. Le recueil des données s'est fait à partir d'entretiens en face à face, effectués à l'aide d'un questionnaire anonyme.

Résultats : Nous avons enquêté au total 384 parents de nourrissons. Le niveau de connaissance des maladies cibles du PEV était faible (92%). La plupart avait des enfants complètement vaccinés (81%) et la survenue d'effets indésirables était corrélée à la complétude vaccinale. Les menaces liées à la non vaccination et les avantages d'une vaccination correcte, étaient perçus respectivement par 84,1 et 95,6% des parents. Néanmoins, les rumeurs, la survenue d'effets indésirables (50,5%) et le nombre élevé de doses au cours d'une même séance (47,5%) constituaient un obstacle pour certains parents. Cependant la quasi-totalité des parents a reconnu la nécessité de la vaccination soit 99,5% et ils adhéraient aux conseils en matière de vaccination (82,3%).

Conclusion : Le niveau de connaissance était faible parmi les parents accompagnateurs d'enfants. Les rumeurs, les effets indésirables ainsi que les croyances erronées, amplifiées par l'avènement de la vaccination contre la Covid-19 constituaient un obstacle à la vaccination, qu'il faille lever.

Mots clés : Vaccination PEV, parents accompagnateurs, croyances, connaissances

[C110] Comportements des étudiants hospitaliers de l'UFR des sciences médicales d'Abidjan en matière de santé

Abina Audrey Marie-Michelle¹, Attoh-Toure Harvey¹, N'guessan Konan², Noufe Soualihou², Oussou Roland¹, Ayeva-Adam Edwige², Konan Kwakou Maximin, Dagnan Simplicie¹

1. Département de Santé publique et Spécialités

2. Institut National d'Hygiène Publique

Introduction : La santé des étudiants en médecine est souvent précaire. Peu d'études ont été réalisées sur ce sujet dans notre pays. Dans le but de contribuer à l'amélioration de leur santé, nous avons entrepris d'évaluer les comportements en matière de santé des étudiants hospitaliers de l'UFR des Sciences Médicales d'Abidjan.

Méthode : Il s'est agi d'une étude transversale à visée descriptive portant sur les étudiants inscrits en Doctorat 2 de Médecine à l'UFR des Sciences Médicales d'Abidjan. Le recueil des données a été effectué à l'aide d'un questionnaire électronique en ligne, distribué via une application de messagerie instantanée (WhatsApp).

Résultats : Nous avons enregistré au total 384 étudiants. L'âge moyen était de 27,2 ans avec une prédominance masculine 85,7%. La majorité des étudiants, soit 90,6%, affirmaient avoir un bon état de santé général et 6,8% avaient des problèmes psychologiques à type de dépression. Le bon état de santé était associé au sexe masculin, à la vie en cité universitaire, à la présence d'une assurance maladie et à la consommation de fruits. Au niveau du comportement des étudiants, on enregistrerait chez 26% d'entre eux, des rapports sexuels non protégés, une consommation régulière d'alcool chez 22,4 % et les consommateurs de tabac en représentaient 2,3%. La toxicomanie concernait 1% des étudiants en médecine. Une proportion de 70,8 % n'avait pas d'assurance maladie. Les besoins de santé exprimés étaient, dans 97,6% des cas, celui d'avoir une assurance médicale spéciale pour étudiants en médecine et pour 2,3%, celui de bénéficier d'une gratuité pour la vaccination des étudiants en médecine.

Conclusion : Les étudiants adoptaient des comportements de santé à risque. Des stratégies visant à promouvoir la santé en milieu universitaire devraient être élaborées et mises en œuvre.

Mots clés : comportements, santé, étudiants, sciences médicales

[C111] Respect du schéma vaccinal contre l'hépatite virale B à la naissance au service PEV du CMSSTEJ de Koumassi : facteurs associés

Abina Audrey Marie-Michelle¹, Attoh-Toure Harvey¹, N'guessan Konan², Noufe Soualihou², Oussou Roland¹, Ayeva-Adam Edwige², Kanga Massianou N'da, Tiembre Issaka¹

1. Département de Santé publique et Spécialités

2. Institut National d'Hygiène Publique

Introduction : Le retard de vaccination dans l'enfance contre l'hépatite B observé, devient préoccupant car pouvant être la cause d'affections chroniques à l'âge adulte. Nous avons donc recherché les facteurs associés à ce retard de vaccination chez les mères fréquentant l'unité PEV du CMSSTEJ de Koumassi.

Méthode : il s'agissait d'une étude transversale à visée analytique portant sur les accompagnateurs de nourrissons, fréquentant l'unité PEV du CMSSTEJ de Koumassi. Les données ont été collectées à partir d'un questionnaire anonyme, permettant de recueillir les paramètres étudiés notamment l'administration de la dose de naissance (DN). La saisie et l'analyse des données ont été effectuées avec les logiciels Word, Excel et Épi info.

Résultats : Nous avons enquêté 384 accompagnants essentiellement des mères (99,7%) avec une moyenne d'âge de $28 \pm 6,37$ ans, vivant pour la plupart en couple (78,1%) et provenant de différentes communes. Ces mères avaient en majorité accouché par voie basse (75,8%) et n'avaient pas bénéficié d'hospitalisation (82%). Celles ayant connaissance notamment, de la maladie de la vaccination et du schéma vaccinal, en représentaient respectivement 38%, 27,1% et 5,5%. Pourtant 65,9% des enfants étaient vaccinés dans les 24h comme le recommandait l'OMS et 72,2% dans les 72h comme le recommande la DCPEV. L'hospitalisation des mères impactait le respect du schéma vaccinal. La connaissance du calendrier vaccinal était liée significativement au respect de la vaccination.

Conclusion : Une bonne sensibilisation et une bonne communication sur l'hépatite B contribueront à un meilleur respect du schéma vaccinal contre cette maladie.

Mots clés : Facteurs, Respect, Vaccination, Hépatite B, Naissance

[C114] Investigation des cas de rougeole dans le village de Soungbonon Bambarasso, District Sanitaire Dabakala, Côte d'Ivoire, Mai 2023

Ouattara Issouf, Y. Kouyate, W. Pierre, J. Otshudiandjeka, I. Tiembré

Introduction : A la semaine 18, 32 cas suspect notifié par le District de Dabakala dont 11cas notifié par l'aire sanitaire de M'borla-Dioulasso et un (1) cas est revenu positif. Une investigation a été menée dans l'objectif de décrire le cas confirmé.

Méthode : Une étude descriptive a été menée a la semaine 19, 2023 à Soungbonon Bambarasso village situé dans l'aire sanitaire de M'borla-Dioulasso, District Sanitaire de Dabakala. Les définitions de cas suspects et confirmés de rougeole du SIMR ont été utilisées. Une liste linéaire a été élaborée et utilisée pour la recherche active des cas. Les caractéristiques sociodémographiques, les informations cliniques et le statut vaccinal du cas confirmé, des contacts et les cas de rumeurs ont été considérées. Les données ont été collectées sur support papier et analyser sur Excel et Epi-Info 7, calculant les mesures de fréquences.

Résultats : Enfant âgé de cinq, sexe féminin, ayant été vaccinée, avec aucun signe de la maladie au moment de l'enquête et la maman aurait quitté un village d'orpaillage. Trois personnes contacts vivant sous le même toit dont 1(33%) hommes et 2 (67%) femmes. Deux (2) personnes d'entre elles soit 67% ont eu un statut vaccinal inconnu. De même, la recherche de cas des rumeurs de rougeole a permis de recenser (02) cas suspects, 2(100%) femme. La tranche d'âge variait de 1 à 5 ans avec 91% de couverture vaccinale.

Conclusion : Non existence d'épidémie de rougeole. Remarque d'une faible couverture vaccinale. Absence de nouveau cas de rougeole. Il a été recommandé de faire vacciner tous les enfants de 0 - 5 ans autour du ménage et de respecter le calendrier vaccinal.

Mots clés : Rougeole, Investigation, Soungbonon Bambarasso, Côte d'Ivoire

[C116] Evaluation des connaissances et pratiques des sage-femmes d'Abidjan (Côte d'Ivoire) au sujet du traitement préventif intermittent en 2021

Dou Gonat Serge Pacôme¹, Nassoué Dobré Maryse Olivia¹, Aka NA¹, Adjo Guy Landry¹, Tamboura Mariétou Timité Adiaffi¹, Adoubryn Koffi Daho²

1. Laboratoire de Parasitologie Mycologie UFR des Sciences Médicales d'Abidjan

2. Laboratoire de Parasitologie Mycologie UFR CHU Bouaké

Introduction : La lutte contre le paludisme chez la femme enceinte passe par le traitement préventif intermittent. L'efficacité de cette stratégie dépend de sa réelle application sur le terrain par les professionnels de santé en charge des CPN. L'objectif est d'évaluer le niveau de connaissance et d'application du TPIg-SP par les sage-femmes à Abidjan.

Méthode : Il s'est agi d'une étude descriptive, qui a été réalisée du 23 mars au 17 avril 2021, dans 14 formations sanitaires de la ville d'Abidjan. Elle a concerné les sage-femmes exerçant dans ces centres et ayant donné leur consentement pour répondre au questionnaire.

Résultats : L'âge moyen était de 31,7 ans avec des extrêmes de 28 et 59 ans. La molécule utilisée était connue par 91,7 %, tandis qu'aucune n'en connaissait le dosage. Chez 86,7 % des sage-femmes, le TPI devrait débuter à la 16^e Semaine d'aménorrhée. Elles toutes connaissaient la posologie et le délai entre les doses. Cependant, leur niveau de connaissance du nombre de doses était moyen. La stratégie DOTS n'était pas pratiquée par 98,3 %. L'association de la SP à l'acide folique était recommandée par 63,3 % de ces sage-femmes avec un dosage non adapté de l'acide folique et 78,3 % associaient chez les PVVIH, le traitement SP- cotrimoxazole.

Conclusion : Le TPI n'était pas suffisamment bien connu. Des formations post universitaires s'avèrent nécessaires pour atteindre les objectifs de la lutte contre le paludisme chez la femme enceinte.

Mots clés : TPI, femme enceinte, Abidjan

[C119] Évaluation de l'offre intégrée de soins maternels et infantiles, de planification familiale et de nutrition au Burkina Faso, Côte d'Ivoire et Niger.

Halima Tougri^{1,2}, Wambi Maurice Evariste Yameogo^{1,3}, Denise Kpebo^{2,4}, Rachidatou Compaore^{1,2}, Abou Coulibaly¹, Isabelle Bicaba⁵, Ramatoulaye Hamidou Lazoumar⁶, Marguérite Ndour⁵, Seni Kouanda^{1,2}

1. Institut de recherche en sciences de la santé (IRSS), Ouagadougou, Burkina Faso
2. Ecole doctorale sciences, santé et technologies de l'Université Saint Thomas d'Aquin (USTA), Ouagadougou, Burkina Faso
3. Institut africain de santé publique (IASP), Ouagadougou, Burkina Faso
4. Institut national de santé publique, Abidjan, Côte d'Ivoire
5. IntraHealth International, bureau regional, Ouagadougou, Burkina Faso

Introduction : Les décès maternels et infantiles peuvent être évités grâce à l'offre intégrée de services. Cependant, ces services ne sont pas facilement accessibles pour le couple mère-enfant. Afin d'augmenter la couverture de ces services, un modèle d'offre intégrée de soins maternels et infantiles (SMNI), de planification familiale (PF) et nutrition a été développé et mis en œuvre au Burkina Faso, Côte d'Ivoire et Niger. Le présent article évalue la mise en œuvre du modèle et les facteurs d'influences.

Méthode : Nous avons conduit une étude qualitative, comprenant une revue documentaire, des observations, des entretiens individuels et des focus groupes. Nous avons utilisé un échantillonnage raisonné pour recruter les prestataires et les femmes qui ont bénéficié de soins prénatals, de soins postnatals, de la PF et de la vaccination. Les femmes ont été interviewées à la sortie du centre de santé. Les entretiens ont été enregistrés, transcrits et analysés avec Nvivo 12. Le cadre de « Integra Initiative » a été utilisé pour analyser l'offre de soins intégrés classée en intégration physique, temporelle et fonctionnelle.

Résultats : Les résultats montrent que tous les centres de santé d'intervention dans les trois pays offrent des services intégrés au couple mère-enfant. Toutefois, le degré d'intégration varie en fonction du point de contact. L'intégration physique est forte dans tous les points de contact, tandis que l'intégration temporelle est moyenne et l'intégration fonctionnelle insuffisante. L'implication des parties prenantes dans le développement du modèle, l'amélioration des conditions de travail et le renforcement des capacités des prestataires ont contribué à la réussite de la mise en œuvre du modèle d'intégration. Toutefois, ce modèle a été limité par des facteurs liés à l'infrastructure et au personnel soignant.

Conclusion : La prise en compte de ces éléments dans la conception est essentielle pour optimiser l'offre intégrée des services de SMNI/PF/Nutrition au centre de santé.

Mots clés : Evaluation, mother child care, family planning, nutrition, integration

[C120] Evaluation de l'automate sysmex xn 31 dans le diagnostic biologique du paludisme simple à Abidjan (Côte d'Ivoire)

Adjo Gl1, Dou Gsp2, Aka Ad2, Tamboura Mta1, Nassoue Dmo1

1. Laboratoire de Parasitologie-Mycologie CHU Cocody
2. Laboratoire de Parasitologie-Mycologie UFRSMA

Introduction : Dans le but d'améliorer le diagnostic du paludisme, de nouveaux outils ont été mis sur le marché notamment l'Automate Sysmex XN 31. L'intégration de cet automate dans l'arsenal diagnostique est conditionnée par ces performances internes. L'objectif de notre étude était d'évaluer les performances de l'automate Sysmex XN 31 dans un pays d'endémie palustre comme la Côte d'Ivoire à la Polyclinique des Deux Plateaux à Abidjan

Méthode : Il s'est agi d'une étude transversale à visée descriptive qui a été réalisée du 11 juillet au 11 Août 2022 à la Polyclinique des Deux Plateaux. Pour chaque échantillon inclus, il a été réalisé la microscopie et l'analyse par l'automate Sysmex XN 31 en vue de déterminer la densité parasitaire et l'espèce plasmodiale ; la référence étant le couple Goutte Epaisse/Frottis Sanguin. Les données ont été recueillies grâce à une fiche d'enquête élaborée à cet effet

Résultats : Au total 364 patients ont été inclus dans notre étude avec un sex-ratio de 1,1. La prévalence du paludisme était de 11% avec *Plasmodium falciparum* comme unique espèce retrouvée. L'automate XN 31 avait de bonnes performances internes avec une sensibilité de 95 %, une spécificité de 99 %, une valeur prédictive positive de 90 % et une valeur prédictive négative de 99 %.

Conclusion : Au vu de ses performances internes qui satisfont aux critères de l'OMS, l'automate XN 31 peut être utilisé pour le diagnostic biologique du paludisme en Côte d'Ivoire.

Mots clés : Paludisme, Automate Sysmex XN31, Goutte épaisse, Frottis sanguin

[C121] La riposte à la pandémie de la covid-19 en 2022 au Bénin : cas des équipes d'intervention rapide des zones sanitaires du littoral

Paraïso Moussiliou Noël¹, Semassa Mèdèssè Damase², Sopoh Ghislain Emmanuel¹, Zounmenou Eugène²

1. Institut Régional de Santé Publique de l'UAC, Ouidah
2. Faculté des Sciences de la Santé de l'UAC, Cotonou

Introduction : Les équipes d'intervention rapides constituent un maillon essentiel dans la réponse aux urgences en santé publique. Leur rôle est déterminant dans le cadre de la riposte aux épidémies. Dans le cadre de lutte contre la Covid-19 qui a été à l'origine de plusieurs milliers de décès dans le monde, les autorités sanitaires ont mis en place un système de riposte dans toutes les zones sanitaires du Bénin au travers d'EIR. Notre objectif était d'évaluer l'action des équipes d'intervention rapide des zones sanitaires du littoral dans la lutte contre l'infection à SRAS-CoV-2.

Méthode : Il s'agissait d'une évaluation normative dont la collecte de données s'est déroulée du 17 janvier au 09 février 2022 dans 04 zones sanitaires du Littoral. Les données relatives aux ressources mobilisées, au respect des procédures opérationnelles, à la gestion des cas, la mobilisation sociale et aux extrants ont été collectées.

Résultats : Au total, 25 agents de santé ont été enquêtés. La composante Structuration a été satisfaisante (82,74%). La composante Procédures a été globalement satisfaisante (98,28%) avec une effectivité des interventions mises en œuvre. L'évaluation des extrants était satisfaisante à 100%.

Conclusion : cette évaluation a abouti à des résultats satisfaisants. L'amélioration de certains points notamment la formation, la motivation, l'évaluation des ressources humaines, la disponibilité des ressources financières et l'organisation des ressources temporelles contribuerait à renforcer l'action de ces équipes dans la riposte.

Mots clés : évaluation, équipes d'intervention rapide, SRAS-CoV-2, Bénin

[C096] Bioéthique et système de santé en contexte de pauvreté

SORO Torna¹

1. Département de Philosophie, UFHB

Introduction : La bioéthique se présente à la fois comme une réflexion critique et un ensemble de principes encadrant les recherche et pratique médicales et biomédicales. Comme telle, elle se retrouve au cœur des systèmes de santé. La Déclaration universelle de l'UNESCO sur la Bioéthique et les Droits de l'homme, adoptée en 2005, consacre les principes fondamentaux et universels de la bioéthique. Cependant, en contexte de pauvreté, l'intégration de la bioéthique dans les systèmes de santé semble constituer un réel défi. C'est dans ce sens que Désiré Adiogo Dieudonné (2007) estime que l'Afrique ne semble pas concernée par les principes universels de la bioéthique. De même, certains sont amenés à penser à une bioéthique propre aux pays du tiers-monde, notamment ceux de l'Afrique (Onuoha, 2007 ; Behrens et al., 2013). Par ailleurs, alors que la bioéthique constitue la gloire des systèmes de santé d'autres pays, elle semble être encore un rêve pour l'Afrique (Biradzem, 2016). Pour mieux comprendre, la présente contribution se propose d'analyser la place de la bioéthique dans le système de santé en contexte de pauvreté, particulièrement celui de l'Afrique. Il s'agit d'examiner l'interrogation suivante : Quelles est la place de la bioéthique dans un système de santé en contexte de pauvreté ?

Méthode : Cette analyse se fait à partir d'une analyse documentaire doublée d'une méthode phénoménologico-critique.

Résultats : Les principaux résultats en vus sont :

- Les défis de la prise en compte de la bioéthique sont essentiellement d'ordre infrastructurel, législatif et formatif/éducatif.
- Le contexte de pauvreté peut être une entrave à la bonne intégration de la bioéthique dans un système de santé, mais il ne peut y justifier son absence.

Conclusion : À l'analyse, il apparaît que la bioéthique est indispensable dans les systèmes santé africains, en dépit du contexte de pauvreté.

Mots clés : Afrique - Bioéthique - Droits de l'homme - Pauvreté - Pratiques médico-biomédicales - Système de santé.

**[C126] Indicateurs d'alerte précoce de résistance du VIH aux antirétroviraux au Togo :
une étude de cohorte rétrospective sur 15 mois en pleine COVID-19**

Roméo M. Togan¹, Malana Bigma¹, Kparakate B. Kota-Mamah¹, Mandjareaou Assih¹, Fifonsi Gbeasor-Komlanvi¹, Arnold J. Sadio², Rodion Y. Konu¹, Martin K. Tchankoni², Anoumou Dagnra¹, Didier K. Ekouevi¹

1. Université de Lomé, Faculté des Sciences de la Santé, Département de Santé Publique

2. Centre Africain de Recherche en Epidémiologie et Santé Publique (CARESP), Togo

Introduction : La pandémie de COVID-19 a eu un impact significatif sur l'offre et la demande de soins pour le VIH. Cette étude visait à décrire les indicateurs d'alerte précoce (IAP) de résistance du VIH au Togo.

Méthode : Une étude de cohorte rétrospective a été réalisée dans 40 sites de prise en charge du VIH. Les patients adultes ayant débuté un traitement antirétroviral (TAR) entre le 1er janvier 2020 et le 30 juin 2021 ont été inclus et suivis sur 15 mois. Les outils standardisés de l'OMS ont été utilisés pour la collecte des données. Les IAP suivants ont été décrits : la pratique de la prescription du TAR, les patients perdus de vue pendant les 12 premiers mois du TAR, les patients sous un régime de première ligne approprié pendant 12 mois, le retrait des ARV à temps, le respect des rendez-vous de TAR, l'adhésion du patient au TAR, et la suppression de la charge virale à 12 mois après l'initiation du TAR.

Résultats : Au total, 3498 patients ont été recrutés. Les pratiques de prescription des ARV étaient de 100 % et la cohérence de la dispensation des ARV était de 100 %. Le taux de perte de vue à trois mois au cours des 12 premiers mois de traitement antirétroviral était de 9,9 %. Presque tous les patients (98,7 %) suivaient un traitement approprié à 12 mois. Seuls 64,7 % des patients ont reçu leur traitement à temps, tandis que 72,8 % ont respecté leurs rendez-vous pour le traitement antirétroviral. Le taux de réalisation de la charge virale était de 70,1% et 92,3% des patients avaient une charge virale supprimée.

Conclusion : Il existe un risque de résistance du VIH aux ARV au Togo. L'éducation thérapeutique doit être renforcée pour améliorer l'adhésion des patients au traitement antirétroviral

Mots clés : Indicateurs d'Alerte Précoce (IAP) ; VIH ; résistance aux médicaments ; Togo

[C129] Effets de l'application PANDA (Pregnancy and Newborn Diagnostic Assessment) sur la qualité des soins prénatals au Burkina Faso : essai clinique randomisé contrôlé

Abou Coulibaly¹

1.Département Biomédical et Santé Publique, Institut de Recherche en Sciences de la Santé, Ouagadougou, Burkina Faso

Introduction : Le système PANDA est une application mobile qui a pour but de faciliter le diagnostic et la prise de décision en matière de soins prénatals. La présente étude avait pour objectif d'évaluer son effet sur la qualité des soins prénatals.

Méthode : Il s'est agi d'un essai contrôlé randomisé dans deux groupes de centres de santé (groupe d'intervention ayant reçu l'application PANDA et groupe de comparaison) dans le district sanitaire de Koupéla (région du Centre-Est, Burkina Faso). Nous avons inclus les femmes enceintes de moins de 20 semaines lors de leur première consultation prénatale (CPN) dans 12 établissements de santé et nous les avons suivies jusqu'à leur sixième semaine de post-partum. Le résultat principal était le score de qualité de la CPN, variable binaire codée 1 (oui) pour les femmes ayant obtenu au moins 75% du score total et 0 dans le cas contraire. Nous avons comparé les résultats ajustés entre les deux groupes d'étude en utilisant les modèles linéaires généralisés.

Résultats : Dans cette étude, 319 et 272 femmes ont été incluses, respectivement dans le groupe d'intervention et de comparaison. Dans le groupe d'intervention, 50 femmes sur 319 (15,67%) avaient au moins 75% du score total de qualité de la CPN contre 17 femmes sur 272 (6,25%) dans le groupe de comparaison. Les résultats ajustés ont montré que les chances de bénéficier d'une bonne qualité de la CPN chez les femmes du groupe d'intervention étaient de 2,70 fois (IC95%=1,60-4,60) celles des femmes du groupe de comparaison ($p<0,001$).

Conclusion : Cette étude a montré que l'application PANDA améliore significativement la qualité des soins prénatals. Ces résultats sont d'une importance capitale car le Burkina Faso, a décidé d'utiliser les registres électroniques pour les soins en maternité et pour les soins des enfants.

Mots clés : consultation prénatale, qualité, application

[C130] État de la « communication des risques et engagement communautaire » en post-COVID-19 dans l'espace CEDEAO en 2023

Houéto DS¹, Bancolé IMS¹

1.École de Santé Publique, Université de Parakou

Introduction : L'objectif était de procéder à l'analyse de la situation de la communication des risques et engagement communautaire (CREC) dans l'espace CEDEAO en post-COVID-19 en 2023.

Méthode : Un entretien individuel semi-structuré a été organisé avec les chargés de CREC de tous les 15 pays de l'espace CEDEAO à l'aide d'un guide d'entretien auto-administré élaboré à cet effet accompagné d'un formulaire pour recenser les bonnes pratiques à recommander en la matière. Des interviews individuelles et de groupes ont également été organisées avec un certain nombre de responsables CREC au niveau régional choisis selon l'importance de leurs responsabilités dans le développement de la CREC. Une revue de littérature a été faite pour compléter les données collectées auprès des acteurs dans les pays. L'analyse par regroupement thématique suivant les objectifs de l'étude a permis de dégager les forces, faiblesses, menaces et opportunités de la CREC dans l'espace CEDEAO.

Résultats : Au total, 27 retours ont été obtenus tant sur le guide d'entretien individuel auto-rempli (20) que sur le formulaire de bonnes pratiques CREC (7). Deux focus group de discussion ont été organisés, l'un en français et l'autre en anglais pendant que trois interviews individuelles ont été organisées avec des responsables CREC au niveau régional. La revue de littérature a permis l'exploitation de 86 articles et documents portant sur la CREC dans l'espace CEDEAO. La CREC dans l'espace CEDEAO retrouve une importance plus que jamais renforcée surtout dans la perspective de l'approche « Une Seule Santé » dans le processus de la préparation et riposte aux situations d'urgence de santé publique. Il se pose cependant un véritable problème de rareté de ressources humaines compétentes CREC pour assurer le relèvement des défis en vue dans le domaine.

Conclusion : La CREC, autrefois très peu valorisée dans l'espace CEDEAO, revêt en 2023 une importance cruciale dans la préparation et riposte aux situations d'urgence de santé publique avec l'expérience de la pandémie de COVID-19.

Mots clés : CREC, post-COVID-19, espace CEDEAO, Afrique

[C131] Approche « Une Seule Santé » dans l'espace CEDEAO : Nouvelle rhétorique dans une même posture biomédicale

Houéto DS¹, Bancolé IMS¹

1.École de Santé Publique, Université de Parakou

Introduction : L'objectif était d'étudier la perception de l'approche « Une Seule Santé » (USS) par les acteurs du secteur de la santé en charge de la communication des risques et engagement communautaire (CREC) dans l'espace CEDEAO en post-COVID-19 en 2023.

Méthode : Un entretien individuel semi-structuré a été organisé avec les chargés de CREC de tous les 15 pays de l'espace CEDEAO à l'aide d'un guide d'entretien auto-administré élaboré à cet effet. Des interviews individuelles et de groupes ont également été organisées avec un certain nombre de responsables CREC au niveau régional choisis selon l'importance de leurs responsabilités dans le développement de la CREC et USS. Une revue de littérature a été faite pour compléter les données collectées auprès des acteurs dans les pays. L'analyse par regroupement thématique suivant les objectifs de l'étude a permis de dégager les perceptions actuelles de l'approche USS auprès des acteurs du secteur de la santé dans l'espace CEDEAO.

Résultats : Au total, 20 retours ont été obtenus sur le guide d'entretien individuel auto-rempli. Deux focus group de discussion ont été organisés, l'un en français et l'autre en anglais pendant que trois interviews individuelles ont été organisées avec des responsables CREC/USS au niveau régional. La revue de littérature a permis l'exploitation de 17 articles et documents portant sur l'approche USS dans l'espace CEDEAO. L'approche USS dans l'espace CEDEAO reste encore essentiellement dominée par une vision biomédicale de la santé ne permettant pas de positionner cette dernière dans une perspective élargie allant au-delà des trois secteurs directement impliqués et ce, malgré toutes les leçons apprises de la pandémie de COVID-19. L'une des difficultés qui pourrait expliquer cet état de chose est le manque criard de ressources humaines compétentes en promotion de la santé dans le secteur de la santé.

Conclusion : La pandémie de la COVID-19, malgré les défis mis sur le chemin des secteurs de la santé en termes de vision écologique de la santé, n'a pas permis de positionner l'approche USS dans une perspective élargie.

Mots clés : Une Seule Santé, post-COVID-19, espace CEDEAO, Afrique

[C135] Analyse de la base de données de la surveillance épidémiologique de la poliomyélite de la région de Ménaka 2023

Keita Ibrahima Dit Boua¹, Sangho Oumar²

1. District sanitaire d'Andéramboukane

2. Département d'Enseignement et de Recherche en Santé Publique et Spécialités (DERSP) / FMOS / USTTB

Introduction : La poliomyélite, maladie virale aigue contagieuse, est une pathologie évitable par la vaccination. L'un des socles de l'espoir d'éradication de la poliomyélite est la surveillance. Durant les trois dernières années, très peu d'étude d'analyse de la base de la surveillance de la poliomyélite au niveau de la région de Ménaka ont été menées, d'où l'intérêt de notre étude. Objectif : Analyser la base de données de la surveillance de la poliomyélite de la région de Ménaka de 2020 à 2022.

Méthode : Etude transversale descriptive avec une analyse en temps, lieu, personne et d'indicateurs de performance de la surveillance de la poliomyélite.

Résultats : Les cas résidaient à Ménaka chez 10%. Le sexe féminin était de 55% des cas, l'âge moyen de $4,40 \pm 3,05$ ans. Les cas étaient vaccinés chez 57%. Les districts d'Andéramboukane et de Ménaka ont notifié chacun 50% des cas de PVDVc. Les semaines de notifications étaient 6^{èmes} ; 25^{ème} et 27^{ème} (2020), 37^{ème} (2022) les selles étaient adéquates chez 95%. La classification finale retrouva 7,14% de PVDVc. Le taux de sensibilité était de 21,07%, 42,12% et 23,28%. Le délai moyen de réception des résultats du laboratoire de référence était de 41,01 jours.

Conclusion : La surveillance de la poliomyélite a enregistré des résultats performants. Les délais de communications des résultats de laboratoire doivent être améliorer pour permettre au système d'atteindre l'objectif d'éradication de la poliomyélite.

Mots clés : Surveillance, Poliomyélite, Région de Ménaka

[C146] Facteurs associés à l'intention d'utilisation de la planification familiale du post-partum parmi les femmes enceintes consultant à l'hôpital général de Dabou

Kpebo Denise¹

1.Département de Santé Publique et Spécialité

Introduction : La prévalence de la planification familiale du post-partum (PFPP) reste faible en Côte d'Ivoire. Cependant, peu d'études se sont intéressées aux intentions des femmes enceintes qui sont les futures cibles de la PFPP. Nous avons donc conduit cette étude pour analyser les facteurs associés à l'intention d'utilisation de la PFPP parmi les femmes enceintes consultant à l'hôpital général de Dabou.

Méthode : Il s'agissait d'une étude transversale à visée descriptive et analytique qui a été conduite du 24 Novembre au 07 Décembre 2020 auprès de 325 gestantes reçues en consultation prénatale. Les données ont été analysées à l'aide du logiciel Stata 15. Une régression logistique bivariée puis multivariée a été conduite pour identifier les facteurs associés à l'intention d'utilisation de la PFPP. Les Odds-ratio ajustés, avec un intervalle de confiance à 95% ont été calculés, et les tests statistiques étaient considérés significatifs pour $p < 0,05$.

Résultats : L'intention d'utilisation de la PFPP était de 53,7%, et était plus élevée chez les femmes enceintes ayant un niveau d'étude primaire (OR ajusté 2,14[1,92-4,96] $p=0.015$) et secondaire (OR ajusté 3,41[1,42-5,15] $p=0.023$). L'utilisation antérieure de méthodes contraceptives (OR ajusté 2,22 (1,59-3,11) $p=0.023$), la discussion de la PF avec le partenaire (OR ajusté 1,52 (1,25-2,20) $p=0.035$), ainsi que l'attitude favorable du partenaire vis-à-vis de la PFPP (OR ajusté 1.97 (1.50-2.59) $p=0.005$) étaient les facteurs reproductifs associés à l'intention d'utilisation de la PFPP.

Conclusion : Les résultats de cette étude montrent que seulement la moitié des femmes enceintes ont l'intention d'utiliser la PFPP. La communication en couple et l'attitude du partenaire vis-à-vis de la planification ont une influence importante sur cette intention d'utilisation. Les interventions visant à faire la promotion de la PFPP doivent intégrer des approches visant à favoriser l'implication des partenaires.

Mots clés : Planification familiale du post-partum, Contraception, Grossesse, Côte d'Ivoire

[C147] Effets de l'intégration des services de santé maternelle et infantile, de nutrition et de planification familiale sur la charge de travail des prestataires au Burkina Faso, en Côte d'Ivoire et au Niger : une étude quasi expérimentale.

Kpebo Denise¹

1.Département de Santé Publique et Spécialité

Introduction : Les effets des interventions d'intégration des services sur la charge de travail des prestataires ont souvent été postulés mais peu évalués. Cette étude visait à évaluer les effets d'un modèle d'intégration de services de planification familiale, de santé maternelle et infantile et de nutrition sur la charge de travail des prestataires de santé de 1ère ligne, en Côte d'Ivoire, au Burkina Faso et au Niger.

Méthode : Il s'agissait d'une étude quasi expérimentale. Dans chaque pays, nous avons un groupe de centres de santé exposés à l'intervention (groupe d'intervention) et un autre groupe dont les prestataires prodiguaient les soins standards (groupe de comparaison). Nous avons utilisé la méthodologie WISN de l'OMS. A partir de revues documentaires, d'entretiens approfondis avec les prestataires de santé et d'observations des prestations, nous avons calculé le besoin en personnel grâce à la différence WISN (personnel actuel-personnel requis) et la pression de la charge de travail grâce au ratio WISN (personnel actuel/personnel requis). Les données ont été analysées à l'aide des logiciels Excel et stata 17.0.

Résultats : Les résultats ont montré que l'intervention n'a pas eu d'influence notable sur la situation du personnel ainsi que sur la pression de charge de travail des prestataires. Lors des deux enquêtes (pré et post intervention), les structures urbaines avaient généralement un effectif de personnel suffisant tandis que les structures en milieu rural présentaient un déficit de personnel avec une pression de charge de travail modérée ou élevée (rapport WISN <1). Sur les sites d'intervention, l'on a toutefois noté une augmentation relative des effectifs requis mais les effectifs antérieurement disponibles restaient suffisants pour couvrir le volume de travail (34 agents disponibles contre 31 requis pour l'enquête de base, vs 34 requis pour l'enquête finale au Burkina Faso). De façon spécifique, les maternités rurales des sites d'intervention ont présenté une pression de charge de travail relativement accrue après la mise en œuvre de l'intervention (plus de 40% au Burkina Faso et en Côte d'Ivoire).

Conclusion : L'intégration des services de santé maternelle et infantile n'entraîne pas une surcharge de travail chez les prestataires. Toutefois, pour une meilleure réussite et pérennisation de telles initiatives, Il s'avère nécessaire de pallier aux problèmes préexistants d'insuffisance et de distribution inéquitable des ressources humaines en santé.

Mots clés : Indicateurs de charge de travail pour les besoins en personnel de santé, Ressources humaines pour la santé, Personnel de santé de 1ère ligne, Santé maternelle et infantile

[C149] Connaissances, Attitudes et Pratiques de la population de Sikasso face à la COVID-19, Mali, 2021

Oumar Sangho¹, Aissata Sangho², Ousmane Boua Togola³, Germain Ildevert Zefack Momo², Tyeri Dackouo², Ousmane Fomba², Abdoulaye Konaté², Souleymane Sawadogo², Boubacar Camara², Niakaling Sissoko², Moussa Coulibaly², Ambadjigna Hervé Somboro², Fanta Sangho³, Aboubacar Sangho³, Kassoum Koné⁴, Boureyma Belem⁴, Titi Simaga⁵, Cheick Oumar Bagayoko¹, Hamadoun Sangho¹

1.Département d'Enseignement et de Recherche en Santé Publique et Spécialités (DERSP), Faculté de Médecine et d'Odontostomatologie (FMOS), Bamako, Mali

2.Agence Nationale de Télésanté et d'Informatique Médicale (ANTIM), Hamdallaye ACI, Bamako, Mali

3.Direction Générale de la Santé et de l'Hygiène Publique (DGSHP), Bamako, Mali

4.Institut National de Santé Publique (INSP), Bamako, Mali

Introduction : En novembre 2021, 253.870.057 infections à COVID-19 et 5.107.084 décès ont été enregistrés dans le monde. A la même période, la région de Sikasso, au Mali, comptait 521 cas et 15 décès. L'objectif de notre étude était d'évaluer le niveau des connaissances, attitudes et pratiques (CAP) de la population de Sikasso sur les mesures de prévention contre la COVID-19.

Méthode : Nous avons réalisé une étude transversale, descriptive entre le 02 décembre 2020 et 30 Juin 2021. La population d'étude était constituée des appelants du numéro vert 36061 de la COVID-19 de ladite région ayant consentis à notre étude. Chaque CAP a été noté 0 ou 1. Le score total, dont le maximum était de 34points, a été apprécié en Insuffisant (<15points) ; Satisfaisant (≥15points et <25points) ; Très satisfaisant (≥25points). Le protocole a été approuvé par le Comité National d'Ethique pour la Santé et les Sciences de la vie.

Résultats : L'âge moyen des appelants était de 19,31±6,66ans avec une sex-ratio de 3,24 en faveur des hommes. La radio était la principale source d'information de la COVID-19 (20,5%) suivie de la télévision avec 18,6%. Plus de la moitié (51,8%) des personnes interrogées n'avaient pas confiance au vaccin. Parmi les personnes informées sur la disponibilité du vaccin, 85,20% étaient consentante pour la vaccination et 11,5% en avaient peur. Environ 39,4% des enquêtées affirmaient avoir constaté un changement dans la cohésion sociale. La principale raison était la peur d'attraper la maladie (42,3%). Le score de CAP était insuffisant pour la région (13,38points) et dans tous les cercles sauf Yanfolila (15,50points).

Conclusion : L'étude a noté un faible niveau de score CAP et la peur de la vaccination. Un renforcement des activités de communication et de sensibilisation sont nécessaire pour un meilleur contrôle de la COVID-19.

Mots clés : COVID-19, Connaissances, Attitudes, Pratiques, Sikasso, Mali.

[C150] Connaissances, attitudes et pratiques du personnel soignant de l'hôpital général de Jacqueville sur la gestion des déchets hospitaliers en 2021

Kilanko Grace Esther^{1,2}, Aholia Cyriaque Valencia^{1,2}, Kohion Aristide Romaric Odré^{1,2}, Adagra Ophélia Irma Charlene³, Breimi Amoussan Privat^{1,2}, Guiegui Chimène Pulchérie³, Aka Irel Narcisse³, Tchicaya Aimé François³, Kouassi Yao Mathias³

1. Service de médecine du travail et pathologie professionnelle. Centre Hospitalier

2. Universitaire d'Angré, Abidjan – Côte d'Ivoire

3. Département de santé publique et spécialités. UFR Sciences Médicales, Université Félix Houphouët-Boigny. BP V 166 Abidjan - Côte d'Ivoire

Introduction : Les déchets hospitaliers, quels qu'ils soient, constituent un véritable problème de santé publique. L'objectif était d'évaluer les connaissances du personnel soignant de l'hôpital général de Jacqueville et de décrire leurs attitudes et pratiques sur la gestion des déchets hospitaliers.

Méthode : Nous avons réalisé une étude transversale et descriptive de mai à novembre 2021 (6 mois) à l'hôpital général de Jacqueville, en Côte d'Ivoire. Le recueil des données s'est fait à l'aide d'un auto-questionnaire renseignant sur le niveau de connaissances, attitudes et pratiques du personnel soignant concernant la gestion des déchets des activités de soins et d'une deuxième fiche destinée à la direction de l'hôpital qui renseignait sur l'aspect administratif et réglementaire de la gestion des déchets. La saisie et l'analyse des données ont été effectuées au moyen des logiciels Word et Excel 2016.

Résultats : Notre étude a porté sur 65 agents de soins dont 67,7% de femmes. L'âge moyen était de $39,96 \pm 6,82$ ans. Il s'agissait principalement d'infirmiers (27,7 %), de sages-femmes (21,5%), d'agents d'hygiène (15,4%) et de médecins (12,3%) avec une ancienneté professionnelle moyenne de $7,78 \pm 5,66$ ans. En rapport avec le niveau de connaissance, trente agents (46,15 %) désignaient les déchets ménagers et assimilés comme étant aussi des déchets hospitaliers et plusieurs affirmaient que les risques sanitaires d'une mauvaise gestion des déchets étaient dominés par les infections nosocomiales (69,2%). Concernant l'attitude des travailleurs, 36,9 % ne faisaient pas de tri de déchets. Ceux qui en faisaient (63,1%), utilisaient les boîtes de sécurité (84,6 %) et les poubelles couvertes (70,8 %). Selon les travailleurs, les déchets étaient stockés à l'extérieur des services (58,5 %) dans de mauvaises conditions (32,3%). Lors du transport des déchets, environ la moitié des agents portait les EPI. Pour leur élimination, il n'y avait pas d'incinérateur, les déchets étaient donc brûlés à l'air libre. Au niveau administratif et réglementaire, les mesures indispensables à la gestion efficace des déchets hospitaliers n'étaient pas effectives.

Conclusion : Ces constats imposent la mise en place d'une politique de gestion des déchets hospitaliers mettant l'accent sur la formation des agents et la mise à disposition du personnel soignant d'un équipement adéquat.

Mots clés : Etude CAP – Déchets hospitaliers – Personnel soignant - Jacqueville

[C154] Facteurs associés à satisfaction des prestataires sur le système d'information sanitaire basé des dossiers médicaux électroniques dans des hôpitaux du Burundi

Sossa Charles¹, Munezero Florence¹, Ahanhanzo Glele Yolaine¹, Azandjeme Colette¹, Paraïso Moussiliou¹, Bazira Léodégal²

1. Institut Régional de Santé Publique de Ouidah

2. Faculté de Médecine de Bujumbura, Université du Burundi

Introduction : L'informatisation du dossier médical est l'un des moyens d'améliorer la performance du système d'information au sein de l'hôpital et la continuité et la qualité des soins et des services offerts à la population. L'objectif de l'étude était de déterminer les facteurs associés à la satisfaction des prestataires de soins à l'égard du système d'information hospitalier basé sur le dossier électronique.

Méthode : Il s'agit d'une étude transversale, descriptive et analytique menée dans 11 hôpitaux du Burundi, dont le dossier patient était informatisé entre 2015 et 2017 avec le logiciel OpenClinicGA. Les données ont été collectées par questionnaire auto-administré auprès des prestataires sélectionnés par échantillonnage aléatoire simple. L'analyse des données a été faite avec STATA 15.

Résultats : Parmi les 155 prestataires enquêtés, la majorité étaient des infirmiers (51%) suivis des médecins (23%). En ce qui concerne la satisfaction, 55,5 % des prestataires étaient satisfaits du nouveau système basé sur le DSE. Les hommes étaient 2,21 fois plus satisfaits de l'utilisation du DSE que les femmes (OR=2,21 ; IC95% : [1,09-4,46]). Les prestataires formés par les informaticiens du projet étaient 4,24 fois plus satisfaits que ceux qui avaient été formés par leurs collègues (OR=4,24 ; IC95% : [1,47-12,23]) et 3,69 fois plus satisfaits que ceux qui avaient été formés par leurs collègues (OR=2,21 ; IC95% : [1,09-4,46]). De même, l'utilisation du logiciel pour générer des rapports et des statistiques était 2,27 fois associée à la satisfaction du prestataire (OR = 2,27 ; IC95% : [1,14-4,49]).

Conclusion : La durabilité et le succès du projet d'informatisation du dossier patient dépendent de la prise en compte des attentes des prestataires lors de la mise en œuvre.

Mots clés : Dossiers de santé électroniques, Hôpitaux, Prestataires, Satisfaction, Burundi

[C155] Bilan du contrôle de qualité des médicaments distribués par les programmes de lutte contre le sida, la tuberculose et le paludisme au Bénin

Sossa Charles¹, Kpanou Fataï², Azandjeme Colette¹, Paraïso Moussiliou¹, Yemoa Achille²

1. Institut Régional de Santé Publique de Ouidah
2. Unité de formation et de recherche en Pharmacie, FSS Cotonou

Introduction : L'infection à VIH, la tuberculose ainsi que le paludisme demeurent des problèmes de santé publique. La lutte contre ces maladies nécessite une prise en charge médicamenteuse. Le suivi de la qualité des médicaments distribués pour lutte contre ces maladies prioritaires est un aspect important de cette lutte. L'objectif de cette étude était d'analyser les résultats des contrôles de la qualité des antirétroviraux, antituberculeux et antipaludiques distribués au Bénin.

Méthode : Notre étude s'est déroulée aux sièges des Programmes Nationaux de Lutte contre les maladies prioritaires et à l'Agence nationale de Contrôle de Qualité et de la Société béninoise pour l'approvisionnement en produits de santé. Il s'agissait d'une étude transversale menée en 2022 qui a porté sur des rapports de contrôle de qualité effectués de 2015 à 2020 et personnel impliqué dans le processus de contrôle de qualité sélectionnés par recensement et choix raisonné respectivement. Une analyse descriptive a été faite.

Résultats : Parmi les 288 certificats de contrôle de qualité collectés, cinq avaient rapporté de non-conformes soit un pourcentage de 1.7%. La quasi-totalité (4 sur les 5) de ces non-conformités provenait de l'Inde. Sur ces cinq non-conformités, quatre étaient des comprimés et l'autre, une suspension buvable. Les cinq non-conformités provenaient de quatre fabricants : Oxalis (2 lots non-conformes sur les 3 fournis), Novartis Saglik (1 lot), Mylan Laboratories Limited (1lot), et Cipla Ltd (1lot). La Névirapine était le principe actif le plus représenté avec 2 des 5 non-conformités, suivie par l'Artémether/Lumefantrine (1 sur 5), le Pyrazinamide (1 sur 5) et l'association Rifampicine/Isoniazide/Pyrazinamide (1 sur 5).

Conclusion : L'étude a montré que la proportion de conformités est faible, cependant le contrôle de qualité des médicaments de lutte contre les maladies prioritaires doit être maintenu car le risque d'introduction de médicament non conforme demeure possible.

Mots clés : Médicaments, Antirétroviraux, Antipaludiques, Antituberculeux, Contrôle de qualité, Bénin.

[C156] Facteurs associés à l'utilisation des services et prestations des relais communautaires par les mères d'enfants de 0 à 5 ans au Bénin

Atiogbe Kougbessi Gélase¹, Gaffan Nicolas¹, Aviansou Annonciat Sèmèvo², Sopoh Emmanuel Ghislain¹, Ouendo Edgard-Marius¹

1. Institut Régional de Santé Publique de Ouidah – Université d'Abomey Calavi – Bénin

2. Ministère de la santé du Bénin

Introduction : Le renforcement des systèmes de santé, préoccupation majeure pour de nombreux pays. Pour ce faire, différentes stratégies telles que l'utilisation des relais communautaires (RC) à travers les interventions traceuses du Paquet d'Intervention à Haut Impact (PIHI) au niveau Communautaire au Bénin sont mises en œuvre. L'objectif de ce travail était de déterminer les facteurs associés à l'utilisation des services et prestations des relais communautaires par les mères d'enfants de 0 à 5 ans au Bénin.

Méthode : Etude transversale et analytique portant sur les enfants de 0 à 5 ans et leur mère, déroulée en 2022. La technique d'échantillonnage aléatoire simple de la méthode probabiliste a été utilisée. La variable dépendante était l'utilisation des prestations et/ou services des relais communautaires par les mères d'enfants de 0 à 5 ans dans la mise en œuvre des interventions traceurs du PIHI Communautaire. Les variables indépendantes étaient les informations liées aux mères et aux enfants ainsi qu'aux prestations et services des relais. Les données ont été collectées par le biais d'un questionnaire. Les facteurs associés ont été identifiés par une régression logistique multivariée.

Résultats : 448 mères d'enfants de moins de cinq ans ont été incluses dans l'étude. A l'issue de l'analyse multivariée, les mères d'enfants de 0 à 5 ans (69,42%) qui n'avaient jamais entendu parler du PIHI Communautaire (ORa = 5,45, IC95% = 2,69-11,06, p<0,001) et (46,43%) qui n'ont pas été en mesure de citer au moins une prestation/service offert par les relais communautaires (ORa = 46,71, IC95% = 23,63-92,34, p<0,001) étaient plus susceptibles de ne pas faire usage des prestations et/ou services des relais communautaires. En outre, vivre au centre du Bénin (ORa = 3,46, IC95% = 1,65-7,28, p=0,001) ou au sud (ORa = 2,92, IC95% = 1,45-5,86, p=0,003) y étaient également associés.

Conclusion : Une meilleure communication autour des interventions à base communautaire pourrait améliorer leur performance.

Mots clés : Relais-communautaires ; Services-prestations ; Mères-d'enfants-0-5 ans ; Facteurs-associés ; Bénin

[C157] Analyse du problème de la qualité des données de surveillance, Région de la santé de l'Indénié-Djuablin, Côte d'Ivoire, mai 2023

Datte K. Romeo¹, Mangoua Hervé-Gérard², Wilnique Pierre³, O. Joseph³, Benie Bi Vroh Joseph⁴

1. Direction Régionale de la santé de l'Indénié-Djuablin
2. Direction Départementale de la Santé de Bondoukou
3. AFNET
4. INHP

Introduction : La qualité de données est une mesure de l'état des données fondées sur la précision, l'exhaustivité, l'homogénéité, la fiabilité et l'actualité. Un contrôle de la qualité de données de surveillance a été réalisé dans le but d'améliorer le niveau de la qualité de données. Au vu des problèmes relevés, nous avons procédé à l'analyse de l'absence de notification « 0 » cas dans la région de l'Indénié-Djuablin.

Méthode : Une étude descriptive a été menée le 03 mai 2023 au bureau de la Direction régionale de la santé de l'Indénié-Djuablin. Cette étude concernait tous les acteurs de la surveillance de la région. Elle a été réalisée par un échantillon de l'Equipe Régionale de Santé de l'Indénié-Djuablin réunie en focus group. Les informations ont été obtenues par brainstorming. Elles ont été analysées selon le diagramme d'Ishikawa ou arête de poisson prenant en compte la méthode de priorisation de problème en santé publique (TPN).

Résultats : 10 personnes de l'Equipe Régionale de Santé ont participé à ce focus group. Le problème principal identifié était l'absence de notification « 0 » cas des maladies sous surveillance. Plusieurs causes secondaires au problème principal ont été identifiées, et à l'aide de la méthode de priorisation de problème suivant le degré de contrôle, l'absence de suivi des activités de surveillance a été identifiée comme cause critique.

Conclusion : Au terme de notre analyse, nous avons identifié comme problème principal, l'absence de notification « 0 » cas des maladies sous surveillance et comme cause critique l'absence de suivi des activités de surveillance. La mise en place de nouvelles stratégies permettra d'assurer une bonne surveillance des maladies à potentiel épidémique.

Mots clés : Analyse, problème, surveillance, Indénié-Djuablin

[C158] Apports de l'informatisation du dossier patient sur sa complétude dans des hôpitaux du Burundi

Sossa Charles¹, Munezero Florence¹, Ahanhanzo Glele Yolaine¹, Azandjeme Colette¹, Paraïso Moussiliou¹, Bazira Léodéga²

1. Institut Régional de Santé Publique de Ouidah

2. Faculté de Médecine de Bujumbura, Université du Burundi

Introduction : L'informatisation du dossier médical contribue à l'amélioration de la complétude des dossiers patient. L'objectif de l'étude était de déterminer les apports de l'information hospitalier du dossier patient à sa complétude en comparaison au dossier papier.

Méthode : Il s'agit d'une étude transversale menée dans 11 hôpitaux du Burundi, dont le dossier patient était informatisé entre 2015 et 2017. Les données ont été collectées par dépouillement des dossiers patients dans quatre services choisis au hasard dans les services déjà informatisés dans tous les 11 hôpitaux de l'étude. Un cinquième (1/5) des dossiers patients sur quatre mois ont été sélectionnés par choix aléatoire simple. La complétude du dossier médical a été appréciée sur un élément : l'inscription du diagnostic principal à la sortie sur dossier. La comparaison entre le dossier patient électronique et le dossier patient version papier a été faite pour les services de pédiatrie sur des dossiers sélectionnés par choix aléatoire simple.

Résultats : Sur les 11 hôpitaux, le diagnostic principal à la sortie était inscrit pour 50% des dossiers pour l'ensemble des quatre services. Tous les hôpitaux qui ont été informatisés en 2015 avaient plus de chance d'avoir des dossiers médicaux avec le diagnostic à la sortie que les hôpitaux informatisés en 2017 pour les quatre services. En considérant du niveau de remplissage du dossier médical avant et après l'introduction du dossier patient électronique dans les services de Pédiatrie, la mention du diagnostic principal à la sortie était correctement renseignée sur 61% (159/260) des dossiers des patients papiers et sur 81% (211/260) des dossiers des patients informatisés. Le dossier patient électronique mentionnait plus souvent le diagnostic à la sortie (OR = 2,73 [1,83 – 4,07 ; p<10-4]) que le dossier papier.

Conclusion : L'informatisation du dossier patient semble améliorer sa complétude

Mots clés : Informatisation, dossier patient, complétude, hôpitaux, Burundi,

[C159] Profils épidémiologiques et socio-démographiques des travailleuses du sexe sous traitement antirétroviral suivies à l'institut d'hygiène social (IHS) de Dakar

Sow Papa Gallo¹, Bambey Drame Aboubakry¹, Bambey Diop, Fatou², Diouf, Louis Augustin², M'baye, Gora²

1. UFR Développement Durable, Université Alioune Diop

2. Université Cheikh Anta Diop de Dakar, département de Pharmacie

Introduction : La prévalence du VIH au Sénégal passe de 0,75% en 2005 à 0,32 % en 2021. Même si cette prévalence est faible dans la population générale, elle reste toujours élevée chez les travailleuses du sexe (TS) estimée à 5,8% en 2019. Cette population de TS étant en danger constant d'infection VIH a motivé le choix de cette étude avec comme objectif à étudier le profil épidémiologique et socio-démographique des TS sous traitement antirétroviral suivies à l'IHS de Dakar.

Méthode : Ce travail a été réalisé chez les TS séropositives au VIH et suivies à l'IHS de Dakar entre août 2001 et novembre 2021. Il s'agissait d'une étude rétrospective basée sur l'exploitation des dossiers médicaux de TS suivant correctement leur rendez-vous et respectant leurs traitements médicamenteux.

Résultats : Au total 52 TS étaient suivies. L'âge moyen était de 44,36 ans variant de 21ans à 70ans. La grande majorité des TS étaient âgées entre 30 et 39ans. Plus de la moitié (51,92%) n'avait pas d'autres travaux générateurs de revenus et 23,08% étaient des commerçantes. Elles étaient majoritairement soit divorcées (45,10%) ou célibataires (35, 29%). La représentativité des TS avec le niveau d'instruction allant de 39,58% pour le niveau primaire à 2,08% pour le niveau supérieur tout en sachant que 37,5% n'étaient pas instruites.

Conclusion : L'épidémie du VIH/SIDA qui est de type concentré au Sénégal montre qu'à l'IHS étaient toutes âgées de plus de 30 ans, divorcées, sans profession et sans instruction. Une sensibilisation est nécessaire pour ces catégories de personnes afin de mieux prévenir le VIH/SIDA.

Mots clés : Epidémiologie, Travailleuses, Sexe, VIH/SIDA

[C160] Facteurs de non-divulgence du statut psychiatrique aux conjoint(e)s : cas des patients suivis au service d'addictologie et d'hygiène mentale d'Adjamé de 2017 à 2022

Son Gbolerou Jocelyne Prisca Epse Diah¹, Ekou Franck¹

1. Institut National de Santé Publique, Abidjan, Côte d'Ivoire

Introduction : la divulgation de son statut psychiatrique à son conjoint (e) est parfois difficile parce qu'elle fait l'objet de rupture de la relation qui lie ces derniers et expose à un risque de stigmatisation

Méthode : Il s'agissait d'une étude transversale prospective à visée descriptive qui s'est déroulée au Service d'Addictologie et Hygiène Mentale pendant une période de 3 mois allant de janvier-mars 2022. Ont été inclus 522 patients psychiatriques en couple âgés de plus 18 ans.

Résultats : Le sexe masculin a prédominé dans 54,4%. La tranche d'âge de 35 et 45 ans était la plus représentée dans 35,4% et près des 2/3 de nos patients (62,8%) était en couple entre 1 et 10 ans. Le diagnostic clinique le plus fréquent était les psychoses délirantes aiguës (43,3%) et plus de la moitié (54,4%) de nos patients était suivis en psychiatrie début moins 1an. (2,7%) de nos patients n'avait pas divulgué leur statut psychiatrique à leur conjoint, (57,1%) de nos enquêtés venait seul en consultation pour dissimuler leur statut, tous nos patients (100%) n'ayant pas divulgués leur statut prenaient leurs médicaments en cachette. Les motifs de non-divulgence étaient la crainte de la rupture conjugale et la stigmatisation sociale à 100 %. Parmi ceux qui n'avaient pas divulgué leur statut psychiatrique (53,3%) ont refusé de vivre en couple et de concevoir avec un malade mental.

Conclusion : la divulgation du statut psychiatrique au conjoint est avantageuse pour une meilleure observance thérapeutique

Mots clés : divulgation, stigmatisation, patients

[C161] Renforcer la surveillance épidémiologique et la réponse à la COVID-19 en milieu communautaire : cas des zones à risque épidémiologique élevé au MALI

Dia Amadou¹, Diawara Fatou¹, Kone Kassoum¹, Danfakha Keïta Fatoumata², Diarra Assa², Terera Ibrahim², Danioko Yacouba², Soumano Modibo¹, Belemou Boureyma², N'DEYE Doumbia¹, Traore Maimouna¹, Yaro Fatimata N'go³, Traore Diakalia³

1. Service Santé Communautaire Département Etudes et Recherches Médicale et Communautaire, INSP Mali
2. Service épidémiologie et biostatistique INSP Mali
3. Centre Pharmacovigilance INSP Mali

Introduction : L'Organisation mondiale de la santé (OMS) a déclaré la pandémie du COVID-19, en mars 2020. Le SRAS-CoV-2 a touché plus de 230 millions de personnes et fait plus de 4,8 millions de morts dans le monde au 6 Octobre 2021. Le Bureau régional de l'OMS pour l'Afrique (AFRO) a développé le projet de surveillance et de réponse à base communautaire (SBC) pour renforcer les efforts de certains États membres de la région africaine pour la détection et la réponse à la pandémie de la COVID-19 dans les zones à risque. Afin de contribuer à la lutte contre cette maladie au Mali, l'INSP assurant la coordination nationale de la lutte contre le COVID-19 avec l'appui technique et financier de l'OMS Mali, a réalisé une recherche opérationnelle sur la surveillance épidémiologique et la réponse à la COVID-19 en milieu communautaire en 2022. Le but de cette étude était de contribuer à l'amélioration de la surveillance et la réponse à la pandémie à COVID-19 en milieu communautaire au Mali.

Méthode : Les sites retenus par choix raisonné concernaient les districts sanitaires de Kayes, Kalaban Koro, Kati et de la commune VI à Bamako. La méthodologie fait référence à l'approche mixte

Résultats : Les entretiens ont concerné 691 enquêtés, soit 639 par approche quantitative avec 38 cas de malade de covid traités à domicile et 52 par l'approche qualitative.

Conclusion : Nous retenons de cette étude qu'il faut nécessairement la sensibilisation sur la prévention impliquant la communauté par ses leaders et représentants locaux, la veille et la riposte avec pour effet d'assurer la référence des cas suspects à temps, pour le dépistage et éventuellement pour un traitement à domicile bien conduit et suivi par les agents de santé.

Mots clés : Covid-19, surveillance, riposte, communautaire, prévention, traitement à domicile, Mali

[C162] Evolution des raisons de non-vaccination du PEV de routine en Côte d'Ivoire de 2006 à 2021

Aka Lepri Bernadin Nicaise¹, Ekra Kouadio Daniel¹, Aka Desquit Angèle¹, Yao Kossia², Yeboua Amoikon²

1. Université FHB d'Abidjan – Cocody

2. PEV Côte d'Ivoire

Introduction : Depuis sa création, le programme de vaccination de Côte d'Ivoire est passé de 6 à 14 maladies couvertes par les antigènes du programme et de 5 à 8 contacts dans le calendrier vaccinal du PEV de routine. On note des performances sous optimales avec pour corollaire une persistance voire une résurgence de certaines maladies évitables par la vaccination. Nous avons étudié l'évolution des raisons de non-vaccination de 2006 à 2021.

Méthode : Nous avons entrepris une transversale à visée descriptive sur la période 2006 à 2021 basée sur les revues externes du PEV des années 2006, 2010, 2015 et 2021 et sur les estimations OMS/Unicef des couvertures vaccinales nationales. Il s'est agi d'analyser les performances vaccinales et les raisons de non-vaccination ou de vaccination incomplète durant cette période.

Résultats : Selon les estimations OMS/Unicef la couverture vaccinale en Penta 3 étaient de 78% en 2010, 79% en 2015 et 76% en 2021. La couverture vaccinale en VAR/RR étaient de 64% en 2010, 67% en 2015 et 68% en 2021. Les raisons de non-vaccination étaient constituées des obstacles liés au service de vaccination 21% en 2006, 48% en 2010, 32% en 2015 et 43% en 2021. Le manque de motivation représentait 32% en 2006, 36% en 2010, 46% en 2015 et 23% en 2021. Le manque d'information constituait 36% en 2006, 14% en 2010, 16% en 2015 et 33% en 2021. Les principales raisons de non-vaccination étaient la négligence des parents, la non-disponibilité des vaccins et l'ignorance de la nécessité de la vaccination.

Conclusion : Les raisons de non-vaccination ou de vaccination incomplète de la vaccination de routine en Côte d'Ivoire étaient dominées par les obstacles liés au dispositif pour la génération de la demande en vaccination. L'amélioration des performances vaccinales nécessite une démedicalisation du suivi de celles-ci avec une implication des acteurs de la société civile.

Mots clés : PEV de routine, Couverture vaccinale, Côte d'Ivoire

[C163] Acteurs de non-divulgence du statut psychiatrique aux conjoint(e)s : cas des patients suivis au service d'addictologie et d'hygiène mentale d'Adjamé de 2017 à 2022

Son Gbolerou Jocelyne Prisca epse Diah¹, Ekou Franck²

1. Interne des hôpitaux, INSP

2. Assistant Chef Clinique Santé Publique, INSP

Introduction : la divulgation de son statut psychiatrique à son conjoint (e) est parfois difficile parce qu'elle fait l'objet de rupture de la relation qui lie ces derniers et expose à un risque de stigmatisation. L'objectif de notre travail était d'étudier les facteurs de non-divulgence des patients psychiatriques suivis au service d'addictologie et d'Hygiène Mentale de 2017-2022.

Méthode : Il s'agissait d'une étude transversale prospective à visée descriptive qui s'est déroulée au Service d'Addictologie et Hygiène Mentale pendant une période de 3 mois allant de janvier-mars 2022. Ont été inclus 522 patients psychiatriques en couple âgés de plus 18 ans.

Résultats : Le sexe masculin a prédominé dans 54,4%. La tranche d'âge de 35 et 45 ans était la plus représentée dans 35,4% et près des 2/3 de nos patients (62,8%) était en couple entre 1 et 10 ans. Le diagnostic clinique le plus fréquent était les psychoses délirantes aiguës (43,3%) et plus de la moitié (54,4%) de nos patients était suivis en psychiatrie début moins 1an. (2,7%) de nos patients n'avait pas divulgué leur statut psychiatrique à leur conjoint, (57,1%) de nos enquêtés venait seul en consultation pour dissimuler leur statut, tous nos patients (100%) n'ayant pas divulgués leur statut prenaient leurs médicaments en cachette. Les motifs de non-divulgence étaient la crainte de la rupture conjugale et la stigmatisation sociale à 100 %. Parmi ceux qui n'avaient pas divulgué leur statut psychiatrique (53,3%) ont refusé de vivre en couple et de concevoir avec un malade mental.

Conclusion : la divulgation du statut psychiatrique au conjoint est avantageuse pour une meilleure observance thérapeutique

Mots clés : divulgation, stigmatisation, patients

[C165] Facteurs associés aux pratiques d'alimentation chez les nourrissons de 0 à 24 mois dans les districts à forte prévalence de malnutrition chronique en Côte d'Ivoire

Coulibaly Amed¹, Sable Stephane Parfait¹, Aka Brou Serges², Dagnan N'cho Simplicie¹

1. UFHB, UFR Sciences Médicales, Département de Santé Publique et Spécialités

2. Institut National de Santé Publique (INSP) Côte d'Ivoire

Introduction : La malnutrition chronique est un problème de santé publique en Côte d'Ivoire et les districts du Woroba et du Zanzan sont les plus touchés avec des prévalences respectivement de 30,4 et 30,5%. L'objectif de cette étude était d'étudier les facteurs associés aux pratiques d'alimentation des nourrissons de 0 à 24 mois dans ces deux districts.

Méthode : Il s'est agi d'une étude transversale à visée descriptive et analytique qui s'est déroulée sur une période de 4 mois. Au total, 414 enfants ont été enquêtés. Une régression logistique a été réalisée pour identifier les facteurs associés aux mauvaises pratiques. Le seuil de significativité des tests statistiques était fixé à 5%.

Résultats : La proportion d'enfants ayant bénéficié d'une mise au sein précoce représentait 68,9% tandis que les moins de six mois allaités exclusivement au sein représentaient seulement 35,8%. Cet allaitement exclusif était plus pratiqué en milieu rural (OR = 2,87 [1,26 – 6,52] et par les mères sans emploi (OR = 2,69 [1,15 – 6,27]). La diversification à 6 mois avait été respectée pour 32,2% des enfants. Elle était plus pratiquée en milieu urbain (OR = 2,05 [1,20 – 3,50]) et par les ménages ayant une dépense alimentaire quotidienne supérieure ou égale à 2000 FCFA (OR = 2,26 [1,34 – 3,81]). L'âge moyen de l'arrêt de l'allaitement était $14,8 \pm 6,8$ mois. Seul 29,2% avait une bonne diversité alimentaire.

Conclusion : Les pratiques d'alimentation du nourrisson sont influencées par des facteurs sociodémographiques. Leur prise en compte dans l'élaboration de stratégies visant à améliorer la nutrition des nourrissons et des jeunes enfants dans les zones de forte prévalence de la malnutrition en Côte d'Ivoire est indispensable.

Mots clés : facteurs associés, pratiques d'alimentation, nourrissons, malnutrition chronique, Côte d'Ivoire.

[C167] Evaluation du burnout du personnel soignant de l'Institut de Cancérologie d'Akanda

Filankembo Kava Angéla Christie¹

1. Département d'épidémiologie, de biostatistiques et d'informatique médicale ; Institut de Cancérologie d'Akanda

Introduction : Les oncologues sont particulièrement prédisposés à développer le burnout. L'objectif de l'étude est de mesurer la fréquence du burnout au sein du personnel soignant de l'institut de cancérologie d'Akanda (ICA) et d'évaluer les principaux facteurs de risque.

Méthode : Nous avons mené une étude transversale à l'ICA durant le mois de janvier 2023. Tout le personnel soignant en service depuis plus de 6 mois a été inclus dans l'étude. Le burnout a été évalué à l'aide du Maslach Burnout Inventory (MBI).

Résultats : Sur les 42 participants, on notait une prédominance féminine (57,1%). L'âge moyen était de $39,57 \pm 8,13$ ans. Les infirmiers représentaient plus de la moitié de l'échantillon (52,5%). La moyenne d'années de service à l'ICA était de $6,30 \pm 4,80$ ans. Le burnout sévère a été retrouvé chez 14,3% des sujets de l'échantillon. Les sujets victimes d'actes de violence ont 5 fois plus de risque de développer un épuisement émotionnel sévère que les sujets non-victimes ($p=0,031$). Les sujets bénéficiant d'un soutien familial ont une réduction du risque de 82,6% de développer un épuisement émotionnel sévère ($p=0,042$).

Conclusion : Le burnout est relativement fréquent à l'ICA. Il est important de pouvoir l'identifier car non diagnostiqué et incorrectement pris en charge, le burnout peut avoir un impact négatif sur le fonctionnement du service, la prise en charge des patients mais également sur l'état de santé physique et mentale du personnel.

Mots clés : burnout ; oncologie ; soignant

[C168] Contribution d'un programme informatique dans la gestion des tubes de prélèvement sanguin en laboratoire d'analyses biomédicales

Tahirou Djara¹, Eugénie A. A. Anago²

1. Laboratoire d'Electrotechnique de Télécommunications et d'Informatique Appliqué, LETIA

2. Laboratoire de Recherche en Biologie Appliquée, LARBA

Introduction : Les analyses biomédicales constituent un moyen important de détermination du mal d'un patient. Il est de coutume d'ailleurs qu'un médecin étant même certain de son premier diagnostic demande au patient de faire un certain nombre d'analyses. Bon nombre de ces analyses nécessite un prélèvement sanguin. Il existe pour cela une liste bien définie de 6 tubes utilisés pour recueillir le sang à analyser, chacun ayant une liste d'analyses pour lesquelles ils peuvent être utilisés. Lorsqu'une liste d'analyses est demandée, les spécialistes sont amenés à dégager un ensemble de tubes pouvant être utilisés pour réaliser ces analyses. Vu le nombre d'analyses qui existe et les correspondances entre tubes et analyses, il se pose les trois problèmes suivants :

(i) un tube peut être sélectionné à la place d'un autre, (ii) l'ensemble optimal de tubes pouvant faire un ensemble d'analyses est rarement identifié, après sélection d'un tube pour un nombre élevé de tests, (iii) la quantité de sang pouvant contenir ce tube peut être inférieure à la quantité minimale nécessaire à la réalisation de ces analyses. Dans ce travail, nous avons mise au point une plateforme pour déterminer de façon correcte un ensemble optimal de tubes pour un ensemble d'analyses. Ce système permet de quantifier la quantité exacte de sang à prélever évitant ainsi le manque et l'excès de celui-ci.

Méthode : Dans la mise en place de notre plateforme nous avons suivi la méthodologie suivante :

1. Analyse des besoins
2. Spécifications
3. Design
4. Tests

Résultats : Implémentation de deux plateformes l'une mobile et l'autre web.

Conclusion : L'application qui a été réalisée a pour objectif d'aider les laborantins dans l'identification des tubes de prélèvements sanguins. Il contient néanmoins d'autres modules tels que la gestion administrative des comptes d'un laboratoire. Il permet aussi de garder une traçabilité des analyses effectuées par un individu.

Mots clés : Analyse biomédicale, prélèvement sanguin, tubes, patient, algorithme.

[C169] Stratégies d'adaptation pour maintenir le continuum de soins durant la pandémie à Covid-19

Ngom Ndeye Fatou¹, Ndiaye Kiné², Ndiaye Alassane², Ousseynou Ka³

1. Département de Médecine de l'UFR Santé et développement durable (SDD) de l'Université Alioune Diop de Bambey

2. Centre de traitement Ambulatoire de l'hôpital de Fann

3. UFRSDD de l'Université Alioune Diop de Bambey

Introduction : Le monde fait face à une pandémie à COVID-19 et aucun pays du monde n'a été épargné. Le Programme VIH a développé son plan de contingence avec des stratégies d'adaptation pour la communication, la prévention et la prise en charge des PVVIH. C'est ainsi que des activités ont été planifiées pour assurer la continuité des soins en termes de fréquentation des structures de soin et de dotation du traitement chez les PVVIH.

Méthode : Une mission de collecte a été organisée au niveau de 04 régions du Sénégal notamment Dakar, Saint-Louis, Thiès et Ziguinchor du 02 au 11 Juin 2021. Elle a été menée dans 04 régions médicales, 14 sites de prise en charge du VIH et 06 organes de coordination, d'accompagnement du VIH. Des entretiens ont été réalisés pour le volet qualitatif auprès du personnel impliqué dans la prise en charge des PVVIH et des PVVIH pour comprendre leurs perceptions des stratégies. Le second volet était marqué par l'exploitation documentaire à travers la revue des rapports d'activités.

Résultats : Nous avons interrogé 126 personnes dont 45 prestataires, 65 PVVIH et 16 responsables de programmes. Nous avons noté une baisse de la fréquentation des sites de prise en charge, un redéploiement des ressources humaines, Substitution des sites de dépistage et de PEC VIH pour la Covid-19, une tension sur la disponibilité des intrants pour le VIH et des difficultés d'acheminement des prélèvements. Des stratégies d'adaptation telles la prise en charge différenciée et l'organisation de soins à domicile entre autres ont aidées au continuum des soins. Une meilleure organisation des structures, la sensibilisation à travers la ligne verte et la diffusion de spots publicitaire ont contribué à la prévention de la Covid-19. La quasi-totalité (64/65) des patients interrogés ont exprimé leur satisfaction pour les nouvelles stratégies d'adaptation.

Conclusion : Ce travail de documentation a permis d'identifier les stratégies d'adaptation mises en œuvre pour maintenir l'offre de service malgré le contexte de Covid-19 mettant ainsi en évidence la capacité de résilience et la proactivité des acteurs de la PEC VIH.

Mots clés : Stratégies, résilience, Covid-19, soins VIH

[C170] Chaîne de traitement et de sécurisation du DMP par des technologies émergentes : Application au modèle basé sur le cas du Paludisme

Tahirou Djara¹, Abdou-Rahamane Ambarka Tenga¹, Vignon Dègbédji Bedie²

1. Laboratoire d'Electrotechnique de Télécommunications et d'Informatique Appliqué, LETIA

2. Institut Régional de Santé Publique de Ouidah

Introduction : Dans ce papier, nous présentons une chaîne de traitement qui utilise des technologies émergentes notamment l'intelligence artificielle, la blockchain et la biométrie multimodale pour non seulement accélérer le diagnostic d'une maladie (cas du paludisme) mais surtout assurer la sécurisation des résultats et leurs échanges sécurisés entre professionnels de santé dans un contexte de dossier médical partagé. Cette chaîne consiste à recevoir en entrée des images (frottis sanguins dans notre cas) à analyser. Ces images sont ensuite soumises à des modèles d'analyse et de prédictions de l'intelligence artificielle. Le modèle adéquat est activé selon le cas, et les résultats sont stockés dans un réseau de blockchain. Pour assurer une sécurisation lors des échanges entre professionnels de santé, l'identification et l'authentification sont assurées par une biométrie multimodale grâce à l'empreinte digitale et l'empreinte veineuse. Ainsi, dans une première étape, nous effectuons le traitement du type et de la phase du plasmodium en utilisant les algorithmes de détections d'objets Yolo et Faster-RCNN. Les résultats sont obtenus en 0,4s contre au moins six (6) heures lorsqu'on utilise les méthodes classiques. De plus, le patient reçoit de manière sécurisée les données de ses analyses et y donne accès à l'acteur de son parcours, détenant ainsi le contrôle de ses données.

Méthode : 1. Mise en place d'une base de données pour la sécurisation biométrique.

2. Mise en place d'une base de données pour l'IA (Malaria)

3. Sécurisation des données d'analyse dans une blockchain

Résultats : Les résultats que nous présentons sont de deux ordres :

1. Module de diagnostic

2. Sécurisation

2.1 Biométrie multimodale.

2.2 Sauvegarde sur la blockchain.

Conclusion : Le système que nous avons mis en place est une chaîne de traitement qui positionne l'intelligence artificielle en entrée de tout diagnostic de maladie. Dans notre cas, nous avons basé notre diagnostic sur le paludisme, cette maladie qui décime les populations en causant de nombreuses victimes chaque année dans le monde. Nous précisons qu'une autre maladie pourrait être diagnostiquée et les modèles d'intelligence artificielle les plus adaptés pourront être utilisés. Grâce à la combinaison de la blockchain et de la biométrie dans notre chaîne de traitement nous avons pu fiabiliser et sécuriser les données et leurs échanges entre professionnels de santé dans la chaîne du dossier médical patient.

Mots clés : Intelligence artificielle, blockchain, biométrie multimodale, dossier médical partagé, empreinte digitale, empreinte veineuse

[C172] Evaluation de la performance du système local d'information sanitaire (SLIS) du district sanitaire de la commune 1 de Bamako de 2020 à 2021.

Fatou Diawara^{1,2}, Oumou Diarra¹, Cheick Sidy Samake³, Akory Ag Iknane⁴

1. Faculté de pharmacie de l'USTTB
2. Institut National de santé Publique (INSP).
3. Service de pédiatrie du centre de santé de référence de la commune 1 du district de Bamako
4. Professeur titulaire en santé publique, faculté de pharmacie de l'USTTB

Introduction : Le système d'information sanitaire (SIS) sert à la génération d'informations sur la base desquelles les acteurs en santé décident et entreprennent les actions jugées appropriées. Ce système fait face à de nombreux défis surtout au niveau local. L'objectif de cette étude était d'évaluer la performance du système local d'information sanitaire (SLIS) du district sanitaire de la commune I de Bamako.

Méthode : L'étude s'est déroulée au centre de santé de référence de la commune 1 du district de Bamako de 2020 à 2021. Il s'agissait d'une transversale et descriptive ayant concerné 32 membres du personnel en charge du système local d'information sanitaire du centre de santé de référence et des centres de santé communautaire. Les aspects éthiques ont été pris en compte.

Résultats : La majorité des agents en charge du SLIS avaient reçu la formation sur DHIS2 avec 81,3% et 87,5% faisait l'analyse des données avant leur transmission et 81,3% d'entre eux remplissaient correctement les outils de collecte. Les rapports étaient complets dans 100% des cas cependant toujours transmis en retard. Le ministère de la santé finançait les activités du SLIS à hauteur de 44,0%. Dans notre étude, 84,4% de personnel du SLIS utilisaient pour la collecte des données des supports électroniques et papiers en même temps. L'utilisation de l'information sanitaire pour la planification des activités était faite dans 87,5% des structures sanitaires.

Conclusion : Pour assurer une efficacité du SLIS il est nécessaire de faire une intégration harmonieuse des technologies de l'information et de la communication et des compétences humaines qui gèrent le système afin de répondre efficacement aux besoins sanitaires des populations.

Mots clés : Evaluation, performance, système locale d'information sanitaire (SLIS), district sanitaire de la commune 1 du district de Bamako.

[C173] Renforcement de la Couverture Vaccinale en Côte d'Ivoire : Approches Innovantes et Partenariats Publics-Privés en 2023

Aka Lepri Bernadin Nicaise¹, Ekra Kouadio Daniel¹, Akani Bangaman Christian¹, Agbassi Yvan²

1. Université FHB Abidjan - Cocody

2. EnovPharm

Introduction : La Côte d'Ivoire a fait face à des défis pour atteindre ses objectifs de couverture vaccinale. Parmi ses défis figure le faible engagement du secteur privé. Ces défis se résument en amélioration de l'offre des services de vaccination d'une part et à celle de la génération de la demande en vaccination. Notre étude vise à documenter le projet Vaccipha qui a pour objectif d'impliquer les structures sanitaires privées de la ville d'Abidjan dans la vaccination de routine.

Méthode : Problématique : Il s'agit d'une étude transversale à visée descriptive portant sur les activités menées dans le cadre de l'initiative « Vaccipha » d'intégration de la vaccination de routine y compris la vaccination anti Covid19 les structures privées que sont les pharmacies privées et les cliniques privées. Cette activité a eu lieu en 2023.

Résultats : Description : Deux approches clés ont été mise en œuvre pour adresse ce problème à travers le projet VacciPha :

- Engagement du Secteur Privé : Des accords formels ont été établis avec des cliniques privées, étendant l'accès aux vaccins et assurant une supervision de qualité.
- Solution de Suivi Numérique, VacciPha : Cette plateforme a automatisé la gestion des rendez-vous, la surveillance des stocks de vaccins et l'engagement des patients, améliorant considérablement la collecte et la gestion des données.
- Leçons Tirées :
- Engagement du Secteur Privé Réussi : L'implication des cliniques privées a renforcé l'accès à la vaccination grâce à des accords formels et une supervision adéquate.
- Impact Positif de la Technologie Numérique : VacciPha a amélioré l'efficacité de la vaccination grâce à l'automatisation des processus et à une meilleure gestion des données.
- Adaptabilité et Apprentissage Continu : L'expérimentation et l'ajustement ont été essentiels pour maintenir le succès du projet.

Conclusion : Recommandation : Cette approche multidimensionnelle, combinant partenariat public-privé et solutions numériques, peut servir de modèle pour améliorer la vaccination en Côte d'Ivoire, garantissant un accès équitable, une gestion des données améliorée et un impact durable en santé publique. Une surveillance continue et une adaptation agile sont essentielles pour relever les défis en constante évolution de la vaccination.

Mots clés : Vaccination, Partenariat Public-Privé, Solutions Numériques Côte d'Ivoire

[C174] Facteurs Associés aux Décès Maternels en Milieu Hospitalier dans la Région Maritime, Togo, 2019-2021

Mandjaréou Assih^{1,2}, A. Sadjì³, Roméo M. Togan², Y. Douti⁴, K. Akolly⁴, Koumahada Tatao⁵, Didier K. Ekouévi^{2,4}

1. Direction Préfectorale de la Santé du district de Yoto/ Togo
2. Département de Santé Publique Université de Lomé
3. Programme de formation en épidémiologie de Terrain, Lomé – Togo
4. Centre de Formation et de Recherche en Santé Publique, Lomé - Togo
5. Direction Régionale de la Santé de la Région Maritime, Togo

Introduction : Au Togo, la région maritime enregistre l'un des niveaux de mortalité maternelle les plus élevés. Cette étude visait à identifier les facteurs associés aux décès maternels (DM) dans la région maritime de 2019 à 2021.

Méthode : Une étude multicentrique de type cas-témoins a été réalisée dans quatre hôpitaux de la région maritime de janvier 2019 à décembre 2021. Les cas étaient des femmes enceintes ou accouchées décédées et les témoins, des accouchées restées vivantes sélectionnées dans les mêmes hôpitaux préfectoraux de district. Les données de 130 cas et 260 témoins ont été collectées sur la base d'outils standardisés d'audit de DM. Les médianes avec leur intervalle interquartile et les effectifs ainsi que leurs proportions ont été déterminées. Les Odd Ratio et leur intervalle de confiance à 95% ont été calculés pour apprécier l'association entre les variables. Toutes les analyses ont été faites avec le logiciel R. 4.2

Résultats : La mortalité hospitalière était estimée à 8 DM/1000 naissances vivantes (NV). L'âge médian des cas était de 30 ans IIQ (25-36). Les 20 à 29 ans étaient les plus représentées (39,2%) et 54 femmes décédées (41,53%) avaient au moins 4 enfants. L'hémorragie était la principale cause probable de DM (45,38%) et 63 femmes (48,46%) étaient décédées dans le post partum immédiat. Les femmes référées représentaient 78,46% des DM. Les DM étaient associés aux facteurs tels que la référence de la patiente (OR=2,9 IC à 95% [1,8-4,7]), la multiparité (OR=1,8 ; IC à 95% [1,1-2,7]), la réalisation d'au moins 4 consultations prénatales (OR=0,3 IC [0,2-0,5]).

Conclusion : Les actions urgentes doivent être orientées sur les retard de références, le suivi prénatal, la prévention des hémorragies obstétricales et promotion de la planification familiale afin d'avoir une réduction de la mortalité maternelle dans la région maritime et au Togo.

Mots clés : Décès maternels ; Hémorragie, Femme enceinte, Togo

[C177] Évaluation du paiement numérique des agents de santé dans les campagnes de vaccination en Côte d'Ivoire : étude qualitative, 2022

Akani Bangaman Christian¹, Samassi Sokodogo Awa Madaho², Konan Loukou Gilbert¹, Konan Eugène¹, Acray- Zengbe Pétronille¹

1. Département de Santé Publique et Spécialités, UFHB

2. Département de Santé Publique et Spécialités, INHP

Introduction : Initié par les autorités sanitaires ivoiriennes et ses partenaires techniques et financiers, le paiement numérique des agents vaccinateurs offre un potentiel considérable pour améliorer la qualité des services de vaccination. Notre objectif visait à examiner les avantages et les limites de l'utilisation de ce mode de paiement dans les activités vaccination.

Méthode : Nous avons conduit de juin à juillet 2022 des entretiens individuels approfondis avec des bénéficiaires, les représentants et les partenaires du ministère de la santé. Les données collectées ont été retranscrites et analysées par une approche inductive, utilisant le logiciel Nvivo 12.

Résultats : Au total 14 entretiens individuels approfondis ont été réalisés dont des représentants du ministère de la santé (n=3), des bénéficiaires (n=9), des partenaires techniques et financiers (n=2). Tous les participants à l'étude ont reconnu que le paiement digital représentait un mode de paiement fiable, confidentiel, sûr et sécurisé, qui renforce la confiance entre les différents acteurs et qui évite les fraudes, les déplacements et les longues attentes. Les inconvénients évoqués étaient les problèmes liés à la couverture de réseau, la manipulation du téléphone, l'identification des bénéficiaires, les arnaques, les erreurs dans l'établissement des listes, et les retards de paiements.

Conclusion : Le paiement numérique dans le contexte de la vaccination offre des avantages, mais il est essentiel de résoudre les limites identifiées pour assurer son efficacité et sa pérennité.

Mots clés : Vaccination, paiement numérique, personnels de santé, Côte d'Ivoire

[C178] Étude des facteurs associés à la vaccination contre la rougeole chez les enfants âgés de 12 à 59 mois dans la commune de Tambacounda (Sénégal)

Tidiane Gadiaga¹, Mouhamadou Faly Ba², Siré Sagna³, Ousseynou Badiane⁴, Abdoulaye Diallo⁵, Sylla Thiam⁵, Elhadj Konko Ciré B⁵, Samba Cor Sarr¹, Mouhamaddou Mbacké Leye², Jean Louis Abdou Ndiaye⁵

1. Direction de la Planification de la recherche et des statistiques, Ministère de la Santé et de l'Action sociale, Dakar, Sénégal
2. Institut santé et développement, Université Cheikh Anta Diop, Dakar, Sénégal
3. District sanitaire de Tambacounda, Ministère de la Santé et de l'Action sociale, Sénégal
4. Direction de la Prévention, Ministère de la Santé et de l'Action sociale, Dakar, Sénégal
5. Université Iba Der Thiam de Thiès, Thiès, Sénégal

Introduction : Pour améliorer la couverture vaccinale contre la rougeole chez les enfants dans la commune de Tambacounda, une enquête ménage a été faite auprès des mères et/ou gardiennes d'enfants. L'objectif était d'étudier les facteurs liés à la couverture vaccinale au RR1 chez les enfants de 12 à 59 mois.

Méthode : Une étude transversale descriptive et analytique était réalisée du 1er au 6 Août 2022 avec un sondage aléatoire en grappes à trois degrés. La collecte des données était faite sur questionnaire, la saisie et l'analyse des données sur Epi Info 7.2 et R.

Résultats : Parmi les femmes enquêtées (714), les mères biologiques (94,1%) étaient les plus représentatives, 89,6% étaient mariées, 74,5% ménagères et 48,3% non instruites. Seules 58,1% des femmes connaissaient la maladie contre laquelle on vaccine l'enfant, 43,1% l'âge du premier contact avec le vaccin RR et 42,1% le nombre de contacts. Une proportion de 82,6% des femmes enquêtées était satisfaite de l'accueil, 79,5% du temps d'attente et 81,2% des explications sur le RV. L'âge moyen des enfants était de 33,7 mois. Seuls 80,0% des enfants étaient vaccinés au RR1 et 8,0% avaient présenté un épisode de rougeole ou des signes suspects de la maladie. Il existait un lien statistiquement significatif entre la vaccination au RR1 de l'enfant avec la scolarisation de la mère (OR=1,69), la connaissance de l'importance de la vaccination par la femme (OR=3,67), la connaissance de l'âge du premier contact RR (OR=1,77), la connaissance du nombre de contact RR (OR=2,35), la satisfaction de la femme par rapport à l'accueil (OR=1,76) et au temps d'attente (OR=1,55).

Conclusion : Le rapprochement des sites de vaccinations aux ménages, la réduction du temps d'attente, l'amélioration de l'accueil et l'accroissement des connaissances des femmes sur la vaccination RR constituent des piliers essentiels pour améliorer la couverture vaccinale contre la rougeole à Tambacounda

Mots clés : Couverture vaccinale Rougeole, Tambacounda, Sénégal

[C179] Profils de résistance de *Klebsiella pneumoniae* isolées des hémocultures chez l'enfant de 0 à 15 ans à l'Institut Pasteur de Côte d'Ivoire de 2021 à 2022

Okpo-Boyoun Sophia¹, Yapi Adompo Jaures Cedric¹, Anné Blessa Jean Claude¹, Kangah-N'goran Asseh Tatiana¹, Kouame Elogne Clarisse¹, Guessend Nathalie¹, Dosso Mireille¹

1. Département de Bactériologie-virologie, IPCI

Introduction : Les bactéries du genre *Klebsiella* sont endémiques dans les services de néonatalogie, et les éclosions nosocomiales dans ce type de services, sont fréquentes. *Klebsiella pneumoniae* (Kp) est responsable de nombreuses affections notamment de septicémies. Cependant, l'augmentation de la résistance aux antibiotiques rend difficile la prise en charge chez ces patients fragiles. D'où l'intérêt de notre travail qui est de décrire la résistance de Kp dans les bactériémies chez les enfants.

Méthode : Etude rétrospective qui a porté sur les souches de Kp isolées de 2021 à 2022 à l'Institut Pasteur. Ont été incluses, toutes les hémocultures provenant des cas de bactériémies chez les enfants de 0 à 15ans dans services de Néonatalogie et de Pédiatrie. Les échantillons de sang ont été analysés et les bactéries isolées ont été identifiées par les techniques usuelles de la bactériologie classique. L'antibiogramme souches a été réalisé selon la méthode de diffusion sur gélose de Kirby bauer et l'interprétation conformément aux normes du CASFM-EUCAST 2021-2022.

Résultats : Sur 276 cas de bactériémies, Kp a été isolée dans 19,20% des cas. Les souches de Kp productrices de bêta lactamase à spectre élargi (BLSE) représentaient 68,9% ; celles présentant une résistance croisée aux fluoroquinolones (RCF) étaient de 39,6%, les résistantes à l'imipenem (carbapénem) étaient de 9,4%. Les bactéries BLSE+RCF étaient de 28,3% et les BLSE+RCF+IMPR représentaient 3,8%.

Conclusion : La circulation de souches de Kp multi résistantes dans les services de pédiatrie et néonatalogie nécessiterait un renforcement de la surveillance

Mots clés : *Klebsiella pneumoniae*, septicémie, enfant, résistance

[C180] Les facteurs de risque de prématurité à l'hôpital général de Yopougon Attié, en Côte D'Ivoire

Ekra Kouadio Daniel¹, Ano Ama K Marie Noelle^{1,2}, Ehilé Kacou Marielle³, Diallo Maky^{1,4}, Konan N'guessan², Akani Bangama Christian^{1,2}, Ekou Franck Kokora^{1,2}, Sangaré Nantenin⁵, Dagnan N'cho Simplicie¹

1. Département de Santé publique et Spécialités
2. Institut National Hygiène Publique
3. CHU de Yopougon, service de Pédiatrie
4. Laboratoire de Biostatistique, Méthode et Informatique médicale, UFHB
5. Hôpital Général de Yopougon Attié, service de Pédiatrie

Introduction : La prématurité représente 29% des principales causes directes de mortalité néonatale. L'objectif de notre travail était d'identifier les facteurs en cause dans la survenue des accouchements prématurés au service de néonatalogie de l'hôpital général de Yopougon Attié.

Méthode : Il s'agissait d'une étude prospective à visée descriptive qui s'est déroulée sur 03 mois. Ont été inclus toutes naissances prématurées de 0 à 28 jours admises au service de néonatalogie pendant la période d'étude.

Résultats : Au total, 69 prématurés ont été enregistré. La proportion de naissances prématurées moyennes était de 55,1%, grande prématuré 40,6% et très grande prématurité 4,3%. Avec 50,7% qui avaient un poids entre 1500 et 2000 grammes et un apgar entre 7-8. La majorité des mères vivaient en couple soit 47,8% des cas et le budget journalier pour le repas familial était de 2000 francs pour 34,8% des ménages. Et 49,3% vivaient dans des cours communes et exerçaient un emploi de vendeuse dans 40% des cas. Plus de trois CPN1 avaient été réalisé par 39,1% des gestantes avec la moitié qui avaient réalisé un bilan prénatal. Les complications survenues à l'accouchement ont été les hémorragies dans 7,2% des cas, les infections dans 8,7% des cas et les ruptures prématurées de membrane à 2,9%. Le lieu de l'accouchement était le domicile dans 11,6% des et la rue dans 1,4% des cas. Le paludisme, les infections urinaires et l'HTA ont été retrouvé à respectivement 23,2% et 5,8% des pathologies sur la grossesse.

Conclusion : Les travaux réalisés ont retrouvé nombre de facteurs associés à la prématurité. Le poids des facteurs sociaux et du mauvais suivi de grossesse, suggéraient qu'une approche populationnelle pourrait être pertinente. Ainsi les femmes les plus vulnérables résidaient souvent dans des zones bien identifiées qui pourraient faire l'objet d'actions ciblées.

Mots clés : Prématurité, Facteurs de risque, Hôpital Général Yopougon Attié, Côte d'Ivoire

[C181] Immunologie et Santé Publique en Afrique : une combinaison gagnante

Liliane K. Siransy¹, Dasse S. Romuald¹, Adou Honoré¹, Nguessan Charles¹, Patricia Kouacou¹, Richard Yeboah¹, Memel Charlene¹, Assi-Sahoin Aniella¹, Oura Doris¹, Moussa Y. Salimata¹, Seri Jocelyne¹

1. Département Immunologie, UFRSMA

Introduction : Les liens entre la santé publique et l'immunologie sont profonds et significatifs. L'immunologie apporte un soutien crucial à la santé publique contribuant à la prévention, à la gestion et à la compréhension des maladies.

Méthode : L'immunologie, qui est l'étude du système immunitaire de l'organisme, joue un rôle essentiel dans la santé publique de plusieurs manières.

Résultats : 1. Vaccination et prévention des maladies infectieuses : L'immunologie est à la base du développement de vaccins et de traitements. Les vaccins stimulent le système immunitaire pour qu'il produise une réponse immunitaire protectrice 2. Gestion des épidémies et pandémies : L'immunologie joue un rôle clé dans la compréhension de la propagation des maladies infectieuses et la surveillance de l'immunité collective est essentielle pour contrôler les épidémies et les pandémies. 3. Recherche sur les maladies infectieuses : Comprendre comment le système immunitaire réagit aux agents pathogènes aide à développer des traitements et des thérapies pour lutter contre ces maladies. 4. HLA : L'association entre les antigènes HLA (Human Leukocyte Antigens ou Antigènes Leucocytaires Humains en français) et les maladies est un domaine de recherche essentiel. Plusieurs maladies comme le diabète de type 1, ont été associées à des variants spécifiques des antigènes HLA. Ces associations peuvent être utilisées pour aider au diagnostic et à la compréhension des mécanismes sous-jacents de ces maladies. Ceci peut être exploitée pour le développement de médicaments personnalisés et de thérapies ciblées.

Conclusion : L'immunologie et la santé publique sont étroitement liées, car la compréhension du fonctionnement du système immunitaire et la mise en œuvre de mesures préventives sont essentielles pour préserver la santé des populations et lutter contre les maladies qu'il s'agisse de lutter contre les infections, de traiter les allergies, les cancers ou les maladies auto-immunes.

Mots clés : Immunologie, Santé Publique, Vaccination, Prévention des maladies infectieuses, Afrique

[C182] Séroprévalence chez les donneurs de sang et impact sur la qualité des produits sanguins 2000 à 2022.

Liliane K. Siransy¹, Oura Doris¹, Moussa Y. Salimata¹, Honoré Adou¹, Patricia Kouacou¹, Richard Yeboah¹, Memel Charlene¹, Assi-Sahoin Aniella¹, Seri Jocelyne¹, Dasse S. Romuald¹

1. Département d'Immunologie UFRSMA

Introduction : La forte prévalence de nombreuses maladies infectieuses transmissibles par transfusion sanguine comme le virus de l'immunodéficience humaine (VIH), le virus de l'hépatite B (VHB) et le virus de l'hépatite C (VHC) en Afrique subsaharienne et particulièrement en Côte d'Ivoire met en mal la sécurité transfusionnelle. Cette étude visait à déterminer la prévalence au VIH, au VHB et au VHC chez les donneurs de sang sur une période de vingt-deux ans au Centre National de Transfusion Sanguine de Côte d'Ivoire.

Méthode : Les données ont été colligées à travers les rapports d'activités du CNTSCI. Les informations concernant les marqueurs infectieux ont été relevés sur la période de janvier 2000 à décembre 2022

Résultats : Entre 2000 et 2022, un total de 2 711 641 dons ont été réalisés grâce à la générosité de personnes bénévoles et volontaires pour le don de sang. L'analyse de tendance montre que les séroprévalences VIH, et VHC ont considérablement diminué sauf pour l'hépatite B où elles restent élevées. En 2022, les prévalences du VIH, de l'Hépatite B et C étaient respectivement de 0,8%, 6% , 1,08% contre 4,5%, 5,75% et 3,25% en 2000.

Conclusion : Le risque infectieux lié aux produits sanguins reste important malgré les dépistages systématiques des marqueurs infectieux. L'amélioration constante du recrutement et de la sélection des donneurs est nécessaire pour améliorer la sécurité transfusionnelle et l'étude de l'impact du DGV permettrait de diminuer le risque résiduel vis-à-vis des agents conventionnels recherchés.

Mots clés : Evolution des prévalences, VIH, VHB, VHC, donneurs de sang, Côte d'Ivoire.

[C183] Séroprévalences VIH, VHB et VHC chez les donneurs de sang de 2000 à 2022 et impact sur la qualité des produits sanguins

Liliane K. Siransy¹, Oura Doris¹, Moussa Y. Salimata¹, Honoré Adou¹, Patricia Kouacou¹, Richard Yeboah¹, Memel Charlene¹, Assi-Sahoin Aniella¹, Seri Jocelyne¹, Dasse S. Romuald¹

1. Département d'Immunologie UFRSMA

Introduction : La forte prévalence de nombreuses maladies infectieuses transmissibles par transfusion sanguine comme le virus de l'immunodéficience humaine (VIH), le virus de l'hépatite B (VHB) et le virus de l'hépatite C (VHC) en Afrique subsaharienne et particulièrement en Côte d'Ivoire met en mal la sécurité transfusionnelle. Cette étude visait à déterminer la prévalence au VIH, au VHB et au VHC chez les donneurs de sang sur une période de vingt-deux ans au Centre National de Transfusion Sanguine de Côte d'Ivoire.

Méthode : Les données ont été colligées à travers les rapports d'activités du CNTSCI. Les informations concernant les marqueurs infectieux ont été relevés sur la période de janvier 2000 à décembre 2022.

Résultats : Entre 2000 et 2022, un total de 2 711 641 dons ont été réalisés grâce à la générosité de personnes bénévoles et volontaires pour le don de sang. L'analyse de tendance montre que les séroprévalences VIH, VHB et VHC ont considérablement diminué sauf pour l'hépatite B (VHB) où elles restent élevées. En 2022, les prévalences du VIH, de l'Hépatite B et C étaient respectivement de 0,8%, 6%, 1,08% contre 4,5%, 5,75% et 3,25% en 2000.

Conclusion : Le risque infectieux lié aux produits sanguins reste important malgré les dépistages systématiques des marqueurs infectieux. L'amélioration constante du recrutement et de la sélection des donneurs est nécessaire pour améliorer la sécurité transfusionnelle et l'étude de l'impact du DGV permettrait de diminuer le risque résiduel vis-à-vis des agents conventionnels recherchés.

Mots clés : Prévalence, incidence, risque résiduel, VIH, VHB, VHC, donneurs de sang, 2000-2022.

[C187] Prevalence et facteurs associes au vih chez les diabetiques suivis au centre antidiabetique d'abidjan (COTE D'IVOIRE)

Konan Yao Eugène¹, Tetchi Ekissi Orsot¹, Ekou Franck Kokora¹, Akanza Akpole Kindo Coquin¹, Diallo Maky¹, Boumouan Jean Fabien¹, Aka Felix², Tiembre Issaka¹, Dagnan N'cho Simplicie¹

1. Département de Santé Publique et Spécialités (UFR Sciences Médicales Abidjan, Université Félix Houphouët Boigny ; Institut National de Santé Publique (Côte d'Ivoire)

2. Centre antidiabétique d'Abidjan (Institut National de Santé Publique, Côte d'Ivoire)

Introduction : La prévalence du VIH en Côte d'Ivoire était 2,39% en 2019. Cependant, cette valeur générale pourrait masquer des différences entre les différents groupes de populations. La présente étude avait pour objectif de déterminer la prévalence et d'identifier les facteurs de risque du VIH chez les diabétiques

Méthode : Cette étude a consisté en une enquête transversale à visée descriptive et analytique avec analyse rétrospective des dossiers de 840 diabétiques soumis au test de dépistage du VIH en 2019 et en 2020. Elle s'est déroulée au centre antidiabétique d'Abidjan de novembre 2020 à janvier 2021. Une analyse multivariée en régression logistique a été réalisée au seuil de 5% afin d'identifier les facteurs de risque associés.

Résultats : Les diabétiques en majorité de sexe féminin (58,3%) avait un âge moyen de 51,5 ans avec des extrêmes de 20 ans et de 83 ans. Sur les 840 diabétiques testés pour le VIH, 39 avaient un résultat positif soit une séroprévalence de 4,6%. En analyse multivariée, les facteurs associés retrouvés ($p < 0,05$) étaient la présence de surcharge pondérale ($OR = 0,22$ [0,07-0,65]), les complications infectieuses ($OR = 3,54$ [1,42-8,80]) et les complications métaboliques ($OR = 5,98$ [1,12-31,88]).

Conclusion : La séropositivité au VIH est élevée chez les diabétiques suivis au Centre antidiabétique d'Abidjan. Les complications infectieuses et métaboliques sont les facteurs prédictors de la séropositivité au VIH chez les diabétiques. Les résultats de cette étude peuvent contribuer à l'élaboration des programmes de lutte spécifiques contre le VIH/SIDA dans ce centre de référence nationale de prise en charge du diabète en Côte d'Ivoire.

Mots clés : Prévalence, VIH, diabétique, facteurs associés, Abidjan, Côte d'Ivoire

[C188] Facteurs associés à la pratique de l'allaitement maternel exclusif dans le district sanitaire de Podor au Sénégal en 2020

Papa Gallo Sow¹, Aboubakry Dramé¹, Djibril Diallo², Oumar Bassoum², Gora M'baye², Yoro Tine²

1. Université Alioune Diop de Bambey, Département santé communautaire

2. Université Cheikh Anta Diop de Dakar, Département Pharmacie

Introduction : L'Allaitement maternel exclusif (AME) au sein diminue la mortalité infantile imputable aux maladies courantes de l'enfance comme les diarrhées ou les pneumopathies et il accélère la récupération en cas de maladie. Malgré ce pouvoir bénéfique, l'allaitement maternel rencontre différents obstacles selon qu'il s'agisse des pays riches ou des pays pauvres.

Méthode : Une étude transversale à visée analytique et à base communautaire était réalisée. Il s'agissait d'une analyse secondaire de données collectées lors d'une enquête de couverture vaccinale chez les enfants âgés de 12 à 23 mois. La population étudiée était constituée des mères d'enfants âgés de 12 à 23 mois. Au total 870 participants ont été retenus après le calcul de la taille de l'échantillon selon la formule de schwartz. Un sondage en grappes à deux degrés était réalisé.

Résultats : Les résultats ont montré que l'âge moyen des mères était de 26,5 ans (sd=6,6) allant de 12 à 60 ans et 54,1 % d'entre elles n'étaient pas scolarisées. Les enquêtées qui étaient mariées représentaient 62,2% et la majorité de celles-ci (86,3%) avait mis au sein leur enfant dans l'heure qui a suivi la naissance. L'analyse bi-variée montre que La proportion d'AME chez les enquêtées non mariées était de 94,7% tandis qu'elle était de 73,5% chez enquêtées mariées ($p<0,001$). Notons que 78,8% des enfants exclusivement allaités avaient effectué la vaccination HEPB zéro ($p<0,001$).

Conclusion : L'AME est une préoccupation et une priorité de santé publique puisqu'il présente de nombreux bénéfices pour la santé de la mère et de son enfant.

Mots clés : Connaissances, Attitudes, Pratiques Allaitement, maternel, Sénégal

[C189] Surveillance basée sur les événements : description de la mise en place du Manuel Multisectoriel en Côte d'Ivoire

Traore Youssouf^{1,2}, Kadjo Florence¹, Ouattara Douyeri Thierry³, N'guesssan Saya⁴, Savané-Kroman Sita¹, Coulibaly Daouda¹, Chérif Djibril¹, Benié Bi Vroh Joseph^{1,2}

1. Institut National d'Hygiène Publique

2. Département de Santé publique et Spécialités : UFR Sciences Médicales d'Abidjan, Université Félix HOUPHOUËT-BOIGNY, Côte d'Ivoire

3. Direction des Services vétérinaires

4. International Rescue Committee (IRC), Côte d'Ivoire

Introduction : Le règlement sanitaire international recommande le renforcement des capacités de prévention, détection et de riposte aux urgences de santé publique. La Côte d'Ivoire a décidé de mettre en place le système de surveillance fondée sur les événements (SBE) avec pour objectif de décrire le processus de mise en place par l'élaboration du manuel multisectoriel.

Méthode : Le processus de mise en place de la SBE a débuté depuis l'an 2018 pour répondre aux épidémies. Suite à l'adhésion du gouvernement ivoirien à cette nouvelle approche, plusieurs groupes de travail techniques ont été constitués avec l'identification des secteurs susceptibles d'être impliqués dans la mise en œuvre de cette surveillance. Par la suite, les acteurs provenant des institutions impliquées dans cette surveillance ont de façon consensuelle retenus des signaux et décrit le circuit de notification des signaux.

Résultats : Les résultats découlant de ce processus étaient les suivants :

- Identification des signaux prioritaires pour le système de santé ivoirien sur la base d'un consensus impliquant tous les secteurs
 - Description des étapes et du circuit de l'information. Suite à l'implication de tous les secteurs, le circuit de notification par de la communauté reposant sur la pyramide sanitaire. Depuis la communauté, les acteurs communautaires notifient les signaux aux responsables des aires de santé par la santé humaine et/ou correspondant des autres secteurs. Elle a permis de standardiser la collecte des données et la notification
 - Développement des formulaires de notification des signaux pour la surveillance
- Toute chose qui dénote notre engagement pour faire suite aux recommandations.

Conclusion : La SBE, approche nécessaire à la prévention, détection et réponse des événements de santé publique. Ce processus confirme l'implication et l'adhésion des acteurs et du gouvernement ivoirien, et mérite un partage d'expérience.

Mots clés : Manuel Multisectoriel – SBE – Mise en place

[C192] Une revue systématique des facteurs associés à l'utilisation effective des latrines par les ménages

Nicolas Gaffan¹, Alphonse Kpozèhouen¹, Cyriaque Degbey¹, Yolaine Glèlè Ahanhanzo¹, Moussiliou Noël Paraïso¹

1. Département d'Epidémiologie et de Biostatistiques, Institut Régional de Santé Publique, Université d'Abomey-Calavi, Ouidah, Bénin

Introduction : Des travaux en Afrique et Asie rapportent que plus de la moitié des ménages disposant de latrines continuent de pratiquer la défécation à l'air libre. Ce constat soulève la question, pourquoi les ménages disposant de latrines ne les utilisent-ils pas ? Afin d'apporter des éléments de réponses à cette question, le présent travail se propose de faire une revue de la littérature sur les facteurs qui déterminent l'utilisation effective des latrines par les ménages.

Méthode : Nous avons effectué une revue de la littérature à partir des banques de données PubMed, Google Scholar, ScienceDirect, Epistemonikos, Cairn et Semantic Scholar jusqu'en Avril 2023. Des articles supplémentaires ont été identifiés à l'aide des références des articles inclus. Une analyse de contenu a été réalisée afin d'identifier les facteurs associés à l'utilisation effective des latrines.

Résultats : Cette revue de la littérature a sélectionné un total de 31 articles. Le pourcentage d'utilisation des toilettes variait de 36,00 % à 94,30 %. On note une utilisation moindre des latrines chez les individus ayant un âge avancé et peu ou pas instruits, en comparaison aux jeunes et ceux ayant un niveau d'instruction élevé. De même, les membres des ménages sans enfants scolarisés, de taille élevée et pauvres faisaient moins usage des latrines dont ils disposaient par rapport à ceux venant de ménage avec des enfants scolarisés, de faible taille et riches. Diverses caractéristiques inhérentes aux latrines, telles que leur âge, leur accessibilité géographique, leur superstructure et le niveau d'implication des membres des ménages dans leur construction, ont été identifiés comme ayant une influence notable sur leur utilisation effective. L'exposition à des actions de communications en matière d'assainissement augmentaient les chances pour une utilisation effective des latrines par les membres des ménages.

Conclusion : L'étude fournit des preuves pour orienter les efforts visant à améliorer l'utilisation des toilettes.

Mots clés : latrines, toilette, assainissement, barrière, utilisation, revue de littérature, Asie, Afrique

[C193] Etude du niveau de satisfaction des bénéficiaires des activités des équipes d'intervention rapide dans la riposte contre la covid-19 à Abidjan de juin 2020 à mai 2022

Ano Ama K Marie Noelle^{1,2}, Diallo Maky^{2,3}, Zogbe Bérengère¹, Yao Gogoly Joseph⁴, Benie Bi Vroh Joseph

1. Institut National Hygiène Publique
2. Département de Santé publique et Spécialités
3. Laboratoire de Biostatistique, Méthode et Informatique médicale, UFHB
4. UFR Sces Médicales Abidjan

Introduction : L'épidémie de COVID-19 a été déclarée urgence de santé publique de portée internationale en janvier 2020 par l'OMS, ce qui a conduit à des mesures de prévention et de contrôle strictes mises en place par le gouvernement ivoirien dont l'instauration des EIR.

Méthode : Il s'agit d'une étude transversale portant sur les usages des services des EIR faite dans le grand Abidjan. A partir d'une revue documentaire les enquêtés ont été sélectionnés et interviewés à partir d'un questionnaire après consentement éclairé.

Résultats : Les bénéficiaires des EIR étaient en des hommes dans 62,8% âgés de 55±6,4 ans en moyenne résidant dans la commune de Cocody (43,86%). Le lieu privilégié des prélèvements était au domicile (62,18%) et 43,67% des prélèvements étaient destinés au dépistage. 66,08% étaient modérément satisfaits et 23,78% étaient très satisfaits. 33,89% les agents ont été trouvés très réactifs. 66,3% des enquêtés ont trouvé que la stratégie des EIR était une bonne initiative. Les prélèvements étaient dans 43,67% pour des dépistages, à 29,62% pour les voyageurs suivis à 15,57% pour des contrôles et enfin à 11,14% pour des manifestations.

Conclusion : Les EIR ont répondu aux attentes des populations et étaient un élément important de la riposte contre la COVID-19. Il faudrait une meilleure communication sur les actions des EIR.

Mots clés : Activité, équipes d'intervention rapide, riposte, COVID-19, appréciation

[C194] Facteurs de risque cardiovasculaire chez les femmes après un trouble hypertensif de la grossesse : données du système de surveillance démographique et sanitaire Kaya (Kaya-HDSS).

Franck Garanet¹, Imou ouro-Bang'na², Adama Baguiya¹, Abou coulibly¹, Wendpouiré Ida Carine Zida-Compaoré³, Kadari Cissé¹, Seni Kouanda^{1,4}

1. Centre National de la Recherche Scientifique et Technologique (CNRST), Institut de recherche en Sciences de la santé (IRSS), Kaya Unit, Ouagadougou, Burkina Faso

2. Université Senghor, Alexandrie, Égypte

3. Université de Lomé, Département de santé publique, Lomé, Togo

4. Institut Africain de Santé Publique (IASP), Ouagadougou, Burkina Faso

Introduction : Les troubles hypertensifs de la grossesse (THG) sont une cause majeure de morbidité et de mortalité materno-fœtales, avec une prévalence mondiale de 10 à 15 %. Des études ont montré que les femmes atteintes de THG ont deux fois plus de risques de maladie cardiovasculaire (MCV). La période post-partum permet d'identifier ces femmes pour leur fournir une gamme de soins préventifs par le biais de conseils, soutenus par diverses sociétés savantes de ces troubles. L'objectif de cette étude était d'identifier les facteurs de risque cardiovasculaire chez les femmes atteintes de THG sur le système de surveillance démographique et sanitaire Kaya (Kaya-HDSS).

Méthode : Une étude transversale a été réalisée du 10 au 18 juillet 2021, avec des femmes Kaya-HDSS après un THG. Un questionnaire normalisé a été utilisé pour la collecte des données.

Résultats : Au total, 60 femmes ont participé à l'étude. Les femmes avaient un âge moyen de 31,63±7,63 ans. Ils étaient pour la plupart mariés (96,7 %), originaires de régions urbaines (95,0 %). La présence de facteurs de risque supplémentaires pour les MCV, était de 20,0% pour le surpoids, 38,3% pour l'obésité, 58,3% pour l'obésité abdominale, 25,0% pour le mode de vie sédentaire, 25,0% pour la consommation de moins de 5 portions de fruits et légumes par jour, 3,3% pour le diabète. Moins d'un tiers (31,7 %) avait une pression artérielle non contrôlée.

Conclusion : La plupart des femmes après un THG au site Kaya-HDSS présentaient des facteurs de risque supplémentaires de MCV. Des initiatives doivent être prises pour renforcer le counseling post-partum en lien avec les facteurs de risques cardiovasculaires.

Mots clés : Facteurs de risque, Troubles hypertensifs, Grossesse, Maladies cardiovasculaires, Kaya-HDSS, Burkina Faso

[C195] Facteurs associés de la consommation d'alcool chez les femmes enceintes au Burkina Faso : résultats d'une étude transversale

Franck Garanet¹, Adama Baguiya¹, Abou Coulibaly¹, Seni Kouanda¹

1.Centre National de la Recherche Scientifique et Technologique (CNRST), Institut de recherche en Sciences de la santé (IRSS), Kaya Unit, Ouagadougou, Burkina Faso

Introduction : Cette étude visait à estimer la prévalence de la consommation d'alcool chez les femmes enceintes au Burkina Faso et à identifier leurs facteurs associés.

Méthode : Les femmes enceintes qui ont suivi des services de soins prénatals entre décembre 2018 et mars 2019 ont été incluses dans cette étude. Un modèle de régression de Poisson modifié a été utilisé pour estimer les rapports de prévalence ajustés (RPa). Les participants qui avaient consommé toute forme d'alcool au cours des 30 derniers jours étaient considérés comme des consommateurs actuels.

Résultats : Au total, 1027 femmes enceintes ont participé à cette étude. Dans l'ensemble, 4,6 % des femmes avaient des maladies préexistantes ou des antécédents familiaux d'hypertension. La prévalence de la consommation d'alcool était de 10,2 % (intervalle de confiance (IC) à 95 % [8,51-12,23]). Cette prévalence était élevée dans le groupe des personnes sans emploi (10,9 %) et le quatrième quintile de richesse (13,2 %) (tableau 2). Dans le modèle de régression multivariable, les prédicteurs significativement associés à la consommation d'alcool étaient le niveau d'éducation primaire ou supérieur (rapport de prévalence ajusté (aPR) 1,82; IC à 95 % [1,27-2,62]) et les zones rurales (aPR) 1,94; IC à 95 % [1,31-2,87]

Conclusion : Cette étude a rapporté une prévalence élevée de la consommation d'alcool chez les femmes enceintes. Tout contact avec des femmes enceintes devrait être utilisé comme une occasion de conseiller les femmes sur la réduction des facteurs de risque liés au mode de vie cardiovasculaire afin d'améliorer les chances d'une meilleure expérience de grossesse et les résultats souhaités. D'autres recherches sont nécessaires pour déterminer les stratégies de prévention optimales pendant et après la grossesse afin d'améliorer la santé cardiovasculaire des femmes.

Mots clés : Alcool, femmes enceintes, facteurs associés, Burkina Faso

[C196] Evaluation de la plateforme nationale Une seule santé à l'aide de l'outil OH-APP (USAID) de 2018 à 2021 en Côte d'Ivoire

Kroman Savane Sita¹, Yao Kouadio Alain Marc², Kadjo Kouadio N. Judith Florence¹

1. Institut National d'Hygiène Publique ; Ministère de la Santé de l'Hygiène Publique et de la Couverture Maladie Universelle

2. Direction des Services Vétérinaires, Ministère des Ressources Animales et Halieutiques

Introduction : La plateforme Une seule santé est un mécanisme de coordination multisectorielle pour la prévention et la gestion des menaces sanitaires. Son niveau d'opérationnalisation est apprécié chaque année au cours d'une évaluation. Ainsi, de 2018 à 2021, quatre ateliers d'évaluations de la performance et de planification à l'aide de l'outil OH-APP (USAID) ont été conduits par les acteurs des différents secteurs impliqués dans l'approche Une seule santé.

Méthode : Nous avons réalisé une étude rétrospective basée sur la revue documentaire des rapports d'activités et des rapports d'évaluation générés par l'outil OH APP de l'USAID de 2018 à 2021. L'évaluation est basée sur le degré de maturité avec quatre niveaux : démarrage, développement, expansion et maturité.

Résultats : De façon générale, l'on retrouve une amélioration des capacités organisationnelles qui sont passées du niveau « Développement » en 2018 à un niveau « Expansion » en 2021 avec quatre domaines de capacités sur six ayant atteint le niveau « Maturité ». Concernant les performances organisationnelles, le niveau global « Développement » est resté identique depuis 2018 avec trois domaines de capacités sur six ayant atteint le niveau « Expansion » en 2021. Le statut du genre a atteint un niveau de maturité concernant "la composition et l'inclusion".

Conclusion : L'auto-évaluation annuelle a permis de considérer les domaines prioritaires dans les différents plans d'actions opérationnels de la plateforme Une seule santé. Néanmoins des efforts restent à faire pour améliorer les performances organisationnelles et de continuer le plaidoyer afin de mobiliser des ressources pour la mise en œuvre des activités planifiées.

Mots clés : Evaluation, Une seule santé, OH-APP, Côte d'Ivoire

[C197] Capacités de préparation et de réponse aux urgences sanitaires : évaluation de six COUSP régionaux en Côte d'Ivoire

Koffi Félix^{1,2}, Kadjou Florence^{1,2}, Yapi Marius^{1,2}, Atseye N'Cho Hyacinthe^{1,2}, Savané Sita^{1,2}, Beugré Landry^{1,2}, Cherif Djibril^{1,2}, Daouda Coulibaly^{1,2}, Benié Bi Vroh Joseph^{1,2}, Dakouri Djibret^{2,3}, San Koffi Adom⁴, Diarrassouba Mamadou⁵

1. Institut National d'Hygiène Publique
2. Centre des Opérations d'urgences de Santé Publique
3. Direction de la Santé et des Actions Sociales des Armées
4. Organisation Mondiale de la Santé (OMS)
5. Centre de prévention et de contrôle des infections, CDC, Bureau Côte d'Ivoire

Introduction : Le Centre des Opérations d'Urgence de Santé Publique (COUSP) coordonne les activités de prévention, de détection et de riposte aux menaces sanitaires. Cette gestion est réalisée au niveau décentralisé à travers les Centres des Opérations d'Urgences Régionaux (COUSP-R). Ainsi, six COUSP-R ont été créés par arrêtés préfectoraux et, trois années après leur mise en place, une évaluation du niveau de préparation et des capacités de réponse a été réalisée dans les régions de Guiglo, Bouaké, Man, Odienné, San Pedro et Aboisso.

Méthode : Une étude transversale descriptive, basée sur des entretiens individuels, l'observation, la visite des infrastructures et l'analyse des documents à l'aide de l'outil d'évaluation des capacités de gestion des urgences de santé publique de l'OMS a été conduite. Elle a permis d'évaluer les piliers d'un centre des opérations d'urgence.

Résultats : Les concepts liés à la gestion des urgences sont connus des membres de l'ensemble des COUSP R notamment le rôle du COUSP [75-100%], les fonctions des membres du système de gestion des incidents [50-75%] et le personnel d'appoint [26-50%]. Les infrastructures sont peu adaptées et sous équipées avec des besoins en réhabilitation. Moins de 25% disposent de procédures et de rapport d'évaluation des risques sanitaires. Concernant la riposte, 66% des COUSP régionaux ont été activés au moins une fois pour la gestion d'une urgence sanitaire et [26-50%] disposent de personnel pour les sections Opérations, Logistique ainsi que d'équipement minimal pour le déploiement des Equipes d'Intervention Rapide (EIR).

Conclusion : Les COUSP R, bien que disposant de ressources humaines impliquées dans les activités de préparation, sont confrontés à une insuffisance d'infrastructures et d'équipements. Un renforcement de capacités en gestion des urgences et des mécanismes réels de fonctionnement en routine doit être réalisé en vue de l'opérationnalisation effective des CROUSP R.

Mots clés : Evaluation ; Urgence sanitaire ; centre des opérations d'urgence

[C198] Déterminants de la consommation de tabac chez les adolescents scolarisés au lycée municipal 1 de Koumassi

Kouadio Evelyne¹, Angan G.A¹, Djegbeton Alitondé², Sangbeu Bertrand³

1. Département mère- enfant
2. Médecine et spécialité médicale
3. Physiologie biochimie pharmacologie

Introduction : le tabagisme en milieu scolaire est une réalité et pose un véritable problème de santé publique ce travail avait pour objectif de déterminer la prévalence et les facteurs associés à la consommation de tabac chez les adolescents scolarisés au lycée municipal 1 de Koumassi

Méthode : nous avons réalisé une étude transversale à visée descriptive et analytique au lycée municipal 1 de Koumassi du 22 au 26 mai 2023. Ont été inclus les adolescents de 10 ans à 19 ans quel que soit leur niveau d'étude.

Résultats : cette étude a porté sur 753 adolescents scolarisés au lycée municipal 1 de Koumassi. La prévalence du tabagisme était de 11,8%. On notait une prédominance masculine (57.3%) parmi les adolescents tabagiques avec un âge moyen de la première consommation de tabac à 13,48 ans. Ces adolescents consommaient le tabac par imitation des parents et des pairs (29,2%) et à la recherche de plaisir (40,4%) lors des fêtes (62,9%). Ce tabagisme s'inscrivait dans le cadre d'une poly intoxication avec l'alcool (77,5%) et la drogue (11,2%)

Conclusion : le tabagisme des adolescents au lycée municipal 1 de Koumassi est une réalité inquiétante. Le profil des adolescents tabagiques doit interpeller les autorités sur les stratégies de luttes ciblées, efficaces et la cellule familiale sur l'encadrement des adolescents

Mots clés : tabagismes- adolescents-déterminants-lycée municipal 1 de Koumassi

[C199] Evaluation du système de surveillance des Décès Maternels dans la région sanitaire de la Marahoué, Côte d'Ivoire 2020-2022

Gueu D. Judith¹, P. Wilnique², Otshudiandjeka³, E. Ahoussou⁴

1. IDE participant de FETP intermédiaire, Cote d'Ivoire
2. MD, coordinateur AFENET, FETP, Cote d'Ivoire
3. MD, conseiller résident FETP, Cote d'Ivoire
4. Epidémiologiste, Mentor FETP intermédiaire, Cote d'Ivoire

Introduction : La mortalité maternelle constitue un véritable problème de santé publique. La Côte d'Ivoire pays d'Afrique subsaharienne, a un taux estimé à 315 décès pour 100 000 naissances vivante. La stratégie pour réduire ce taux est la surveillance des décès maternel. L'objectif de l'étude est d'évaluer cette surveillance afin d'apprécier son utilité dans la réduction de la mortalité maternelle dans la région sanitaire de la Marahoué, Côte d'Ivoire.

Méthode : Analyse rétrospective de la base de données de décès maternelle MAGPI (2020-2022) avec le programme Epi Info 7.2 et enquête prospective qualitative par interview des principaux intervenants du système de surveillance réalisée en février 2023.

Résultats : Au total 60 décès maternels enregistrés dont 52 audités. 38 acteurs de la surveillance des décès maternels dans la Marahoué interviewé. La surveillance est complexe à 40% (définition de cas et réalisation d'enquête de confidentialité), mais acceptable à 95% (respect des délais de notification et de réalisation de revue), sensible à 100% et représentatif en personne, temps et lieu. Le système de surveillance est utile à 100% pour la détermination des causes évitables et la prise de décision pour prévenir ces décès évitables.

Conclusion : Bien que les taux de mortalité maternels aient diminué dans la région de la Marahoué, la surveillance des décès maternelle reste une des meilleures stratégies de réduction de la mortalité maternelle du fait de son utilité pour la réduction de la mortalité maternelle. La mise en œuvre des recommandations (renforcement du suivi de la mise en œuvre des actions correctrices issues des revues) pourraient augmenter l'impact de la surveillance sur la survie du couple mère enfant.

Mots clés : Evaluation, système de surveillance, Décès maternels, Marahoué, Cote d'Ivoire

[C200] Profil épidémiologique des Décès Maternels dans la région sanitaire de la Marahoué, Côte d'Ivoire 2020-2022.

Gueu D. Judith¹, P. Wilnique², Otshudiandjeka³, E. Ahoussou⁴

1. IDE participant de FETP intermédiaire, Cote d'Ivoire
2. MD, coordinateur AFENET, FETP, Cote d'Ivoire
3. MD, conseiller résident FETP, Cote d'Ivoire
4. Epidémiologiste, Mentor FETP intermédiaire, Cote d'Ivoire

Introduction : La mortalité maternelle constitue un véritable problème de santé publique. La Côte d'Ivoire pays d'Afrique subsaharienne, a un taux estimé à 315 décès pour 100 000 naissances vivante. Cependant, aucune analyse n'a été effectuée dans la région. L'objectif de cette étude est d'analyser les données des décès maternel de la région de la Marahoué

Méthode : Une étude a été menée de 2020 à 2022 sur les données de surveillance nationale MAGPI. Les fiches de déclaration et les rapports de revue de décès maternel ont également été utilisés. Les données ont été apurées et analysées avec les logiciels Excel et Epi Info 7.2. Ont été calculés les mesures de tendances centrales, proportions et taux.

Résultats : Au total 60 décès maternels enregistrés dont 52 audités. 38 acteurs de la surveillance des décès maternels dans la Marahoué interviewé. La surveillance est complexe à 40% (définition de cas et réalisation d'enquête de confidentialité), mais acceptable à 95% (respect des délais de notification et de réalisation de revue), sensible à 100% et représentatif en personne, temps et lieu. Le système de surveillance est utile à 100% pour la détermination des causes évitables et la prise de décision pour prévenir ces décès évitables.

Conclusion : Bien que les taux de mortalité maternels aient diminué dans la région de la Marahoué, cela reste toujours une préoccupation du fait des causes qui sont évitables. La mise en œuvre des recommandations (renforcement de capacité des sages femmes et renforcement du plateau technique des Hôpitaux de référence) issues des revues pourraient améliorer cet indicateur.

Mots clés : Profil épidémiologique, Décès maternels, Marahoué, Cote d'Ivoire

[C201] Audit de la prise en charge hospitalière de l'hémorragie digestive haute au service d'hépatogastroentérologie du CHU de Cocody

Nigue L¹, Allade N.E.B¹, Diallo M¹, Adjobia E.T.E², Lohoues-Kouacou M. J.

1.Laboratoire de Biostatistique, Méthode et Informatique médicale, UFHB

2.Service d'hépatogastro-entérologie CHU Cocody Abidjan

Introduction : Les hémorragies digestives hautes constituent des urgences médico-chirurgicales très fréquentes et graves en raison des risques élevés de décès. Quelle prise en charge au regard des recommandations de bonnes pratiques dans nos conditions de travail ? L'objectif était d'évaluer la prise en charge hospitalière de l'hémorragie digestive haute

Méthode : Etude rétrospective sur 46 mois (1^{er} janvier 2015 au 31 octobre 2018) au service d'hépatogastro entérologie du CHU de Cocody sur les dossiers des patients ayant présenté une hémorragie digestive haute et qui ont réalisé une FOGD. L'audit clinique a consisté en la comparaison des pratiques professionnelles à un référentiel.

Résultats : 100 dossiers retenus sur 167. Il s'agissait d'une hématemèse dans 56% des cas, deux hommes pour une femme, une moyenne d'âge de 49 ans avec 84% des patients à niveau de ressource faible. L'hémorragie était modérée (71%). Le délai moyen d'admission était de 79,44 heures. Les mesures de réanimation ont été appliquées à 100% sans traitement vasoactif. Les constantes hémodynamiques ont été surveillées deux fois par jour chez 59% des patients. La FOGD réalisée en 95,56 heures en moyenne. Etiologie dominée par l'UGD (34,64%) et la rupture des varices œsogastriques (31,38%). La ligature endoscopique des varices œsophagiennes a été réalisée chez 8% des patients. Le coût moyen de la prise en charge était de 10 730 FCFA pour l'UGD et de 201 730 FCFA pour les varices œsogastriques. La durée d'hospitalisation était en moyenne de 8 jours. La mortalité de 13%, La qualité de la prise en charge était influencée par la présence de VO et la récurrence hémorragique

Conclusion : La prise en charge de l'HDH n'est pas optimale comparée aux recommandations de bonnes pratiques applicables.

Mots clés : Audit Médical, Hémorragie digestive haute, prise en charge

[C1202] Impact du reflux gastro œsophagien sur la qualité de vie des patients au service de gastroentérologie du CHU de Cocody

Nigue L¹, Allade N.E.B¹, Diallo M¹, Fanou K. D², Lohoues-Kouacou M. J²

1.Laboratoire de Biostatistique, Méthode et Informatique médicale, UFHB

2.Service d'hépatogastro-entérologie CHU Cocody

Introduction : Le reflux gastro-œsophagien (RGO) représente un problème majeur pour santé publique en raison de sa forte prévalence. En Côte d'Ivoire, sa prévalence est estimée à environ 15%. Comme toute maladie chronique, le RGO peut altérer la qualité de vie (QdV) des patients. Le but de notre étude est d'évaluer l'impact du RGO sur la qualité de vie de nos patients et de déterminer les principaux facteurs aggravants.

Méthode : Il s'agit d'une étude transversale de 79 patients présentant des signes de RGO vue dans les services de consultation extrême et d'endoscopie digestive du CHU de Cocody pour une durée de 3 mois (juin & Aout 2020). Nous avons utilisé le Reflux-Qual simplifié (RQS), qui est un questionnaire spécifique, simple, fiable et sensible chez tout patients de plus de 15 ans présentant un ou plusieurs signes cliniques de RGO typiques (Pyrosis, régurgitation acide) associés ou non à des signes atypiques.

Résultats : Au cours de la période d'étude, 79 patients ont été inclus. L'âge moyen était de 43,73 ans ± 15,52 avec une sex-ratio H/F de 0,85. La qualité de vie des patients était altérée (RQS <16) chez 48, 10% de patients (n = 38). Cette déficience était associée avec l'âge (p = 0,00270), le sexe féminin (p = 0,0027) et la fréquence des symptômes (p = 0,0000), la sévérité des symptômes (p = 0,0000). De plus, les patients qui avaient un soulagement après la prise d'un traitement du RGO avaient un score de RQS » 16 (p = 0. 000). Cependant l'altération de la qualité de vie n'était pas associée à l'IMC, la répartition des heures de travail, le style de vie, les habitudes alimentaires et la durée d'évolution du RGO.

Conclusion : L'amélioration du niveau de vie des malades, un suivi régulier associé à une évaluation régulière de la QdV des patients lors des consultations pourrait améliorer leur bien-être.

Mots clés : Reflux gastro-œsophagien, Reflux-Qual short-form, qualité de vie

[C203] Profil des personnes en charge de la gestion des données dans les établissements de santé en Côte d'Ivoire

Allade N'dah Eric Bérenger^{1,2}, Nigué Luc^{1,2}, N'da Kouassi Ezéchiel Kouassi¹, Diallo Maky¹, Aka Joseph^{1,2}

1.Laboratoire de Biostatistique, Méthode et Informatique médicale.

2.Département de Santé publique et Spécialités

Introduction : Le système d'information sanitaire est un pilier du système de santé avec pour objectif la production de données de qualité pour une prise de décision factuelle. Le fonctionnement d'un tel système repose sur des ressources humaines capables d'en assurer sa gestion. En effet, la mue progressive de l'hôpital de l'offre de soins vers l'offre de service a mis en évidence le rôle nécessaire de nouveaux acteurs tels que les gestionnaires de données en santé dont les tâches principales sont la collecte, l'analyse et la transmission des données. Avec l'évolution et le développement des nouvelles technologies, il était important d'analyser les profils des acteurs en charge des données dans les établissements de santé.

Méthode : Nous avons conduit une étude évaluative transversale dans 20 structures de santé constituant des établissements pilotes du projet ACUIS (Amélioration des capacités d'Utilisation de l'information sanitaire).

Résultats : Sur 28 personnes en charge des données ayant participé à notre enquête, 78,6%% étaient composés de personnel de soins (infirmier/sage-femme). Seulement 10,8% étaient dans l'emploi des gestionnaires de données. 2/3 (67,9%) des personnes en charge des données occupaient plus d'une fonction en plus de celle de la gestion des données. Malgré un descriptif de poste existant pour leur fonction de gestionnaire de données, ceux-ci affirmaient n'avoir pas reçu de formation sur les activités de gestion des données au cours des deux dernières années. Seulement 46,4% disposaient d'un guide de procédure pour le travail quotidien. 46,4% utilisaient DHIS2 et 39,3% utilisaient Excel pour l'analyse des données.

Conclusion : Les chargés de la gestion des données doivent souvent naviguer dans un environnement où les ressources (tant humaines que technologiques) sont souvent limitées. Il paraît essentiel pour bâtir un système d'information performant, de reconnaître l'importance de ces professionnels et d'en élaborer un profil de carrière par la mise en place d'une formation dédiée.

Mots clés : Gestionnaires de données, utilisation des données, système d'information sanitaire, Côte d'Ivoire

[C204] Développement d'un système de gestion intégrée des notes de stages des étudiants à partir de district health information system 2 à l'unité de formation et de recherche sciences médicales abidjan

Allade N'dah Eric Bérenger^{1,2}, Nigué Luc^{1,2}, N'dri Kouakou Emmanuel¹, Diallo Maky¹, Aka Joseph^{1,2}

1 Laboratoire de Biostatistique, Méthode et Informatique médicale.

2 Département de Santé publique et Spécialités

Introduction : Le stage hospitalier constitue une place de choix dans la formation initiale des futurs cadres de la santé. Selon Bourgogne DRASS, la finalité de la formation au stage est d'amener l'étudiant à devenir un praticien autonome, responsable et réflexif. Ainsi les évaluations marquent la fin des stages et prennent en compte le savoir, le savoir-faire et le savoir être de l'étudiant. Ces notes sont délivrées par les encadreurs et transmises au décanat de manière manuelle ou sous format électronique par fichier Excel avec pour corollaire la non-réception des notes, retard dans la transmission des notes, notes perdues, incohérence dans les notes transmises et celles affichées entraînant ainsi un retard des délibérations ou les délibérations sans les UE stages. Dans une vision de modernisation, le décanat a souhaité développer une solution informatique adéquate pour une gestion intégrée des notes de stage des étudiants de l'UFR SMA à partir du logiciel DHIS2.

Méthode : Notre étude décrit le processus de développement logiciel en s'appuyant sur le circuit de transmission des notes de stages. La méthode ADDIE (Analyse, Design, Développement, Implémentation, Evaluation) a été utilisée pour la mise en œuvre de notre projet. Le langage UML pour le Design et le module Tracker de DHIS2 pour le paramétrage selon le processus organisationnel de la gestion des notes de stage a été utilisé. Le module de gestion des notes de stage a été validé conforme après une série de tests.

Résultats : L'analyse de l'existant a mis en évidence des encadreurs qualifiés et jeunes avec une moyenne d'âge de 42 ans, familiers aux outils informatiques et à l'utilisation des TIC. L'ensemble des encadreurs ont émis un avis favorable pour l'informatisation de la gestion des notes de stage. L'engagement du décanat dans un processus d'accréditation et la volonté d'informatisation du processus avec une expertise du Laboratoire de Biostatistique en DHIS2 (Logiciel open source) en constituaient les principales opportunités.

Conclusion : Le développement d'un module de gestion intégrée des notes de stage des étudiants de l'UFR SMA s'est avéré réalisable. Cette solution permettra de minimiser les erreurs, de transmettre les notes en temps réel avec un meilleur suivi et un meilleur archivage des notes.

Mots clés : Plateforme de gestion, notes de stage, DHIS2-Tracker, UFR Sciences Médicales d'Abidjan

[C299] Facteurs associés à la violence basée sur le genre chez les travailleuses du sexe à berbérati, république centrafricaine

Jean de Dieu Longo^{1,2}, Henri Saint Calvaire Diemer^{1,2}, Sylvain Honoré Woromogo^{1,3,4}, Rodrigue Herman Doyama-Woza¹, Prince Holfadh Farazara Kario¹, Gérard Grésenguet¹²

1. Public Health Department, Faculty of Health Sciences, Bangui, University of Bangui, Central African Republic

2. National Reference Centre for Sexually Transmitted Diseases and AIDS, Bangui, Central African Republic

3. Doctoral School of Human and Veterinary Sciences, University of Bangui, Central African Republic

4. Inter States Centre of Higher Education in Public Health for Central Africa, Brazzaville, Congo

Introduction : Le Centrafrique traverse depuis plusieurs années une crise complexe et profonde avec de graves conséquences humanitaires et de protection. Cela expose encore davantage les groupes les plus vulnérables que sont les femmes et les filles à davantage de violence, notamment au viol et aux agressions sexuelles. Les travailleuses du sexe (TS) font partie des populations les plus vulnérables à la violence basée sur le genre (VBG). C'est dans ce contexte que notre étude vise à décrire les cas de VBG chez les TS à Berbérati.

Matériels et méthodes : Une étude transversale a été menée en utilisant la technique d'échantillonnage piloté par les répondants (RDS) pour recruter des participants. Il s'agit d'une méthode de recrutement par paires souvent utilisée pour créer un échantillon à partir de graines. Les premières participantes, appelées « seed », sont ensuite invitées à recruter d'autres paires parmi une série de chaînes d'échantillonnage de référence.

Résultats : Au cours de cette période d'étude, 256 TS ont été recrutées. Les principaux déterminants associés à la violence sexuelle chez les TS étaient : la tranche d'âge de moins de 18 ans : (ORa = 2,69 [1,93 -3,28] ; p = 0,001) ; consommation régulière d'alcool : (ORa = 2,58 [1,39 - 4,78] ; p=0,003) ; le travail du sexe est la principale source de revenus : (ORa = 2,13 [1,94-3,08] ; p = 0,001) et avoir un partenaire sexuel (client) militaire ou policier : (ORa = 3,57 [2,81-5,23] ; p=0,001).

Conclusion : Cette étude a révélé que les adolescentes de moins de 18 ans qui vendent des services sexuels ; la consommation régulière d'alcool et d'autres substances psychoactives et le fait d'avoir un client militaire ou policier étaient associés à une forte probabilité d'être victime de violence sexiste. Le développement d'interventions spécifiques pour réduire ces risques est crucial.

Mots clés : Travailleuse du sexe, Violences basées sur le genre, RCA

[C300] Facteurs associés aux troubles dépressifs parmi Étudiants en médecine à Bangui

Jean de Dieu Longo^{1,2}, Henri Saint Calvaire Diemer^{1,2}, Sylvain Honoré Woromogo^{1,3,4}, Rodrigue Herman Doyama-Woza¹, Prince Holfadh Farazara Kario¹, Gérard Grésenguet¹²

1. Département de Santé Publique, Faculté des Sciences de la Santé, Bangui, Université de Bangui, République Centrafricaine ;
2. Centre National de Référence des Maladies Sexuellement Transmissibles et du SIDA, Bangui, République Centrafricaine ;
3. École Doctorale des Sciences Humaines et Vétérinaires, Université de Bangui, République centrafricaine ;
4. Centre Inter Etats d'Enseignement Supérieur en Santé Publique pour l'Afrique Centrale, Brazzaville, Congo

Introduction : La dépression est un trouble mental courant. On estime que 3,8% de la population est touchée, dont 5 % des adultes et 5,7 % des personnes de plus de 60 ans. De nombreuses études ont montré que les taux de dépression chez Les étudiants universitaires sont plus nombreux que ceux de la population générale. C'est dans ce contexte que notre étude propose de déterminer la proportion d'étudiants de la Faculté des Sciences de la Santé (FACSS) de l'Université de Bangui qui présentaient des symptômes de dépression et d'en analyser les déterminants.

Matériels et méthodes : Il s'agissait d'une étude transversale descriptive et analytique. La population étudiée était composée de tous les étudiants du FACSS régulièrement inscrits pour l'année universitaire 2021-2022. Deux des questionnaires ont été utilisés ; Le résumé de BECK pour évaluer le niveau de dépression et un autre questionnaire pour étudier ses déterminants. Les données ont été analysées à l'aide du logiciel Epi info.

Résultats : L'âge moyen des étudiants était de 21 ans ($\pm 2,5$ ans), avec des extrêmes allant de 16 à 31 ans. La majorité des étudiants étaient originaires de zones urbaines (81,8 %) et vivaient avec leurs parents/tuteurs (70,5%). La prévalence de la dépression chez les étudiants était de 52,6 %. Les principaux symptômes dépressifs subjectifs étaient la fatigue (63,5 %), la nécessité d'un effort physique supplémentaire pour travailler (61,4 %) et la tristesse (52,6 %). Difficultés de logement, absence de l'érudition et la pression des parents/tuteurs étaient les principaux facteurs associés à l'apparition de la dépression.

Conclusion : La forte prévalence de la dépression chez les étudiants du FACSS devrait inciter les responsables académiques à mettre en place un dispositif de détecter les élèves présentant des signes de dépression afin de leur proposer un soutien psychosocial.

Mots clés : Troubles dépressifs, Étudiants, Bangui

[C301] Prévention et Contrôle de la Tuberculose en Côte d'Ivoire : Connaissances et Pratiques en Biosécurité chez le personnel de laboratoire : cas des Centres Anti-Tuberculeux d'Adjamé et d'Abobo (Abidjan -Côte d'Ivoire / Afrique de l'Ouest)

Doumbia Mariamou Cissé^{1,2}, Kouakou Julie Sackou^{2,5}, N'gbesso N'gbesso Jean Paul³, Soumahoro Fatoumata Aïdja⁴, Cissé Raïssa Adja Mayaka², Guessennnd Nathalie Kouadio⁶

1. Ministère de la Santé, de l'Hygiène Publique et de la Couverture Maladie Universelle/Direction Générale de la Santé, BP V 4 Abidjan, CI-AB. IV93. 14/ CI.AB. 110. Côte d'Ivoire
2. Université Félix Houphouët Boigny au Département de Santé Publique de l'UFR des Sciences Pharmaceutiques et Biologiques, 22 BP 582 Abidjan 22, CI-AB. IV93. 14/ CI.AB. 110. Côte d'Ivoire
3. Laboratoire Biologie et Santé, Université Félix Houphouët Boigny, 22 B.P. 582, Abidjan 22, CI-UN B. IV93. 14/ CI.AB. 110. Côte d'Ivoire
4. Ministère de la Santé, de l'Hygiène Publique et de la Couverture Maladie Universelle/Programme National de Lutte contre la Tuberculose, BPV 47 Abidjan, CI-AB. IV93. 14/ CI.AB. 110. Côte d'Ivoire
5. Institut National de Santé Publique, BPV 47 Abidjan, CI-AB. IV93. 14/ CI.AB. 110. Côte d'Ivoire
6. Institut Pasteur de Côte d'Ivoire

Introduction : La biosécurité représente l'ensemble des mesures visant à prévenir et à contrer les dangers qui sont liés à la manipulation et à l'utilisation de matériel biologique dans les laboratoires. L'étude a permis d'évaluer le niveau de connaissances et de pratiques en biosécurité pour la détection du risque d'exposition du personnel de Laboratoire.

Méthodes : Une étude a été diligentée dans les Centres Antituberculeux (CAT) d'Adjamé et d'Abobo du 12 au 19 Octobre 2022. Un questionnaire couplé d'observations a servi à l'évaluation des connaissances et des pratiques en Biosécurité. La saisie des données et le traitement statistique ont été effectués par Excel et le R.

Résultats : L'étude a mis en évidence une connaissance moyenne en termes de biosécurité et des pratiques augmentant le risque d'exposition aux produits biologiques dans les CAT. Une couverture vaccinale faible a été signalée pour l'ensemble des acteurs. L'absence de produits de nettoyage du matériel techniques a été mentionnée. L'usage du même site pour le prélèvement et la réception du matériel biologique, ainsi que le traitement des blouses à domicile ont été signalées. Concernant la gestion des déchets, l'entreposage est utilisé. L'absence d'incinérateur a été également relevée dans les CAT visités.

Conclusion : La sensibilisation sur la biosécurité, la fourniture régulière en produits et matériels techniques, ainsi que la gestion rationnelle des déchets s'avèrent essentielles pour la sécurité du personnel travaillant dans les laboratoires des CAT d'Abobo et d'Adjamé.

Mots clés : Laboratoire ; Biosécurité ; CAT ; Abobo ; Adjamé ; Côte d'Ivoire.

[C302] Evaluation d'impact du projet « American Rescue Plan Act CN #164 COVID-19 avec l'appui de AFROHUN en Côte d'Ivoire via le financement USAID : Détermination des facteurs influençant le refus ou l'acceptation de la vaccination contre la COVID-19 en Côte d'Ivoire (Afrique de l'Ouest)

Doumbia Mariamou Cissé^{1,2}, Kouadio Luc Philippe^{2,3}, Koné Atioumounan Blaise^{1,3}, N'gbesso N'gbesso Jean Paul⁴, N'Guessan Monique⁵, Dionkounda Rondouba Aristide⁵, Samba Mamadou^{1,6}, Kouassi M'Bengue Alphonsine^{5,7}

1. Ministère de la Santé, de l'Hygiène Publique et de la Couverture Maladie Universelle/Direction Générale de la Santé, BP V 4 Abidjan, CI-AB. IV93. 14/ CI.AB. 110. Côte d'Ivoire
2. Université Félix Houphouët Boigny au Département de Santé Publique de l'UFR des Sciences Pharmaceutiques et Biologiques, 22 BP 582 Abidjan 22, CI-AB. IV93. 14/ CI.AB. 110. Côte d'Ivoire
3. Institut National d'Hygiène Publique, BPV 14 Abidjan 01, CI-AB. IV93. 14/ CI.AB. 110. Côte d'Ivoire
4. Laboratoire Biologie et Santé, Université Félix Houphouët Boigny, 22 B.P. 582, Abidjan 22, CI-UN B. IV93. 14/ CI.AB. 110. Côte d'Ivoire
5. Afrohun / UFR de Sciences Médicales, 01 BP V34, Abidjan, Réf.ECI554. Abidjan, CI-AB. IV93. 14/ CI.AB. 110. Côte d'Ivoire
6. Université Félix Houphouët Boigny au Département de Santé Publique, UFR d'Odonto-stomatologie, 01 BPV 34 Abidjan 01, CI-AB. IV93. 14/ CI.AB. 110. Côte d'Ivoire
7. Université Félix Houphouët Boigny, UFR de Sciences Médicales, 01 BP V34, Abidjan, Réf.ECI554. Abidjan, CI-AB. IV93. 14/ CI.AB. 110. Côte d'Ivoire

Contexte : La pandémie à CoViD-19 a menacé le monde entier par la rapidité de sa contagion et de son impact sur la Santé Publique. Pour lutter contre cette urgence sanitaire mondiale, des stratégies ont été mises en œuvre dont la vaccination anti-CoViD-19. Cependant, la vaccination a été confrontée à la réticence des communautés. L'objectif était de relever les facteurs influençant le refus et l'acceptation de cette vaccination.

Méthodes : Il s'agissait d'une étude transversale à visée descriptive et analytique menée du 13 au 27 mars 2023 à l'Université Félix Houphouët Boigny et écoles partenaires. Elle a combiné une approche mixte par la collecte de données quantitative et qualitative. Un questionnaire en ligne a été administré aux bénéficiaires des secteurs animal et humain, sur les connaissances, attitudes et facteurs liés à cette vaccination. Des interviews faites auprès de personnes ressources ont permis d'approfondir et d'explorer les préoccupations qui ont émergées de l'enquête en ligne. Les données ont été traitées avec le logiciel Excel 2010 et analysées avec le logiciel R.

Résultats : L'évaluation a permis d'interroger 478 individus et 12 interviews de personnes ressources tous consentant. Une proportion de 87,44% des répondants avait une connaissance générale de la maladie et de la vaccination contre la CoViD-19. La raison essentielle pour justifier le refus était les facteurs liés aux vaccins (OR=3,23, p-value < 0,05), en revanche les facteurs probables de l'acceptation étaient : protéger ma santé (OR=2,24 ; p-value < 0,05), travailler et voyager (OR=3,96 ; p-value < 0,05) et exigences de l'employeur (OR=3,76 ; p-value < 0,05).

Conclusion : La compréhension plus approfondie des facteurs influençant le refus et l'acceptation de la vaccination contre la CoViD-19 sont des aspects importants pour des stratégies efficaces d'amélioration du taux de couverture vaccinal.

Mots clés : Vaccination CoViD-19, Côte d'Ivoire, Afrique de l'Ouest.

[C303] Evaluation de la mise en œuvre des composantes de la prévention et du contrôle des infections dans 30 établissements de santé du District Autonome d'Abidjan (Côte d'Ivoire) avec l'outil cadre d'évaluation (IPCAF) de l'OMS

Doumbia Mariamou Cissé^{1,2}, Essis Esme Marie Laure^{3,4}, Koné Atioumounan Blaise^{1,5}, N'gbesso N'gbesso Jean Paul⁶, Mbengue Valérie Gbonon^{7,8}, Cissé Raïssa Adja Mayaka², Gagne Doh Eugénie⁹, Dagnan N'cho Simplicie¹⁰, Kouadio Luc Philippe^{2,5}, Samba Mamadou^{1,11}

1. Ministère de la Santé, de l'Hygiène Publique et de la Couverture Maladie Universelle/Direction Générale de la Santé, BP V 4 Abidjan, CI-AB. IV93. 14/ CI.AB. 110. Côte d'Ivoire
2. Université Félix Houphouët Boigny au Département de Santé Publique de l'UFR des Sciences Pharmaceutiques et Biologiques, 22 BP 582 Abidjan 22, CI-AB. IV93. 14/ CI.AB. 110. Côte d'Ivoire
3. Institut National de Santé Publique, BPV 47 Abidjan, CI-AB. IV93. 14/ CI.AB. 110. Côte d'Ivoire
4. Unité de Recherche en Santé de la Reproduction de Côte d'Ivoire, BPV 47 Abidjan, CI-AB. IV93. 14/ CI.AB. 110. Côte d'Ivoire
5. Institut National d'Hygiène Publique, BPV 14 Abidjan 01, CI-AB. IV93. 14/ CI.AB. 110. Côte d'Ivoire
6. Laboratoire Biologie et Santé, Université Félix Houphouët Boigny, 22 B.P. 582, Abidjan 22, CI-UN B. IV93. 14/ CI.AB. 110. Côte d'Ivoire
7. Institut Pasteur de Côte d'Ivoire, 01 BP 490 Abidjan 01, CI-AB. IV93. 14/ CI.AB. 110. Côte d'Ivoire
8. Plateforme de Génétique Moléculaire du Centre National de Référence, CI-AB. IV93. 14/ CI.AB. 110. Côte d'Ivoire
9. Direction de l'Hygiène Publique et de la Santé-Environnement, BP V 4 Abidjan, CI-AB. IV93. 14/ CI.AB. 110. Côte d'Ivoire
10. Université Félix Houphouët Boigny au Département de Santé Publique et de Biostatistique, UFR de Sciences Médicales, 01 BP V34, Abidjan, Réf.ECI554. Abidjan, CI-AB. IV93. 14/ CI.AB. 110. Côte d'Ivoire
11. Université Félix Houphouët Boigny au Département de Santé Publique, UFR d'Odonto-stomatologie, 01 BPV 34 Abidjan 01, CI-AB. IV93. 14/ CI.AB. 110. Côte d'Ivoire

Introduction : Dans le cadre de la mise en œuvre de sa mission « d'intégration des activités de l'hygiène dans les activités des soins de santé », la Direction Générale de la Santé a réalisé avec ses structures techniques, une évaluation de la mise en œuvre de la Prévention et du Contrôle des Infections (PCI) à l'aide de l'outil cadre d'évaluation de l'OMS dans 30 établissements de santé du District Autonome d'Abidjan. L'objectif était d'harmoniser le système d'évaluation mis en place.

Méthodes : Il s'agissait d'une enquête transversale avec un volet conceptualisé prenant en compte la problématique de la gestion des déchets sanitaires et de la sécurité des injections. Cette étude a été menée du 07 au 28 mars 2018 dans 30 établissements de santé. Les scores des volets essentiels de l'outil d'évaluation ont permis d'apprécier le niveau de PCI global de l'ensemble des établissements évalués.

Résultats : Le score IPCAF médian global des établissements de santé était de 242,5/800 et correspondait à un niveau basique. Aucun établissement n'a atteint le niveau de performance "avancé", 5 établissements (17%) ont atteint le niveau "intermédiaire", 10 (33%) avaient un niveau "basique", et 15 (50%) étaient au niveau "inadéquat". Les hôpitaux de référence avaient des scores beaucoup plus élevés que les Etablissements Sanitaires de Premier Contact (ESPC).

Conclusion : Les composantes PCI étaient inadéquates dans l'ensemble des établissements de santé au moment de l'évaluation. Il serait approprié de fournir des ressources adéquates et de développer une expertise en PCI grâce à une volonté politique et un leadership fort. Cela contribuera à l'atteinte des objectifs de la Couverture Sanitaire Universelle avec des services de santé sûrs pour les patients.

Mots clés : Prévention et Contrôle des Infections associées aux soins, Evaluation des structures de soins, Sécurité des patients, Côte d'Ivoire.

[C304] Processus de Mise en place du Tableau de bord du Ministère de la Santé, de l'Hygiène Publique et de la Couverture Maladie Universelle de Côte d'Ivoire (MSHPCMU) pour l'optimisation de la prise de décision

Doumbia Mariamou Cissé^{1,3}, Pongathié Adama Sanogo², Koné Atioumounan Blaise¹⁴, Samba Mamadou^{1,5}, Bluesquare⁶

1. Ministère de la Santé, de l'Hygiène Publique et de la Couverture Maladie Universelle/Direction Générale de la Santé, BP V 4 Abidjan, CI-AB. IV93. 14/ CI.AB. 110. Côte d'Ivoire
2. Ministère de la Santé, de l'Hygiène Publique et de la Couverture Maladie Universelle/Direction de l'Information Sanitaire, BP V 4 Abidjan, CI-AB. IV93. 14/ CI.AB. 110. Côte d'Ivoire
3. Université Félix Houphouët Boigny au Département de Santé Publique de l'UFR des Sciences Pharmaceutiques et Biologiques, 22 BP 582 Abidjan 22, CI-AB. IV93. 14/ CI.AB. 110. Côte d'Ivoire
4. Institut National d'Hygiène Publique, BPV 14 Abidjan 01, CI-AB. IV93. 14/ CI.AB. 110. Côte d'Ivoire
5. Université Félix Houphouët Boigny au Département de Santé Publique, UFR d'Odonto-stomatologie, 01 BPV 34 Abidjan 01, CI-AB. IV93. 14/ CI.AB. 110. Côte d'Ivoire
6. Bluesquare / Hive 5, Rue des Francs 79, 1040 Brussels, belgium.info@bluesquarehub.com

Introduction : L'avènement de la pandémie à Covid-19 a permis de mettre en évidence les insuffisances et les limites de la gestion de l'information sanitaire.

Pour pallier cette situation, la Direction Générale de Santé en collaboration avec la Direction de l'Information Sanitaire et l'appui de ses partenaires, a initié la conception et la réalisation d'un tableau de bord pour le MSHPCMU. L'objectif était de garantir la bonne exploitation des données sanitaires, en vue de l'optimisation de la prise de décision, conformément à sa politique de santé.

Méthodes : L'élaboration du tableau de bord s'est déroulée sur deux ans (2020 à 2022) avec l'appui technique de Bluesquare et financier de Bill and Melinda Gates. Des plénières et séances techniques ont permis d'identifier et de valider les principaux axes thématiques. Les objectifs associés aux besoins réels du MSHPCMU ont été identifiés, puis pour chaque objectif, les sources et les indicateurs ont été définis. Des points focaux officiellement désignés par leur structure ont été formés sur l'Open Hexa et le Power Bi. Des paramétrages ont été faits avec les données du DHIS 2.

Résultats : Un tableau de bord intégrant la plupart des sources de données existantes a été élaboré. Il comprend la disponibilité des produits traceurs, la surveillance des maladies à potentiel épidémiques, la santé mère-enfant, l'offre de services et la satisfaction des patients.

Conclusion : Le tableau de bord de suivi des indicateurs permettra d'optimiser la prise de décision pour l'amélioration système de santé.

Mots clés : Tableau de bord ; MSHPCMU, Côte d'Ivoire, Afrique de l'Ouest, Elaboration.

[C305] Prévention du risque de transmission des Infections Associées aux Soins (IAS) dans 14 hôpitaux de références de Côte d'Ivoire (Afrique de l'Ouest)

Doumbia Mariamou Cissé^{1,2}, Koné Atioumounan Blaise^{1,3}, Fanta Comara Dali⁵, N'gbesso N'gbesso Jean Paul⁴, Cissé Raïssa Adja Mayaka², Gagne Doh Eugénie⁵, Kouakou Julie Sackou^{2,6}, Samba Mamadou^{1,7}

1. Ministère de la Santé, de l'Hygiène Publique et de la Couverture Maladie Universelle/Direction Générale de la Santé, BP V 4 Abidjan, CI-AB. IV93. 14/ CI.AB. 110. Côte d'Ivoire
2. Université Félix Houphouët Boigny au Département de Santé Publique de l'UFR des Sciences Pharmaceutiques et Biologiques, 22 BP 582 Abidjan 22, CI-AB. IV93. 14/ CI.AB. 110. Côte d'Ivoire
3. Institut National de Santé Publique, BPV 47 Abidjan, CI-AB. IV93. 14/ CI.AB. 110. Côte d'Ivoire
4. Laboratoire Biologie et Santé, Université Félix Houphouët Boigny, 22 B.P. 582, Abidjan 22, CI-UN B. IV93. 14/ CI.AB. 110. Côte d'Ivoire
5. Direction de l'Hygiène Publique et de la Santé-Environnement, BP V 4 Abidjan, CI-AB. IV93. 14/ CI.AB.110. Côte d'Ivoire
6. Institut National de Santé Publique, BPV 47 Abidjan, CI-AB. IV93. 14/ CI.AB. 110. Côte d'Ivoire
7. Université Félix Houphouët Boigny au Département de Santé Publique, UFR d'Odonto-stomatologie, 01 BPV 34 Abidjan 01, CI-AB. IV93. 14/ CI.AB. 110. Côte d'Ivoire

Introduction : Les IAS constituent un souci majeur de santé publique dans le monde et en particulier en Afrique. Elles sont caractérisées par un lourd impact financier et de mortalité à cause de la virulence et la résistance des agents pathogènes incriminés. Ces infections sont la résultante de la défaillance des mécanismes d'hygiène dans les établissements sanitaires. L'objectif était d'évaluer le niveau de performance des hôpitaux de référence en matière de l'Eau, l'Hygiène et l'Assainissement.

Méthodes : Il s'agit d'une étude transversale à visée descriptive. Elle a été menée de Mai à juillet 2023, à l'aide de l'outil WASHFIT dans 14 hôpitaux de références.

Résultats : Sur un total de 14 hôpitaux de références, la moyenne arithmétique des scores était de 83,86, ce qui correspond à une performance inappropriée mais ayant un potentiel. La grande majorité de ces hôpitaux 10/14 (71,42%) avait obtenu une performance inappropriée alors 3/14 (21,43%) avaient une performance inacceptable. Seulement, 1/14 avait une performance qui réponde aux attentes pour prévenir les IAS. De façon spécifique 92,85% ont un réseau raccordé à la SODECI, et parmi ceux-ci 35,71% n'ont pas disposé régulièrement d'eau courante. Pour la gestion des déchets, 85,71% n'ont pas réalisé de tri, et pour l'assainissement, 50% n'ont pas disposé de latrines améliorées pour les patients. En ce qui concerne l'hygiène, 64,28% n'ont pas disposé de produits d'hygiène et seulement un hôpital a monitoré les directives de l'hygiène des mains.

Conclusion : Les hôpitaux de références ont obtenu une performance inappropriée dans l'ensemble lors de l'évaluation. Il serait approprié de fournir des ressources et développer une expertise en prévention et contrôle des infections associées aux soins grâce à une volonté politique et un leadership fort.

Mots clés : Prévention et Contrôle des Infections associées aux soins, Evaluation des hôpitaux de références, WASHFIT Côte d'Ivoire, Afrique de l'Ouest

Partenaires

